Perfil V3 · código por código

Pediatría

Los 227 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Pediatría, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 142 códigos

2.01.1.001 Desnutrición

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Desnutrición: evaluar con curvas OMS; <2 años P/E y P/T, ≥2 años IMC/E; T/E < -2 DE indica talla baja (desnutrición crónica).
- Clasificación: riesgo de desnutrir P/T o IMC/E entre -1 y -2 DE; desnutrición < -2 DE. Marasmo (déficit calórico, emaciado) vs Kwashiorkor (déficit proteico, edema, hipoalbuminemia).
- Estudio: encuesta alimentaria, hemograma, albúmina, orina completa/urocultivo, parasitológico; buscar causa secundaria (celiaquía, FQ, cardiopatía, negligencia).
- Tratamiento: realimentación gradual con aporte calórico-proteico aumentado, suplemento de hierro, zinc y vitaminas; tratar la causa e incorporar al PNAC.
- Grave: riesgo de síndrome de realimentación (hipofosfemia, hipokalemia), hipoglicemia e hipotermia; hospitalizar si hay edema, compromiso general o infección.
- Seguimiento: control nutricional mensual con curva de peso y talla en APS; derivar si no hay recuperación o se sospecha causa orgánica.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niña de 3 años, traída a control. Ha tenido diarreas a repetición los últimos 2 meses. En las curvas OMS: Peso para la Edad –2,4 DE, Talla para la Edad –1,3 DE y Peso para la Talla –2,1 DE. **¿Cuál es su diagnóstico nutricional?**

A) Desnutrición
B) Riesgo de desnutrición
C) Eutrófica con talla normal
D) Talla baja
E) Desnutrición crónica con talla baja

Respuesta A. En menores de 5 años el diagnóstico nutricional lo define el Peso para la Talla: –2 DE o menos es desnutrición. La Talla para la Edad en –1,3 DE está en rango normal, así que no hay talla baja. El Peso para la Edad no define el diagnóstico.

2.01.1.002 Dislipidemias

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Dislipidemia pediátrica: tamizaje universal con perfil lipídico entre 9-11 años y 17-21; selectivo desde 2 años si hay historia familiar de ECV precoz o hipercolesterolemia, obesidad, DM o HTA.
- Valores aceptables: CT <170 mg/dL, LDL <110, TG <75 (<10 años) o <90 (10-19 años), HDL >45. LDL ≥130 alterado; LDL ≥190 sugiere hipercolesterolemia familiar.
- Confirmar con 2 perfiles en ayuno; descartar causas secundarias: obesidad, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, colestasia, fármacos (corticoides, isotretinoína).
- Tratamiento inicial: dieta (grasa total 25-30%, saturada <7%, sin trans), actividad física ≥60 min/día y manejo del peso por 6-12 meses.
- Estatinas desde los 8-10 años si LDL persiste ≥190 mg/dL, o ≥160 con factores de riesgo, tras fallar dieta: lo indica el especialista.
- Seguimiento: derivar a nutriología/endocrinología infantil; estudio en cascada de familiares si hay hipercolesterolemia familiar.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 11 años es derivado por colesterol LDL de 205 mg/dL, confirmado en dos mediciones. Su padre tuvo un infarto agudo al miocardio a los 42 años. Lleva 6 meses con dieta y actividad física supervisadas, con LDL de control de 198 mg/dL. Su IMC es normal y no tiene otras enfermedades. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Mantener solo dieta y controlar en un año
B) Indicar suplementos de omega 3 como única medida
C) Iniciar fibratos
D) Esperar hasta los 18 años para iniciar fármacos
E) Iniciar una estatina en dosis baja manteniendo la dieta

Respuesta E. LDL de 190 mg/dL o más persistente tras 6 meses de dieta, en un niño de 10 años o más, sugiere hipercolesterolemia familiar y es indicación de estatina, sobre todo con antecedente de enfermedad coronaria precoz. Se inicia en dosis baja, manteniendo cambios de estilo de vida y vigilando CK y transaminasas. Los fibratos son para hipertrigliceridemia.

2.01.1.003 Obesidad

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Obesidad: <5 años P/T > +2 DE (sobrepeso +1 a +2); ≥5 años IMC/E ≥ +2 DE (≥p95 en CDC), sobrepeso +1 a +2 DE. Perímetro de cintura ≥p90 = obesidad abdominal.
- Buscar comorbilidad: HTA, acantosis nigricans (resistencia insulínica), dislipidemia, hígado graso (ALT), apnea del sueño, epifisiólisis, SOP, impacto psicosocial.
- Sospechar causa endocrina o genética si hay talla baja con obesidad (hipotiroidismo, Cushing, déficit de GH) o dismorfias/retraso (Prader-Willi).
- Exámenes en obesidad: glicemia ayuno, perfil lipídico, transaminasas; insulinemia/PTGO si acantosis o antecedentes familiares de DM2.
- Tratamiento: cambio de estilo de vida familiar, dieta saludable sin bebidas azucaradas, ≥60 min/día de actividad física, pantallas <2 h/día; meta en niño pequeño mantener peso mientras crece.
- Seguimiento: controles mensuales en APS con equipo (nutricionista, psicólogo); derivar si comorbilidad grave, sospecha de causa secundaria o falla del manejo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 7 años, en control de salud. Toma 2 vasos de bebida azucarada al día y juega pocas horas al aire libre. En las curvas OMS: Talla para la Edad +0,5 DE e IMC para la Edad +2,4 DE. Su Peso para la Talla calculado por la madre en una aplicación es +1,6 DE. **¿Cuál es su diagnóstico nutricional?**

A) Eutrófico
B) Sobrepeso, según el Peso para la Talla
C) Obesidad
D) Obesidad severa
E) Talla alta constitucional

Respuesta C. Desde los 5 hasta los 19 años se usa el IMC para la Edad, no el Peso para la Talla. Entre +2 y +2,9 DE corresponde a obesidad; la obesidad severa parte en +3 DE. Usar el Peso para la Talla a esta edad lleva al error de diagnosticar sobrepeso.

2.01.1.004 Adenitis cervical

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.20 Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Adenitis cervical aguda: ganglio >2 cm, doloroso, eritematoso, unilateral, generalmente por S. aureus o S. pyogenes, en preescolares tras infección respiratoria.
- Bilateral y pequeña: reactiva viral (sin antibiótico). Fluctuación indica absceso (confirmar con ecografía).
- Tratamiento empírico: cefadroxilo 50 mg/kg/día c/12 h o amoxicilina-ácido clavulánico por 10 días; hospitalizar si tóxico, <1 año o sin respuesta en 48-72 h (cloxacilina/cefazolina EV).

- Absceso: drenaje quirúrgico. Subaguda/crónica: pensar en micobacterias atípicas, enfermedad por arañazo de gato (Bartonella: azitromicina), TBC o toxoplasmosis.
- Banderas rojas de neoplasia: ganglio supraclavicular, duro, adherido, >3 cm, sin respuesta a 2-4 semanas, síntomas B o hepatoesplenomegalia: hemograma, Rx tórax y derivar para biopsia.
- Seguimiento: control a las 48-72 h y al terminar el tratamiento hasta la regresión del ganglio.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 142

Un escolar de 6 años presenta aumento de volumen submandibular derecho, doloroso. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen, de aspecto eritematoso, de 3 cm de diámetro, doloroso a la palpación. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Bacteroides fragilis
B) Peptoestreptococo
C) Streptococcus pyogenes (grupo A)
D) Staphylococcus aureus
E) Escherichia coli

Respuesta D. Una adenitis cervical aguda unilateral, eritematosa y dolorosa en un niño es una adenitis bacteriana piógena. Los agentes son Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes; cuando el ganglio está inflamado y tiende a abscedarse, el más probable es S. aureus. Se trata con cefadroxilo o cloxacilina y drenaje si fluctúa.

2.01.1.005 Celulitis periorbitaria

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.17 Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC · Tema 14.10 Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Celulitis preseptal (periorbitaria): edema y eritema palpebral sin compromiso del globo; motilidad ocular, agudeza visual y pupilas normales. Origen cutáneo (picadura, herida) o sinusal.
- Celulitis orbitaria (postseptal): proptosis, oftalmoplejía dolorosa, disminución de agudeza visual, quemosis; complicación de sinusitis etmoidal. Es urgencia: TC de órbita y senos con contraste.
- Preseptal leve en niño >1 año con buen estado: amoxicilina-ácido clavulánico 80-90 mg/kg/día o cefadroxilo por 7-10 días con control en 24-48 h.
- Hospitalizar con antibiótico EV (ceftriaxona + cloxacilina, o clindamicina) si orbitaria, <1 año, compromiso general, sin respuesta oral o duda diagnóstica.
- Complicaciones de la orbitaria: absceso subperióstico, trombosis del seno cavernoso, meningitis, pérdida visual.
- Seguimiento: derivar a oftalmología y otorrinolaringología toda celulitis orbitaria o la preseptal que no responde.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 122

Una niña de 4 años presenta un cuadro catarral, con abundante rinorrea. Evoluciona con eritema y dolor periocular derecho, asociado a proptosis. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Celulitis preorbitaria
B) Celulitis orbitaria
C) Orbitopatía distiroidea
D) Pseudotumor orbitario
E) Etmoiditis aguda

Respuesta B. La proptosis es la que define el compromiso orbitario, y por eso la respuesta es celulitis orbitaria. Es secundaria a la sinusitis que acompaña al cuadro catarral, casi siempre etmoidal en una niña de esta edad. La celulitis preseptal, por definición, no da proptosis.

Pregunta de práctica

Un niño de 7 años tiene 6 días de rinorrea mucopurulenta y congestión nasal, tratados como resfrío. En las últimas 24 horas presenta fiebre de 39,4 °C y tumefacción progresiva del ojo izquierdo. Tiene edema y eritema palpebral marcado, proptosis evidente y limitación muy dolorosa de la abducción y la elevación de ese ojo. La agudeza visual está conservada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Amoxicilina oral ambulatoria y control en 48 horas
B) Descongestionante tópico y paracetamol
C) Radiografía de senos paranasales y alta
D) Hospitalizar, solicitar TAC de senos y órbitas con contraste e iniciar antibióticos endovenosos
E) Solo lavados nasales con suero fisiológico

Respuesta D. La proptosis y la oftalmoplejía dolorosa indican celulitis orbitaria (Chandler II), una emergencia por el riesgo de absceso, amaurosis y trombosis del seno cavernoso. Se hospitaliza, se toman hemocultivos, se pide TAC con contraste y se inicia ceftriaxona endovenosa con vancomicina o clindamicina.

Pregunta de práctica

Niño de 6 años, con antecedente de picadura de insecto en el párpado hace 2 días, consulta por edema y eritema palpebral derecho, con fiebre de 38,2 grados. Los movimientos oculares están conservados, sin dolor al moverlos, no hay proptosis y la agudeza visual es 20/20 en ambos ojos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Hospitalizar de inmediato e iniciar ceftriaxona más vancomicina endovenosas
B) Solicitar tomografía computada de órbita antes de definir el tratamiento
C) Iniciar amoxicilina con ácido clavulánico oral en forma ambulatoria, con control clínico en 24 horas
D) Indicar corticoides orales en dosis altas para bajar el edema
E) Derivar de urgencia a neurocirugía por sospecha de trombosis del seno cavernoso

Respuesta C. La motilidad ocular conservada e indolora, la ausencia de proptosis y la agudeza visual normal descartan compromiso orbitario y confirman una celulitis preseptal secundaria a la picadura. El manejo es ambulatorio con amoxicilina y ácido clavulánico oral, con control a las 24 horas; ni la hospitalización ni la tomografía son necesarias de entrada.

2.01.1.006 Coqueluche

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 18.5 Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Coqueluche (Bordetella pertussis): fase catarral (1-2 sem), paroxística con tos en accesos, estridor inspiratorio («gallito»), vómitos post-tos y cianosis; convaleciente semanas.
- Lactante <3 meses: presentación atípica con apneas y cianosis sin gallito; alto riesgo de muerte (hipertensión pulmonar). Hemograma con leucocitosis y linfocitosis marcada.
- Confirmar con PCR para B. pertussis en hisopado nasofaríngeo. Es de notificación obligatoria inmediata.
- Tratamiento: azitromicina 10 mg/kg/día por 5 días (en <1 mes preferida); alternativas claritromicina 7 días o cotrimoxazol >2 meses. Antibiótico no acorta la tos pero corta el contagio.
- Hospitalizar a todo <3 meses o con apneas, cianosis, dificultad para alimentarse o hiperleucocitosis. Quimioprofilaxis con azitromicina a contactos estrechos, priorizando lactantes y embarazadas.
- Prevención: vacuna hexavalente (2-4-6-18 meses), dTpa en 1º y 8º básico y dTpa a la embarazada desde las 28 semanas. Seguimiento: control hasta resolución de los paroxismos.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 72

Un recién nacido de 2 semanas es hospitalizado por presentar apneas. La madre refiere tos de 3 semanas de evolución, en crisis, que en ocasiones la hace vomitar. **¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?**

A) Amoxicilina
B) Azitromicina
C) Ceftriaxona
D) Oseltamivir
E) Aciclovir

Respuesta B. Apneas en un recién nacido con una madre con tos paroxística emetizante de 3 semanas sugieren coqueluche (Bordetella pertussis). El tratamiento es un macrólido; en menores de 1 mes se prefiere azitromicina por el menor riesgo de estenosis hipertrófica del píloro. Se confirma con PCR y se trata también a los contactos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 151 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 13 meses, es traído por presentar desde hace 4 días cuadro caracterizado por crisis de tos que aparecen de forma repetitiva durante el día, asociado a decaimiento, rechazo alimentario, náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecia hemorragia subconjuntival derecha, examen pulmonar con murmullo pulmonar presente, sin otros hallazgos. El agente etiológico más probable en este caso es:

A) Virus respiratorio sincicial
B) Virus parainfluenza
C) Mycoplasma
D) Bordetella pertusis
E) Virus sarampión

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Bordetella pertusis). Es un coqueluche de libro. El coqueluche (tos ferina o tos compulsiva) es una enfermedad incluida en el Plan Nacional de Inmunizaciones causada por Bordetella pertussis. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 40 · texto original del banco, sin revisar

Un recién nacido de 3 semanas de vida es hospitalizado por presentar apneas. La madre refiere tos frecuente de 2 semanas de evolución, intensa, que en ocasiones la hacen vomitar. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

A) Amoxicicilina
B) Azitromicina
C) Ceftriaxona
D) Oseltamivir
E) Aciclovir

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Azitromicina (opción B). La sospecha es un coqueluche, que se trata con macrólidos.. Diagnóstico de elección: PCR para Bordetella pertussis; cultivo es poco sensible (bacteria fastidiosa) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 151 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 5 meses de edad presenta un cuadro de rinorrea y tos, que va en aumento, hasta presentar accesos de tos y dificultar la alimentación. Al examen físico está en buenas condicioness generales, afebril y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicita un hemograma, que muestra leucocitosis de 17.000, con 78% de linfocitos y 22% de neutrófilos. La PCR y VHS están levemente elevadas. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un patrón intersticial leve. El diagnóstico más probable es:

A) Neumonía atípica
B) Infección por virus influenza
C) Infección por adenovirus
D) Coqueluche
E) Bronquiolitis aguda

Respuesta D. Es un coqueluche clásico: tos en accesos, precedido por cuadro catarral y linfocitosis en el hemograma.

2.01.1.007 Enteroparasitosis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 6.1 Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Enteroparasitosis más frecuentes en Chile: Giardia lamblia (diarrea crónica, malabsorción, distensión), Oxiuros (prurito anal nocturno), Blastocystis y Ascaris.
- Diagnóstico: parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras); test de Graham (cinta adhesiva perianal matinal) para Enterobius vermicularis.
- Giardiasis: metronidazol 15 mg/kg/día por 5-7 días, o tinidazol 50 mg/kg dosis única, o nitazoxanida.
- Oxiuriasis: mebendazol 100 mg dosis única o albendazol 400 mg (200 mg <2 años), repetir a las 2 semanas; tratar a todo el grupo familiar y lavar ropa de cama.
- Ascaris y otros helmintos: albendazol 400 mg dosis única o mebendazol 100 mg c/12 h por 3 días. Teniasis: praziquantel.
- Prevención: lavado de manos, agua potable, lavado de verduras, cocción de carnes. Seguimiento: parasitológico de control post tratamiento si persisten síntomas.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 120

Un niño de 4 años presenta intenso prurito anal desde hace varios días, lo que se ha asociado a dificultades para dormir y bruxismo. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Parasitológico de deposiciones
B) Test de Graham
C) Hemograma
D) Prueba de reacción cutánea (prick test)
E) Recuento de inmunoglobulina E específica

Respuesta B. Prurito anal nocturno con trastornos del sueño y bruxismo en un preescolar sugiere oxiuriasis (Enterobius vermicularis). La hembra deposita los huevos en la piel perianal, por lo que no suelen aparecer en las deposiciones; el examen de elección es el test de Graham (cinta adhesiva perianal en la mañana).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 125 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 5 años persenta prurito anal importante, asociado a prurito vulvar. La madre refiere que también presenta bruxistmo. Al examen físico presenta signos de grataje en la zona perianal y perivulvar. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Parasitológico seriado
B) Test de Graham
C) Microscopía óptica de frotis directo de deposiciones
D) Coprocultivo
E) Medición de eosinófilos en sangre

Respuesta B. Diagnóstico: Test de Graham (opción B). La oxiuriasis se diagnostica con el test de Graham.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 143 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 7 años es llevado a consulta por prurito anal intenso, mayor en las noches, de 2 semanas de evolución. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones generales, con signos vitales y examen abdominal normales. El examen anal no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada para continuar el estudio de este paciente?

A) Colonoscopía
B) Examen directo de heces
C) Examen parasitológico de deposiciones
D) Test de Graham
E) Serología para Enterobius vermicularis

Respuesta D. Diagnóstico de Enterobiasis: El test de Graham es el examen de elección para diagnosticar enterobiasis (oxiuariasis). Recolecta los huevos del parásito en la zona perianal, utilizando una cinta adhesiva, con mayor efectividad que los análisis parasitológicos convencionales.

2.01.1.008 Escarlatina

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki · Tema 18.10 Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)

QUÉ HAY QUE SABER

- Escarlatina: exantema por toxina eritrogénica de S. pyogenes en faringoamigdalitis; 3-15 años. Exantema micropapular áspero (piel de lija) que respeta el surco nasogeniano.
- Signos clave: lengua aframbuesada, palidez peribucal (Filatov), líneas de Pastia en pliegues, descamación furfurácea/en guante a la semana.
- Diagnóstico clínico; test rápido de antígeno o cultivo faríngeo si hay dudas.
- Tratamiento: penicilina benzatina 600.000 UI IM (<27 kg) o 1.200.000 UI (≥27 kg) dosis única, o amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días; alergia a penicilina: azitromicina 5 días.
- Complicaciones: fiebre reumática (prevenible con antibiótico iniciado hasta 9 días), glomerulonefritis postestreptocócica (no prevenible), absceso periamigdalino.
- Seguimiento: control clínico al terminar tratamiento; orina completa si aparecen edema, hematuria o HTA a las 1-3 semanas. Retorno al colegio tras 24 h de antibiótico.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 71

Un niño de 7 años, consulta por fiebre, malestar general y dolor de garganta, a lo que se le agregó un exantema. Al examen físico presenta adenopatías cervicales anteriores sensibles y un rash generalizado, mayor en los pliegues de los codos y axilas. La piel se palpa áspera. **¿Cuál es el agente más probable?**

A) Virus de Ebstein Baar
B) Virus sarampión
C) Estreptococo betahemolítico grupo A
D) Virus rubéola
E) Estafilococo aúreo

Respuesta C. Faringitis con adenopatías cervicales anteriores y exantema áspero acentuado en pliegues (líneas de Pastia): escarlatina por Streptococcus pyogenes. Se trata con amoxicilina por 10 días.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 96

Niño de 6 años con odinofagia intensa, fiebre y decaimiento. Luego aparece un exantema eritematoso generalizado, más marcado en los pliegues inguinales y axilares. Al examen: febril, faringe eritematosa, adenopatías cervicales sensibles, y piel áspera al tacto. **¿Qué complicación puede desarrollar este paciente?**

A) Aneurismas coronarios
B) Meningitis
C) Fascitis necrotizante
D) Glomerulonefritis
E) Miocarditis

Respuesta D. Es un cuadro de escarlatina (odinofagia, fiebre, exantema en piel de lija más marcado en pliegues). La complicación que puede aparecer, incluso tratada, es la glomerulonefritis postestreptocócica; el antibiótico previene la fiebre reumática, pero no esta.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 48 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 6 años, con historia de 5 días de odinofagia intensa asociada a secreción purulenta y sensación febril que durante el último día se acompañó de rash papular eritematoso que es más intenso en pliegues. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

A) Hemograma
B) IgM para virus Epstein barr
C) Panel viral
D) Cultivo de secreción faríngea
E) Test pack para Streptococo grupo A

Respuesta D. Es una escarlatina y el diagnóstico es clínico. No hay que pedir ningún examen, por lo que esta pregunta está técnicamente mala. El cultivo faríngeo es el goldstandard, pero demora. La verdad es que no estoy 100% seguro de que esta sea la respuesta correcta, ya que al igual que en el Herpes, el diagnóstico es clínico y el gold standard es el cultivo. Eso sí, el test pack tiene el resultado es inme

2.01.1.009 Exantemas virales

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki · Tema 18.10 Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sarampión: fiebre alta, tos, coriza, conjuntivitis, manchas de Koplik y exantema maculopapular céfalo-caudal confluente. Notificación inmediata; vacuna SRP.
- Rubéola: exantema rosado leve, adenopatías retroauriculares y occipitales; riesgo de rubéola congénita. Eritema infeccioso (parvovirus B19): mejillas abofeteadas y exantema en encaje; aplasia en anemias hemolíticas.
- Exantema súbito (VHH-6): lactante con 3-5 días de fiebre alta y exantema al desaparecer la fiebre; puede dar convulsión febril.
- Varicela: exantema polimorfo pruriginoso «en cielo estrellado» (mácula, pápula, vesícula, costra), compromete mucosas. Aciclovir 80 mg/kg/día en 4 dosis por 5 días en >12 años, inmunodeprimidos o enfermedad cutánea/pulmonar crónica.
- Enfermedad mano-pie-boca (coxsackie): vesículas orales y en palmas/plantas. Manejo sintomático con paracetamol; evitar aspirina (síndrome de Reye) e ibuprofeno en varicela (fascitis).

- Seguimiento: control si sobreinfección bacteriana o signos de complicación (neumonía, encefalitis, ataxia cerebelosa en varicela).

PREGUNTAS (18)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 23

Un lactante de 10 meses de edad presenta eritema en la cara, que al día siguiente se generaliza. Al examen físico tiene un exantema rosado macular tenue, asociado a adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores. **El diagnóstico más probable es:**

A) Eritema infeccioso
B) Rubéola
C) Exantema por citomegalovirus
D) Sarampión
E) Exantema súbito

Respuesta B. Exantema macular rosado tenue de progresión rápida con adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores: rubéola. Con menos de un año, aún no recibe la vacuna tresvírica.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 127

Un prescolar de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 38 grados, asociado a eritema en las mejillas, que aumenta en los periodo de fiebre y con el calor y se vuelve más pálido cuando no hay fiebre. Luego se agrega un exantema reticular en el tronco. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Virus rubéola
B) Virus Coxsackie
C) Parvovirus B19
D) Streptococcus pyogenes
E) Virus herpes 6

Respuesta C. Eritema de mejillas (signo de la bofetada) que se acentúa con el calor, seguido de exantema reticular en el tronco: eritema infeccioso por parvovirus B19.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 25

Un niño de 5 años presenta un exantema pruriginoso, desde hace 4 días, generalizado y pleomorfo, consistente en máculas, pápulas, vesículas, que inició en el cuero cabelludo y luego se extendió al tronco y las extremidades. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Aciclovir
B) Valaciclovir
C) Prednisona
D) Clorfenamina maleato
E) Talco mentolado

Respuesta D. Varicela clásica no complicada en un niño sano: tratamiento sintomático, con antihistamínico para el prurito. El antiviral se reserva para mayores de 13 años, el segundo caso intradomiciliario, los cuadros graves o los inmunodeprimidos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 13

Lactante de 8 meses con fiebre de 39,5 °C durante 5 días. Al sexto día la fiebre cede y aparece un exantema rosado generalizado no pruriginoso. El niño está en buen estado general. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Control sano habitual: es un exantema súbito, de evolución benigna
B) Derivar a especialista de inmediato
C) Hospitalizar para estudio
D) Iniciar aciclovir oral
E) Solicitar serología viral urgente

Respuesta A. Fiebre alta de varios días que cede bruscamente, seguida de exantema rosado en un lactante con buen estado general: exantema súbito por HHV-6. Es diagnóstico clínico, autolimitado, y no requiere estudio ni antiviral.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 37

Niño de 5 años con fiebre baja hasta 37,5 °C y eritema malar. Dos días después se agrega un exantema eritematoso macular en el tronco y las extremidades, con un cuadro que dura un total de 10 días. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Streptococcus pyogenes
B) Parvovirus B19
C) Virus de Epstein-Barr
D) Virus herpes humano número 6
E) Virus rubéola

Respuesta B. Eritema malar (signo de la bofetada) seguido de exantema reticular en tronco y extremidades, con fiebre baja y curso prolongado, es el cuadro clásico del eritema infeccioso por Parvovirus B19.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 70 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 18 meses lleva 3 días con fiebre, cuantificada de 38,8°. Se inicia amoxicilina, desapareciendo la fiebre y apareciendo un exantema eritematoso generalizado, que se muestra en la siguiente imagen: Foto 6 (http://www.childnurture.com/article/XXXXXXX) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Eritema infeccioso
B) Exantema súbito
C) Reacción alérgica a medicamentos
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Síndrome de piel escaldada

Respuesta B. Diagnóstico: Exantema súbito (opción B). Es un exantema súbito clásico, por virus herpes 6.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 52 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 14 meses de edad presenta un cuadro febril de 4 días de evolución, con fiebre hasta 39,2°C, la que desaparece abruptamente, dado paso a la aparición de un rash eritematoso maculopapular, que afecta la cara, el tronco y las cuatro extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Eritema infeccioso
B) Síndrome de pie mano boca
C) Síndrome de Kawasaki
D) Exantema súbito
E) Rubéola

Respuesta D. Exantema súbito (Roséola infantil): Es un exantema súbito clásico, que afecta principalmente a niños entre 6 y 12 meses de edad. Se caracteriza por una fiebre muy alta que cesa repentinamente, seguida de la aparición de un rash generalizado.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 35 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 18 meses presenta, desde hace 5 días irritabilidad y fiebre, cuantificada hasta 38,8°. Se inicia amoxicilina, cediendo la fiebre fiebre hace 48 horas y apareciendo un exantema eritematoso generalizado hace 24 horas, que se muestra en la siguiente imagen (fuente: wikipedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Eritema infeccioso
B) Exantema súbito
C) Reacción cutánea a medicamentos
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Rubéola

Respuesta B. Diagnóstico: Exantema súbito (opción B). Es un exantema súbito clásico. También se llama sexta enfermedad o roséola.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 69 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 5 años, es traído por su madre, por fiebre hasta 38,0°C y aparición de eritema facial marcado, que luego desaparece, dando paso a aparición de un exantema “en encaje”, que afecta el abdomen, las extremidades superiores y las extremidades inferiores, el que ha persistido por 15 días. Ha recibido ibuprofeno para sus síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Rubéola
B) Infección por virus Coxsackie A16
C) Infección por parvovirus B19
D) Reacción adversa al ibuprofeno
E) Mononucleosis infecciosa

Respuesta C. Diagnóstico: Infección por parvovirus B19 (opción C). Es un eritema infeccioso clásico. El exantema puede durar hasta 30 días.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 139 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 5 años presenta fiebre no cuantificada, asociada a un exantema que inicia en las mejillas y que luego se extiende a la zona proximal de las extremidades, con una disposición, en encaje. Al examen físico tiene 37,1 grados de temperatura y se aprecia la faringe congestiva, con amígdalas rosadas y el exantema descrito. El diagnóstico más probable es:

A) Exantema súbito
B) Eritema infeccioso
C) Exantema por virus Coxsackie
D) Rubéola
E) Escarlatina

Respuesta B. Diagnóstico: Eritema infeccioso (opción B). Es un eritema unfeccioso clásico, por PVB19.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 27 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 10 meses de edad, presenta un cuadro de fiebre hasta 37,8 grados Celsius, asociado a aparición de un exantema generalizado, de timo macular eritematoso, de aspecto tenue. Al examen físico destacan adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores, sensibles a la palpación. El diagnóstico más probable es:

A) Exantema súbito
B) Eritema infeccioso
C) Rubeola
D) Sarampión
E) Exantema por citomegalovirus

Respuesta C. Es una rubeola clásica (exantema macular tenue y generalizado, con adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores). Por tener menos de 1 años, aún no recibe la trivírica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 132 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 5 años de edad presenta fiebre leve, asociada a eritema malar, que dura 2 días y luego cede. Al cuarto día aparece un exantema que afecta el tronco y las zonas extensoras de las extremidades. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Virus herpes 6
B) Virus rubeola
C) Virus sarampión
D) Parvovirus B19
E) Streptococcus pyogenes

Respuesta D. Pregunta muy mal intencionada. El VH6 produce exantema súbito, pero habitualmente entre los 6 y 18 meses y con fiebre alta (cercana a 40 grados). El PVB19 produce el eritema infeccioso o quinta enfermedad, que produce el eritema malar (signo de la cachetada) y el exantema con esa distribución. Afecta a escolares con mayor frecuencia.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 168 · texto original del banco, sin revisar

Niño con historia de malestar general y fiebre 37.5°C-37.9°C de una semana de evolución, manejado con ibuprofeno. Le aparecia rash eritematoso en mejillas y Extremidades:

A) Eritema infeccioso
B) RAM
C) KAWASAKI
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Eritema infeccioso). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (RAM, KAWASAKI) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 131 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 3 años de edad, previamente sano, hace dos días inicia cuadro caracterizado por fiebre intensa, cuantificada hasta 39ºC, no asociado a otros síntomas. Su madre le administra acetaminofeno por vía oral durante el primer día, tras lo cual evoluciona con disminución de la fiebre y hoy amanece con exantema maculopapular no pruriginoso, sin fiebre y en buenas condiciones. El agente etiológico más probable es:

A) Citomegalovirus
B) Virus Epstein barr
C) Virus Herpes 6
D) Parvovirus B19
E) Enfermedad de Still

Respuesta C. Tiene un exantema súbito clásico, aunque está muy grande para tenerlo (suele ser en menores de dos años)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 30 · texto original del banco, sin revisar

Niña escolar con fiebre y exantema en mejillas y tronco (aspecto de 'bofetada'). ¿Cuál es el agente más probable?

A) Virus del sarampión
B) Virus de la rubéola
C) Herpes virus 6
D) Enterovirus
E) Parvovirus B19

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Parvovirus B19). Parvovirus B19. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Virus del sarampión, Virus de la rubéola) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación de

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 32 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 4 años es traída por un cuadro de 3 días de evolución de malestar general, fiebre hasta 38,5°C y, el día de hoy, aparición de un lesiones cutáneas que abarcan tronco extremidades y cara, como se muestra en la imagen (fuente: dortorgo.es): ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Virus rubéola
B) Parvovirus B19
C) Coxsackie A16
D) Virus herpes simple
E) Virus herpes 6

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Coxsackie A16). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Virus rubéola, Parvovirus B19) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 31 · texto original del banco, sin revisar

Lactante menor con fiebre alta; cuando cede aparece rash maculopapular en tronco y extremidades. ¿Cuál es el agente más probable?

A) Parvovirus B19
B) Enterovirus
C) Virus herpes 6
D) Adenovirus
E) Virus varicela-zóster

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Virus herpes 6). Virus herpes 6. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Parvovirus B19, Enterovirus) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 43 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 11 meses de edad presenta fiebre hasta 39°C, desde hace 3 días, asociado a irritabilidad, que ha sido manejeada con paracetamol. El día de hoy presenta lesiones cutáneas papulares eritematosas, generalizadas. El resto de su examen físico no tiene alteraciones ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Virus herpes 6
B) Parvovirus B19
C) Virus Coxsackie A16
D) Virus varicela zóster
E) Virus de Epstein Baar

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Virus de Epstein Baar). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Virus herpes 6, Parvovirus B19) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

2.01.1.010 Hepatitis viral

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Hepatitis A: la más frecuente en niños, transmisión fecal-oral; en menores casi siempre asintomática o leve; ictericia, coluria, acolia, transaminasas >10 veces.
- Diagnóstico: IgM anti-VHA confirma infección aguda. Hepatitis B: HBsAg y anti-HBc IgM; VHB adquirido perinatal cronifica en ~90%.
- Manejo VHA: sintomático, reposo relativo, dieta habitual, evitar paracetamol en exceso y hepatotóxicos; no requiere antiviral.
- Banderas rojas de falla hepática: TP <50% / INR >1,5 que no corrige con vitamina K, encefalopatía, hipoglicemia: hospitalizar y derivar a centro con trasplante.
- Prevención: vacuna hepatitis A a los 18 meses (PNI) y hepatitis B al nacer + hexavalente. RN de madre HBsAg+: vacuna e inmunoglobulina en <12 h.
- Seguimiento: control clínico y de transaminasas/TP hasta normalización; contactos domiciliarios sin vacunar pueden recibir vacuna VHA post exposición.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 79

Adolescente de 15 años con cuadro de 5 días de evolución con fiebre, astenia, náuseas e ictericia, a lo que últimamente se ha agregado prurito. Ha tomado paracetamol (500 mg), un total de 6 tabletas. Al examen físico, hipocondrio derecho levemente sensible a la palpación. Tiene antecedente de haber estado en un campamento hace 1 mes. En sus exámenes: fosfatasas alcalinas y GGT 8 veces sobre el valor normal, transaminasas 20 veces sobre el valor normal y bilirrubinemia aumentada. **¿Cuál es el diagnóstico probable?**

A) Coledocolitiasis
B) Hepatitis A
C) Hepatitis C
D) Hepatitis por fármacos
E) Hepatitis autoinmune

Respuesta B. Pródromo febril seguido de ictericia, transaminasas muy elevadas (patrón hepatocelular) y exposición en un campamento un mes antes (incubación de 2 a 6 semanas, transmisión fecal-oral) orientan a hepatitis A. Los 3 g de paracetamol repartidos en 5 días no alcanzan dosis hepatotóxica; el prurito refleja un componente colestásico frecuente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 128 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 8 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y aparición de ictericia asociado a orinas oscuras que se identifica como coluria. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran GOT 1.525UI/L, GPT 1.216 UI/L, bilirrubina total 11,3mg/dL de predominio directo e IgM para VHA (+). Se indica reposo por 10 días evolucionando favorablemente, sin embargo, 10 días después reaparece la ictericia, agregándose pruri- to y astenia. Se controlan pruebas hepáticas que muestran protrombinemia: 90%, GOT: 1.025 UI/L y GPT: 968 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hepatitis crónica
B) Remisión completa
C) Portación asintomática del virus
D) Remisión parcial con recurrencias
E) Falla hepática

Respuesta D. Diagnóstico: Remisión parcial con recurrencias (opción D). Es una hepatitis A recurrente (una de las forma de presentación de la hepatitis A).. Clase sobre el enfoque global de la ictericia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

2.01.1.011 Infecciones de piel y partes blandas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Impétigo: costras melicéricas (S. aureus, S. pyogenes) o ampollas (S. aureus). Localizado: mupirocina o ácido fusídico tópico 5-7 días; extenso: cefadroxilo oral.
- Celulitis: placa eritematosa, caliente, de bordes difusos; erisipela con bordes netos y solevantados (S. pyogenes). Cefadroxilo 50 mg/kg/día o flucloxacilina/cloxacilina por 7-10 días.
- Foliculitis, forúnculos y abscesos: calor local; absceso requiere drenaje, antibiótico si celulitis asociada, fiebre o localización facial.
- Hospitalizar con antibiótico EV (cefazolina o cloxacilina) si compromiso sistémico, celulitis facial extensa, lactante pequeño o falta de respuesta en 48-72 h.
- Banderas rojas de fascitis necrotizante: dolor desproporcionado, crepitación, bulas hemorrágicas, toxicidad (riesgo mayor tras varicela): urgencia quirúrgica.
- Seguimiento: control a las 48-72 h para evaluar respuesta; impétigo recurrente: buscar portación nasal de S. aureus y descolonizar.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 26

Un niño de 3 años presenta lesiones pruriginosas en la nariz y la cara de 3 días de evolución. Al examen físico se aprecian erosiones con costras amarillentas de aspecto melicérico sobre base eritematosa, en región perinasal y peribucal. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Curaciones con suero fisiológico
B) Curaciones con povidona yodada
C) Aciclovir oral por 5 días
D) Prednisona oral por 7 días
E) Flucloxacilina por 7 días

Respuesta E. Costras melicéricas periorificiales en un preescolar corresponden a impétigo, causado por S. aureus y S. pyogenes. Se trata con antibiótico antiestafilocócico: tópico (mupirocina) si es muy localizado, u oral (flucloxacilina, cloxacilina o cefadroxilo) por 7 a 10 días. Las curaciones solas no erradican la infección y los corticoides la empeoran.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 153 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 3 meses presenta aparición de lesiones en el abdomen y muslo, que se muestran a continuación: Foto 16 (https://accesspediatrics.mhmedical.com/content.aspx?bookid=447&sectionid=40442582). ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Virus herpes simplex
B) Streptococcus pyogenes
C) Virus varicela zóster
D) Virus pox
E) Staphilococcus aureus

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Staphilococcus aureus). Es un impétigo buloso, causado por S. aureus.. El SBOR secundario agrupa las causas no virales que pueden producir un síndrome bronquial obstructivo recurrente en lactantes y niños. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 90 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 8 años presenta aparición de lesiones en la cara, desde hace 3 días, las que han aumentado. Al examen físico se aprecia lo siguiente: El diagnóstico más probable es:

A) Acné
B) Rosácea
C) Erisipela
D) Impétigo
E) Antrax

Respuesta D. Diagnóstico: Impétigo (opción D). Se ve en la foto: Las costras mielicéricas.. El SBOR secundario agrupa las causas no virales que pueden producir un síndrome bronquial obstructivo recurrente en lactantes y niños. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

2.01.1.012 Infecciones por HIV

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- VIH pediátrico: casi siempre transmisión vertical (embarazo, parto, lactancia). Sospechar si infecciones recurrentes o graves, candidiasis oral persistente, retraso del crecimiento, parotiditis crónica, adenopatías y hepatoesplenomegalia.
- Diagnóstico en <18 meses: PCR-ADN/carga viral (los anticuerpos maternos persisten); en >18 meses ELISA confirmado en ISP.
- Prevención de la transmisión vertical (GES): tamizaje en embarazo, TARV materna, zidovudina intraparto, cesárea si carga viral detectable, profilaxis al RN y suspensión de lactancia materna.
- Tratamiento inicial: notificar, apoyo nutricional, profilaxis con cotrimoxazol según CD4/edad; no usar vacunas vivas (BCG) en inmunosupresión grave.
- Derivar a centro de atención VIH pediátrico para TARV (GES) y seguimiento con carga viral y CD4.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer con infección por VIH, con carga viral detectable al término del embarazo, tiene un parto por cesárea. El recién nacido de término está en buenas condiciones. **Respecto de la alimentación del recién nacido, ¿cuál es la indicación correcta?**

A) Lactancia materna exclusiva, porque los anticuerpos maternos protegen al niño
B) Suspender la lactancia materna y alimentar con fórmula láctea
C) Lactancia materna solo si la madre recibe terapia antirretroviral
D) Lactancia mixta durante los primeros 6 meses
E) Extraer y pasteurizar la leche en el hogar

Respuesta B. En Chile, la prevención de la transmisión vertical del VIH incluye terapia antirretroviral materna, cesárea según carga viral, profilaxis antirretroviral al recién nacido y suspensión de la lactancia materna, que se reemplaza por fórmula láctea entregada por el programa. La leche materna transmite el virus, por lo que la lactancia está contraindicada.

2.01.1.013 Infecciones por Salmonella

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 4.5 Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea

QUÉ HAY QUE SABER

- Salmonella no tífica: gastroenteritis con fiebre, diarrea (puede ser disentérica), dolor abdominal; asociada a huevos, aves y reptiles; autolimitada.
- Fiebre tifoidea (S. Typhi): fiebre prolongada escalonada, cefalea, dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, bradicardia relativa, roséola; leucopenia. Diagnóstico con hemocultivo (1ª semana), luego coprocultivo.
- Gastroenteritis por Salmonella no tífica: solo hidratación; antibióticos prolongan portación y se reservan para <3 meses, inmunodeprimidos, hemoglobinopatías o bacteriemia.
- Fiebre tifoidea: ceftriaxona 50-100 mg/kg/día EV o azitromicina; ciprofloxacino en adolescentes según susceptibilidad, 7-14 días.
- Complicaciones: perforación y hemorragia intestinal (3ª semana), osteomielitis por Salmonella en drepanocitosis, portación crónica vesicular.
- Notificación obligatoria de fiebre tifoidea; seguimiento con coprocultivos de control en manipuladores de alimentos y control clínico hasta la resolución.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 23

Niño con fiebre de 10 días de evolución, cefalea, mialgias, diarrea y luego deposiciones duras. Al examen físico se palpan el hígado y el bazo. **¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio?**

A) Coproparasitológico seriado
B) Coprocultivo
C) Serología para virus Epstein-Barr
D) Hemocultivo
E) Prueba de Widal

Respuesta D. Fiebre prolongada, cefalea, alteración del tránsito intestinal y hepatoesplenomegalia sugieren fiebre tifoidea (Salmonella Typhi). En la primera y segunda semana el examen de mayor rendimiento es el hemocultivo; el mielocultivo es el más sensible. El coprocultivo se positiviza más tarde y la reacción de Widal tiene baja sensibilidad y especificidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 137 · texto original del banco, sin revisar

Pediátrico, 2 días de dolor abdominal, diarrea líquida 10-15 episodios/día, 3 máculas que blanquean a la presión en abdomen, hepatomegalia, hemograma con Eosinofilos en 0, Anemia, coprocultivo negativo.

A) Salmonella tiphy
B) Campylobacter
C) Salmonella enteritidi
D) Shigella
E) E. Coli entero hemorrágica

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Salmonella tiphy). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Campylobacter, Salmonella enteritidi) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

2.01.1.014 Infecciones recurrentes

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Infecciones recurrentes: considerar normal hasta 6-8 IRA altas virales/año en lactantes que asisten a sala cuna; sospechar inmunodeficiencia si son graves, de localización inusual o por gérmenes oportunistas.
- Signos de alarma (Jeffrey Modell): ≥8 otitis/año, ≥2 sinusitis graves/año, ≥2 neumonías/año, ≥2 meses de antibióticos sin mejoría, abscesos profundos recurrentes, candidiasis persistente >1 año, necesidad de antibióticos EV, historia familiar.
- Descartar causas no inmunológicas: asma, rinitis alérgica, ERGE, hipertrofia adenoidea, tabaquismo pasivo, FQ, cardiopatía, cuerpo extraño, sala cuna.
- Estudio inicial: hemograma con recuento absoluto de linfocitos y neutrófilos, inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM, IgE y VIH.
- Neumonías recurrentes en el mismo lóbulo sugieren causa anatómica (cuerpo extraño, malformación); en distintos lóbulos, trastorno sistémico (FQ, aspiración, inmunodeficiencia).
- Seguimiento: derivar a inmunología pediátrica si hay signos de alarma o estudio alterado; no vacunas vivas si se sospecha inmunodeficiencia celular.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 2 años asiste a sala cuna desde los 12 meses. En el último año ha tenido 8 resfríos, 2 otitis medias agudas y 1 episodio de gastroenteritis, todos de evolución favorable y manejo ambulatorio. Su peso y talla progresan en percentil 50 y el examen físico es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar inmunoglobulinas séricas
B) Solicitar test de VIH y subpoblaciones linfocitarias
C) Tranquilizar a los padres: es un patrón esperable para su edad
D) Indicar profilaxis antibiótica
E) Derivar a inmunología

Respuesta C. Los niños que asisten a sala cuna pueden tener 6 a 10 infecciones respiratorias virales al año. Infecciones leves, de buena evolución, con crecimiento normal, no sugieren inmunodeficiencia. Las señales de alarma son infecciones graves, por gérmenes oportunistas, 2 o más neumonías al año, necesidad de antibióticos endovenosos, falla de crecimiento o antecedentes familiares.

2.01.1.015 Meningoencefalitis/ Meningitis bacteriana aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

QUÉ HAY QUE SABER

- Meningitis bacteriana: fiebre, cefalea, vómitos, compromiso de conciencia, rigidez de nuca, Kernig/Brudzinski; lactante: irritabilidad, rechazo alimentario, fontanela abombada, convulsiones.
- Agentes: RN estreptococo grupo B, E. coli, Listeria; >3 meses neumococo y meningococo (Hib raro por vacuna).
- Confirmar con punción lumbar: LCR turbio, >1.000 cél/mm³ con predominio PMN, glucosa baja (<40 o <0,4 de la glicemia), proteínas elevadas; Gram, cultivo y PCR. TC previa solo si focalidad, papiledema o shock.
- Si la PL se retrasa, no postergar antibiótico: hemocultivos y ceftriaxona 100 mg/kg/día EV (+ vancomicina 60 mg/kg/día por neumococo resistente); RN ampicilina + cefotaxima.
- Dexametasona 0,15 mg/kg c/6 h por 2-4 días, antes o con la primera dosis de antibiótico en >6 semanas (reduce hipoacusia por Hib/neumococo). Notificación inmediata y quimioprofilaxis a contactos en meningococo.
- Seguimiento: derivar/hospitalizar en UCI pediátrica; potenciales evocados auditivos al alta por riesgo de hipoacusia.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 157

Un niño de 8 años presenta un cuadro de cefalea y fiebre de 2 días de evolución, a lo que se agrega una conducta agresiva y luego desorientación. Convulsiona en varias oportunidades. Su TAC descarta hipertensión endocraneana, por lo que se realiza punción lumbar que da salida a líquido cefalorraquídeo con 100 glóbulos rojos por mm3, 20 glóbulos blancos por mm3, con 90% de mononucleares, proteínas: 80 mg/dl y glucosa: 60 mg/dl. **¿Cuál es el tratamiento inicial?**

A) Oseltamivir
B) Vancomicina
C) Ceftriaxona
D) Aciclovir
E) Ampicilina

Respuesta D. Conducta alterada, desorientación y convulsiones con LCR viral hemorrágico: encefalitis herpética. Se trata con aciclovir EV.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 22

Niño de 4 años, con antecedente de una convulsión febril hace 2 años, presenta fiebre y cefalea, seguidas de deterioro del estado general y compromiso de conciencia, y luego una convulsión. La punción lumbar muestra 300 glóbulos blancos por milímetro cúbico, 80% mononucleares, y 60 glóbulos rojos crenados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Encefalitis herpética
B) Hemorragia subaracnoidea
C) Meningitis bacteriana
D) Meningitis tuberculosa
E) Convulsión febril benigna

Respuesta A. El compromiso de conciencia persistente y el líquido cefalorraquídeo hemorrágico con pleocitosis mononuclear no corresponden a una convulsión febril simple: orientan a una encefalitis herpética, que suele afectar los lóbulos temporales.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 157

Un niño de 8 años presenta cefalea y fiebre de 2 días de evolución, a lo que se agrega conducta agresiva y luego desorientación. Convulsiona en varias oportunidades. Su TAC descarta hipertensión endocraneana, por lo que se realiza punción lumbar: LCR con 100 glóbulos rojos/mm3, 20 glóbulos blancos/mm3 (90% mononucleares), proteínas 80 mg/dL y glucosa 60 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento inicial?**

A) Oseltamivir
B) Vancomicina
C) Ceftriaxona
D) Aciclovir
E) Ampicilina

Respuesta D. Fiebre con alteración conductual, desorientación y convulsiones (compromiso del parénquima) más LCR con pleocitosis mononuclear, glucosa normal, proteínas elevadas y eritrocitos sugieren meningoencefalitis herpética. Debe iniciarse aciclovir endovenoso de inmediato, sin esperar la PCR para virus herpes simple, porque reduce marcadamente la mortalidad y las secuelas.

2.01.1.016 Mononucleosis infecciosa

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

QUÉ HAY QUE SABER

- Mononucleosis (VEB): adolescente con fiebre, faringoamigdalitis exudativa, adenopatías cervicales posteriores, esplenomegalia, edema palpebral y astenia marcada.
- Hemograma: linfocitosis >50% con >10% de linfocitos atípicos; transaminasas elevadas frecuentes.
- Confirmación: anticuerpos heterófilos (falsos negativos en <4 años) o IgM anti-cápside viral (VCA) para VEB.
- Tratamiento sintomático: paracetamol/AINE, hidratación, reposo; corticoides solo si obstrucción de vía aérea, anemia hemolítica o trombocitopenia grave. Amoxicilina produce exantema.
- Evitar deportes de contacto 3-4 semanas por riesgo de rotura esplénica; dolor abdominal izquierdo súbito es urgencia.
- Seguimiento: control clínico hasta resolución; la fatiga puede durar semanas. Diferencial: CMV, toxoplasmosis, VIH agudo, leucemia.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 122

Un niño de 3 años, con un cuadro de fiebre alta, asociada a malestar general y odinofagia intensa. Se inició tratamiento con amoxicilina, pero a las 48 horas presenta un exantema, que se muestra más abajo. Al examen físico, se aprecia decaído, con adenopatías cervicales anteriores dolorosas y amígdalas edematosas y eritematosas, con exudado blanco en su superficie. El exantema se muestra a continuación: **El diagnóstico más probable es:**

A) Escarlatina
B) Mononucleosis infecciosa
C) Alergia a la penicilina
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Sarampión

Respuesta B. Síndrome mononucleósico (fiebre, odinofagia, adenopatías, exudado amigdalino blanco) más exantema morbiliforme tras iniciar amoxicilina: mononucleosis infecciosa. No es una alergia verdadera a la penicilina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 129 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 7 años de edad presenta un cuadro de fiebre y odinofagia, asociado a malestar general. Al examen físico presenta faringe congestiva, con exudado amigdalino bilateral y se palpa adenopatía cervical, por lo que se inicia amoxicilina oral. Dos días después evoluciona con un exantema, que se muestra en la FOTO. El diagnóstico más probable es: NOTA: la foto original era de un niño, pero el exantema es muy similar a este (fue la foto más parecida que hallé en Google)

A) Escarlatina
B) Reacción alérgica a la amoxicilina
C) Eritema multiforme menor
D) Artritris reumatoide juvenil
E) Mononucleosis infecciosa

Respuesta E. Diagnóstico: Mononucleosis infecciosa (opción E). Tiene la clínica de mononucleosis clásica. El rash post-ampicilina es clásico también.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 86 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 11 años presenta fiebre de 10 días de evolución, asociado a astenia, cefalea, malestar general y odinofagia. Al examen físico tiene FC: 90x', T°: 37,9°C, faringe congestiva y se palpan adenopatías cervicales anteriores múltiples de 0,5 cm. En el examen abdominal, tanto el hígado como el bazo se palpan 2 cm por debajo del reborde costal. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Coprocultivo
B) Hemocultivos
C) Serología para Brucella
D) IgM para virus hepatitis A
E) Anticuerpos heterófilos

Respuesta A. Diagnóstico: Coprocultivo (opción A). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Hemocultivos, Serología para Brucella) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la present

2.01.1.017 Síndrome febril agudo sin foco

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 18.9 Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Fiebre sin foco: fiebre ≥38 °C de <7 días sin foco tras anamnesis y examen; el riesgo de infección bacteriana grave depende de la edad.
- <28 días: hospitalizar siempre, hemograma, PCR, hemocultivos, orina por sondeo con urocultivo y punción lumbar; ampicilina + cefotaxima (no ceftriaxona en RN).
- 29-90 días: criterios de Rochester (buen aspecto, previamente sano, sin foco, GB 5.000-15.000, baciliformes <1.500, orina ≤10 GB/campo). Todos presentes: bajo riesgo, ambulatorio con control en 24 h; falla uno: hospitalizar.

- 3-36 meses con buen estado: buscar ITU (causa oculta más frecuente) con orina completa y urocultivo por sondeo; si fiebre >39 °C sin vacunas completas considerar hemograma y PCR.
- Antipirético: paracetamol 10-15 mg/kg/dosis c/6 h; ibuprofeno 5-10 mg/kg c/8 h solo >6 meses. Mal aspecto a cualquier edad: hospitalizar y tratar.
- Seguimiento: control en 24-48 h y reconsulta si fiebre >5 días, decaimiento, petequias o rechazo alimentario.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 50 días de vida, con fiebre de 38,6 °C constatada en el hogar. Al examen se ve alerta, reactivo y sin foco infeccioso. El hemograma muestra 17.200 leucocitos/mm³ con 12% de baciliformes. El sedimento de orina es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Manejo ambulatorio con paracetamol y control en 24 horas
B) Hospitalizar, completar el estudio e iniciar antibióticos empíricos
C) Dar de alta porque el examen físico y la orina son normales
D) Iniciar amoxicilina oral ambulatoria y repetir el hemograma en 48 horas
E) Solicitar solo una radiografía de tórax antes de decidir

Respuesta B. El paciente tiene 50 días, el rango de Rochester, pero falla el criterio de laboratorio (leucocitos y baciliformes elevados), aunque el examen físico y la orina sean normales. Un solo criterio alterado saca al paciente del grupo de bajo riesgo: se hospitaliza, se completa el estudio (incluida la punción lumbar) y se inician antibióticos empíricos.

2.01.1.018 Síndrome febril prolongado

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

QUÉ HAY QUE SABER

- Fiebre prolongada: fiebre >38 °C por más de 7-10 días (pediatría) sin causa aparente tras evaluación inicial.
- Causas: infecciosas las más frecuentes (VEB, CMV, Bartonella, ITU, TBC, osteomielitis, abscesos), luego reumatológicas (AIJ sistémica, LES, Kawasaki) y neoplásicas (leucemia, linfoma).
- Estudio inicial: hemograma con frotis, VHS, PCR, orina completa y urocultivo, hemocultivos, transaminasas, Rx tórax, serologías (VEB, CMV, Bartonella), PPD/IGRA.
- No dar antibióticos empíricos en niño estable sin diagnóstico: enmascaran la causa.
- Banderas rojas: baja de peso, sudoración nocturna, dolor óseo, citopenias, hepatoesplenomegalia, adenopatías duras: derivar con urgencia a hematooncología.
- Seguimiento: hospitalizar o derivar a infectología/reumatología pediátrica para estudio dirigido; registrar curva febril.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 153

Un niño de 5 años presenta fiebre desde hace 7 días, que ha respondido parcialmente al uso de antipiréticos. Al examen físico se palpa una adenopatía cervical de 1,5 cm y en el examen abdominal se palpa esplenomegalia. Se solicita ecografía abdominal, que muestra múltiples lesiones hipoecogénicas de pequeño tamaño en hígado y bazo, compatibles con microabscesos, sin pared visible. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Citomegalovirus
B) Virus de Epstein-Barr
C) Bartonella henselae
D) Echinococcus granulosus
E) Mycobacterium tuberculosis

Respuesta C. Fiebre prolongada con adenopatía regional y lesiones hipoecogénicas hepatoesplénicas (microabscesos o granulomas) es la forma hepatoesplénica de la enfermedad por arañazo de gato, causada por Bartonella henselae; es una causa importante de síndrome febril prolongado en niños. Se confirma con serología IgM/IgG. Epstein-Barr y citomegalovirus dan esplenomegalia difusa, no lesiones focales.

2.01.1.019 Asma bronquial

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Asma: sibilancias, tos nocturna o con ejercicio, disnea recurrente reversible, atopía personal/familiar. En >5-6 años confirmar con espirometría: obstrucción reversible con aumento VEF1 ≥12% post broncodilatador.
- Clasificar control (GINA): síntomas diurnos, despertares nocturnos, uso de rescate >2 veces/semana, limitación de actividad. Asma en <15 años es GES.
- Tratamiento de mantención: corticoide inhalado en dosis baja (budesonida 200 µg/día o fluticasona 100 µg/día) con aerocámara; escalar a dosis media o agregar LABA (>6 años) o montelukast.
- Rescate: salbutamol 2-4 puff (100 µg/puff) con aerocámara c/20 min por 3 veces en crisis; crisis moderada-grave: prednisona 1-2 mg/kg/día por 3-5 días.
- Educación: técnica inhalatoria, plan de acción escrito, evitar tabaco y alérgenos, vacuna influenza anual.
- Seguimiento: control cada 3 meses en APS (programa IRA); ajustar escalón según control; derivar si asma grave o mal controlada pese a tratamiento adecuado.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 8 años con asma usa salbutamol inhalado a demanda. En el último mes ha tenido síntomas diurnos 4 días por semana, despertares nocturnos por tos 2 veces por semana y limitación para hacer deporte. Su técnica inhalatoria con aerocámara es correcta. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Mantener salbutamol a demanda
B) Iniciar corticoide inhalado en dosis baja de mantención
C) Iniciar prednisona oral por 5 días
D) Iniciar montelukast como monoterapia de primera línea
E) Iniciar teofilina oral

Respuesta B. Un asma no controlada (síntomas más de 2 veces por semana, despertares nocturnos, limitación de actividad) requiere tratamiento de mantención. De acuerdo con la guía GES de asma en menores de 15 años y GINA, el pilar es el corticoide inhalado en dosis baja (ej. budesonida o fluticasona) con aerocámara, más salbutamol de rescate.

2.01.1.020 Bronquiolitis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 18.5 Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Bronquiolitis: primer episodio de obstrucción bronquial en <1-2 años tras pródromo catarral; VRS el principal agente (invierno). Taquipnea, retracción, sibilancias y crépitos difusos.
- Diagnóstico clínico; Rx de tórax solo si duda o gravedad (hiperinsuflación, atelectasias). Panel viral para cohortear en hospitalizados.
- Tratamiento de soporte: aseo nasal, fraccionar alimentación, O2 si saturación <93%; hidratación. Sin evidencia para broncodilatadores, corticoides ni antibióticos de rutina.
- Factores de riesgo de gravedad: <3 meses, prematurez, cardiopatía congénita, displasia broncopulmonar, inmunodeficiencia. Apneas en RN y prematuros.
- Hospitalizar si saturación <93% con aire ambiente, apneas, dificultad respiratoria importante, rechazo alimentario o deshidratación.
- Prevención: nirsevimab al RN y lactantes en su primera temporada de VRS (campaña MINSAL). Seguimiento: control en 24-48 h en APS con score de Tal.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 72

Un lactante de 5 meses presenta un cuadro de tos y coriza, asociado a fiebre hasta 38,5°C. Al día siguiente evoluciona con dificultad respiratoria, taquipnea, retracción subcostal. Al examen físico tiene FR 70x', uso de musculatura accesoria, sibilancias inspiratorias y espiratorias difusas e intensas, más cianosis perioral. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Virus respiratorio sincicial
B) Bordetella pertussis
C) Virus influenza
D) Virus parainfluenza
E) Neumococo

Respuesta A. Bronquiolitis clásica del lactante, cuyo agente etiológico principal es el virus respiratorio sincicial.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 158

Un lactante de 8 meses presenta fiebre y rinorrea de 48 horas de evolución, con dificultad respiratoria en las últimas horas. Al examen físico presenta retracción subcostal e intercostal moderada, FC 120x', FR 35x', saturación de oxígeno del 93%. En el examen pulmonar se auscultan sibilancias y crépitos bilaterales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Bronquiolitis
B) Asma del lactante
C) Neumonía multifocal
D) Neumonía atípica
E) Cardiopatía congénita

Respuesta A. Cuadro catarral seguido de dificultad respiratoria con sibilancias en un lactante: caso clásico de bronquiolitis, definida como el primer episodio de síndrome bronquial obstructivo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 148

Un lactante de 5 meses de edad es llevado a urgencias, por presentar un cuadro de obstrucción bronquial. Al examen físico presenta taquipnea importante, satura 90%, tiene retracción intercostal, cianosis perioral y sibilancias bilaterales intensas. **¿Cuál es la primera medida que se debe tomar?**

A) Nebulizaciones con salbutamol
B) Nebulizaciones con budesonida
C) Dar corticoides orales
D) Dar oxígeno por mascarilla
E) Administrar corticoides endovenosos

Respuesta D. Ante hipoxemia en un lactante grave, la medida más urgente es corregir la oxigenación; el oxígeno es la intervención con mayor evidencia de beneficio en la bronquiolitis, más que broncodilatadores o corticoides.

2.01.1.021 Enfermedad pulmonar crónica

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.18 Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad pulmonar crónica pediátrica: síntomas respiratorios persistentes >3 meses o recurrentes (tos húmeda crónica, sibilancias, neumonías a repetición) con compromiso del crecimiento.
- Causas: displasia broncopulmonar (prematuro con O2 a las 36 semanas corregidas), fibrosis quística, bronquiectasias, aspiración crónica, discinesia ciliar, bronquiolitis obliterante post adenovirus.
- Sospechar: hipocratismo digital, deformidad torácica, crépitos persistentes, desnutrición, hipoxemia crónica.
- Estudio inicial: Rx de tórax, saturometría, test del sudor, evaluación nutricional; TC de tórax por especialista.
- Manejo inicial: oxigenoterapia si saturación <93%, kinesioterapia respiratoria, apoyo nutricional, vacunas al día (influenza, neumococo) y nirsevimab/palivizumab en displásicos.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar infantil; programa de oxígeno domiciliario (POD) cuando corresponde.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un recién nacido de 26 semanas de edad gestacional y 850 g recibió surfactante y ventilación mecánica por enfermedad de membrana hialina. Al llegar a las 36 semanas de edad gestacional corregida aún requiere oxígeno suplementario para mantener saturaciones adecuadas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Taquipnea transitoria del recién nacido
B) Síndrome de aspiración meconial
C) Displasia broncopulmonar
D) Hipertensión pulmonar persistente aislada
E) Fibrosis quística

Respuesta C. La displasia broncopulmonar es la enfermedad pulmonar crónica del prematuro: requerimiento de oxígeno a las 36 semanas de edad corregida en un prematuro menor de 32 semanas, tras ventilación mecánica u oxígeno. Se asocia a prematurez extrema, barotrauma, toxicidad por oxígeno e infección.

2.01.1.022 Estridor

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.6 Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona

QUÉ HAY QUE SABER

- Estridor: ruido inspiratorio por obstrucción de vía aérea extratorácica (laringe, tráquea alta); bifásico si es subglótico o traqueal.
- Agudo con fiebre y tos perruna: laringitis (lo más frecuente). Agudo sin fiebre y súbito: cuerpo extraño. Toxicidad, babeo, posición trípode: epiglotitis o traqueítis bacteriana.
- Crónico desde el nacimiento: laringomalacia (lo más frecuente, aumenta en decúbito supino y con llanto, mejora al año), parálisis de cuerdas vocales, estenosis subglótica, hemangioma subglótico.
- Tratamiento: laringitis con dexametasona 0,15-0,6 mg/kg VO/IM y nebulización con adrenalina si estridor en reposo; sospecha de epiglotitis: no examinar faringe, O2, vía aérea por experto y ceftriaxona.
- Signos de gravedad: estridor en reposo, retracción, cianosis, compromiso de conciencia, saturación baja.
- Seguimiento: derivar a otorrinolaringología/broncopulmonar para nasofibroscopía si estridor persistente, recurrente o con mal incremento ponderal.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 2 meses, traído porque desde las 2 semanas de vida tiene un ruido inspiratorio agudo que aumenta con el llanto, al alimentarse y en decúbito supino, y disminuye en decúbito prono. Afebril, sin coriza, sin tos ni disfonía. Buen incremento de peso y saturación de 98%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Laringomalacia congénita
B) Laringitis aguda obstructiva
C) Cuerpo extraño en la vía aérea
D) Epiglotitis
E) Absceso retrofaríngeo

Respuesta A. Estridor inspiratorio desde las primeras semanas, que empeora con el llanto, la alimentación y el decúbito supino, sin fiebre ni cuadro catarral y con buen crecimiento, es típico de laringomalacia: la causa más frecuente de estridor crónico del lactante, benigna y que suele resolverse sola.

2.01.1.023 Faringoamigdalitis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.13 Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Faringoamigdalitis estreptocócica: 5-15 años, fiebre, odinofagia, exudado, adenopatías cervicales anteriores dolorosas, petequias en paladar, sin tos ni coriza.
- <3 años y presencia de tos, rinorrea, conjuntivitis o aftas: etiología viral (adenovirus, coxsackie/herpangina, VEB).
- Test rápido o cultivo faríngeo si hay dudas; criterios de Centor/McIsaac orientan.
- Tratamiento: penicilina benzatina 600.000 UI IM (<27 kg) o 1.200.000 UI (≥27 kg) dosis única, o amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días; alergia: azitromicina 12 mg/kg/día por 5 días.
- Complicaciones: absceso periamigdalino, fiebre reumática, glomerulonefritis postestreptocócica, PANDAS.
- Seguimiento: no requiere control si buena evolución; reconsultar si fiebre >48 h con tratamiento, trismus o dificultad para tragar.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 75

Un niño de 2 años y 6 meses presenta fiebre, hasta 39°C, asociado a irritabilidad, odinofagia y malestar general. En su examen físico destacan adenopatías cervicales bilaterales y faringe eritematosa y congestiva, con abundante exudado amigdalino bilateral. La auscultación pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Amigdalitis estreptocócica
B) Mononucleosis infecciosa
C) Influenza
D) Infección por Streptococcus pneumoniae
E) Infección por adenovirus

Respuesta E. En un niño menor de 3 años la causa más probable de una faringitis con exudado es viral, por adenovirus. La faringitis estreptocócica es extraordinariamente rara a esa edad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 131

Un paciente de 8 años presenta un cuadro de odinofagia de un día de evolución, intenso, asociado a fiebre. Al examen físico tiene faringe congestiva, con exudado amigdalino bilateral y presencia de una adenopatía cervical. Su hermano menor está en tratamiento por escarlatina confirmada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar amoxicilina oral
B) Solicitar test pack para estreptococo
C) Solicitar cultivo faríngeo
D) Solicitar IgM para virus Ebstein Baar
E) Indicar tratamiento sintomatico

Respuesta A. Niño en edad escolar con fiebre, exudado y adenopatía, y contacto familiar con escarlatina confirmada: la probabilidad de estreptococo es alta y se inicia amoxicilina empírica.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 143

Un paciente de 8 años consulta por fiebre alta, asociada a odinofagia intensa. En su examen físico se aprecia faringe eritematosa, asociada a exudado bilateral. Se solicita una prueba rápida de detección de antígenos estreptocócicos, la que resulta positiva. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Amoxicilina
B) Amoxicilina + ácido clavulánico
C) Azitromicina
D) Clindamicina
E) Metronidazol

Respuesta A. Test rápido positivo para estreptococo del grupo A: el tratamiento de elección es amoxicilina por 10 días. El estreptococo es 100% sensible a la penicilina, por lo que no se necesita clavulánico ni macrólidos, que quedan para la alergia a penicilina.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 110 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 18 meses presenta dolor de garganta y fiebre de 2 días de evolución de hasta 39,0°C, asociado a irritabilidad, malestar general y secreción conjuntival bilateral. Al examen físico, además, se observa faringe eritematosa exudado amigdalino bilateral y se palpan adenopatías cervicales anteriores. El agente etiológico más probable es:

A) Staphilococcus aureus
B) Streptococcus pyogenes
C) Metaneumovirus
D) Adenovirus
E) Virus de Ebstein Baar

Respuesta D. La clásica amigdalitis exudativa en el menor de 3 años es por ADV. Suele tener fiebre alta y, en este caso, además, viene con la clásica fiebre faringoconjuntival por ADV. Si no hubiese tenido afectación ocular igual sería por ADV, así que a aprender este caso clínico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 107 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 8 años presenta odinofagia intensa, de dos días de evolución, con escasa congestión nasal. Al examen físico se observan amígdalas edematosas y aumentadas de volumen, con exudado blanquecino en los surcos, adenopatías cervicales dolorosas y fiebre: 39°C. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar amoxicilina
B) Solicitar TAC de cuello
C) Iniciar cetriaxona
D) Iniciar tratamiento sintomático
E) Solicitar prueba rápida de detección de Streptococcus pyogenes

Respuesta A. Orienta a etiología bacteriana: 1. el dolor intenso, 2. el exudado característico, 3. las adenopatías, 4. la fiebre alta, 5. la edad (3 a 15 años) y la ausencia de sintomatología catarral. La congestión nasal suele orientar más a etiología viral, pero se describe como "escasa". Con ello, cumple 4 o 5 criterios para iniciar antibióticos (amoxicilina de elección). Con 0 o 1, se asume viral; con 2 o

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 107 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 2 años consulta por odinofagia de 2 días de evolución, asociada a fiebre de 38,1 °C. En su examen Fsico presenta amígdalas eritematosas y aumentadas de tamaño, con exudado bilateral de aspecto purulento, y se palpan adenopa`as cervicales pequeñas bilaterales. Su examen cardiopulmonar es normal. Se solicita prueba de detección de estreptococo beta hemolí8co del grupo A, que resulta posi8va. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Azitromicina
B) Amoxicilina
C) Claritromicina
D) Amoxicilina + ácido clavulánico
E) Penicilina sódica

Respuesta B. Si bien es rara la amigdaliGs bacteriana en menores de 3 años, en este caso Gene 3 criterios de Centor (fiebre, exudado y adenopaVas), por lo que es correcto haberle pedido las pruebas de detección de SGA. Al estar positivas, se obliga al tratamiento antibiótico. De elección se usa la amoxicilina sola. El SGA no desarrolla betalactamasas, por lo que no es necesario el ácido clavulánico. La penicili

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 144 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 10 meses, presenta fiebre de 4 días de evolución, de hasta 39,1°C, asociado a irritabilidad y malestar general. Al examen físico tiene secreción conjuntival bilateral, adenopatías cervicales anteriores y amígdalas con exudado blanquecino bilateral. El agente etiológico más probable es:

A) Streptococcus pneumoniae
B) Streptococcus pyogenes
C) Staphilococcus aureus
D) Adenovirus
E) Citomegalovirus

Respuesta D. Es la clásica infección por ADV, en este caso con una fiebre faringoconjuntival. Es importante hacer notar que es la causa más frecuente de amigdalitis exudativa en el menor de 3 años, así que, incluso si no hubiese tenido una conjuntivitis, seguiría siendo una infección por ADV.

2.01.1.024 Infecciones respiratorias agudas bajas y sus complicaciones

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 18.7 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- IRA baja: neumonía adquirida en la comunidad (NAC) con fiebre, tos, taquipnea según edad (<2 m >60; 2-12 m >50; 1-5 años >40 rpm), retracción y crépitos.
- Agentes: virus en <2 años (VRS); neumococo la principal bacteria a toda edad; Mycoplasma y Chlamydophila en escolares (tos persistente, cefalea, infiltrado intersticial).
- Rx tórax confirma y detecta complicaciones: derrame pleural, empiema, neumonía necrotizante, absceso, neumotórax.
- NAC bacteriana ambulatoria: amoxicilina 80-100 mg/kg/día c/8-12 h por 7-10 días; atípica (>5 años): azitromicina 10 mg/kg/día por 5 días o claritromicina.
- Hospitalizar si <3 meses, saturación <93%, dificultad respiratoria grave, apneas, rechazo alimentario, complicación o mal estado general (ampicilina o ceftriaxona EV); derrame: toracocentesis y drenaje si empiema.
- Seguimiento: control a las 48-72 h en APS (programa IRA); Rx de control solo si evolución tórpida o neumonía complicada.

PREGUNTAS (10)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 45

Un niño de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 39,5°C, asociada a tos con expectoración mucopurulenta, de 2 días de evolución. Además refiere cefalea y marcado malestar general. Al examen físico está decaído, febril, con FC 100x', examen pulmonar con crepitaciones localizadas en la zona superior. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Mycoplasma pneumoniae
B) Chlamydia pneumoniae
C) Streptococcus pneumoniae
D) Haemophilus influenzae
E) Staphylococcus aureus

Respuesta C. Cuadro agudo, fiebre alta, crépitos localizados en un niño de 4 años: neumonía típica bacteriana, cuyo agente clásico es Streptococcus pneumoniae.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 15

Niña escolar con tos seca, crepitaciones bilaterales e infiltrados intersticiales en la radiografía de tórax. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Streptococcus pneumoniae
B) Mycoplasma pneumoniae
C) Virus sincicial respiratorio
D) Haemophilus influenzae
E) Chlamydia trachomatis

Respuesta B. Escolar con tos seca prolongada e infiltrado intersticial bilateral: cuadro típico de neumonía atípica, cuyo agente clásico en esta edad es Mycoplasma pneumoniae.

Pregunta de práctica

Lactante de 9 meses, previamente sano, con 2 días de fiebre hasta 38,9°C y tos. Al examen: FR 52 rpm, saturación 96% ambiental, buen estado general, crépitos localizados en la base pulmonar derecha. Tolera bien la alimentación. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?**

A) Amoxicilina oral 80 a 90 mg/kg/día por 7 días
B) Azitromicina oral por 5 días
C) Ampicilina endovenosa en hospitalización
D) Amoxicilina con ácido clavulánico
E) Solo control ambulatorio, sin antibiótico

Respuesta A. Lactante de 9 meses con neumonía típica sin criterios de hospitalización: amoxicilina oral en dosis alta por 7 días es la primera línea.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 8 · texto original del banco, sin revisar

Un recién nacido de 2 meses de edad, presenta un cuadro de tos con expectoración, asociado a taquipnea. Al examen físico, tiene T°: 38,5°C, frecuencia cardíaca de 100 x' y frecuencia respiratoria de 30 por minuto, saturando 91% a FiO2 ambiental. Su examen pulmonar solo muestra crepitaciones bilaterales. Como antecedentes, nació por parto vaginal y sufrió una conjuntivitis neonatal con secreción serosa a los 15 días de vida, la que fue tratada exitosamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cardiopatía congénita
B) Infección por estreptococo grupo B
C) Fibrosis quística
D) Infección por Streptoccus pneumoniae
E) Infección por Chlamydia trachomatis

Respuesta B. Diagnóstico: Infección por estreptococo grupo B (opción B). Positiva (parto progresa) → continuar vía vaginal. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 157 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 7 años, con historia de 8 días de tos y coriza, sin otros síntomas, presenta desde hace 24 horas aumento de su tos asociado a expectoración mucopurulenta, dificultad respiratoria y sensación febril. Al examen físico se encuentra decaído, con temperatura de 38ºC, su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente de forma bilateral, asociado a estertores y sibilancias difusas. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Claritromicina
B) Amoxicilina
C) Amoxicilina con ácido clavulánico
D) Acetaminofeno y salbutamol
E) Cefadroxilo

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Claritromicina (opción A). Es una NAC atípica. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 43 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 8 años presenta, desde hace dos semanas de odinofagia, rinorrea y tos, a lo que se le ha agregado disnea progresiva y fiebre hasta 38,5°C. Hace dos días se agrega un exantema eritematoso polimorfo. Al examen físico destacan crepitaciones y sibilancias bilaterales, difusas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Amoxicilina
B) Amoxicilina más ácido clavulánico
C) Claritromicina
D) Oseltamivir
E) Aciclovir

Respuesta C. Tiene una neumonía atípica por Mycoplasma pneumoniae. Recordar que puede hacer un exantema eritematoso o un eritema multiforme menor (más frecuentemente el EMM se produce por infección por herpes o por medicamentos).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 108 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 7 años presenta un cuadro de 4 días de evolución con fiebre alta, tos con expectoración mucopurulenta, a lo que se agregó dolor torácico con la inspiración profunda y, recientemente, también dolor abdominal y deposiciones diarreicas. Al examen físico, está febril con T°: 38,8°C, con frecuencia cardíaca: 110x' y, en su examen cardiopulmonar se ausculta murmullo pulmonar disminuido bilateralmente, abolido en la base derecha, con crépitos en esa zona. El examen abdominal muestra dolor difuso a la palpación profunda, sin signos peritoneales y se ausculta aumento de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál de los siguientes es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Ecografía abdominal
B) Videotoracoscopía
C) Radiografía de tórax lateral en decúbito lateral
D) TAC de tórax
E) Radiografía de tórax anteroposterior y lateral

Respuesta E. Neumonía y Dolor Abdominal: El paciente presenta un cuadro clínico de neumonía clásica. Es importante tener en cuenta que la neumonía puede manifestarse con dolor abdominal y otros síntomas abdominales. Por lo tanto, el examen inicial a realizar es una radiografía de tórax anteroposterior y lateral.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 157 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 7 años presenta rinorrea y tos de 9 días de evolución, que han aumentado y se asociaron a disnea, progresiva y fiebre hasta 38,2°C. Al examen físico presenta T°C: 37,5°C, frecuencia respiratoria de 30 por minuto, murmullo pulmonar bilateral, simétrico, algo diminuido, con sibilancias y crepitaciones bilaterales. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Mycoplasma pneumoniae
B) Streptococcus pyogenes
C) Bordetella pertusis
D) Virus parainfluenza
E) Virus respiratorio sincicial

Respuesta A. Es una neumonía atípica, que suelen ser causadas por mycoplasma y son muy frecuentes en la edad escolar.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 16 · texto original del banco, sin revisar

Niño de 2 meses con conjuntivitis a los 12 días, luego tos seca, crepitaciones y sibilancias. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Streptococcus pneumoniae
B) Mycoplasma pneumoniae
C) Virus sincicial respiratorio
D) Ureaplasma urealyticum
E) Chlamydia trachomatis

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Chlamydia trachomatis). Chlamydia trachomatis. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan c

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 19 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 7 años presenta un cuadro de 9 días de tos disfónica, a lo que, en los últimos días, se agrega astenia, malestar general, dificultad respiratoria y fiebre hasta 38,5°C. Al examen físico está en buenas condiciones, con frecuencia cardíaca: 90x', saturación arterial 95% y T°:38°C. Tiene faringe eritematosa, sin exudado. Al examen pulmonar, se auscultan sibilancias y crepitaciones bilaterales. Se solicita una radiografía, que muestra múltiples infiltrados pulmonares bilaterales, con atelectasias lineales en las bases. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Adenovirus
B) Virus parainfluenza
C) Mycoplasma pneumoniae
D) Streptococcus pneumoniae
E) Bordetella pertusis

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Mycoplasma pneumoniae). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Adenovirus, Virus parainfluenza) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

2.01.1.025 Laringitis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.17 Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia · Tema 18.6 Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona

QUÉ HAY QUE SABER

- Laringitis aguda obstructiva (crup): 6 meses-3 años, parainfluenza; tos perruna, disfonía, estridor inspiratorio, inicio nocturno, fiebre baja.
- Graduación (Downes/Westley): I disfonía y estridor con llanto; II estridor en reposo y retracción; III agitación, palidez, retracción intensa; IV cianosis, compromiso de conciencia.
- Tratamiento: dexametasona 0,15-0,6 mg/kg VO o IM dosis única en todos los grados (o budesonida nebulizada 2 mg).
- Grado ≥II: nebulización con adrenalina racémica 0,05 ml/kg o adrenalina corriente 1:1.000 0,5 ml/kg (máx 5 ml); observar 2-4 h por efecto rebote.
- Hospitalizar si grado III-IV, estridor persistente en reposo tras tratamiento, <6 meses o recurrencia; diferencial con epiglotitis, cuerpo extraño y traqueítis bacteriana.
- Seguimiento: control en 24 h; laringitis recurrente o en <6 meses: derivar a otorrino para descartar anomalía de vía aérea.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 133

Un lactante de 12 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea y fiebre hasta 38,8°C de 24 horas de evolución, a lo que hoy se agregó dificultad respiratoria. Al examen físico presenta estridor inspiratorio, que aumenta con el llanto, asociado a retracción intercostal moderada. Su saturación de oxígeno es 94% y, al examen pulmonar se ausculta murmullo pulmonar conservado bilateral con transmisión de ruidos desde la vía aérea superior. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Laringitis aguda obstructiva
B) Neumonía atípica
C) Neumonía bilateral
D) Asma del lactante
E) Neumonitis viral

Respuesta A. Es una laringitis aguda obstructiva clásica: un cuadro gripal seguido de síntomas obstructivos, con estridor laríngeo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 158

Una niña de 3 años, previamente sana, presenta un cuadro de 2 días de evolución de rinorrea, asociada a fiebre de 39°C, con tos disfónica, a la que se agrega dificultad respiratoria hace una hora. Al examen físico, su frecuencia respiratoria es 48 por minuto, se escucha estridor inspiratorio y espiratorio y se objetiva retracción subcostal y supraesternal. **La conducta inicial más adecuada es:**

A) Administrar adrenalina subcutánea
B) Realizar nebulizaciones con salbutamol al 0,5%
C) Realizar intubación orotraqueal
D) Realizar nebulizaciones con bromuro de ipatropio al 0,5%
E) Realizar nebulizaciones con adrenalina racémica al 0,1%

Respuesta E. La laringitis obstructiva se trata con oxígeno, adrenalina racémica en nebulización y corticoides sistémicos, en ese orden de administración.

Pregunta de práctica

Un lactante de 14 meses llega a urgencia a las 2:00 AM con tos ronca perruna de inicio brusco y dificultad respiratoria. Tuvo congestión nasal leve 2 días. Está tranquilo en brazos de su madre, afebril. En reposo se ausculta estridor inspiratorio continuo, con retracción supraesternal e intercostal moderada. FR 38 por minuto, saturación 96% ambiental, murmullo pulmonar simétrico. Recibió dexametasona oral y adrenalina nebulizada, y a los 30 minutos está sin estridor. **¿Cuál es la conducta más adecuada ahora?**

A) Alta inmediata, porque ya no tiene estridor
B) Observación en urgencia por 2 a 4 horas y alta si no reaparece el estridor en reposo
C) Agregar amoxicilina oral por 7 días
D) Intubación orotraqueal profiláctica
E) Repetir la dexametasona cada 6 horas por 3 días

Respuesta B. Es un croup grado II de Taussig. La adrenalina alivia rápido, pero su efecto dura unas 2 horas y puede haber rebote, por lo que se observa 2 a 4 horas. La dexametasona es de dosis única. No hay indicación de antibiótico en un croup viral.

Pregunta de práctica

Niño de 2 años, con 2 días de coriza, presenta esta noche disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio audible en reposo. Tiraje subcostal leve. Afebril, sin sialorrea. Buen estado general entre los episodios de tos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Dexametasona oral en dosis única, con observación breve
B) Solo observación, sin fármacos, porque está afebril
C) Adrenalina racémica nebulizada y hospitalización directa
D) Amoxicilina oral por sospecha de sobreinfección
E) Intubación orotraqueal preventiva

Respuesta A. Estridor en reposo con tiraje leve corresponde a grado II moderado. La dexametasona oral está indicada en todos los grados; la adrenalina se reserva para disnea más marcada, que este caso no presenta.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 139 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 18 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea, disfonía y fiebre, hasta 38,5°C. Hace una hora presenta un cuadro de dificultad respiratoria, con respiración ruidos

A) Al examen físico se aprecia niño taquipneico, con estridor inspiratorio, uso de musculatura accesoria, sin cianosis. La auscultación pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:
A) Laringitis aguda viral
B) Croup espasmódico
C) Cuerpo extraño bronquial
D) Laringomalacia

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (). Esta clase aborda la laringitis aguda y su variante obstructiva (crup viral). Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Al examen físico se aprecia niño taquipneico,, Laringitis aguda viral) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenc

2.01.1.026 Otitis media

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.1 Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- Otitis media aguda: otalgia, fiebre, irritabilidad; otoscopía con tímpano abombado, eritematoso, sin movilidad u otorrea. Agentes: neumococo, H. influenzae no tipificable, Moraxella.
- Tratamiento de elección: amoxicilina 80-90 mg/kg/día c/12 h, 10 días en <2 años y 5-7 días en ≥2 años con cuadro leve.
- Falla a 48-72 h o uso reciente de amoxicilina: amoxicilina-ácido clavulánico; alergia: macrólido o cefalosporina de 2ª generación; no tolera VO: ceftriaxona 50 mg/kg IM por 1-3 días.
- Observación sin antibiótico posible en >2 años con cuadro unilateral leve y control asegurado; analgesia con paracetamol o ibuprofeno siempre.
- Complicaciones: mastoiditis (retroauricular eritematoso, pabellón desplazado), parálisis facial, meningitis, absceso; hospitalizar y derivar.
- Seguimiento: control al terminar tratamiento; otitis media con efusión persistente >3 meses o hipoacusia: derivar a ORL.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 175

Un paciente de 3 años, sin antecedentes, con cuadro de rinofaringitis viral de dos días de evolución en tratamiento sintomático, es traído por presentar desde hace unas horas mayor compromiso del estado general, asociado a otalgia intensa izquierda y sensación febril. Al examen físico destaca examen cardiopulmonar normal y a la otoscopía se aprecia tímpano izquierdo eritematoso y abombado con escasa secreción purulenta. **El fármaco de elección en este caso es:**

A) Ibuprofeno oral
B) Amoxicilina oral
C) Amoxicilina con ácido clavulánico oral
D) Gentamicina tópica
E) Claritromicina oral

Respuesta B. Es una OMA: se parte con amoxicilina sola. El ácido clavulánico se agrega solo si no responde a las 72 horas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 13

Un niño de 3 años presenta un cuadro de 5 días de evolución de rinorrea, fiebre y odinofagia, al que, hace dos días se le agrega otalgia, por lo que se realiza otoscopía que muestra tímpano abombado y eritematoso. Se inicia amoxicilina 50 mg/kg al día, sin embargo, a las 48 horas no ha mostrado ningún tipo de mejoría. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar la dosis a 100 mg/Kg al día
B) Cambiar el tratamiento a azitromicina oral 10 mg/Kg al día
C) Agregar ácido clavulánico al tratamiento oral
D) Solicitar una TAC de peñasco
E) Iniciar ceftriaxona endovenosa

Respuesta C. Sin respuesta a las 48 a 72 horas se agrega ácido clavulánico, para cubrir Haemophilus y Moraxella productores de betalactamasas. Aquí la dosis inicial fue baja, por lo que la dosis recomendada sigue siendo 80 a 90 mg/kg/día.

2.01.1.027 Resfrío común

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.13 Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Resfrío común: rinorrea, obstrucción nasal, estornudos, odinofagia leve, fiebre baja; rinovirus el principal agente. Duración 7-10 días, autolimitado.
- Rinorrea purulenta no implica infección bacteriana; no requiere antibiótico.
- Manejo: aseo nasal con suero fisiológico, hidratación, paracetamol si fiebre; elevación de la cabecera.
- No usar antitusivos, mucolíticos ni descongestionantes en <6 años (riesgo de toxicidad); no usar aspirina.
- Complicaciones a vigilar: otitis media, sinusitis (síntomas >10 días o empeoramiento tras mejoría), neumonía, crisis obstructiva.
- Seguimiento: no requiere control; reconsultar si fiebre >3 días, dificultad respiratoria, otalgia o compromiso del estado general.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 147

Un niño de 3 años presenta congestión nasal, con rinorrea serosa, asociada a tos y ligera odinofagia. Al examen físico tiene temperatura de 37,3 °C, faringe congestiva rosada y rinorrea abundante. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Solución salina intranasal
B) Amoxicilina oral
C) Corticoides nasales
D) Diclofenaco oral
E) Azitromicina oral

Respuesta A. Rinorrea serosa, tos, odinofagia leve y temperatura normal corresponden a un resfrío común viral. El manejo es sintomático: aseo nasal con solución salina, hidratación y paracetamol si hay fiebre o molestias. Los antibióticos no acortan el cuadro ni previenen complicaciones, y los AINE como el diclofenaco no se recomiendan en preescolares para este fin.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 166 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 10 años, es traído por cuadro de 2 días de odinofagia, asociado a tos seca y rinorrea, que durante el primer día se asoció a sensación febril. Al examen físico se encuentra con temperatura de 36,8ºC, faringe eritematosa, amígdalas aumentadas de tamaño con escaso exudado blanquecino, examen cardiopulmonar normal. El diagnóstico más probable es:

A) Amigdalitis pultácea
B) Influenza
C) Rinofaringitis aguda
D) Coqueluche
E) Adenovirus

Respuesta C. Tiene una infección respiratoria alta, con signos virales: tos, rinorrea. Si bien tiene exudado (orienta a adenovirus), no hay mayores indicios que sea por adenovirus (si hubiese conjuntivitis viral sí sería adenovirus). Es seguro que hay una rinofaringitis viral

2.01.1.028 Síndrome bronquial obstructivo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 18.5 Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome bronquial obstructivo (SBO): sibilancias y espiración prolongada en <2-3 años, gatillado por virus; recurrente si ≥3 episodios.
- Evaluar gravedad con score de Tal (FR, sibilancias, cianosis, retracción): 0-5 leve, 6-8 moderado, 9-12 grave; y saturometría.
- Tratamiento: salbutamol 2 puff con aerocámara c/10 min por 5 veces (1 h); reevaluar con Tal. Si no mejora repetir 1 h más y agregar prednisona 1-2 mg/kg/día por 3-5 días.
- Hospitalizar si Tal ≥9, saturación <93% tras tratamiento, falla de 2 horas de manejo, apneas o cianosis.
- SBO recurrente: considerar asma del lactante (índice predictivo de asma), corticoide inhalado como mantención; descartar FQ, aspiración, cardiopatía o cuerpo extraño.
- Seguimiento: control en 24-48 h en sala IRA; derivar a broncopulmonar si SBO grave, recurrente sin respuesta o atípico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 18 meses, con 4 episodios de obstrucción bronquial con sibilancias en los últimos 12 meses, todos tratados con salbutamol y uno que requirió hospitalización. Entre los episodios está asintomático y con buen incremento ponderal. Hoy consulta en control, sin dificultad respiratoria. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Salbutamol inhalado diario de forma permanente
B) Amoxicilina profiláctica durante el invierno
C) Prednisona oral diaria por 3 meses
D) Corticoide inhalado de mantención con aerocámara y seguimiento
E) No requiere tratamiento, porque hoy está asintomático

Respuesta D. Tres o más episodios obstructivos en el año en un menor de 2 años definen un síndrome bronquial obstructivo recurrente. Con episodios frecuentes o severos se indica corticoide inhalado de mantención con aerocámara. El salbutamol es solo de rescate y el corticoide oral crónico no se usa.

2.01.1.029 Sinusitis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.10 Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Sinusitis aguda bacteriana: secreción nasal o tos diurna persistente >10 días sin mejoría, empeoramiento tras mejoría inicial, o inicio grave (fiebre ≥39 °C y rinorrea purulenta ≥3 días).
- Seno etmoidal y maxilar presentes desde el nacimiento; frontal se desarrolla a los 6-10 años. Diagnóstico clínico; Rx de senos no se recomienda de rutina.
- Tratamiento: amoxicilina 80-90 mg/kg/día c/12 h por 10-14 días (o 7 días tras resolución); falla o factores de riesgo: amoxicilina-ácido clavulánico.
- Medidas coadyuvantes: lavado nasal con suero; corticoide intranasal si rinitis alérgica asociada.
- Complicaciones: celulitis periorbitaria/orbitaria, meningitis, absceso cerebral, osteomielitis frontal (tumor de Pott): TC y hospitalizar.
- Seguimiento: control a las 72 h; sinusitis recurrente o crónica (>12 semanas): derivar a ORL y descartar rinitis alérgica, FQ, inmunodeficiencia.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 14

Niño con 10 días de congestión nasal y rinorrea, hace 2 días con fiebre y rinorrea mucopurulenta. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Amoxicilina por 10 días vía oral
B) Azitromicina por 5 días
C) Cotrimoxazol por 7 días
D) Tratamiento sintomático (suero fisiológico nasal)
E) Amoxicilina-clavulánico por 14 días

Respuesta A. Diez días de evolución con empeoramiento (fiebre y rinorrea mucopurulenta) cumple criterio de rinosinusitis bacteriana. La primera línea es amoxicilina oral por 7 a 10 días.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 59

Un niño de 8 años presenta un cuadro de 14 días de congestión nasal con rinorrea purulenta, cefalea, sensación febril, asociada a odinofagia y tos con expectoración mucopurulenta. En los últimos días se agrega mayor malestar general y fiebre. Al examen físico presenta rinorrea purulenta abundante, descarga posterior y faringe congestiva y eritematosa, con examen pulmonar normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar tratamiento sintomático con paracetamol
B) Iniciar claritromicina oral
C) Iniciar ceftriaxona endovenosa
D) Iniciar amoxicilina oral
E) Solicitar radiografía de tórax y baciloscopías

Respuesta D. Es una rinosinusitis aguda bacteriana, con 14 días de evolución y empeoramiento reciente. Se trata con amoxicilina oral. La tos con expectoración se explica por la descarga posterior y el examen pulmonar es normal.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 67 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 6 años, con antecedente de obstrucción nasal y rinorreas frecuentes, mayor en primavera, presenta un cuadro de 10 días de evolución caracterizado por rinorrea mucosa abundante, tos y picos subfebriles hasta 37,8 °C. Inicialmente tendió a mejorar, sin embargo, desde hace 4 días se produjo un aumento en la secreción nasal, la que en ocasiones tenía mal olor, y se agregó cefalea frontal. Al examen Fsico está en buenas condiciones, con temperatura: 36,5 °C, FC: 90x' y FR: 15x', se observa faringe eritematosa con descarga posterior y se constata dolor a la percusión de la zona frontal. El examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente y escasos roncus bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar radiogra:a de senos paranasales
B) Iniciar amoxicilina vía oral
C) Solicitar TAC de cavidades paranasales
D) Iniciar prednisona oral
E) Solicitar nasofibroscopía

Respuesta B. Tiene una sinusiGs aguda, con alta sospecha de infección bacteriana (por empeoramiento y Gempo de evolución). El diagnóstico es clínico y se trata con amoxicilina oral, como antibiótico de primera línea.

2.01.1.030 Adenopatías

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

QUÉ HAY QUE SABER

- Adenopatía: ganglio >1 cm (>1,5 cm inguinal, >0,5 cm epitroclear; cualquier supraclavicular es patológico). Generalizada si ≥2 regiones no contiguas.
- Causas frecuentes: reactivas virales, infección bacteriana local, VEB/CMV, toxoplasmosis, Bartonella, TBC; malignas: leucemia, linfoma, neuroblastoma.
- Banderas rojas: supraclavicular, >2-3 cm, dura, adherida, indolora, crecimiento progresivo, >4-6 semanas, síntomas B (fiebre, sudoración, baja de peso), hepatoesplenomegalia, citopenias.
- Estudio: hemograma con frotis, VHS, LDH, serologías (VEB, CMV, toxoplasma, Bartonella), PPD, Rx tórax (masa mediastínica) y ecografía ganglionar.
- Localizada con signos inflamatorios: tratar como adenitis (cefadroxilo) y controlar en 2 semanas; no usar corticoides antes de descartar linfoma/leucemia.
- Seguimiento: derivar a hematooncología/cirugía para biopsia si banderas rojas o sin regresión en 4-6 semanas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 18

Niño con adenopatías cervicales y granulomas hepatoesplénicos en la ecografía abdominal. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Bartonella henselae
B) Toxoplasma gondii
C) Virus Epstein-Barr
D) Mycobacterium tuberculosis
E) Leishmania sp.

Respuesta A. La asociación de adenopatías con granulomas o microabscesos hepatoesplénicos en un niño es característica de la enfermedad por arañazo de gato (Bartonella henselae), que suele seguir al contacto con gatos jóvenes. La toxoplasmosis y el Epstein-Barr causan adenopatías, pero no lesiones focales hepatoesplénicas; la tuberculosis miliar es mucho menos probable.

2.01.1.031 Anemia ferropriva

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 8.3 Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Anemia ferropriva: la más frecuente en pediatría, peak 6-24 meses y adolescencia. Hb <11 g/dL (6 m-5 años), <11,5 (5-11 años), <12 (12-14 años).
- Factores de riesgo: prematurez/bajo peso, leche de vaca antes del año, dieta pobre en hierro, pérdidas (parásitos, menstruación).
- Laboratorio: anemia microcítica hipocrómica (VCM bajo), ferritina baja (<12 ng/mL), ADE (RDW) alto, saturación de transferrina baja. Diferencial: talasemia (RDW normal, índice de Mentzer <13).
- Tratamiento: sulfato ferroso 3-6 mg/kg/día de hierro elemental en ayunas o lejos de las comidas, por 3-4 meses tras normalizar Hb (para reponer depósitos). Evitar leche y té con el hierro.
- Respuesta esperada: reticulocitosis a los 5-10 días y alza de Hb ≥1 g/dL en 4 semanas; si no responde, revisar adherencia, pérdidas o diagnóstico alternativo.
- Prevención: suplemento de hierro desde 4 meses en lactancia exclusiva (desde 2 meses en prematuros), fórmulas y cereales fortificados (PNAC). Seguimiento: hemograma a las 4 semanas y al terminar.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 106

Un niño de 4 años, con antecedente de ictericia neonatal, que requirió fototerapia, es traído a la urgencia por dolor abdominal y náuseas de 4 días de evolución. Al examen físico destaca ictericia de piel y mucosas, asociado a palidez y en el examen abdominal se objetiva esplenomegalia, con bazo por 3 cm bajo el reborde costal. Su hemograma muestra hematocrito de 20%, hemoglobina de 6,9 g/dl, VCM: 70 fl, 17% de reticulocitos, blancos: 8.000 por mm3 y plaquetas: 200.000 por mm3. El frotis sanguíneo muestra macrocitosis, poiquilocitosis y anisocitosis. En sus pruebas hepáticas destaca bilirrubina 6 mg/dl, con bilirrubina directa de 0,9 mg/dl. **El diagnóstico más probable:**

A) Anemia hemolítica
B) Leucemia aguda
C) Anemia ferropénica
D) Anemia por déficit de vitamina B12
E) Anemia de Fanconi

Respuesta A. Reticulocitos 17 % y bilirrubina de predominio indirecto: anemia hemolítica regenerativa. Blancos y plaquetas normales descartan leucemia. La ictericia neonatal y la esplenomegalia sugieren una hemolítica congénita, como la esferocitosis hereditaria.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 115

Un niño de 9 meses tiene palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita un hemograma, que muestra hemoglobina: 9 g/dl, hematocrito: 36%, VCM: 68 fl, glóbulos blancos: 6.500 por mm3, plaquetas: 450.000 por mm3. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Anemia ferropriva
B) Anemia por enfermedades crónicos
C) Trombocitosis esencial
D) Hemoglobinopatía
E) Microesferocitosis familiar

Respuesta A. Es una anemia ferropénica clásica, tanto por la edad como por la microcitosis. La hemoglobinopatía es posible, pero mucho menos frecuente; sin un recuento de glóbulos rojos alto, RDW normal y ferritina normal, no hay por qué pensar primero en ella.

2.01.1.032 Leucemias

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.16 Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

QUÉ HAY QUE SABER

- Leucemia: cáncer más frecuente en niños; LLA ~80% (peak 2-5 años). Sospechar ante palidez, fiebre, petequias/equimosis, dolor óseo (cojera nocturna), hepatoesplenomegalia y adenopatías.
- Hemograma: bicitopenia o pancitopenia, blastos en frotis; leucocitos pueden estar bajos, normales o muy altos.
- No dar corticoides antes del diagnóstico (alteran el mielograma). Diagnóstico definitivo con mielograma: >20-25% de blastos.
- Manejo inicial: hidratación, evaluar fiebre y neutropenia (antibióticos EV de amplio espectro), transfusión si sangrado o anemia sintomática; vigilar lisis tumoral (hiperkalemia, hiperuricemia, hiperfosfemia).
- Masa mediastínica (LLA T) puede comprimir vía aérea: Rx tórax antes de sedar.
- Cáncer infantil es GES: derivar con urgencia a centro PINDA de hematooncología; seguimiento por especialista.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 15

Un niño de 11 años presenta un cuadro de astenia y fiebre de algunas semanas de evolución. Al examen físico se aprecia palidez, asociado a esplenomegalia. **¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para continuar el estudio en este paciente?**

A) IgM para virus Ebstein Baar
B) Hemograma VHS
C) Biopsia ganglionar
D) IgM para Bartonella henselae
E) Tiempos de coagulación

Respuesta B. Fiebre, astenia, palidez y esplenomegalia de semanas en un niño: sospecha de leucemia aguda. El estudio se inicia con el hemograma con frotis, que busca citopenias y blastos; el mielograma viene después, para confirmar.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 27

Un niño de 8 años presenta dolores óseos generalizados, malestar general y fiebre de 3 semanas de evolución. Al examen físico se palpa el bazo aumentado de tamaño, se constatan poliadenopatías indoloras y se observan petequias y equimosis generalizadas, mayores en las extremidades inferiores. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

A) Cintigrafía ósea
B) Hemograma
C) Biopsia esplénica
D) Mielograma
E) Cuantificación de inmunoglobulinas

Respuesta D. Dolor óseo, fiebre, adenopatías, esplenomegalia y sangrado cutáneo en un escolar sugieren leucemia aguda, probablemente linfoblástica. El hemograma orienta (citopenias, blastos), pero la confirmación requiere estudio de médula ósea: mielograma (con inmunofenotipo y citogenética), que demuestra 20% o más de blastos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 85 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 9 meses de edad, estuvo alimentada con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, momento en que inició la alimentación sólida. Sin embargo, la madre, vegana estricta, consideró que la niña no toleraba bien los alimentos, por lo que la mantuvo con leche materna exclusiva hasta ahora. Evoluciona con detención del crecimiento, dificultades para sentarse y hablar, además de estar más hipoactiva de lo normal. Al examen físico, se aprecia pálida y letárgica, con signos vitales normales y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar ni abdominal. Se solicitan exámenes, que muestran hemoglobina: 7,9 g/dl, hematocrito: 24%, blancos: 3.700 por mm3, plaquetas: 45.000 por mm3, VHS: 12 mm/h, TSH: 1,2 UI/L, creatininemia: 0,5 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Déficit de vitamina B12
B) Anemia hemolítica
C) Enfermedad celíaca
D) Leucemia aguda
E) Fibrosis quística

Respuesta D. Diagnóstico: Leucemia aguda (opción D). :::note Dopamina inhibe la prolactina → antidopaminérgicos (antipsicóticos) pueden causar galactorrea incluso en no embarazadas. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 158 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 10 años es traído a la consulta por aparición de múltiples equimosis y petequias, desde hace 2 semanas, asociadas a palidez. Al examen físico se aprecia pálido, con petequias en las extremidades inferiores y el tronco y múltiples equimosis de gran tamaño en las extremidades inferiores. Además, se palpa hepatomegalia de 3 cm bajo el reborde costal. El diagnóstico más probable es:

A) Púrpura trombopénica inmune
B) Enfermedad de von Willebrand
C) Púrpura de Schönlein Henoch
D) Meningococcemia
E) Leucemia

Respuesta E. Es una leucemia clásica, con signos de insuficiencia medular (anemia y alteraciones de la hemostasia primaria) y hepatoesplenomegalia. Ninguna de las otras tiene anemia. La meningococcemia es muy agresiva, en cosa de horas o pocos días. La PSH tiene púrpura palpable, alteraciones digestivas, compromiso articular y GNA. la EvW es algo crónico con alteración de la hemostasia primaria. La PTI sí pued

2.01.1.033 Linfomas

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.18 Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

QUÉ HAY QUE SABER

- Linfoma de Hodgkin: adolescentes; adenopatía cervical o supraclavicular indolora, dura, de crecimiento lento, masa mediastínica, síntomas B, prurito.
- Linfoma no Hodgkin: niños menores, crecimiento rápido; Burkitt abdominal (masa, invaginación en >2 años), linfoblástico mediastínico con síndrome de vena cava superior.
- Estudio inicial: hemograma, VHS, LDH, ácido úrico, Rx tórax; biopsia excisional del ganglio confirma (Reed-Sternberg en Hodgkin).
- Urgencias: compresión de vía aérea o vena cava superior, lisis tumoral (hiperuricemia, hiperkalemia, IRA): hidratación y alopurinol/rasburicasa.
- No usar corticoides antes de la biopsia.
- Cáncer infantil es GES: derivar con urgencia a hematooncología pediátrica (PINDA); seguimiento por especialista.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un adolescente de 15 años consulta por una adenopatía supraclavicular izquierda indolora, de consistencia elástica, de 3 cm, que crece desde hace 6 semanas. Refiere sudoración nocturna y baja de 5 kg de peso. La radiografía de tórax muestra ensanchamiento mediastínico. **¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico?**

A) Punción aspirativa con aguja fina del ganglio
B) Mielograma
C) TAC de tórax, abdomen y pelvis
D) Serología para virus Epstein-Barr
E) Biopsia excisional del ganglio

Respuesta E. Adenopatía supraclavicular, síntomas B y masa mediastínica en un adolescente sugieren linfoma de Hodgkin. El diagnóstico requiere biopsia excisional del ganglio completo, que permite ver la arquitectura y las células de Reed-Sternberg. La punción con aguja fina no basta para clasificar un linfoma. El TAC y el PET sirven para etapificar, después de confirmar.

2.01.1.034 Neutropenia febril

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.5 Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

QUÉ HAY QUE SABER

- Neutropenia febril: T° ≥38,3 °C una vez o ≥38 °C por 1 h, con RAN <500/mm³ (o <1.000 con tendencia a caer), habitualmente post quimioterapia.
- Es urgencia: evaluación rápida, sin tacto rectal ni toma de temperatura rectal; buscar foco (catéter, piel, mucositis, perianal, pulmón).
- Estudio: hemograma, PCR, hemocultivos periférico y de catéter, orina completa y urocultivo, Rx tórax si síntomas.
- Antibiótico empírico EV en <1 h: cefalosporina antipseudomónica (cefepime o ceftazidima) o piperacilina-tazobactam; agregar vancomicina si sospecha de catéter, piel o inestabilidad.
- Alto riesgo: hipotensión, mucositis grave, leucemia en inducción, neutropenia prolongada; considerar antifúngico si fiebre persiste >4-7 días.
- Seguimiento: hospitalizar y derivar al centro oncológico tratante.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 58

Un niño de 7 años, diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda, inicia sus ciclos de quimioterapia hace 7 días. Consulta por fiebre asociada a malestar general. Al examen físico presenta temperatura 38,5 °C y frecuencia cardíaca 110 x minuto, sin alteraciones en el examen físico segmentario. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar ceftriaxona intramuscular y controlar en 24 horas
B) Indicar antipiréticos y controlar en caso de persistencia de la fiebre
C) Administrar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa
D) Solicitar serología para virus de Epstein-Barr y citomegalovirus
E) Iniciar amoxicilina por vía oral

Respuesta C. Fiebre 7 días después de iniciar quimioterapia: neutropenia febril hasta demostrar lo contrario. Es una urgencia infectológica que requiere antibióticos endovenosos de amplio espectro con cobertura antipseudomónica durante la primera hora, sin esperar el foco.

2.01.1.035 Síndrome purpúrico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.12 Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Púrpura: petequias/equimosis por alteración plaquetaria o vascular. Diferenciar con hemograma y frotis: trombocitopenia vs plaquetas normales.
- PTI: niño sano 2-6 años, petequias súbitas tras infección viral, plaquetas aisladas bajas (<100.000), sin hepatoesplenomegalia ni otras citopenias.

- PTI manejo: observación si solo sangrado cutáneo aunque plaquetas <20.000; sangrado mucoso: prednisona 2-4 mg/kg/día o inmunoglobulina 0,8-1 g/kg. Evitar AINE e intramuscular.
- Plaquetas normales con púrpura palpable en extremidades inferiores, artralgia, dolor abdominal: Schönlein-Henoch.
- Banderas rojas: fiebre con petequias y mal estado (meningococcemia), bicitopenia o hepatoesplenomegalia (leucemia; mielograma antes de corticoides), SHU.
- Seguimiento: derivar a hematología si plaquetas <20.000 con sangrado, PTI persistente >3 meses o duda diagnóstica.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 101

Un niño de 5 años cursa un cuadro respiratorio alto desde hace 7 días que ha recibido tratamiento con paracetamol e ibuprofeno. Consulta por aparición de múltiples lesiones cutáneas consistentes en petequias y equimosis en las extremidades y el abdomen, asociadas a epistaxis en algunas oportunidades. Se solicitan exámenes, destacando hemograma con hematocrito: 42%, hemoglobina: 14 g/dL, glóbulos blancos: 9.500/mm³ con 65% linfocitos, 30% neutrófilos y 5% monocitos, plaquetas: 60.000/mm³. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Leucemia linfática aguda
B) Meningococcemia
C) Púrpura trombocitopénica inmune
D) Alteración de la hemostasia secundaria a fármacos
E) Púrpura de Schönlein-Henoch

Respuesta C. Trombocitopenia aislada tras una virosis en un niño: PTI. Ninguna otra serie está alterada, lo que aleja la leucemia. La disfunción plaquetaria por AINE y el Schönlein-Henoch tienen plaquetas normales.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 159 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 8 años acude al servicio de urgencia por un cuadro de epistaxis, que respondió al tratamiento con taponamiento nasal anterior. Al examen físico tiene petequias generalizas y equimosis, principalmente en las extremidades inferiores. Su hemograma muestra hemoglobina 12 g/dl, hematocrito: 36%, plaquetas: 10.000 por mm3 y glóbulos blancos: 5.600 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Leucemia aguda
B) Púrpura trombocitopénico inmune
C) Púrpura trombocitpénico trombótico
D) Hemofilia
E) Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta B. Diagnóstico: Púrpura trombocitopénico inmune (opción B). Tiene un PTI clásico: alteración de hemostasia primaria, con trombocitopenia aislada.. :::warning Púrpura + FIEBRE = URGENCIA → descartar meningococcemia (instalación aguda, grave) o leucemia aguda (fiebre + adenopatías + esplenomegalia + anemia de días a semanas). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad cl

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 146 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de edad escolar presenta aparición de petequias y equimosis en el dorso y en las extremidades, con epistaxis y gingivorragia, que comenzaron hace 4 días. Se solicita un hemograma, que demuestra hematocrito de 35%, con hemoglobina de 11,8 g/dl, blancos: 9.000 por mm3, con fórmula diferencial normal y plaquetas: 18.000 por mm3. Además presenta INR: 1,1 y protrombinemia de 80%. El diagnóstico más probable es:

A) Púrpura de Schönlein Henoch
B) Púrpura trombocitopénico inmune
C) Leucemia aguda
D) Meningococcemia
E) Hemofilia

Respuesta B. Diagnóstico: Púrpura trombocitopénico inmune (opción B). Es un PTI clásico, con el hemograma característico: trombocitopenia asilada.. :::warning Púrpura + FIEBRE = URGENCIA → descartar meningococcemia (instalación aguda, grave) o leucemia aguda (fiebre + adenopatías + esplenomegalia + anemia de días a semanas). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 111 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 6 años, con historia de que hace dos semanas presentó cuadro caracterizado por rinorrea, odinofagia y tos, el cual fue manejado adecuadamente. Actualmente consulta por presencia de sangrado de encías, sin otros síntomas. Al examen físico destaca en buenas condiciones generales, con petequias en tronco y extremidades, resto normal. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina 12 mg/dL, leucocitos 8.000/mm3 y plaquetas 10.000/mm3. El diagnóstico más probable es:

A) Purpura trombocitopénico trombótico
B) Hemofilia A
C) Púrpura de Schonlein Henoch
D) Purpura trombocitopénico inmune
E) Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta D. Diagnóstico: Purpura trombocitopénico inmune (opción D). PTI de libro. :::warning Púrpura + FIEBRE = URGENCIA → descartar meningococcemia (instalación aguda, grave) o leucemia aguda (fiebre + adenopatías + esplenomegalia + anemia de días a semanas). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 47 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 12 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de hemorragia gingival al lavarse los dientes, asociado a equimosis frente a pequeños traumatimos desde hace 2 semanas. Al examen físico destacan dichas equimosis y petequias generalizadas, sin otros hallazgos. Se solicita hemograma donde destaca hemoglobina de 12mg/dL, leucocitos de 7.000/mm3 y plaquetas de 4000/ mm3. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Transfusión de plaquetas
B) Esplenectomía
C) Corticoides
D) Inmunoglobulina no específica
E) Administrar crioprecipitado

Respuesta C. Tiene un PTI agudo, pero por tener menos de 20.000 plaquetas, hay que indicarle corticoides. En general solo se observa. Si tuviese hemorragias graves (ej: HDA o hemorragia intracraneal), se debería dar IgG ev. Si fuera crónico: siempre corticoides y si fallan: esplenectomía.

2.01.1.036 Trastornos coagulación

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.13 Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos de coagulación: hemofilia A (déficit factor VIII) y B (IX), ligadas al X en varones: hemartrosis, hematomas musculares, sangrado post circuncisión o extracción dental.
- Enfermedad de von Willebrand: la más frecuente hereditaria; sangrado mucocutáneo (epistaxis, gingivorragia, menorragia).
- Laboratorio: hemofilia TTPA prolongado con TP y plaquetas normales; vW con TTPA normal o prolongado y tiempo de sangría/PFA alterado; corrige con plasma normal si es déficit.
- Manejo inicial: compresión, frío e inmovilización de hemartrosis; no AINE ni inyecciones IM; desmopresina en hemofilia A leve y vW tipo 1; ácido tranexámico en sangrado mucoso.
- Sangrado grave o TEC en hemofílico: administrar concentrado de factor antes de imágenes (meta 100%).
- Seguimiento: derivar a hematología (hemofilia es GES); educación familiar y profilaxis con factor.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 159

Un niño de 2 años presenta tendencia a las hemorragias, ya que sangra con facilidad y presenta múltiples equimosis. En el examen físico, se observan extremidades inferiores con equimosis en distinto grado de resolución, algunas de gran tamaño. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma con recuento de plaquetas normal, TP normal y TTPA alargado. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Púrpura trombocitopénica inmune
B) Hemofilia
C) Enfermedad de von Willebrand
D) Enfermedad de Glanzmann
E) Púrpura trombocitopénica trombótica

Respuesta B. Plaquetas normales, TP normal y TTPA alargado: vía intrínseca. En un niño pequeño con equimosis grandes, la hemofilia es lo más probable. PTI y PTT tienen plaquetas bajas; Glanzmann y von Willebrand alteran la hemostasia primaria y habitualmente no alargan el TTPA, salvo algunas formas de von Willebrand.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 35

Niño con equimosis frecuentes, TTPA prolongado al triple, hermano fallecido por hemorragia intracraneal. **¿Cuál es el examen para el diagnóstico?**

A) Tiempo de hemorragia (Duke)
B) Recuento de plaquetas y función plaquetaria
C) Factor de Von Willebrand y cofactor de ristocetina
D) Proteínas C y S
E) Factores de coagulación VIII y IX

Respuesta E. Varón, hermano fallecido por hemorragia y TTPA francamente prolongado: hemofilia. El diagnóstico y la distinción entre A y B se hacen dosificando los factores VIII y IX. El perfil de von Willebrand se pide ante sangrado de mucosas con TTPA normal o levemente largo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 23 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 8 años presenta epistaxis con frecuencia y, además, tiene antecedente de haber presentado sangramiento bucal prolongado, después de una extracción dental. Al examen físico, se objetivan múltiples equimosis en las piernas y rodillas. Como antecedente, su madre refiere que ella presenta reglas abundantes y también cierta tendencia a tener equimosis. Se solicitan exámenes que muestran protrombinemia: 85%, TTPA: 38 segundos, hemograma con hematocrito: 33%, hemoglobina: 11 g/dl, VCM: 88 ft, glóbulos blancos: 8.000 por mm3 y plaquetas: 323.000 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hemofilia
B) Trombocitopenia inmune
C) Enfermedad de von Willebrand
D) Síndrome antifosfolípidos
E) Niño sano

Respuesta C. Diagnóstico: Enfermedad de von Willebrand (opción C). La epistaxis o sangrado nasal es una consulta frecuente en urgencias. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 135 · texto original del banco, sin revisar

Un recién nacido, presenta un cefalohematoma de gran tamaño, al momento de nacer. Además, presenta hematoma del sitio de punción de la muestra venosa. Sus padres son asintomáticos, pero uno de sus tíos murió en el periodo neonatal por hemorragia intracraneal. Entre sus exámenes, destaca TP: 70%, TTPA: 65 segundos, hemograma con hematocrito 50%, blancos: 8.400 por mm3 y plaquetas: 350.000 por mm3. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Agregometría plaquetaria
B) Factores de coagulación VIII y IX
C) Estudio de trombofilia
D) Biopsia de médula ósea
E) Frotis de sangre periférica

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Factores de coagulación VIII y IX). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Agregometría plaquetaria, Estudio de trombofilia) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la pres

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 77 · texto original del banco, sin revisar

Escolar de 8 años, es traído por su madre ya que desde hace años presenta equimosis frente a pequeños traumatismos y en una ocasión presentó un hematoma en muslo al jugar en el colegio. Actualmente presenta sangramiento gingival, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia dicho sangramiento, asociado a equimosis en extremidades. Se solicitan exámenes que muestran hemoglobina 12mg/dL, leucocitos 6.000/mm3, plaquetas 230.000/mm3, tiempo de protrombina normal y tiempo de tromboplastina parcial activada prolongada. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Enfermedad de Von Willebrand
B) Enfermedad de Bernard Soulier
C) Enfermedad de Glanzmann
D) Hemofilia
E) Escorbuto

Respuesta A. Esta pregunta está muy difícil, ya que la gingivorragia puede estar en la EvW y es más frecuente en ella que en la hemofilia. Además la EvW puede alargar levemente el TTPA. Por ser niño, por tener un hematoma profundo y por tener el TTPA largo, podría ser hemofilia. Sin embargo, que no haya tenido hemartrosis y que solo haya tenido un hematoma muscular, más los otros síntomas, lo más probable es que

2.01.1.037 Tumores sólidos

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.11 Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores sólidos más frecuentes: SNC (1º), neuroblastoma, tumor de Wilms, linfomas, retinoblastoma, sarcomas óseos y de partes blandas.
- Neuroblastoma: <2 años, masa abdominal que cruza línea media, calcificaciones, catecolaminas urinarias elevadas, equimosis periorbitaria, opsoclono-mioclono.
- Tumor de Wilms: 2-5 años, masa abdominal lisa en flanco que no cruza línea media, en niño sano; HTA y hematuria; asociado a aniridia y hemihipertrofia.
- Retinoblastoma: leucocoria, estrabismo. Osteosarcoma/Ewing: dolor óseo persistente nocturno, masa en adolescente.
- Manejo inicial: ecografía abdominal ante masa, evitar palpación repetida (riesgo de rotura en Wilms), hemograma, LDH, función renal.
- Cáncer infantil es GES: derivar con urgencia a oncología pediátrica (PINDA).

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 109

Un niño de 7 años presenta orinas oscuras desde hace 5 días, sin otros síntomas. Al examen físico se palpa una masa abdominal en el flanco derecho de 10 cm de diámetro. Los exámenes muestran bilirrubina 1,0 mg/dL, creatinina 1,1 mg/dL y sedimento de orina con 30 a 40 glóbulos rojos por campo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Riñón poliquístico
B) Neuroblastoma
C) Hepatoblastoma
D) Tumor de Wilms
E) Linfoma

Respuesta D. Masa en el flanco con hematuria en un niño sano obliga a pensar en tumor de Wilms (nefroblastoma), el tumor renal más frecuente en pediatría. El neuroblastoma suele dar compromiso del estado general, cruzar la línea media y calcificarse; el hepatoblastoma no produce hematuria. No se debe palpar repetidamente ni biopsiar: se estudia con imágenes y se deriva.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 77 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 4 años, presenta orinas oscuras, desde hace 7 días. Al examen físico se palpa una masa abdominal sólida, en relación al flanco izquierdo, sin otras alteraciones. Se solicitan exámenes de orina, que muestran sedimento con 2 leucocitos por campo, 35 eritrocitos por campo, sin bacterias ni cristales. El urocultivo resulta negativo. Su hemograma es normal y su creatinina es 0,7 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Riñón poliquístico
B) Neuroblastoma
C) Hepatoblastoma
D) Tumor de Wilms
E) Estenosis pielocalicilar

Respuesta C. Diagnóstico: Hepatoblastoma (opción C). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Riñón poliquístico, Neuroblastoma) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentac

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 32 · texto original del banco, sin revisar

Niño de 4 años con orinas oscuras, masa palpable en flanco izquierdo y hematuria sin leucocituria. ¿El diagnóstico más probable es?

A) Tumor de Wilms
B) Neuroblastoma
C) Quiste renal simple
D) Hidronefrosis severa
E) Linfoma retroperitoneal

Respuesta A. Diagnóstico: Tumor de Wilms (opción A). Tumor de Wilms. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

2.01.1.038 Constipación

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 6.2 Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Constipación: ≥2 criterios de Roma IV por ≥1 mes: ≤2 deposiciones/semana, retención, defecación dolorosa o dura, heces de gran diámetro, masa fecal rectal, encopresis.
- 95% funcional; peak en retiro del pañal e ingreso escolar. Disquecia del lactante es normal (esfuerzo y llanto antes de deposición blanda).
- Banderas rojas de causa orgánica: retraso en eliminación de meconio >48 h (Hirschsprung), distensión, vómitos biliosos, sangre, falla de crecimiento, alteraciones neurológicas o de columna.
- Desimpactación: PEG 3350 1-1,5 g/kg/día por 3-6 días o enemas (no fosfato en <2 años). Mantención: PEG 0,4-0,8 g/kg/día o lactulosa 1-2 ml/kg/día por ≥2 meses.
- Medidas: fibra y agua, entrenamiento de hábito defecatorio (sentarse 5-10 min post comidas), calendario de deposiciones, refuerzo positivo.
- Seguimiento: control mensual en APS; retirar laxante gradualmente tras 1 mes sin síntomas; derivar a gastroenterología si no responde o hay banderas rojas.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 165

Niño de 7 años que desde hace 3 años presenta deposiciones cada vez más infrecuentes y duras. Hace algunas semanas empeoran los síntomas, por lo que se inicia lactulosa 15 mililitros al día, sin lograr cambios. Además, comienza a manchar frecuentemente los calzoncillos con deposiciones. **¿Cuál es la causa más probable de la falta de respuesta en este paciente?**

A) Dosis insuficiente de laxante
B) Dieta baja en fibra
C) Enfermedad de Hirschsprung
D) Presencia de fecaloma
E) Concomitancia de patología psiquiátrica

Respuesta D. Constipación progresiva que no responde a un laxante de mantención, y que ahora se acompaña de manchado fecal: es un fecaloma, con pseudoincontinencia por rebosamiento. Un laxante de mantención no desimpacta; primero hay que sacar el fecaloma, con polietilenglicol oral, y recién después mantener.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 163 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 4 años presenta incontinencia fecal, en algunas ocasiones, desde hace dos meses. Sin embargo, en otras ocasiones, pasan muchos días sin defecar y cuando lo hace, sus deposiciones son duras y caprinas. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Niño sano
B) Atresia duodenal
C) Constipación funcional
D) Megacolon aganglionótico
E) Malrotación intestinal

Respuesta C. Tiene una constipación funcional clásica, probablemente complicada con un fecaloma (por la incontinencia fecal). Es la causa más frecuente de constipación en niños y se mejora con laxantes y formación de hábitos de defecación.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 66 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 4 años acude al servicio de urgencia debido a que no ha defecado en 5 días. La madre refiere que recientemente presentó una infección viral en la que estuvo muy inapetente, rechazando la mayoría de los alimentos que se le ofrecían. Sin embargo, actualmente se encuentra de buen ánimo y con buen ape8to. Su examen Fsico no aporta mayor información. ¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo en este momento?

A) Vaselina líquida por vía oral
B) Hidróxido de magnesio por vía oral
C) Enema evacuante de lactulosa
D) Polie2lenglicol 3350 vía oral
E) Gastroclisis con solución salina

Respuesta D. Es una constipación aguda funcional, probablemente secundaria a la menor ingesta durante la infección viral, sin signos de complicación. El manejo de elección es la desimpactación por vía oral con polietilenglicol 3350, por su eficacia y seguridad. La vaselina líquida se evita por riesgo de aspiración, y los enemas y la gastroclisis se reservan para casos de falla del tratamiento oral.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 13 · texto original del banco, sin revisar

Niña 3 años con fisura anal resuelta, continua con constipación cual es el manejo adecuado:

A) Lactulosa
B) PEG (para desimpactar) sgy era aumentar consumo de fibra. Esq aumentar consumo de fibra va junto con aumentar consumo de agua
C) colonoscopía
D) Agua 2L e. Aumentar consumo de fibra
E) Control sano habitual

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: PEG (para desimpactar) sgy era aumentar consumo de fibra. Esq aumentar consumo de fibra va junto con aumentar consumo de agua (opción B). Diarrea aguda (<2 semanas), prolongada (2-4 semanas), crónica (>=4 semanas); causas y manejo distintos De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

2.01.1.039 Diarrea aguda y en vías de prolongación

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 6.1 Diarrea Aguda y Crónica en el Niño · Tema 18.11 Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

QUÉ HAY QUE SABER

- Diarrea aguda: ≥3 deposiciones líquidas/día por <14 días; rotavirus y norovirus las principales causas. Prolongada 7-14 días; persistente >14 días.
- Evaluar hidratación (OMS): conciencia, ojos, boca/sed, signo del pliegue. Sin deshidratación <5%, moderada 5-10%, grave >10% o shock.
- Plan A (sin deshidratación): continuar alimentación, SRO 10 ml/kg por deposición líquida. Plan B (moderada): SRO 50-100 ml/kg en 4 h. Plan C (grave): SF o Ringer 20 ml/kg EV en bolos hasta 100 ml/kg.
- Zinc 10-20 mg/día por 10-14 días; probióticos pueden acortar la duración. No usar antiespasmódicos ni loperamida; antibióticos solo en disentería con compromiso, cólera, Shigella o <3 meses.
- Diarrea prolongada: descartar intolerancia secundaria a lactosa, parasitosis (Giardia); mantener lactancia.
- Seguimiento: control en 24-48 h si plan B; reconsultar si vómitos persistentes, sangre, decaimiento u oliguria.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 74

Niño de 2 años con gastroenteritis aguda de 24 horas de evolución, con vómitos y diarrea. Sin fiebre alta, sin sangre en las deposiciones, con mucosas hidratadas, llenado capilar normal, y orina presente. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Hospitalización y suero endovenoso
B) Sales de rehidratación oral, fraccionadas, en el domicilio
C) Ayuno absoluto por 6 horas
D) Antibióticos orales empíricos
E) Loperamida

Respuesta B. Sin signos de deshidratación (mucosas hidratadas, llenado capilar normal, orina presente): manejo con Plan A, sales de rehidratación oral fraccionadas en domicilio. La loperamida está contraindicada en menores de 2 años.

Pregunta de práctica

Lactante de 10 meses con diarrea acuosa de 3 días, sin sangre. Al examen está irritable, llora sin lágrimas, tiene las mucosas secas y los ojos hundidos, y ha perdido el 7 % de su peso. Bebe con avidez pequeñas cantidades de líquido que se le ofrecen. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Plan A: SRO 100–200 mL tras cada deposición, en casa
B) Plan B: SRO 50–100 mL/kg en 4–6 horas, reevaluando
C) Plan C: suero fisiológico 20 mL/kg EV en bolo
D) SRO más loperamida para reducir las pérdidas
E) SRO más ciprofloxacino oral por 3 días

Respuesta B. Pérdida del 7 % del peso, mucosas secas, ojos hundidos y llanto sin lágrimas: deshidratación moderada. Como tolera la vía oral, corresponde el Plan B con SRO 50–100 mL/kg en 4–6 h. No requiere suero EV (no hay shock ni intolerancia oral), la loperamida está contraindicada y no hay disentería que justifique antibiótico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 76 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 18 meses, desde hace 24 horas, presenta fiebre hasta 38,7°C, asociado a episodios de vómitos alimentarios y seguido de diarrea acuosa abundante, con múltiples deposiciones. Al examen físico, se ve de buen aspecto, hidratado, tiene T°:37,2°C y frecuencia cardíaca normal. Su examen abdominal muestra abdomen blando, depresible e indoloro, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Se realiza examen de deposiciones con tiras reactivas, que resultan positivos para rotavirus y Clostridium difficile (Clostridioides difficile). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Probar tolerancia y rehidratación por vía oral
B) Administrar suero fisiológico por vía endovenosa
C) Iniciar metronidazol oral
D) Iniciar ceftriaxona endovenosa
E) Iniciar vancomicina endovenosa

Respuesta A. Manejo de Diarrea Aguda con Portación Asintomática de Clostridium difficile: Un niño con diarrea aguda por rotavirus y portación asintomática de Clostridium difficile no requiere tratamiento para C. difficile. La portación asintomática en niños es frecuente y no suele complicarse. El metronidazol no ha demostrado mayor utilidad en estos casos. El manejo de este caso se centra en la diarrea por rot

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 146 · texto original del banco, sin revisar

Lactante de 10 meses con diarrea acuosa de 3 días de evolución, que mejora tras rehidratación oral. Hemograma y electrolitos: normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de la gastroenteritis?

A) Gastroenteritis bacteriana (Salmonella)
B) Gastroenteritis por Rotavirus
C) Infección urinaria
D) Enfermedad celíaca de debut
E) Fibrosis quística

Respuesta B. Gastroenteritis en lactante de 10 meses: Rotavirus es el agente más frecuente (diarrea acuosa, electrolitos normales, responde bien a rehidratación oral, curso benigno). La gastroenteritis bacteriana típicamente tiene fiebre alta y sangre. Rotavirus tiene vacuna desde los 2 meses.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 134 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 7 meses de edad es hospitalizado por una bronquilitis aguda. Al quinto día de la hospitalización, presenta fiebre y diarrea acuosa abundante, de olor ácido, sin sangre, de cerca de 6 deposiciones líquidas al día. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Escherichia coli
B) Shiguella
C) Clostridium difficile
D) Rotavirus
E) Enterovirus

Respuesta D. Las diarreas hospitalarias en niños suelen ser virales. Además una bronquiolitis aguda no tiene por qué recibir ATB, como para pensar en C. difficile

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 121 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 11 meses de edad presenta un cuadro de fiebre, hasta 38,7 grados celsius, asociado a diarrea acuosa abundante, con deposiciones explosivas, ácidas, más irritabilidad importante.

A) Rotavirus
B) Enterovirus
C) Escherichia coli
D) Shigella
E) Adenovirus

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Rotavirus). El rotavirus es la causa más frecuente de diarrea acuosa febril en lactantes.. :::warning Los jugos, bebidas gaseosas y líquidos hiperosmolares están contraindicados: prolongan la diarrea. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

2.01.1.040 Diarrea crónica

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 6.1 Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Diarrea crónica: >4 semanas. Diarrea crónica inespecífica del preescolar (1-4 años): niño que crece bien, deposiciones con restos de alimentos, asociada a exceso de jugos.
- Causas orgánicas: enfermedad celíaca, giardiasis, intolerancia a lactosa, alergia a proteína de leche de vaca, fibrosis quística, EII, post infecciosa.
- Banderas rojas: falla de crecimiento, sangre, diarrea nocturna, distensión, anemia, hipoalbuminemia.
- Estudio inicial: hemograma, parasitológico seriado, leucocitos fecales, Sudán (esteatorrea), pH y sustancias reductoras, IgA total + antitransglutaminasa IgA, test del sudor si corresponde.
- Manejo inicial: alimentación adecuada sin restricción injustificada, limitar jugos; tratar causa identificada (metronidazol en giardiasis, dieta sin gluten tras confirmar celiaquía).
- Seguimiento: derivar a gastroenterología pediátrica si hay compromiso nutricional, sospecha de celiaquía (biopsia), EII o FQ.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 62

Niño de 3 años presenta diarrea de 3 meses de evolución, intermitente, generalmente acuosa, pero que en ocasiones contiene escasos restos vegetales. Ha subido 600 gramos en ese periodo y su talla es 90 cm. Tiene signos vitales normales, se aprecia hidratado y su examen abdominal muestra un abdomen blando, depresible e indoloro, sin visceromegalia ni otras alteraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Diarrea crónica inespecífica
B) Enfermedad celíaca
C) Enteropatía perdedora de proteínas
D) Alergia a la proteína de la leche de vaca
E) Intolerancia a los disacáridos

Respuesta A. Diarrea intermitente con restos vegetales en un niño sano, que sigue creciendo y está hidratado, sin ningún otro hallazgo: diarrea crónica inespecífica, por exceso de jugos hiperosmolares. No necesita exámenes: la conducta es suspenderlos.

Pregunta de práctica

Preescolar de 4 años de una zona rural consulta por diarrea crónica de 2 meses, con abundante flatulencia y dolor abdominal tipo cólico. Dos hermanos tienen síntomas similares. Crece en un percentil bajo pero estable. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y su tratamiento?**

A) Diarrea crónica inespecífica; suspender los jugos
B) Enfermedad celíaca; dieta sin gluten
C) Giardiasis; tinidazol (o metronidazol)
D) Fibrosis quística; enzimas pancreáticas
E) Alergia a la proteína de leche de vaca; fórmula hidrolizada

Respuesta C. Diarrea crónica con flatulencia y dolor cólico en un preescolar rural, con convivientes afectados: giardiasis. Se confirma con parasitológico seriado (3 muestras) y se trata con tinidazol o metronidazol. Puede dar malabsorción idéntica a la celíaca, por lo que siempre se descarta antes.

2.01.1.041 Dolor abdominal recurrente

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 6.2 Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Dolor abdominal recurrente: ≥4 episodios en 2 meses que interfieren con la actividad; mayoría funcional (Roma IV: dispepsia funcional, SII, migraña abdominal, dolor abdominal funcional).
- Funcional: periumbilical, sin relación con comidas, examen normal, crecimiento normal, gatillantes psicosociales.
- Banderas rojas: dolor que despierta, lejos del ombligo, vómitos biliosos, disfagia, sangrado digestivo, baja de peso, fiebre, diarrea nocturna, artritis, historia familiar de EII o celiaquía.
- Estudio básico: hemograma, VHS/PCR, orina completa y urocultivo, parasitológico, perfil hepático, antitransglutaminasa IgA; ecografía si dolor localizado.
- Manejo inicial: explicar y validar el dolor, reducir estrés, tratar constipación si existe, dieta regular; evitar estudios innecesarios.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología si banderas rojas o estudio alterado; a psicología si gatillante emocional relevante.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Escolar de 8 años con 6 meses de episodios de dolor periumbilical varias veces por semana, que no lo despiertan en la noche y suelen aparecer antes de ir al colegio. Crece en percentil 50 de peso y talla. Examen físico, hemograma, VHS, orina completa y parasitológico seriado normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Endoscopía digestiva alta con biopsias
B) TAC de abdomen y pelvis
C) Omeprazol empírico por 3 meses
D) Diagnosticar dolor abdominal funcional, educar a la familia y abordar los factores psicosociales
E) Erradicación empírica de Helicobacter pylori

Respuesta D. Dolor periumbilical recurrente, sin signos de alarma (dolor nocturno o lejos del ombligo, baja de peso, vómitos, sangrado, fiebre) y con exámenes básicos normales es un dolor abdominal funcional. Se maneja con educación, validación del síntoma y apoyo psicosocial, evitando estudios invasivos innecesarios.

2.01.1.042 Fibrosis quística

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 6.1 Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Fibrosis quística: autosómica recesiva (mutación CFTR, ΔF508); infecciones respiratorias recurrentes, tos crónica, insuficiencia pancreática con esteatorrea y desnutrición.
- Sospechar: íleo meconial en RN, prolapso rectal, SBO/neumonías a repetición, sabor salado de la piel, pólipos nasales, deshidratación hiponatrémica con alcalosis metabólica.
- Diagnóstico: test del sudor con cloro ≥60 mmol/L en 2 muestras (30-59 dudoso); confirmación genética. FQ es GES.
- Manejo inicial: apoyo nutricional hipercalórico, enzimas pancreáticas, vitaminas liposolubles (A, D, E, K), kinesioterapia respiratoria diaria.
- Colonización por S. aureus y Pseudomonas aeruginosa: cultivos periódicos de expectoración y erradicación por especialista.
- Seguimiento: derivar a centro de FQ con equipo multidisciplinario (broncopulmonar, gastroenterología, nutrición).

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 6

Lactante de 4 meses con infecciones respiratorias a repetición, deposiciones grasas malolientes y retraso pondoestatural. La madre refiere que el sudor del niño "sabe salado". **¿Cuál es el examen diagnóstico de elección?**

A) Broncoscopía
B) Test del sudor (electrolitos en sudor)
C) Test de metacolina
D) TAC de tórax de alta resolución
E) Espirometría

Respuesta B. Infecciones respiratorias recurrentes, más esteatorrea, más mal incremento de peso, más el detalle clásico del sudor salado: fibrosis quística. El examen diagnóstico es el test del sudor, con cloro mayor o igual a sesenta milimoles por litro.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 135 · texto original del banco, sin revisar

Niño de 8 meses que sufre desde hace 6 meses diarrea pastosa, abundante. Tiene también antecedente de episodios bronquiales obstructivos y 4 cuadros de infecciones respiratorias, que han requerido de hospitalización. Cuál es el diagnóstico de sospecha?

A) Enfermedad celiaca
B) Enteropatía perdedora de proteínas
C) Enfermedad de cilio inmóvil
D) Fibrosis quística
E) Alergia a la proteína de la leche de vaca

Respuesta D. Tanto por las infecciones respiratorias, como por la malabsorción es una fibrosis quística. Las demás opciones producen solo síntomas digestivos (A, B y E) o solo neumonías (C).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 56 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 7 meses, con antecedente de haber sido hospitalizado en varias opor- tunidades por cuadros respiratorios febriles, presenta diarrea de algunos meses de evo- lución, asociada a esteatorrea y mal incremento ponderal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad celíaca
B) Inmunodeficiencia primaria
C) Fibrosis quística
D) Alergia a la proteína de la leche de vaca
E) Giardiasis intestinal

Respuesta C. La FQ suele producir neumonías bacterias (S. aureus y P. aureginosa) y un síndro- me de malabsorción.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 151 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 8 meses de edad ha presentado 5 cuadros de bronquitis obstructiva y además ha presentado diarrea acuosa de 2 meses de evolución. No ha subido de peso en dicho periodo. ¿Qué examen debe realizarse?

A) Anticuerpos antitransglutaminasa
B) Niveles plasmáticos de IgA
C) Test del sudor
D) Elisa VIH
E) Colonoscopía

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Test del sudor). Sospechar una fibrosis quística. Se diagnostica con test del sudor. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 114 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 26 días presenta deposiciones abundantes y frecuentes con visualización de gotas de grasa. Además, sus padres comentan que al besarla su piel 8ene un sabor salado. El resto del examen Fsico no aporta mayor información. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar la sospecha diagnós8ca?

A) Colonoscopía con biopsia por succión
B) Ecogra:a abdominal
C) Endoscopía diges2va alta con biopsia de duodeno
D) Niveles plasmá2cos de 17-hidroxiprogesterona
E) Determinación de electrolitos en el sudor

Respuesta E. La sospecha es una fibrosis quística, cuya clínica se caracteriza por infecciones respiratorias, malabsorción intestinal y puede tener piel salada. El diagnóstico se hace con el test del sudor, que muestra aumento del cloro en sudor. - Cloro > 60 mEq/L: confirma diagnóstico. - Cloro 30-60 mEq/L: sospecha intermedia. Se repite examen y se estudia genéticamente. - Cloro < 30 mEq/L: descarta fibrosis qu

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 156 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 30 días de vida con mal incremento ponderal presenta deposiciones amarillas, abundantes y oleosas. Los padres refieren que su piel tiene un sabor salado. ¿Cuál es el examen más adecuado para realizar el diagnóstico?

A) Ecografía abdominal
B) Colonoscopía
C) Anticuerpos anti-transglutaminasa y endoscopía digestiva alta
D) Electrolitos en sudor
E) Hemograma y pruebas de función renal

Respuesta D. Diagnóstico: Electrolitos en sudor (opción D). Se sospecha una fibrosis quística, que se estudia con el test del sudor, que mide cloro en el sudor.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 125 · texto original del banco, sin revisar

Lactante con bronquitis a repetición, esteatorrea y anemia ferropénica:

A) Fibrosis Quística
B) Enfermedad celiaca
C) Inmunodeficiencia primaria
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Fibrosis Quística). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Enfermedad celiaca, Inmunodeficiencia primaria) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del pacie

2.01.1.043 Hemorragia digestiva

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Hemorragia Digestiva Alta y Baja

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemorragia digestiva: primero confirmar que es sangre y de origen digestivo (descartar epistaxis, alimentos rojos, sangre materna deglutida en RN: test de Apt).
- Alta (sobre ángulo de Treitz): hematemesis o melena; causas: esofagitis, gastritis por AINE/estrés, úlcera, várices (hipertensión portal), Mallory-Weiss.
- Baja por edad: RN ECN y vólvulo; lactante fisura anal (la más frecuente), alergia a proteína de leche de vaca, invaginación (deposición en jalea de grosella); preescolar pólipo juvenil, divertículo de Meckel (sangrado indoloro masivo).
- Manejo inicial: ABC, 2 vías venosas, hemograma, grupo y Rh, pruebas de coagulación, bolo SF 20 ml/kg, transfusión si inestable; omeprazol EV si HDA; octreotide si várices.
- Hospitalizar si inestabilidad hemodinámica, caída de Hb, sangrado activo; endoscopía alta/colonoscopía o cintigrafía con Tc99 (Meckel) por especialista.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología/cirugía infantil.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 11

Niño de 6 años, sin antecedentes, es traído por presentar sangrado rectal fresco en gotas al final de las deposiciones, no asociado a dolor ni a otros síntomas. Al examen físico se encuentra con índice de masa corporal adecuado para su edad, abdomen blando, depresible y no doloroso, con ruidos hidroaéreos presentes. **¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso?**

A) Úlcera rectal solitaria
B) Hemorroides
C) Divertículo de Meckel
D) Pólipo juvenil
E) Fisura anal

Respuesta D. Escolar sano, sin ninguna otra alteración, con sangrado rectal escaso, en gotas y sin dolor: pólipo juvenil, un hamartoma benigno. Se confirma y se trata en el mismo acto con colonoscopía y polipectomía. El divertículo de Meckel sangra de forma más abundante y en niños más pequeños; la fisura anal duele.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 165

Niño de 2 años con diarrea disentérica desde hace 4 días tras consumir una hamburguesa casera. Hoy está pálido, decaído y con disminución marcada de la diuresis. Los exámenes muestran hemoglobina 6,5 g/dL, plaquetas 42.000/mm³, creatinina 2,8 mg/dL, y esquistocitos abundantes en el frotis. **¿Cuál es la sospecha diagnóstica, y qué tratamiento está contraindicado?**

A) Invaginación intestinal; está contraindicada la ecografía
B) Síndrome hemolítico urémico; están contraindicados los antibióticos
C) Púrpura trombocitopénico inmune; están contraindicados los corticoides
D) Apendicitis perforada; está contraindicada la laparotomía
E) Sepsis bacteriana; está contraindicada la hidratación endovenosa

Respuesta B. Diarrea sanguinolenta previa más anemia hemolítica microangiopática (esquistocitos), trombocitopenia e injuria renal aguda oligúrica: síndrome hemolítico urémico. Los antibióticos están formalmente contraindicados, porque lisan la bacteria y liberan más toxina Shiga a la circulación.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 11

Un paciente de 6 años, sin antecedentes, es traído por presentar sangrado rectal fresco en gotas al final de las deposiciones, no asociado a dolor ni a otros síntomas. Al examen físico tiene índice de masa corporal adecuado para su edad, abdomen blando, depresible e indoloro, con ruidos hidroaéreos presentes. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Úlcera rectal solitaria
B) Hemorroides
C) Divertículo de Meckel
D) Pólipo juvenil
E) Fisura anal

Respuesta D. Hematoquecia indolora, intermitente y escasa en un preescolar o escolar sano sugiere pólipo juvenil, un hamartoma colorrectal que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja indolora entre los 2 y 10 años. La fisura anal duele al defecar; el Meckel da sangrado abundante; las hemorroides son raras en niños. Se diagnostica y reseca por colonoscopía.

2.01.1.044 Hepatomegalia

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Hepatomegalia: borde hepático >3,5 cm bajo reborde costal en RN, >2 cm en lactantes o >1 cm en niños mayores; confirmar con altura hepática (descartar ptosis por hiperinsuflación).
- Causas: infecciosas (hepatitis virales, VEB, CMV), congestivas (insuficiencia cardíaca), infiltrativas (leucemia, neuroblastoma), depósito (glucogenosis, Gaucher), hígado graso por obesidad, colestasia.
- Estudio inicial: hemograma con frotis, transaminasas, bilirrubina total y directa, GGT, fosfatasas, albúmina, TP, glicemia; ecografía abdominal.
- Banderas rojas: esplenomegalia asociada, citopenias, ictericia colestásica (acolia, coluria), hipoglicemia, insuficiencia hepática, masa.
- Manejo inicial: tratar causa reconocida (insuficiencia cardíaca, obesidad); corregir coagulopatía con vitamina K.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología/hematooncología según sospecha; colestasia del lactante es urgencia (atresia de vías biliares).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un lactante de 6 meses es traído por irritabilidad, sudoración y temblor cuando pasa más de 3 a 4 horas sin alimentarse. Al examen tiene facies de muñeca, abdomen prominente y hepatomegalia de 6 cm bajo el reborde costal, sin esplenomegalia. Exámenes en ayuno corto: glicemia 35 mg/dL, lactato elevado, triglicéridos y ácido úrico elevados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Atresia de vías biliares
B) Enfermedad de Gaucher
C) Hepatitis viral aguda
D) Glucogenosis tipo I
E) Hiperinsulinismo congénito

Respuesta D. Hepatomegalia aislada sin esplenomegalia, hipoglicemia de ayuno corto, acidosis láctica, hipertrigliceridemia e hiperuricemia es la glucogenosis tipo I (déficit de glucosa-6-fosfatasa). El hígado no puede liberar glucosa. El hiperinsulinismo da hipoglicemia sin hepatomegalia; Gaucher da esplenomegalia marcada; la atresia biliar cursa con ictericia y acolia.

2.01.1.045 Insuficiencia hepática aguda

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia hepática aguda: daño hepático agudo con coagulopatía (INR ≥1,5 con encefalopatía o ≥2 sin ella) que no corrige con vitamina K, sin enfermedad hepática previa.
- Causas en niños: hepatitis A, intoxicación por paracetamol, hongos (Amanita), enfermedad de Wilson, autoinmune, metabólicas en lactantes; muchas indeterminadas.
- Clínica: ictericia, vómitos, encefalopatía (puede ser tardía en niños), sangrado, hipoglicemia, ascitis.
- Manejo inicial: hospitalizar, glicemia seriada y aporte de glucosa, vitamina K EV, evitar sedantes, N-acetilcisteína en intoxicación por paracetamol, plasma solo si sangrado o procedimiento.
- Vigilar edema cerebral, hipoglicemia, infecciones, falla renal.
- Seguimiento: derivar precozmente a UCI de centro con trasplante hepático.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 6 años con hepatitis A confirmada hace 8 días presenta mayor ictericia, vómitos persistentes y somnolencia. Exámenes: bilirrubina total 14 mg/dL, GPT 2.800 UI/L, glicemia 58 mg/dL e INR 2,4, que no corrige tras administrar vitamina K. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Hospitalizar y contactar precozmente a un centro con trasplante hepático
B) Hospitalizar en sala común y repetir exámenes en 72 horas
C) Manejo ambulatorio con reposo y control en una semana
D) Iniciar corticoides endovenosos
E) Administrar plasma fresco congelado y dar el alta al corregir el INR

Respuesta A. Coagulopatía (INR 2 o más, o 1,5 o más con encefalopatía) que no corrige con vitamina K, en un niño sin hepatopatía previa, define insuficiencia hepática aguda; la hepatitis A es una causa frecuente en Chile. Requiere hospitalización en unidad crítica, manejo de hipoglicemia y encefalopatía, y contacto precoz con un centro de trasplante, porque puede progresar rápidamente.

2.01.1.046 Displasia broncopulmonar / Reflujo gastroesofágico y vómitos del lactante (código repetido en el Perfil oficial)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 6.2 Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño · Tema 18.12 Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal

QUÉ HAY QUE SABER

- Reflujo gastroesofágico fisiológico del lactante: regurgitaciones frecuentes en lactante feliz que crece bien; peak 4 meses, resuelve a los 12-18 meses. No requiere estudio ni fármacos.
- ERGE: reflujo con complicaciones: rechazo alimentario, mal incremento ponderal, irritabilidad, hematemesis, esofagitis, síntomas respiratorios, Sandifer.

- Banderas rojas de otra causa: vómitos biliosos (malrotación), en proyectil (estenosis hipertrófica del píloro, 2-8 semanas, alcalosis metabólica hipoclorémica), fiebre, abombamiento de fontanela, inicio después de los 6 meses.
- Manejo: tranquilizar, fraccionar volúmenes, espesar fórmula, posición vertical post comida (dormir siempre en supino); prueba con fórmula extensamente hidrolizada 2-4 semanas si sospecha APLV.
- Omeprazol 1 mg/kg/día solo en ERGE con esofagitis o síntomas significativos, por tiempo limitado.
- Displasia broncopulmonar: prematuro con requerimiento de O2 a las 36 semanas corregidas; seguimiento de ambas: derivar a gastroenterología o broncopulmonar si complicaciones.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 155

Niño de 28 días con vómitos después de comer, que iniciaron hace una semana y han aumentado en frecuencia e intensidad. La madre refiere que llora después de comer y vomitar, y se objetiva que no ha incrementado bien de peso en el último tiempo, viéndose algo enflaquecido. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?**

A) Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
B) Ecografía abdominal
C) Endoscopía digestiva alta con biopsia duodenal
D) Colonoscopía con biopsia de la pared intestinal
E) Radiografía simple toracoabdominal

Respuesta B. Vómitos posprandiales que empiezan hacia las cuatro semanas de vida y van en aumento, con mal incremento de peso: estenosis hipertrófica del píloro. El examen de elección para iniciar el estudio es la ecografía abdominal, que muestra el píloro engrosado.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 147

Un lactante está en tratamiento por reflujo gastroesofágico con medicamento en gotas. Presenta un cuadro de trismus, nistagmus, más hiperextensión del cuello. **¿Qué fármaco es más probable que esté recibiendo?**

A) Omeprazol
B) Cisaprida
C) Metoclopramidad
D) Domperidona
E) Difenhidramina

Respuesta C. Trismus e hiperextensión del cuello en un lactante que recibe un procinético: distonía aguda. La metoclopramida cruza la barrera hematoencefálica y es la que más reacciones extrapiramidales produce; la domperidona casi no la cruza. La difenhidramina es un tratamiento de la distonía, no su causa.

Pregunta de práctica

Lactante de 3 meses con lactancia materna, traído por regurgitaciones después de casi todas las mamadas. Está tranquilo y sonriente, con incremento de peso adecuado y examen físico normal. Los padres, angustiados, piden "algo para el reflujo". **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar omeprazol por 4 semanas
B) Solicitar pH-metría esofágica de 24 horas
C) Educar y tranquilizar a los padres, con medidas posturales y tomas fraccionadas
D) Solicitar ecografía abdominal para descartar estenosis del píloro
E) Suspender la lactancia materna e iniciar fórmula antirreflujo

Respuesta C. Lactante feliz que regurgita pero crece bien y tiene examen normal: reflujo fisiológico. Se educa y tranquiliza, se explica que el pico es entre los 2 y 6 meses y que se resuelve hacia el año, con medidas posturales y fraccionamiento. IBP y estudios se reservan para el reflujo patológico.

Pregunta de práctica

Lactante varón de 4 semanas, primogénito, con vómitos postprandiales que han ido aumentando en intensidad hasta salir con fuerza, en proyectil. El vómito es de leche cortada, sin color verde. Tras vomitar, llora buscando mamar de nuevo. Su peso está estancado desde el nacimiento. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

A) pH-metría esofágica de 24 horas
B) Ecografía abdominal dirigida al píloro
C) Enema baritado con fluoroscopía
D) Endoscopía digestiva alta
E) Colonoscopía con biopsia

Respuesta B. Varón de 4 semanas con vómitos en proyectil no biliosos, avidez por alimentarse y peso estancado: estenosis hipertrófica del píloro. El examen de elección es la ecografía abdominal, que muestra el músculo pilórico engrosado.

2.01.1.047 Síndrome disentérico

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 18.11 Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome disentérico: deposiciones con sangre y mucus, pujo, tenesmo, dolor abdominal, fiebre. Agentes: Shigella, Campylobacter, E. coli enteroinvasiva y STEC, Salmonella, E. histolytica.
- Coprocultivo para identificar agente; leucocitos fecales positivos.
- Hidratación según grado de deshidratación con SRO; mantener alimentación.
- Antibiótico en Shigella, compromiso general o <3 meses: azitromicina 10 mg/kg/día por 3-5 días o ceftriaxona EV si grave; ciprofloxacino como alternativa.
- No dar antibiótico ni antidiarreicos si se sospecha E. coli productora de Shiga toxina (O157:H7): aumentan riesgo de síndrome hemolítico urémico.
- Seguimiento: control en 48 h; vigilar palidez, oliguria y petequias en la semana siguiente (SHU): hemograma, función renal y orina.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 47

Un niño de 14 años, con antecedente de síndrome de QT largo con historia familiar positiva, consulta por un cuadro de fiebre, dolor abdominal y deposiciones líquidas de 5 días de evolución, persistentes, que hace 2 días se han vuelto sanguinolentas. **Además de la hidratación, ¿qué antibiótico debe indicarse?**

A) Ciprofloxacino
B) Azitromicina
C) Metronidazol
D) Sulfametoxazol con trimetoprim
E) Ampicilina

Respuesta D. Un síndrome disentérico febril se trata con antibióticos que cubran Shigella. Ciprofloxacino y azitromicina son opciones habituales, pero prolongan el QT y están contraindicados aquí. El metronidazol no cubre enterobacterias y la ampicilina tiene espectro insuficiente: queda el cotrimoxazol.

2.01.1.048 Síndrome malabsorción

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.3 Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Malabsorción: diarrea crónica, esteatorrea, distensión, falla de crecimiento, hipoalbuminemia, anemia y déficit de vitaminas liposolubles.
- Enfermedad celíaca: inicio tras introducción del gluten; también talla baja, anemia ferropriva refractaria, hipertransaminasemia. Tamizaje con IgA total y antitransglutaminasa IgA; confirma biopsia duodenal (atrofia vellositaria).
- Otras causas: fibrosis quística (test del sudor), giardiasis, intolerancia a lactosa, APLV, intestino corto.
- Estudio inicial: hemograma, ferritina, albúmina, Sudán III/esteatocrito, parasitológico, sustancias reductoras.

- No retirar el gluten antes de completar el estudio (falsos negativos). Tratamiento celíaca: dieta sin gluten estricta de por vida (TACC).
- Seguimiento: derivar a gastroenterología pediátrica para biopsia y control de anticuerpos y crecimiento.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 120**
>
> Una niña de 13 meses ha detenido su crecimiento desde hace 4 meses. Además, presenta deposiciones frecuentes y disgregadas, con tendencia al meteorismo. En sus exámenes destaca anemia ferropénica. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**
>
> **A)** Anticuerpos IgA antiendomisio
> **B)** Cuantificación de inmunoglobulinas
> **C)** Test del sudor
> **D)** Colonoscopía
> **E)** 17-OH-progesterona
>
> Respuesta A. Detención del crecimiento, diarrea crónica, distensión y ferropenia meses después de introducir el gluten sugieren enfermedad celíaca. Se inicia el estudio con serología IgA (antitransglutaminasa o antiendomisio) más IgA total, y se confirma con biopsia duodenal. El test del sudor es para fibrosis quística, que suele dar síntomas respiratorios y esteatorrea desde antes.

2.01.1.049 Arritmias

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-23

QUÉ HAY QUE SABER

- Arritmias pediátricas: la más frecuente sintomática es la taquicardia supraventricular (TPSV): FC >220 lpm en lactante o >180 en niño, QRS estrecho, sin variabilidad, sin onda P visible.
- Arritmia sinusal respiratoria y extrasístoles aisladas en corazón sano son benignas.
- Sospechar: palpitaciones, síncope con ejercicio, irritabilidad y rechazo alimentario en lactante, insuficiencia cardíaca. Pedir ECG de 12 derivaciones.
- TPSV estable: maniobras vagales (hielo en la cara en lactante, Valsalva), luego adenosina 0,1 mg/kg EV rápida (2ª dosis 0,2 mg/kg); inestable: cardioversión sincronizada 0,5-1 J/kg.
- Banderas rojas: síncope con ejercicio, historia familiar de muerte súbita, QT largo, preexcitación (WPW), bloqueo AV completo.
- Seguimiento: derivar a cardiología infantil.

PREGUNTAS (2)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un lactante de 4 meses es traído por rechazo alimentario, palidez y sudoración. Al examen está soporoso, con llene capilar de 5 segundos, pulsos periféricos débiles y frecuencia cardíaca de 280/min. El monitor muestra una taquicardia regular de QRS estrecho, sin ondas P visibles. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Maniobras vagales con hielo en la cara
> **B)** Adenosina en bolo endovenoso rápido como única opción, aunque demore la vía
> **C)** Cardioversión eléctrica sincronizada
> **D)** Amiodarona oral
> **E)** Observar y controlar con ECG en 24 horas
>
> Respuesta C. La taquicardia supraventricular es la arritmia sintomática más frecuente en lactantes (FC habitualmente sobre 220/min, QRS estrecho, sin P). Con signos de shock o compromiso de conciencia es inestable: se trata con cardioversión eléctrica sincronizada (0,5 a 1 J/kg, luego 2 J/kg). Puede usarse adenosina si hay vía venosa inmediata, sin retrasar la cardioversión.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 29 · texto original del banco, sin revisar

Lactante con FC 280 lpm regular, soporoso, pulsos femorales disminuidos, no se puede medir PA. ¿Cual es la conducta?:

A) Cardioversión
B) Adenosina
C) Maniobras vasovagales (PORQUE NO PUEDE SER ESTA DE MANERA INICIAL???) - pulsos disminuidos se puede interpretar como compromiso HDN… ademas maniobras vagales requieren que el pcte coopere y tenia como 2 años
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Cardioversión (opción A). SHU: E.coli O157:H7 (STEC); tríada IRA + anemia hemolítica microangiopática + trombocitopenia; NO antibióticos De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

2.01.1.050 Cardiopatías congénitas frecuentes

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.21 Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Cardiopatías congénitas: ~8-10 por 1.000 RN; CIV la más frecuente. Acianóticas con cortocircuito izquierda-derecha: CIV, CIA, ductus, canal AV; obstructivas: coartación, estenosis aórtica/pulmonar.
- Cianóticas: tetralogía de Fallot (la más frecuente después del período neonatal; crisis hipoxémicas), transposición de grandes arterias (la más frecuente en RN, cianosis precoz).
- Sospecha: soplo, cianosis, taquipnea, sudoración y cansancio al alimentarse, mal incremento ponderal, pulsos femorales débiles (coartación), saturación pre-post ductal diferente.
- Tamizaje neonatal con saturometría preductal y postductal (>95% y diferencia ≤3%). Estudio: Rx tórax, ECG, ecocardiograma.
- Manejo inicial: RN cianótico ductus-dependiente: prostaglandina E1; crisis hipoxémica: posición genupectoral, O2, morfina. Cardiopatía congénita operable es GES.
- Seguimiento: derivar a cardiología infantil; profilaxis de endocarditis cuando corresponde y vacunas completas.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 162

Una niña de 7 meses, con antecedente de síndrome de Down, ha tenido un mal incremento ponderal y aún no duplica su peso de nacimiento. Se cansa al alimentarse y ha presentado varias infecciones respiratorias. Al examen físico se palpa frémito en el precordio izquierdo y se ausculta un soplo holosistólico en el mesocardio, con segundo ruido desdoblado. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Coartación aórtica
B) Comunicación interauricular
C) Canal auriculoventricular completo
D) Comunicación interventricular
E) Ductus arterioso persistente

Respuesta C. El síndrome de Down se asocia típicamente al canal auriculoventricular. La clínica mezcla un componente interventricular (soplo holosistólico con frémito) y uno interauricular (segundo ruido desdoblado), con insuficiencia cardíaca por hiperflujo: mal incremento, cansancio al comer e infecciones respiratorias.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 62 · texto original del banco, sin revisar

Un recién nacido de término, presenta cianosis desde su nacimiento, con saturación arterial de 65% con aporte de oxígeno al 100%. Al examen físico destaca murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, soplo sistólico y pulsos presentes. Como parte de su estudio se solicita radiografía de tórax que muestra cargiomegalia y mediastino delgado. El diagnóstico más probable es:

A) Trasposición de grandes vasos
B) Comunicación interauricular
C) Coartación aórtica
D) Canal auriculoventricular
E) Comunicación interventricular

Respuesta A. Si bien suele no tener soplos, la TGV es la única opción que muestra una cardiopatía cianótica. Además sí tiene el mediastino delgado.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 33 · texto original del banco, sin revisar

Niño con mal incremento pondoestatural, se cansa al alimentarse y presenta soplo holosistólico III en mesocardio. ¿Diagnóstico más probable?

A) Estenosis pulmonar
B) Comunicación interauricular
C) Tetralogía de Fallot
D) Comunicación interventricular
E) Coartación de aorta

Respuesta D. Diagnóstico: Comunicación interventricular (opción D). Comunicación interventricular. Las cardiopatías congénitas son defectos estructurales del corazón presentes desde el nacimiento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 111 · texto original del banco, sin revisar

Usted controla a una niña de 7 meses de edad, con antecedente de síndrome de Down, con infecciones respiratorias en múltiples ocasiones que han requerido hospita- lización y que aún no ha podido duplicar el peso de nacimiento. Al examen físico se ausculta ritmo regular en dos tonos, con soplo holosistólico intenso, irradiado a dorso, asociado a un desdoblamiento del segundo ruido. El diagnóstico más probable es:

A) Comunicación interauricular tipo ostium secundum
B) Canal auriculoventricular
C) Atresia tricuspidea
D) Ductus arterioso persistente
E) Comunicación interventricular

Respuesta B. Diagnóstico: Canal auriculoventricular (opción B). Es un CAV clásico.. Las cardiopatías congénitas son defectos estructurales del corazón presentes desde el nacimiento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 138 · texto original del banco, sin revisar

Un recién nacido presenta un soplo pansistólico, que se escucha entre el tercer y cuarto espacio intercostal. Además presenta algunas crepitaciones escasas en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Comunicación interventricular
C) Ductus arterioso persistente
D) Estenosis mitral
E) Atresia tricuspidea

Respuesta B. Diagnóstico: Comunicación interventricular (opción B). Es una CIV clásica. Las cardiopatías congénitas son defectos estructurales del corazón presentes desde el nacimiento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 89 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 8 años acude a consulta por dificultad para seguir el ritmo en actividades físicas en la escuela. No tiene antecedentes médicos relevantes, salvo infecciones respiratorias recurrentes en los últimos años. Sus signos vitales son normales, al igual que su auscultación pulmonar. A la auscultación cardiaca, se detecta un soplo continuo de intensidad III/VI en la región paraesternal e infraclavicular izquierda. El niño presenta una talla de -1 desviaciones estándar para su edad y un peso adecuado para su talla. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miocardiopatía hipertrófica
B) Comunicación interventricular
C) Comunicación interauricular
D) Ductus arterioso persistente
E) Soplo funcional

Respuesta D. Ductus Arterioso Persistente: El soplo continuo es característico del ductus arterioso persistente. Se recomienda revisar el resumen de semiología cardíaca.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 39 · texto original del banco, sin revisar

Un recién nacido presenta, a los pocos minutos de nacer, cianosis generalizada, con saturación de 65%. En su examen físico, se ausculta un soplo sistólico eyectivo II/VI paraesternal. Su radiografía de tórax muestra campos pulmonares sin alteraciones, hilios de tamaño normal, recesos costodiafragmáticos libres y mediastino delgado ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Canal auriculoventricular completo
B) Coartación aórtica
C) Comunicación interventricular grande
D) Transposición de grandes arterias
E) Cardiopatía hipertrófica

Respuesta D. Revisar el resumen de semiología cardíaca. Si bien la TGV no suele tener soplos, sí puede tenerlo, ya que la arteria pulmonar queda algo estrecha para la sangre que proviene del ventrículo izquierdo y eso produce flujo turbulento. Además, la TGV es la única cardiopatía cianótica de las alternativas y, por ello, es la respuesta correcta con certeza. La TGV sí se caracteriza por un mediastino delgad

2.01.1.051 Endocarditis infecciosa

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-23

QUÉ HAY QUE SABER

- Endocarditis infecciosa pediátrica: principalmente en cardiopatías congénitas (operadas o no) y portadores de catéter venoso central.
- Agentes: Streptococcus viridans y S. aureus; HACEK y hongos menos frecuentes.
- Sospechar: fiebre prolongada en paciente con cardiopatía, soplo nuevo o cambiante, esplenomegalia, fenómenos embólicos, hematuria, petequias, nódulos de Osler, lesiones de Janeway.
- Diagnóstico con criterios de Duke: hemocultivos (3 sets antes de antibiótico) y ecocardiograma (vegetaciones).
- Manejo inicial: hospitalizar, tomar hemocultivos antes de iniciar antibiótico empírico EV (penicilina/ampicilina + gentamicina, cloxacilina si S. aureus), por 4-6 semanas.
- Prevención: profilaxis con amoxicilina 50 mg/kg 30-60 min antes de procedimientos dentales en cardiopatías de alto riesgo. Seguimiento: derivar a cardiología e infectología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 9 años con antecedente de comunicación interventricular no operada presenta fiebre de 2 semanas, decaimiento y baja de peso. Hace un mes se realizó una extracción dental. Al examen tiene soplo holosistólico de mayor intensidad que en controles previos, esplenomegalia leve y hemorragias en astilla subungueales. **¿Cuál es el examen más importante para iniciar el estudio?**

A) Electrocardiograma
B) Proteína C reactiva
C) Radiografía de tórax
D) Serología para Bartonella
E) Hemocultivos seriados antes de iniciar antibióticos

Respuesta E. Fiebre prolongada en un niño con cardiopatía congénita, con soplo que cambia, esplenomegalia y fenómenos vasculares, sugiere endocarditis infecciosa (criterios de Duke). Lo fundamental es obtener 3 hemocultivos de punciones separadas antes de los antibióticos, y luego ecocardiograma. Los agentes más frecuentes son estreptococos del grupo viridans y Staphylococcus aureus.

2.01.1.052 Insuficiencia cardíaca

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-23

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia cardíaca en lactantes: taquipnea, sudoración y fatiga al alimentarse, mal incremento ponderal, taquicardia, hepatomegalia, ritmo de galope; edema periférico es raro.
- Causas: cardiopatías con cortocircuito izquierda-derecha (CIV grande, ductus, canal AV) en lactantes; miocarditis y miocardiopatías en mayores; también arritmias y anemia grave.

- Estudio: Rx tórax (cardiomegalia, congestión), ECG, ecocardiograma, BNP, gases y electrolitos.
- Manejo inicial: O2, posición semisentada, furosemida 1 mg/kg EV/VO, restricción hídrica moderada, aumentar densidad calórica de la alimentación; IECA (captopril) por especialista.
- Shock cardiogénico: evitar sobrecarga de volumen, apoyo inotrópico (milrinona, dobutamina) en UCI.
- Seguimiento: derivar a cardiología infantil.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 173

Lactante de 4 meses de edad, sin antecedentes conocidos, alimentado con lactancia materna exclusiva, es traído por bajo incremento ponderal, asociado a cansancio al alimentarse y decaimiento. Se aprecia decaído, con saturación arterial de 90%, examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos y soplo sistólico, y examen pulmonar con murmullo disminuido en bases y crepitaciones finas bilaterales. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A) Administrar furosemida endovenosa
B) Administrar vasodilatadores endovenosos
C) Administrar epinefrina endovenosa
D) Realizar intubación endotraqueal y ventilación mecánica
E) Administrar betabloqueadores endovenosos

Respuesta A. Cansancio al alimentarse, mal incremento ponderal, soplo y crepitaciones en un lactante sugieren insuficiencia cardíaca por cortocircuito izquierda-derecha (ej. CIV) con congestión pulmonar. El manejo inicial es diurético (furosemida) y oxígeno, y luego ecocardiograma. Los vasodilatadores pueden aumentar el cortocircuito y el paciente no tiene criterios de intubación.

2.01.1.053 Síncope

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.10 Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Síncope: pérdida transitoria de conciencia y tono con recuperación espontánea completa. Vasovagal es el más frecuente en adolescentes: pródromo (calor, náuseas, visión borrosa), gatillado por estar de pie, dolor o emoción.
- Evaluación: anamnesis, examen cardiovascular, presión ortostática y ECG de 12 derivaciones en todos (buscar QT largo, WPW, Brugada, bloqueo, HVI).
- Banderas rojas de síncope cardíaco: durante el ejercicio, en decúbito, precedido de palpitaciones, sin pródromo, con lesiones, historia familiar de muerte súbita <40 años, soplo patológico.
- Diferencial: crisis epiléptica (movimientos prolongados, confusión postictal), hipoglicemia, espasmo del sollozo en lactantes.
- Manejo del vasovagal: educación, ingesta de agua y sal, maniobras de contrapresión, evitar gatillantes.
- Seguimiento: derivar a cardiología si hay banderas rojas o ECG alterado; vasovagal típico se controla en APS.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una adolescente de 14 años, sana, presentó pérdida de conciencia de 20 segundos mientras estaba de pie en un acto escolar con calor. Antes sintió náuseas, calor, visión borrosa y palidez; tras caer se recuperó completamente en segundos, sin confusión. No tiene antecedentes familiares de muerte súbita. Su examen cardiovascular y neurológico y el electrocardiograma son normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar electroencefalograma
B) Solicitar TAC de cerebro
C) Solicitar Holter de ritmo y ecocardiograma
D) Educar sobre síncope vasovagal: hidratación y maniobras de contrapresión
E) Iniciar ácido valproico

Respuesta D. Pérdida de conciencia breve, con gatillante (bipedestación prolongada, calor), pródromo autonómico y recuperación rápida sin período postictal, con examen y ECG normales, es un síncope vasovagal, la causa más frecuente en adolescentes. Se maneja con educación, hidratación, sal y maniobras de contrapresión.

2.01.1.054 Soplos

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-23

QUÉ HAY QUE SABER

- Soplo inocente: muy frecuente (hasta 50% de niños), sistólico, suave (grado ≤2/6), corto, en borde esternal izquierdo, varía con la posición, sin frémito, con examen y desarrollo normales (soplo de Still, zumbido venoso).
- Soplo patológico: diastólico, holosistólico, grado ≥3/6 con frémito, segundo ruido alterado (desdoblamiento fijo en CIA), clic, asociado a síntomas.
- Banderas rojas: cianosis, pulsos femorales disminuidos (coartación), taquipnea, mal incremento ponderal, sudoración al alimentarse, síncope, RN con soplo.
- Estudio: saturometría, presión en 4 extremidades, ECG y Rx tórax; ecocardiograma confirma.
- Soplo inocente no requiere exámenes ni restricción; tranquilizar a la familia.
- Seguimiento: derivar a cardiología infantil todo soplo sospechoso, todo soplo en RN o lactante con síntomas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 154

Un niño de 13 años acude a control médico por una infección respiratoria alta. En su examen físico se ausculta un soplo paraesternal izquierdo, sistólico, de intensidad II/VI, sin otras alteraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Soplo inocente
B) Ductus arterioso persistente
C) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
D) Estenosis aórtica
E) Coartación aórtica

Respuesta A. Un soplo sistólico suave (grado II/VI o menor), paraesternal izquierdo, en un niño asintomático y en contexto febril o infeccioso (estado hiperdinámico), sin otros hallazgos, es un soplo inocente. Signos de soplo patológico: diastólico, holosistólico, grado III o más, frémito, clic, síntomas o pulsos alterados. El ductus da un soplo continuo.

2.01.1.055 Alergias

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.8 Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Urticaria aguda: ronchas pruriginosas evanescentes (<24 h cada lesión); en niños la causa más frecuente es infección viral, luego alimentos y fármacos. Antihistamínico 2ª generación (cetirizina, loratadina) por 1-2 semanas.
- Anafilaxia: compromiso cutáneo con respiratorio, cardiovascular o digestivo tras exposición; adrenalina IM 0,01 mg/kg (1 mg/ml) en cara anterolateral del muslo, máx 0,3 mg (niño) y 0,5 mg (adolescente), repetir c/5-15 min.
- Alergia a proteína de leche de vaca: lactante con proctocolitis (sangre en deposiciones), vómitos, eccema; dieta de exclusión materna o fórmula extensamente hidrolizada (aminoácidos si grave) y reintroducir tras 6-12 meses.
- Alergias alimentarias más frecuentes: leche, huevo, maní, frutos secos, pescado, mariscos; diagnóstico con historia, IgE específica o prick test y prueba de provocación.
- Educación: plan de acción escrito, autoinyector de adrenalina en anafilaxia, lectura de etiquetados.
- Seguimiento: control en APS; derivar a inmunología/alergia si anafilaxia, alergias múltiples o persistentes.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 178

Niño con rash urticarial, edema de labios, taquicardia y sensibilidad abdominal. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A) Adrenalina intramuscular
B) Difenhidramina endovenosa
C) Hidrocortisona endovenosa
D) Clorfenamina oral
E) Salbutamol inhalado

Respuesta A. Rash urticarial más angioedema de labios, taquicardia y dolor abdominal: son criterios de anafilaxia, con compromiso hemodinámico y digestivo asociado. El tratamiento inicial inmediato es siempre la adrenalina intramuscular, no los antihistamínicos ni los corticoides.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 91

Lactante de 2 meses con diarrea, vómitos y dermatitis perioral y perianal tras la introducción de fórmula láctea. El test de parche resulta positivo para proteína de leche de vaca. **¿Cuál es el manejo?**

A) Cambiar a fórmula extensamente hidrolizada o elemental
B) Continuar la fórmula habitual y agregar antihistamínico
C) Hospitalizar para estudio endoscópico
D) Iniciar corticoides orales
E) Cambiar a leche de soja

Respuesta A. Diarrea y vómitos, más dermatitis, tras introducir fórmula láctea: alergia a la proteína de leche de vaca. El tratamiento es retirar la proteína, con una fórmula extensamente hidrolizada o elemental. La leche de soja no se recomienda antes de los seis meses, por reactividad cruzada.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 34

Un niño de 4 años presenta ronchas evanescentes en el tronco y las extremidades desde hace 4 días. Además, desde hace algunos días presentaba congestión nasal, con coriza y estornudos. Al examen físico se observan habones en el tórax y dermografismo en las extremidades inferiores. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar corticoides orales
B) Solicitar prick test
C) Indicar antihistamínicos orales
D) Solicitar IgE sérica total
E) Solicitar test de parches

Respuesta C. Habones evanescentes de pocos días en un niño con un cuadro viral reciente corresponden a urticaria aguda, cuya causa más frecuente en pediatría son las infecciones virales. El tratamiento es antihistamínico H1 oral de segunda generación (ej. cetirizina). No requiere estudio alérgico; los corticoides quedan para casos graves o refractarios.

2.01.1.056 Inmunodeficiencias

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Inmunodeficiencias primarias: sospechar con infecciones recurrentes graves, por gérmenes oportunistas o de localización inusual, falla de crecimiento, historia familiar.
- Humoral (la más frecuente, ej. déficit IgA, agammaglobulinemia de Bruton): infecciones sinopulmonares por bacterias encapsuladas después de los 6 meses.
- Celular/combinada (inmunodeficiencia combinada grave): infecciones virales, fúngicas, Pneumocystis, diarrea crónica y desmedro desde los primeros meses; linfopenia.
- Fagocítica (enfermedad granulomatosa crónica): abscesos por S. aureus y hongos; complemento: infecciones por Neisseria recurrentes. Caída tardía del cordón: defecto de adhesión leucocitaria.
- Estudio inicial: hemograma con recuento absoluto de linfocitos, inmunoglobulinas, VIH; no administrar vacunas vivas (BCG, rotavirus, SRP, varicela) si sospecha de déficit celular.
- Seguimiento: derivar a inmunología pediátrica.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 136

Un lactante de 15 meses fue sano hasta los 6 meses de edad, pero desde entonces ha presentado candidiasis oral a repetición, cuatro otitis medias agudas y dos neumonías que han requerido hospitalización. **¿Cuál es la causa más probable de su inmunodepresión?**

A) Inmunodeficiencia humoral
B) Inmunodeficiencia combinada severa
C) Alteración de la fagocitosis
D) Déficit de complemento
E) Inmunodeficiencia celular

Respuesta A. Infecciones bacterianas sinopulmonares recurrentes (otitis, neumonías) que comienzan después de los 6 meses, cuando desaparece la IgG materna transferida, sugieren una inmunodeficiencia humoral (ej. agammaglobulinemia ligada al X). La inmunodeficiencia combinada severa se manifiesta desde los primeros meses con infecciones oportunistas graves y falla de crecimiento. Se estudia con cuantificación de inmunoglobulinas.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 12 · texto original del banco, sin revisar

Niño que después de los 6 meses presenta candidiasis bucal, otitis media recurrente y 2 neumonías hospitalizadas. ¿Cuál es la inmunodeficiencia más probable?

A) Inmunodeficiencia celular (DiGeorge)
B) Déficit de complemento
C) Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)
D) Inmunodeficiencia combinada severa (SCID)
E) Enfermedad granulomatosa crónica

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)). Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia). Prevención de transmisión vertical (madre VIH+): 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

2.01.1.057 Mesenquimopatías

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.13 Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

QUÉ HAY QUE SABER

- Mesenquimopatías pediátricas: lupus eritematoso sistémico (adolescentes mujeres), dermatomiositis juvenil, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo.
- LES: eritema malar, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, nefritis (proteinuria, hematuria), citopenias, compromiso neurológico; más grave en niños que en adultos.
- Dermatomiositis juvenil: debilidad muscular proximal simétrica, heliotropo, pápulas de Gottron, CK elevada.
- Estudio inicial: hemograma, VHS, PCR, función renal, orina completa, ANA; anti-DNA y complemento (C3, C4 bajos en LES activo), CK.
- Manejo inicial: AINE para artritis, fotoprotección; corticoides e inmunosupresores los indica el especialista.
- Seguimiento: derivar a reumatología pediátrica; urgencia si compromiso renal o neurológico.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 163

Un niño de 12 años consulta por cansancio, artralgias, dolores musculares generalizados y fiebre. Refiere que las mialgias son intensas, al punto que limitan su actividad física. Al examen físico presenta dolor a la palpación de las masas musculares, en especial en la espalda alta y los hombros. Además, tiene eritema violáceo en los párpados superiores.
¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis reumatoide juvenil
B) Distrofia muscular
C) Dermatomiositis
D) Triquinosis
E) Lupus infantil

Respuesta C. Debilidad y dolor muscular proximal con eritema heliotropo (violáceo palpebral) es dermatomiositis; en niños es la miopatía inflamatoria más frecuente. Se apoya con CK elevada, resonancia o biopsia muscular. A diferencia del adulto, la forma juvenil no se asocia a cáncer, pero sí a calcinosis y vasculopatía. La triquinosis da edema palpebral, no eritema heliotropo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 78 · texto original del banco, sin revisar

Escolar femenina de 12 años con artritis en múltiples articulaciones, fotosensibilidad, úlceras orales, proteinuria 4 g/24h, hematuria microscópica y ANA positivo 1:640. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Lupus eritematoso sistémico
B) Artritis idiopática juvenil
C) Dermatomiositis juvenil
D) Vasculitis sistémica
E) Enfermedad de Kawasaki

Respuesta A. LES: artritis + fotosensibilidad + úlceras orales + nefritis lúpica (proteinuria >3.5g + hematuria) + ANA positivo en patrón homogéneo. Cumple criterios SLICC para diagnóstico.

2.01.1.058 Vasculitis: PSH, Kawasaki, otros

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki · Tema 18.10 Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) · Tema 9.22 Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

QUÉ HAY QUE SABER

- Púrpura de Schönlein-Henoch (vasculitis IgA): la más frecuente en niños; púrpura palpable en extremidades inferiores y glúteos con plaquetas normales, artritis/artralgias, dolor abdominal y nefritis.
- PSH manejo: reposo, analgesia (paracetamol, AINE si función renal normal); prednisona si dolor abdominal intenso. Complicación: invaginación intestinal, nefropatía. Orina completa y PA seriadas por 6 meses.
- Enfermedad de Kawasaki: fiebre ≥5 días + ≥4 de 5: conjuntivitis bilateral no purulenta, cambios en labios/mucosa oral (lengua aframbuesada), exantema polimorfo, cambios en extremidades (edema, descamación periungueal), adenopatía cervical >1,5 cm.
- Kawasaki: inmunoglobulina 2 g/kg EV en 12 h + aspirina en dosis altas y luego bajas; idealmente en los primeros 10 días para prevenir aneurismas coronarios. Ecocardiograma al diagnóstico y a las 2 y 6 semanas.
- Kawasaki incompleto: fiebre ≥5 días con <4 criterios y laboratorio compatible (PCR alta, trombocitosis, anemia, piuria estéril).
- Seguimiento: derivar Kawasaki a hospital/cardiología; PSH con nefritis (proteinuria importante, HTA, falla renal) a nefrología.

PREGUNTAS (17)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 11

Niño de 8 años con fiebre de 39°C por 7 días de evolución, exantema polimorfo, adenopatías cervicales, conjuntivitis bilateral no exudativa y lengua en fresa. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Kawasaki
B) Mononucleosis infecciosa
C) Escarlatina
D) Artritis idiopática juvenil
E) Sarampión

Respuesta A. Fiebre ≥ 5 días + 4 criterios (exantema polimorfo, adenopatía cervical, conjuntivitis no exudativa, lengua en fresa): enfermedad de Kawasaki. Requiere ecocardiograma e IGEV + aspirina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 12

Un niño de 3 años presenta un cuadro de 6 días de evolución de fiebre hasta 39,2°C, asociado a malestar general y aparición de un rash eritematoso en tronco y extremidades. Al examen físico está decaído y febril a 38,7°C, se objetiva la presencia del rash descrito y se palpan adenopatías en la cadena cervical anterior e induración de la cicatriz de la vacuna BCG. **Además de solicitar hemograma, VHS y PCR, el examen de elección para continuar el estudio es:**

A) Títulos de anticuerpos antiestreptolisina O
B) Procalcitonina
C) PCR para Mycobacterium tuberculosis
D) Ecocardiograma
E) Serología para virus de Epstein Barr

Respuesta D. Fiebre ≥ 5 días con exantema y adenopatía cervical en un preescolar: sospecha de enfermedad de Kawasaki. El examen clave es el ecocardiograma, para buscar aneurismas coronarios, que determinan el pronóstico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 75

Un niño de 2 años presenta un cuadro de 7 días de fiebre hasta 39 grados, asociado a inyección conjuntival y boca roja con labios partidos, a lo que se agrega un exantema eritematoso generalizado. Al examen, se aprecia decaído, con fiebre de 38,8 grados, presenta adenopatías cervicales y se observa descamación gruesa de los dedos de las 4 extremidades. Se encuentra hospitalizado, recibiendo un tratamiento adecuado. **¿Cuál es la evolución más probable en este paciente?**

A) Daño permanente de las arterias coronarias
B) Recurrencia esporádica de los síntomas
C) Resolución completa, sin secuelas
D) Daño vascular periférico generalizado
E) Daño a las válvulas cardíacas

Respuesta C. Enfermedad de Kawasaki tratada adecuadamente (IGEV + aspirina): el riesgo de aneurismas baja de 25% a menos de 3–5%, por lo que lo más probable es la resolución completa sin secuelas.

Pregunta real · EUNACOM · Diagnóstico de Púrpura de Henoch-Schönlein

Niño de 7 años consulta por dolor abdominal cólico difuso, dolor en ambos tobillos y una erupción cutánea purulenta violácea sobreelevada en ambas extremidades inferiores y nalgas, de 4 días de evolución tras un cuadro de resfrío común. Al examen físico destaca abdomen blando pero doloroso a la palpación difusa sin peritonismo, rodillas y tobillos con aumento de volumen periarticular doloroso y púrpura palpable bilateral confluente en piernas. El hemograma muestra: hematocrito 38%, leucocitos 9.800/mm³, plaquetas 310.000/mm³. El examen de orina revela microhematuria (15 hematíes por campo) sin proteinuria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el pilar del manejo inicial?

A) Púrpura Trombocitopénico Inmune (PTI) · Inmunoglobulina endovenosa urgente
B) Meningococcemia fulminante · Ceftriaxona EV inmediata y aislamiento respiratorio
C) Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA) · Reposo, analgesia con paracetamol y monitorización ambulatoria estrecha de PA y orina
D) Síndrome Urémico Hemolítico · Transfusión urgente de plaquetas y plasmaféresis
E) Lupus eritematoso sistémico pediátrico · Ciclofosfamida endovenosa inmediata

Respuesta C. El cuadro clínico de púrpura palpable en extremidades inferiores y glúteos, artralgias/artritis y dolor abdominal cólico postinfeccioso con un recuento plaquetario rigurosamente normal (310.000/mm³) configura la tétrada diagnóstica del Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA). En ausencia de dolor abdominal intratable, sangrado digestivo o nefritis severa, el curso es típicamente benigno y autolimitado, requiriendo reposo, analgesia con paracetamol y vigilancia seriada de presión arterial y sedimento urinario.

Pregunta de práctica

Niño de 3 años con fiebre de 39,5 °C de 6 días que no cede con paracetamol ni ibuprofeno. Tiene inyección conjuntival bilateral intensa sin secreción, labios eritematosos secos con fisuras sangrantes, lengua aframbuesada, exantema maculopapular en tronco y edema duro con eritema en palmas y plantas. Ganglio cervical derecho único de 2 cm, no fluctuante. El ecocardiograma inicial no muestra alteraciones coronarias. **¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata?**

A) Amoxicilina oral 50 mg/kg/día por 10 días
B) Inmunoglobulina endovenosa 2 g/kg en infusión única + aspirina
C) Corticoides orales y control ambulatorio
D) Observación, ya que el ecocardiograma es normal
E) Vitamina A oral y notificación inmediata

Respuesta B. Fiebre ≥ 5 días + 5 de 5 criterios (conjuntivitis no exudativa, cambios orales, edema palmoplantar, exantema polimorfo, adenopatía cervical unilateral ≥ 1,5 cm): enfermedad de Kawasaki. IGEV 2 g/kg en infusión única + aspirina 30–50 mg/kg/día, antes del día 10 de fiebre, para prevenir los aneurismas coronarios. Un ecocardiograma inicial normal no permite observar.

Pregunta de práctica

Niña de 3 años, con fiebre de 39,5 °C durante 6 días, decaída. Al examen: inyección conjuntival bilateral sin secreción, labios agrietados y sangrantes, lengua roja con papilas marcadas, exantema polimorfo en el tronco, y edema doloroso de manos y pies. No hay adenopatías palpables. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Amoxicilina oral por 10 días, sospechando escarlatina
B) Inmunoglobulina endovenosa más ácido acetilsalicílico, y ecocardiograma
C) Observación domiciliaria, porque falta la adenopatía cervical
D) Aciclovir oral, sospechando varicela atípica
E) Antihistamínicos, sospechando una reacción alérgica

Respuesta B. Fiebre de 5 días o más (aquí 6) más 4 de los 5 criterios (ojos, boca, exantema, extremidades; falta solo la adenopatía) confirma Kawasaki. No necesitas los 5 criterios, basta con 4. El tratamiento urgente es inmunoglobulina más aspirina, con ecocardiograma para vigilar las coronarias.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 128 · texto original del banco, sin revisar

Un prescolar de 2 años, presenta un cuadro de fiebre alta, desde hace 5 días, asociado marcado decaimiento. Al examen físico presenta un exantema eritematoso en el tronco, asociado a eritema de las manos y ojo rojo. La boca muestra amígdalas congestivas y lengua enrojecida. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome pie mano boca
B) Eritema infeccioso
C) Escarlatina
D) Sarampión
E) Enfermedad de Kawasaki

Respuesta E. Diagnóstico: Enfermedad de Kawasaki (opción E). Es una enfermedad de Kawasaki clásica.. El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del médico general. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 53 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 8 años de edad presenta un cuadro de aparición de lesiones eritematosas en las extremidades inferiores y en los glúteos, asociado a dolor en ambos tobillos, a lo que luego se agrega dolor abdominal y vómitos. Al examen presenta lesiones eritematosas solevantadas en las zonas descritas, aumento de volumen en ambos tobillos y dolor abdominal difuso a la palpación. ¿Qué examen es más adecuado para definir el pronóstico de esta enfermedad?

A) Hemograma
B) Sedimento de orina
C) LDH
D) Perfil bioquímico
E) VHS

Respuesta B. Es un púrpura de Schönlein Henoch, cuyo pronóstico depende principalmente de la afectación renal. Se pide un sedimento de orina para determinar si hay glomerulonefritis y también creatinina para ver s hay insuficiencia renal y luego se sigue con examen de orina completa (muestra la hematuria y la proteinuria que pueden persistir, deteriorando el pronóstico).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 120 · texto original del banco, sin revisar

Niño con lesiones eritematosas en miembros inferiores (foto) con artralgias de tobillos de 2 días de evolución y dolor abdominal. Al examen físico presenta edema de ambos tobillos, con lesiones en las piernas, como las que se muestran en la siguiente imagen: Considerando las complicaciones frecuentes del cuadro, es importante solicitar:

A) Creatininemia
B) Hematocrito
C) Plaquetas
D) Protombinemia
E) Proteina C reactiva

Respuesta A. Es un púrpura de Schönlein Henoch, que se complica con glomerulonefritis e Insuficiencia renal. Es normal que se pregunte varias veces lo mismo en el Eunacom.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 21 · texto original del banco, sin revisar

Lactante 2 meses, cuadro de 7 días de fiebre, adenopatías, inyección conjuntival. a. Kawasaki

A) Control sano habitual
B) Derivar a especialista
C) Hospitalizar
D) Observación domiciliaria
E) Iniciar tratamiento empírico

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Control sano habitual). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Derivar a especialista, Hospitalizar) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 126 · texto original del banco, sin revisar

Un escolar de 8 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades infe- riores, consistentes en pápulas eritematosas, palpables. Refiere además artralgias mi- gratorias en las manos, rodillas y codos, y también hematoquezia en algunas oportuni- dades desde hace algunos días ¿Cuál es la complicación más probable en el mediano plazo?

A) Aneurismas coronarios
B) Infartos cerebrales
C) Hepatitis
D) Daño vascular periférico
E) Nefritis

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Nefritis). Es un púrpura de Schönlein Henoch, que suele producir glomerulonefritis.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 30 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 7 años es traído por su madre por un cuadro de una semana de evolución de aparición de lesiones eritematosas en ambas extremidades inferiores, a lo que se agregó dolor y edema en los tobillos. Al examen físico, se observa aumento de volumen en ambos tobillos, doloroso a la palpación. Se solicita hemograma, que resulta normal, al igual que el examen de orina completa y los niveles plasmáticos de creatinina. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Prednisona
B) Paracetamol
C) Gammaglobulina endovenosa
D) Ibuprofeno
E) Colchicina

Respuesta A. Púrpura de Schönlein-Henoch con complicaciones: El cuadro clínico sugiere una púrpura de Schönlein-Henoch, que generalmente se observa. Sin embargo, en presencia de complicaciones como falla renal, artritis o dolor abdominal, se recomienda el manejo con corticoides orales, específicamente prednisona.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 17 · texto original del banco, sin revisar

Niño con fiebre de 7 días, ojo rojo, lengua roja, adenopatías cervicales y exantema maculopapular. ¿Cuál es la complicación más probable?

A) Artritis reactiva
B) Miocarditis aguda
C) Aneurismas coronarios
D) Meningitis aséptica
E) Uveítis anterior

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Aneurismas coronarios). Aneurismas coronarios. El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del médico general. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 49 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 5 años presenta un cuadro de 7 días con fiebre alta, que no ha respondido al uso de antipiréticos, alcanzado peaks febriles de hasta 39°C. Al examen físico tiene T°: 38,6°C, pulso regular a 110x', inyección conjuntival bilateral, lengua muy enrojecida, faringe eritematosa, cuello con adenopatías submandibulares y presencia de un exantema eritematoso en el tronco y la zona genital. ¿Cuál es la complicación más probable?

A) Glomerulonefritis
B) Pericarditis
C) Hepatitis
D) Rotura esplénica
E) Aneurisma coronario

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Aneurisma coronario). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Glomerulonefritis, Pericarditis) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 26 · texto original del banco, sin revisar

Un niño presenta aparición de lesiones eritematosas en las extremidades inferiores, hace 7 días, las que se muestran más abajo, a lo que se ha agregado edema de ambos tobillos. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para identificar una complicación frecuente de esta patología?

A) Creatininemia
B) Coronariografía
C) Recuento de plaquetas
D) Radiografía de pelvis
E) Velocidad de eritrosedimentacón

Respuesta A. Es una púrpura de Schönlein Henoch y su complicación más importante y que marca el pronóstico es la GNA con la consecuente falla renal. De hecho, no solo se pide la creatinina, sino también sedimento y proteinuria.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 60 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 4 años presenta un cuadro de 2 días de evolución de aparición de múltiples lesiones eritematosas en las extremidades inferiores, palpables, asociado a dolor abdominal difuso y dolor de ambos tobillos. Al examen físico se palpa abdomen blando, depresible, doloroso leve, de manera difusa, sin signos peritoneales y los tobillos se aprecian aumentados de volumen, con dolor a la movilización. ¿Qué examen es más adecuado para definir el pronóstico de la enfermedad descrita?

A) Perfil bioquímico
B) Biopsia de médula ósea
C) Hemograma
D) Sedimento de orina
E) LDH

Respuesta D. Es un púrpura de Schönlein Henoch, que se complica con glomerulonefritis. El compromiso renal marca el pronóstico. De hecho, luego se sigue con orina completa (para ver la proteinuria y la hematuria).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 135 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 17 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades inferiores. Al interrogatorio, refiere que desde hace 5 días presenta dolor abdominal asociado a deposiciones diarreicas con estrías de sangre y que ha notado aumento de volumen en ambos tobillos. Hace un día nota aparición de lesiones eritematosas en ambas piernas que han aumentado de tamaño y can8dad. Al examen Fsico se observan petequias y pápulas violáceas palpables en ambas piernas y zona glútea. Entre sus exámenes destaca hemograma con hematocrito: 42%, hemoglobina: 13,1 g/dL, glóbulos blancos: 8.400/mm³ y plaquetas: 200.000/mm³. Refiere que ha tomado an8inflamatorios para el manejo del dolor abdominal. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Enfermedad de Kawasaki
B) Púrpura trombocitopénica inmune
C) Eritema nodoso
D) Púrpura de Schönlein-Henoch
E) Reacción a fármacos

Respuesta D. Es una Púrpura de Schönlein-Henoch clásica. Suele tener hemograma normal (no es trombocitopénica). Sus síntomas más frecuentes son 4: púrpura palpable de extremidades inferiores (puede afectar glúteos y extremidades superiores), compromiso renal (glomerulonefriGs, hematuria, falla renal), compromiso gastrointestinal (dolor abdominal, hematoquecia) y compromiso articular (artralgias y artriGs).

2.01.1.059 Enuresis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: ped-27

QUÉ HAY QUE SABER

- Enuresis: micción involuntaria durante el sueño en ≥5 años, ≥1 vez/semana por ≥3 meses. Primaria (nunca controló, la más frecuente) o secundaria (tras ≥6 meses seco).
- Monosintomática: sin síntomas diurnos; mecanismo poliuria nocturna, baja capacidad vesical y alto umbral de despertar; fuerte componente familiar; resolución espontánea ~15%/año.
- Evaluación: anamnesis (hábitos, síntomas diurnos, constipación), examen (columna lumbosacra, genitales), orina completa y urocultivo; descartar DM, ITU, apnea del sueño, abuso sexual en secundaria.
- Tratamiento: educación y desmitificar, sin castigos; restringir líquidos 1-2 h antes de dormir, micción antes de acostarse, calendario, tratar la constipación.
- Alarma de enuresis (primera línea, más efectiva a largo plazo) o desmopresina 0,2-0,4 mg VO al acostarse (efecto rápido, recaída al suspender; restringir líquidos por riesgo de hiponatremia).
- Seguimiento: control cada 1-3 meses en APS; derivar si enuresis no monosintomática, secundaria con alteración urológica o refractaria.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 7 años moja la cama casi todas las noches desde siempre. Durante el día controla la micción sin urgencia ni incontinencia, no tiene constipación y el examen físico, incluido el examen de orina, es normal. Nunca ha recibido tratamiento. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Ecografía renal y vesical y uretrocistografía
B) Educación y medidas conductuales (micción antes de dormir, reducir líquidos nocturnos, calendario)
C) Imipramina oral
D) Derivar a urología pediátrica
E) Indicar pañales hasta la adolescencia

Respuesta B. Enuresis primaria monosintomática: incontinencia nocturna en mayores de 5 años que nunca han logrado control, sin síntomas diurnos. Es frecuente y benigna. El manejo inicial es desculpabilizar, educar y aplicar medidas conductuales; si fracasan, alarma de enuresis o desmopresina. No requiere imágenes si el examen y la orina son normales. La imipramina está en desuso por su toxicidad.

2.01.1.060 Hematuria

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.15 Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Hematuria: ≥5 GR/campo en sedimento de orina centrifugada; confirmar microscópicamente (tira reactiva positiva sin GR: mioglobinuria o hemoglobinuria; orina roja sin heme: alimentos, fármacos).
- Glomerular: orina color coca-cola, GR dismórficos, cilindros hemáticos, proteinuria, HTA, edema (GNAPE, nefropatía IgA, PSH, Alport).
- No glomerular: orina roja con coágulos, GR eumórficos (ITU, hipercalciuria, litiasis, trauma, tumor de Wilms, malformaciones).
- Estudio inicial: orina completa con sedimento, urocultivo, creatinina, calciuria/creatininuria, C3, ecografía renal y vesical.
- Microhematuria aislada asintomática: repetir orina en 2-3 semanas; persistente: estudio. Hipercalciuria idiopática es causa frecuente.
- Seguimiento: derivar a nefrología si proteinuria, HTA, falla renal, hematuria glomerular persistente o historia familiar de nefropatía/sordera.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 100

Un niño de 7 años se encuentra en el preoperatorio de una cirugía de fimosis. Entre los exámenes prequirúrgicos, el examen de orina reporta 2 a 5 leucocitos por campo, 10 a 15 eritrocitos por campo y proteínas 5 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar índice albúmina/creatinina en orina
B) Solicitar creatinina y calcio en una muestra de orina aislada
C) Repetir el examen de orina
D) Solicitar proteinuria en orina de 24 horas
E) Solicitar títulos de antiestreptolisina O

Respuesta C. Microhematuria aislada, asintomática, sin proteinuria significativa, sin HTA ni edema, es un hallazgo frecuente y muchas veces transitorio. Lo primero es repetir el examen de orina (2 a 3 muestras en semanas). Solo si persiste se estudia: calciuria/creatininuria, función renal, imágenes y antecedentes familiares.

2.01.1.061 Hipertensión arterial

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- HTA pediátrica: PA ≥p95 para edad, sexo y talla en 3 ocasiones (≥13 años: ≥130/80). PA elevada p90-p95. Medir PA desde los 3 años en cada control.
- Etapa 2: ≥p95 + 12 mmHg o ≥140/90; derivar con prontitud.
- En niños pequeños predomina la HTA secundaria: renal (la más frecuente: cicatrices, glomerulopatías), renovascular, coartación aórtica, endocrinas. En adolescentes obesos, esencial.

- Estudio inicial: orina completa, creatinina, electrolitos, perfil lipídico, glicemia, ecografía renal con doppler; ecocardiograma (HVI) y fondo de ojo; PA en 4 extremidades (coartación).
- Manejo inicial: dieta DASH, baja de sal, actividad física, baja de peso; fármaco (IECA, bloqueador de calcio) si HTA sintomática, secundaria, daño de órgano blanco o falla de medidas.
- Seguimiento: derivar a nefrología pediátrica para estudio de HTA secundaria y manejo farmacológico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 6 años, asintomático, presenta presión arterial sobre el percentil 95 para su edad, sexo y talla en tres controles separados. Su IMC es normal. **¿Cuál es la causa más probable de su hipertensión?**

A) Enfermedad del parénquima renal
B) Hipertensión esencial
C) Feocromocitoma
D) Hipertiroidismo
E) Hiperaldosteronismo primario

Respuesta A. En niños pequeños, sobre todo menores de 10 años y sin obesidad, la hipertensión suele ser secundaria, y la causa más frecuente es la enfermedad renal parenquimatosa (cicatrices por pielonefritis, glomerulopatías, displasias), seguida de la renovascular y la coartación aórtica. La hipertensión esencial predomina en adolescentes con obesidad o antecedentes familiares. El estudio inicial incluye orina, creatinina y ecografía renal.

2.01.1.062 Infección urinaria

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- ITU: lactante con fiebre sin foco, vómitos, irritabilidad, rechazo alimentario; preescolar/escolar con disuria, polaquiuria, enuresis secundaria. E. coli >80%.
- Muestra: sin control de esfínter, sondeo vesical o punción suprapúbica; bolsa recolectora solo descarta si es negativa. Con control: segundo chorro limpio.
- Urocultivo positivo: chorro medio ≥100.000 UFC/ml, sondeo ≥10.000 (algunas guías ≥50.000), punción suprapúbica cualquier recuento.
- Cistitis: cefadroxilo 50 mg/kg/día c/12 h o nitrofurantoína 5-7 mg/kg/día por 5-7 días. Pielonefritis ambulatoria: cefadroxilo o cefixima 7-10 días; hospitalizar si <3 meses, tóxico o vómitos (ceftriaxona o amikacina EV).
- Imágenes: ecografía renal y vesical tras primera ITU febril; uretrocistografía miccional si eco alterada, ITU atípica o recurrente (reflujo vesicoureteral); cintigrama DMSA a los 6 meses por cicatrices.
- Seguimiento: derivar a nefrología si ITU recurrente, reflujo, eco alterada o cicatrices; tratar constipación y disfunción miccional.

PREGUNTAS (12)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 156

Niña de 8 meses con cuadro febril hasta 39,2 °C, sin otros síntomas ni alteraciones al examen físico. Se realiza un urocultivo por recolector, que resulta positivo para Escherichia coli sensible, con 45.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tratar con cefadroxilo oral
B) Tratar con nitrofurantoína oral
C) Tratar con amoxicilina oral
D) Solicitar hemograma, VHS y PCR
E) Repetir el urocultivo por sondeo vesical

Respuesta E. El urocultivo por bolsa recolectora solo es positivo si supera las 100.000 UFC por mililitro. Con 45.000, el único paso aceptable es repetirlo con una técnica fidedigna: sondeo vesical.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 50

Niño de 3 años, con antecedente de fimosis, con fiebre hasta 39,5 °C desde hace 48 horas, asociada a vómitos y malestar general. Examen cardiopulmonar y abdominal sin alteraciones relevantes. Sedimento de orina con 20 glóbulos rojos y 50 glóbulos blancos por campo, bacterias en moderada cantidad; hemograma con 14.000 leucocitos por milímetro cúbico y VHS de 42 milímetros por hora. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Balanopostitis
B) Neumonía adquirida en la comunidad
C) Influenza
D) Síndrome hemolítico urémico
E) Pielonefritis aguda

Respuesta E. La fimosis puede orientar a balanopostitis o a pielonefritis; la balanopostitis da alteraciones cutáneas del prepucio sin fiebre alta. Aquí la leucocituria elevada junto con la fiebre define la pielonefritis aguda.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 135 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 18 meses presenta un cuadro de fiebre hasta 39 grados, asociado a decaimiento e irritabilidad. La madre refiere orinas de mal olor, por lo que se realiza un examen de orina por sondeo, que da salida a un líquido con abundante bacterias, 50 piocitos por campo y escasa hematuria. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Ciprofloxacino
B) Cefadroxilo
C) Nitrofurantoína
D) Gentamicina
E) Cefoperazona

Respuesta B. La ITU baja en pediatría se trata con cefalosporinas de primera o segunda generación. Tampoco se usan las quinolonas, por lo mismo.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 29 · texto original del banco, sin revisar

Niño de 8 meses con fiebre, orina por recolector con leucocituria y bacterias abundantes. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar antibiótico oral de inmediato
B) Repetir el examen de orina por sondeo vesical
C) Hospitalizar y tratar ITU febril
D) Solicitar ecografía renal y vesical
E) Derivar a nefrología pediátrica

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Repetir el examen de orina por sondeo vesical (opción B). Repetir el examen de orina por sondeo vesical. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 83 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 4 años presenta disuria, asociada a molestias abdominales, sin fiebre. Su examen físico no tiene alteraciones. Se solicita sedimento de orina, que muestra 6 a 8 glóbulos blancos por campo y urocultivo, que muestra desarrollo de Escherichia coli multisensible, con 60.000 UFC por mm3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el sedimento y urocultivo
B) Iniciar cefadroxilo 50 mg/Kg/día, por 5 días
C) Iniciar nitrofurantoína 5-7 mg/Kg/día, por 7 días
D) Solicitar cintigrafía DSMA
E) Solicitar ecografía abdominal

Respuesta A. En estricto rigor no tiene una ITU, dado que tiene menos de 100.000 colonias en el cultivo de orina obtenida por micción. Dentro de las opciones de manejo están 1. repetirlo y 2. tomar el cultivo por sonda (requiere 10.000 UFC/mm3) o por punción (basta 1 UFC). Una vez que se confirme el diagnóstico recién estaría indicado tratar (B o C sirven) y posteriormente estudiar con la ecografía (toda ITU e

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 134 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 5 años consulta por disuria dolorosa, asociado a orinas turbias y de mal olor, sin fiebre. Se solicita un examen de orina por sondeo, que muestra 20 a 30 leucocitos por campo, con 3 a 4 glóbulos rojos por campo y bacterias abundantes. El urocultivo está pendiente. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección?

A) Nitrofurantoína
B) Ciprofloxacino
C) Metronidazol
D) Amoxicilina
E) Cefoperazona

Respuesta A. La ITU baja en pediatría se trata con cefalosporinas de primera generación o con nitrofurantoína. No se usan quinolonas, por su potencial afectación del cartílago de

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 117 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 14 meses presenta fiebre hasta 38,6°C desde hace dos días. El examen físico no identifica un foco, por lo que se solicitan exámenes de orina, con muestra obtenida por recolector, que muestra sedimento con 10 glóbulos blancos por campo, 2 a 4 glóbulos rojos por campo, células epiteliales en regular cantidad, bacterias en moderada cantidad y citoquímico con nitritos negativos, ausencia de glucosuria y proteinuria, ausencia de cristales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar cintigrafía renal
B) Solicitar ecografía renal y vesical
C) Solicitar examen de orina por sondeo
D) Iniciar cefadroxilo oral
E) Iniciar ceftriaxona endovenosa

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar examen de orina por sondeo (opción C). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 72 · texto original del banco, sin revisar

Lactante de 18 meses, irritable , con sedimento y urocultivo (+), fiebre y decaimiento hace 3 días, antibiograma sensible a imipenem, cipro, Amikacina. ¿qué tratamiento indicar? a. Amikacina b. Carbapenemicos

A) Control sano habitual
B) Derivar a especialista
C) Hospitalizar
D) Observación domiciliaria
E) Iniciar tratamiento empírico

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Control sano habitual (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Derivar a especialista, Hospitalizar) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la present

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 81 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 6 años, con cuadro caracterizado por disuria, polaquiuria y orinas de mal olor desde hace 2 días, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca temperatura de 36.5ºC, abdomen blando, depresible y no doloroso a la palpación, puño percusión negativa. Se realiza sedimento de orina que muestra 6 eritrocitos y 15 leucocitos por campo, además se solicita urocultivo de segundo chorro en el que hay crecimiento de escherichia coli con 60.000 unidades formadoras de colonia multisensible. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Iniciar Cefadroxilo oral
B) Iniciar Nitrofurantoina oral
C) Solicitar Ecografía renal y vesical
D) Solicitar cintigrafía renal estática
E) Repetir sedimento de orina y urocultivo

Respuesta E. Urocultivo está negativo. Idealmente repetirlo por sondeo, porque el sedimento está dudoso y la clínica es sugerente. Pregunta muy rara y difícil. Probablemente venía redactada de una forma distinta en la prueba origina. De las opciones, la más aceptable, dado que el urocultivo es menor a 100 mil colonias, es la repetición.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 49 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 3 años, con antecedente de fimosis, presenta fiebre alta, hasta 39,5°C, desde hace 48 horas, asociada a vómitos y malestar general. Su examen físico muestra frecuencia cardíaca: 130x', T°: 39,0°C, faringe congestiva, examen cardiopulmonar y abdominal sin alteraciones relevantes. Se solicitan exámenes: sedimento de orina con 20 GR/campo, 50 GB/campo, bacterias en moderada cantidad; hemograma con leucocitos 14.000/mm3, VSG: 42 mm/h. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Balanopostitis
B) Neumonía adquirida en la comunidad
C) Influenza
D) Síndrome hemolítico urémico
E) Pielonefritis aguda

Respuesta E. Pielonefritis aguda: La fimosis puede orientar a balanopostitis o pielonefritis. La balanopostitis presenta alteraciones cutáneas en prepucio y glande, sin fiebre alta. La leucocituria elevada (50 GB/campo) junto con la fiebre indica pielonefritis aguda.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 8 · texto original del banco, sin revisar

Guagua de 2 meses con ITU x atipico (nitritos (-)), fiebre, irritabilidad, con 60 blancos, bacterias abundantes: a. Hospitalizar + ATB amplio espectro. (ITU < 2 meses, ITU Atipica) b. ATB vo y control con UC (la guagua estaba regio, sgy igual podia ser esa), no, menor a 3 es indicación absoluta de hospitalizar (mmm, pero estaba febril, así que la sospecha era PNA) Y estaba “decaído”

A) Staphylococcus aureus
B) Streptococcus pneumoniae
C) Escherichia coli
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Klebsiella pneumoniae

Respuesta A. Diagnóstico: Staphylococcus aureus (opción A). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 30 · texto original del banco, sin revisar

ITU febril en guagua. ATB con resistencia pero sensible a nitrofurantoína. Cual le dejas (entregaban antibiograma, era E.Coli blee positivo):

A) Carbapenemico (blee se trata con carbapenemicos) b. Amikacina (¿¿pero amika le pegaba bien o no?, SII, salia sensible a AMIKA). Era amika todo el rato. Amika definitivamente c. Las E. Coli BLEE se tratan con carbapenémicos, siempre, independientemente de a qué más sea sensible
B) Control sano habitual
C) Derivar a especialista
D) Hospitalizar
E) Observación domiciliaria

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Carbapenemico (blee se trata con carbapenemicos) b. Amikacina (¿¿pero amika le pegaba bien o no?, SII, salia sensible a AMIKA). Era amika todo el rato. Amika definitivamente c. Las E. Coli BLEE se tratan con carbapenémicos, siempre, independientemente de a qué más sea sensible). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigenci

2.01.1.063 Insuficiencia renal aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

QUÉ HAY QUE SABER

- Lesión renal aguda: aumento de creatinina ≥1,5 veces basal o diuresis <0,5 ml/kg/h por 6-8 h (criterios pRIFLE/KDIGO).
- Prerrenal (la más frecuente: deshidratación, shock): FENa <1%, osmolaridad urinaria alta; renal: SHU (principal causa en lactantes en Chile), GNAPE, NTA, nefrotóxicos; postrenal: válvulas de uretra posterior, obstrucción.
- Estudio: creatinina, BUN, electrolitos, gases, hemograma con frotis (esquistocitos), orina completa, ecografía renal.
- Manejo inicial: corregir volemia (bolo SF 10-20 ml/kg si hipovolemia), luego balance estricto (pérdidas insensibles + diuresis), suspender nefrotóxicos, ajustar dosis de fármacos.

- Hiperkalemia >6 mEq/L o con cambios en ECG: gluconato de calcio, salbutamol, insulina con glucosa, bicarbonato; indicaciones de diálisis: hiperkalemia, sobrecarga de volumen, acidosis o uremia refractarias.
- Seguimiento: hospitalizar y derivar a nefrología pediátrica.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un niño de 3 años presentó diarrea con sangre hace una semana, ya resuelta. Ahora está pálido, decaído y orina poco. Exámenes: hemoglobina 7,5 g/dL con esquistocitos en el frotis, plaquetas 45.000/mm3, LDH elevada, Coombs directo negativo y creatinina 2,1 mg/dL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
>
> **A)** Púrpura trombocitopénica inmune
> **B)** Glomerulonefritis postestreptocócica
> **C)** Síndrome hemolítico urémico
> **D)** Anemia hemolítica autoinmune
> **E)** Deshidratación con falla prerrenal
>
> Respuesta C. Anemia hemolítica microangiopática (esquistocitos, LDH alta, Coombs negativo), trombocitopenia e injuria renal aguda tras una diarrea disentérica es síndrome hemolítico urémico, por E. coli productora de toxina Shiga. Es la principal causa de injuria renal aguda intrínseca en preescolares en Chile. Manejo de soporte; los antibióticos no están indicados.

2.01.1.064 Insuficiencia renal crónica

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- ERC pediátrica: alteración estructural o funcional >3 meses o VFG <60 ml/min/1,73 m²; estimar con fórmula de Schwartz (0,413 × talla cm / creatinina).
- Causas: malformaciones renales y de vía urinaria (CAKUT: hipodisplasia, uropatías obstructivas, reflujo) las más frecuentes; luego glomerulopatías.
- Clínica: talla baja, anemia, poliuria/polidipsia, HTA, acidosis metabólica, osteodistrofia renal (raquitismo), retraso del desarrollo.
- Manejo inicial: controlar PA (IECA), corregir acidosis con bicarbonato, anemia (hierro, eritropoyetina), calcio/fósforo/PTH, nutrición adecuada y vacunas (hepatitis B).
- Evitar nefrotóxicos (AINE, aminoglicósidos, contraste); ajustar dosis de fármacos según VFG.
- Seguimiento: derivar a nefrología pediátrica; ERC terminal (diálisis y trasplante) es GES.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> En un policlínico de nefrología infantil se revisa la etiología de los niños con enfermedad renal crónica. **¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en niños?**
>
> **A)** Nefropatía diabética
> **B)** Nefropatía hipertensiva
> **C)** Nefropatía por IgA
> **D)** Malformaciones congénitas del riñón y vía urinaria (uropatías obstructivas y displasias)
> **E)** Enfermedad renal poliquística autosómica dominante
>
> Respuesta D. En pediatría, especialmente en menores de 5 años, la principal causa de enfermedad renal crónica son las anomalías congénitas del riñón y la vía urinaria: hipoplasia o displasia renal, uropatías obstructivas como válvulas de uretra posterior y reflujo vesicoureteral con nefropatía. Las glomerulopatías ganan importancia en escolares y adolescentes; la diabetes y la hipertensión son causas del adulto.

2.01.1.065 Malformaciones urogenitales

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Malformaciones urogenitales: hidronefrosis antenatal (la más frecuente detectada por eco), reflujo vesicoureteral, estenosis pieloureteral, válvulas de uretra posterior, riñón multiquístico, hipospadias.

- Válvulas de uretra posterior: varón con hidronefrosis bilateral, chorro débil, globo vesical, ITU precoz, falla renal; urgencia urológica.
- Hipospadias: meato ventral; no circuncidar (prepucio se usa para reparación). Hipospadias con criptorquidia bilateral: estudiar desarrollo sexual diferente (HSC).
- Hidronefrosis antenatal: eco renal post natal después de las 48-72 h (antes subestima por oliguria fisiológica); profilaxis antibiótica según grado.
- Manejo inicial: tratar ITU, profilaxis antibiótica en hidronefrosis grave o reflujo de alto grado (amoxicilina en <2 meses, luego nitrofurantoína o cefadroxilo en dosis baja).
- Seguimiento: derivar a urología/nefrología infantil.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Niña de 2 años, con su segunda infección urinaria febril en 6 meses, confirmada por sondeo vesical y ya tratada con buena respuesta. La ecografía renal y vesical muestra dilatación de la pelvis renal y del uréter izquierdos. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**
> **A)** Cintigrama renal con DMSA en fase aguda
> **B)** Pielografía endovenosa
> **C)** Urocultivo mensual por 1 año
> **D)** Uretrocistografía miccional
> **E)** TAC de abdomen con contraste
> Respuesta D. Una ecografía alterada (ureterohidronefrosis) o una infección urinaria febril recurrente obligan a buscar reflujo vesicoureteral, la malformación más asociada a infección urinaria. La uretrocistografía miccional lo diagnostica y clasifica en grados.

2.01.1.066 Síndrome edematoso

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome edematoso: acumulación de líquido intersticial; en niños la causa más frecuente es renal (síndrome nefrótico).
- Orientación: edema palpebral matinal blando que migra a declive (nefrótico); con hematuria e HTA (nefrítico); con hepatomegalia y ascitis (hepático); con disnea y hepatomegalia (cardíaco); desnutrición (Kwashiorkor); enteropatía perdedora de proteínas.
- Estudio inicial: orina completa, proteinuria (índice proteinuria/creatininuria), albúmina, colesterol, creatinina, electrolitos, transaminasas; Rx de tórax si sospecha cardíaca.
- Manejo inicial: restricción de sodio, tratar la causa; diuréticos con cautela (riesgo de hipovolemia en nefrótico con albúmina muy baja).
- Banderas rojas: anasarca, dificultad respiratoria, oliguria, HTA grave, signos de hipovolemia o trombosis.
- Seguimiento: derivar a nefrología/cardiología/gastroenterología según causa.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un niño de 5 años consulta por edema palpebral matinal de 5 días, que luego se extiende a las piernas. No tiene disnea, ictericia ni diarrea. Al examen la presión arterial es normal y el edema es blando, con fóvea. **¿Cuál es el examen inicial más útil para orientar la causa del edema?**
> **A)** Ecocardiograma
> **B)** TSH y T4 libre
> **C)** Pruebas hepáticas
> **D)** Ecografía abdominal
> **E)** Examen de orina completa con proteinuria
> Respuesta E. En un niño con edema generalizado sin síntomas cardíacos ni hepáticos, la causa más frecuente es el síndrome nefrótico. El primer examen es la orina completa: proteinuria marcada (y luego índice proteinuria/creatininuria) junto con albuminemia y perfil lipídico. La hematuria e HTA orientan a síndrome nefrítico. Las causas cardíacas, hepáticas o por desnutrición se buscan si la orina es normal.

2.01.1.067 Síndrome hemolítico urémico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 8.10 Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU · Tema 18.11 Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome hemolítico urémico: anemia hemolítica microangiopática (esquistocitos, LDH alta, Coombs negativo), trombocitopenia y lesión renal aguda.
- Típico: E. coli productora de toxina Shiga (O157:H7); niño <5 años con diarrea disentérica 5-10 días antes, luego palidez, oliguria, edema, petequias e HTA. Chile tiene alta incidencia; principal causa de IRA en lactantes.
- Estudio: hemograma con frotis, plaquetas, LDH, bilirrubina, creatinina, electrolitos, orina completa, coprocultivo/PCR para STEC.
- Manejo inicial: hospitalizar, balance hídrico estricto, evitar sobrecarga, tratar HTA y electrolitos; transfundir GR si Hb <7 g/dL; diálisis según necesidad.
- No usar antibióticos ni antidiarreicos en diarrea por STEC; evitar transfundir plaquetas salvo sangrado. Notificación obligatoria.
- Seguimiento: derivar a nefrología; control a largo plazo de PA, proteinuria y función renal por riesgo de ERC.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 122

Una niña de 3 años presenta, hace 4 días, un cuadro de diarrea y fiebre hasta 38ºC, a la que se agrega sangre en las deposiciones, 48 horas después. En su examen físico se ve decaída, pálida y en sus exámenes destaca hematocrito de 28%, leucocitos 9.800, plaquetas 75.000, BUN 28, creatinina 2,3 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Leucemia aguda
B) Síndrome hemolítico urémico
C) Shock Séptico
D) Glomerulonefritis aguda
E) Púrpura de Schölein Henoch

Respuesta B. SHU clásico: niña pequeña, diarrea con sangre, falla renal aguda grave, anemia y trombocitopenia.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 61

Un niño de 5 años es hospitalizado por una neumonía con hemocultivos positivos para Streptococcus pneumoniae. Está en tratamiento con ceftriaxona endovenosa. Al tercer día evoluciona con deterioro del estado general y oliguria, por lo que se solicitan exámenes que muestran creatinina: 3,1 mg/dL, BUN: 68 mg/dL, hemograma con hematocrito: 27%, hemoglobina: 9 g/dL, glóbulos blancos: 13.000/mm³, 70% de neutrófilos y plaquetas 70.000/mm³, el tiempo de protrombina resulta 16,2 segundos y los niveles de complemento muestran C3: 81 mg/dL (normal: 90–180 mg/dL) y C4: 8,5 mg/dL (normal: 11–40 mg/dL). El sedimento de orina muestra hematuria con 15% de dismorfia. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Coagulación intravascular diseminada
B) Glomerulonefritis aguda posinfecciosa
C) Síndrome hemolítico urémico
D) Sepsis por neumococo
E) Insuficiencia renal aguda prerrenal

Respuesta C. SHU: falla renal aguda con anemia y plaquetopenia. Sus causas incluyen E. coli enterohemorrágica, Shigella y también Streptococcus pneumoniae. La glomerulonefritis posinfecciosa aparece días después, suele ser por S. pyogenes y no da plaquetopenia.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 17 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 3 años presenta, desde hace 2 días, edema de extremidades inferiores, de la cara y de la zona escrotal, asociado a malestar general. Hace 4 días está con diarrea. Al examen físico se aprecia pálido, se constata el edema blando y se observan múltiples equimosis en las extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 3,0 mg/dl, BUN: 35 mg/dl, hemograma con hematocrito: 28%, plaquetas: 120.000, blancos: 11.000 por mm3, frotis con esquistocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome nefrótico
B) Púrpura de Schönlein Henoch
C) Insuficiencia renal prerrenal
D) Glomerulonefritis aguda posestreptocócica
E) Síndrome hemolítico urémico

Respuesta E. Es un SHU clásico: falla renal, anemia hemolítica y plaquetopenia. Suele estar precedido por diarrea en el 70% de los casos. La IRA prerrenal no tiene edema.

2.01.1.068 Síndrome nefrítico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.3 Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome nefrítico: hematuria (orina coca-cola), edema, HTA y oliguria, con o sin falla renal.
- GNAPE: 5-12 años, 1-3 semanas post faringoamigdalitis o 3-6 semanas post impétigo por S. pyogenes; C3 bajo transitorio (normaliza en 6-8 semanas), ASO elevado.
- Estudio: orina completa (GR dismórficos, cilindros hemáticos), creatinina, electrolitos, C3, C4, ASO, proteinuria.
- Manejo inicial: restricción de sodio y líquidos, furosemida 1-2 mg/kg si edema o HTA, antihipertensivo (amlodipino/nifedipino) si HTA persiste; penicilina si infección estreptocócica activa.
- Complicaciones: encefalopatía hipertensiva (convulsiones), insuficiencia cardíaca congestiva, IRA.
- Derivar a nefrología si C3 bajo >8 semanas, proteinuria nefrótica, falla renal progresiva o hematuria macroscópica persistente; microhematuria puede durar hasta 1-2 años.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 64

Un niño de 7 años presenta edema de párpados y de extremidades inferiores, asociado a orinas oscuras. Al examen tiene edema palpebral y de ambas piernas, con presión arterial de 127/85 mmHg. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome nefrítico
B) Síndrome nefrótico
C) Enfermedad de Berger
D) Necrosis tubular aguda
E) Síndrome hemolítico urémico

Respuesta A. Edema, hematuria macroscópica (orinas oscuras) e hipertensión (127/85 es elevada para 7 años) conforman el síndrome nefrítico; en escolares la causa más frecuente es la glomerulonefritis postestreptocócica. El nefrótico cursa con edema y proteinuria masiva, sin HTA ni hematuria importante. La enfermedad de Berger da hematuria sincrónica con la infección, generalmente sin edema.

2.01.1.069 Síndrome nefrótico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome nefrótico: proteinuria masiva (≥40 mg/m²/h o índice proteinuria/creatininuria >2), hipoalbuminemia <2,5 g/dL, edema y dislipidemia.
- Causa más frecuente en niños 2-8 años: enfermedad por cambios mínimos, que responde a corticoides; sin hematuria, HTA ni falla renal.
- Tratamiento inicial (por especialista): prednisona 60 mg/m²/día (máx 60 mg) por 4-6 semanas y luego 40 mg/m² en días alternos 4-6 semanas.
- Medidas: dieta sin sal, normoproteica; diuréticos con precaución; albúmina EV solo si edema refractario o hipovolemia sintomática.

- Complicaciones: peritonitis bacteriana espontánea por neumococo, trombosis, hipovolemia. Biopsia si edad <1 o >10 años, hematuria, HTA, C3 bajo o corticorresistencia.
- Seguimiento: derivar a nefrología pediátrica; vigilar recaídas con tira reactiva en orina en domicilio.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 60

Un lactante de 2 años es traído por presentar aumento de volumen facial y edema de las extremidades inferiores. La madre refiere, además, que presenta orinas espumosas desde hace una semana. Al examen físico se observa edema blando de las extremidades inferiores y de la cara. Su frecuencia cardíaca es 80 latidos por minuto y su presión arterial es 87/54 mmHg. Se solicitan exámenes, destacando examen de orina con 2 glóbulos rojos por campo y proteinuria: 4+, creatinina: 0,7 mg/dL, BUN: 12 mg/dL, albuminemia: 2,7 g/dL, colesterol total: 310 mg/dL y triglicéridos plasmáticos: 560 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar prednisona vía oral en alta dosis
B) Derivar para biopsia renal
C) Iniciar diuréticos
D) Indicar dieta baja en sodio y en potasio
E) Realizar hemodiálisis

Respuesta A. Síndrome nefrótico puro en un niño: lo más probable es la enfermedad por cambios mínimos (90 % en niños), que se trata con prednisona oral en dosis altas sin biopsia previa. La biopsia se reserva para la falta de respuesta o el nefrótico impuro.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 60

Un niño de 2 años es traído por aumento de volumen facial y edema de las extremidades inferiores. La madre refiere orinas espumosas desde hace una semana. Al examen físico se observa edema blando de extremidades inferiores y cara, frecuencia cardíaca 80/min y presión arterial 87/54 mmHg. Exámenes: orina con 2 glóbulos rojos por campo y proteinuria 4+, creatinina 0,7 mg/dL, BUN 12 mg/dL, albuminemia 2,7 g/dL, colesterol total 310 mg/dL y triglicéridos 560 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar prednisona vía oral en dosis alta
B) Derivar para biopsia renal
C) Iniciar diuréticos
D) Indicar dieta baja en sodio y en potasio
E) Realizar hemodiálisis

Respuesta A. Edema, proteinuria masiva, hipoalbuminemia y dislipidemia sin hematuria, HTA ni falla renal es un síndrome nefrótico puro, que entre 1 y 10 años corresponde casi siempre a enfermedad de cambios mínimos. Se trata empíricamente con prednisona oral en dosis alta (60 mg/m2/día). La biopsia se reserva para corticorresistencia, edad atípica o síndrome impuro.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 22 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 4 años, presenta un cuadro de 10 días de evolución de edema bipalpebral, a lo que se ha agregado, en los últimos dos días, oliguria y orinas espumosas. Al examen físico presenta presión arterial 102/62 mmHg, FC: 80x', edema facial y de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca examen de orina con proteínas ++, creatininemia 0,9 mg/dl y BUN: 20 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome nefrótico
B) Glomerulonefritis aguda
C) Insuficiencia renal crónica
D) Síndrome hemolítico urémico
E) Nefritis intersticial

Respuesta A. Es un síndrome nefrótico clásico (orina espumosa, edema y proteinuria), aunque le faltan los exámenes confirmatorios (proteinuria cuantitativa o índice proteinuria / creatininuria, albumnemia y perfil lipídico). No hay hematuria dismórfica, así que no puede ser una glomerulonefritis. No tiene insuficiencia renal, así que no puede ser ninguna de las otras opciones.

2.01.1.070 Trastornos del equilibrio ácido-base

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Interpretación: pH <7,35 acidosis, >7,45 alcalosis; HCO3 bajo metabólica, pCO2 alta respiratoria. Calcular anión gap = Na - (Cl + HCO3) (normal 8-12).
- Acidosis metabólica con AG elevado: cetoacidosis diabética, láctica (shock), IRA, intoxicaciones (salicilatos, metanol). AG normal (hiperclorémica): diarrea (la más frecuente en niños), acidosis tubular renal.
- Alcalosis metabólica hipoclorémica hipokalémica: vómitos persistentes, estenosis hipertrófica del píloro, fibrosis quística, diuréticos.
- Compensación esperada en acidosis metabólica: pCO2 = 1,5 × HCO3 + 8 ± 2 (Winter); si no cumple, trastorno mixto.
- Tratamiento: corregir la causa (rehidratar en diarrea, insulina en CAD, perfundir en shock); bicarbonato solo en acidosis grave con pH <7,1 o pérdidas de bicarbonato; en píloro corregir con SF y potasio antes de cirugía.
- Seguimiento: derivar a nefrología si acidosis tubular renal o trastorno persistente sin causa clara.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un lactante de 10 meses con diarrea acuosa abundante de 3 días llega deshidratado. Gases venosos: pH 7,24, PCO2 30 mmHg, HCO3- 13 mEq/L. Electrolitos: Na+ 137 mEq/L, K+ 3,2 mEq/L y Cl- 112 mEq/L. **¿Cuál es el trastorno ácido-base?**
>
> **A)** Acidosis metabólica con anión gap normal (hiperclorémica)
> **B)** Acidosis metabólica con anión gap aumentado
> **C)** Acidosis respiratoria
> **D)** Alcalosis metabólica hipoclorémica
> **E)** Trastorno mixto: acidosis respiratoria y alcalosis metabólica
>
> Respuesta A. pH bajo con bicarbonato bajo es acidosis metabólica, con compensación respiratoria (PCO2 baja). Anión gap = 137 - (112 + 13) = 12, normal: acidosis hiperclorémica, típica de la pérdida digestiva de bicarbonato en la diarrea. Si hubiera shock con hipoperfusión se agregaría acidosis láctica con gap aumentado. Los vómitos, en cambio, dan alcalosis hipoclorémica.

2.01.1.071 Trastornos hidro-electrolíticos

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.3 Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Requerimientos de mantención (Holliday-Segar): 100 ml/kg para primeros 10 kg, 50 ml/kg de 10-20 kg y 20 ml/kg sobre 20 kg; Na 2-3 y K 1-2 mEq/kg/día. Usar soluciones isotónicas en hospitalizados.
- Hiponatremia (Na <135): vómitos/diarrea con aporte hipotónico, SIADH (meningitis, neumonía). Sintomática grave (convulsiones): NaCl 3% 2-3 ml/kg en bolo; corrección ≤8-10 mEq/L en 24 h (riesgo de mielinolisis).
- Hipernatremia (Na >145): deshidratación con pérdida de agua, mal técnica de fórmula, diabetes insípida; corregir en 48-72 h, descenso ≤10-12 mEq/L/día (riesgo de edema cerebral).
- Hipokalemia: diarrea, vómitos, diuréticos; debilidad, íleo, onda U. Hiperkalemia: falla renal, hemólisis; ondas T picudas, QRS ancho: gluconato de calcio, salbutamol, insulina + glucosa.
- Deshidratación isonatrémica la más frecuente; hipernatrémica tiene menos signos clínicos y piel pastosa.
- Seguimiento: control electrolítico seriado; derivar si trastorno grave, recurrente o de causa no aclarada.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 155**
>
> Un niño de 6 años fue operado de un tumor cerebral hace 7 días. Desde entonces ha presentado volúmenes urinarios aumentados, de 4,5 litros al día. Exámenes: glicemia de ayuno 103 mg/dL, Na+ 154 mEq/L, K+ 4,9 mEq/L; orina con sedimento normal, densidad 1.005 y osmolaridad urinaria 100 mOsm/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
>
> **A)** Síndrome perdedor de sal cerebral
> **B)** Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
> **C)** Insuficiencia suprarrenal
> **D)** Diabetes insípida
> **E)** Diabetes mellitus
>
> Respuesta D. Poliuria con orina diluida (osmolaridad 100 mOsm/L, densidad 1.005) e hipernatremia tras una cirugía selar o hipotalámica es diabetes insípida central por déficit de ADH. El SIADH y el perdedor de sal cerebral dan hiponatremia; la diabetes mellitus da glucosuria con orina concentrada. Se trata con desmopresina y manejo hídrico cuidadoso.

2.01.1.072 Alteraciones del desarrollo puberal

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Pubertad normal: niña inicio con telarquia entre 8-13 años (menarquia ~2 años después); niño con aumento testicular ≥4 ml entre 9-14 años. Evaluar con estadios de Tanner.
- Pubertad precoz: caracteres sexuales antes de 8 años en niñas o 9 en niños. Central (dependiente de gonadotropinas): en niñas mayoría idiopática; en niños buscar tumor SNC (RM).
- Periférica: hiperplasia suprarrenal congénita, tumores gonadales/suprarrenales, McCune-Albright, exposición a esteroides. Telarquia prematura aislada y pubarquia prematura pueden ser variantes benignas.
- Pubertad retrasada: sin telarquia a los 13 años o sin crecimiento testicular a los 14; causa más frecuente retraso constitucional (edad ósea retrasada, historia familiar); descartar Turner, Klinefelter, hipogonadismo, enfermedad crónica.
- Estudio inicial: curva de crecimiento (velocidad acelerada en precoz), edad ósea; LH, FSH, estradiol/testosterona y RM por especialista.
- Seguimiento: derivar a endocrinología infantil; pubertad precoz central se trata con análogos de GnRH.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 162

Un niño de 8 años es traído por presentar mal olor axilar desde hace semanas, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia vello púbico escaso y testículos de 4 cc de volumen. Su índice de masa corporal está en percentil 50 para su edad y sexo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Pubertad precoz central
B) Pubertad precoz periférica
C) Pubertad temprana
D) Hiperplasia suprarrenal
E) Adrenarquia temprana

Respuesta A. Pubertad precoz en varones es la aparición de caracteres sexuales antes de los 9 años. Un volumen testicular de 4 cc o más indica estimulación por gonadotropinas, es decir, activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada: pubertad precoz central. En la periférica o la adrenarquia (o la HSC) aparece vello y olor con testículos prepuberales.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 151 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 10 meses de edad tiene mamas en desarrollo Tanner II, bilateral. Su crecimiento ha sido adecuado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar ecografía mamaria
B) Solicitar cariograma
C) Observar y controlar en 2 meses
D) Solicitar niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona
E) Solicitar niveles plasmáticos de 17-OH-progesterona

Respuesta C. La presencia de botón mamario es normal en los recién nacidos y suele durar unas pocas semanas, aunque es posible que persista, incluso hasta los 12 meses. Además, la respuesta suele ser "observar" en cualquier pregunta de pediatría que sea más o menos así: "un niño tiene una cosa rara que no tengo idea, pero todo lo demás está normal".

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 146 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 8 años presenta olor axilar. ¿Qué hallazgo debe buscarse para determinar si tiene una pubertad precoz?

A) Ginecomastia
B) Elevación de la 17 hidroxiprogesterona
C) Vello púbico
D) Aumento de la velocidad de crecimiento
E) Aumento de volumen testicular

Respuesta E. Al aumento de volumen testicular es el primer signo de pubertad precoz. Sin embargo también debe evaluarse la presencia de vello púbico, porque es un signo de pubertad precoz igualmente.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 172 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 9 años, sin antecedentes de importancia, consulta por dolor mamario derecho. Al examen físico presenta mama derecha en Tanner II y mama izquierda en Tanner I, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

A) Realizar ecografía mamaria
B) Controlar en 1 año
C) Solicitar resonancia magnética de silla turca
D) Realizar ecografía pelviana
E) Solicitar 17-OH-progesterona

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Controlar en 1 año (opción B). Es una telarquia normal (inicio puberal), que puede ser asimétrica al inicio.. Comparación de las 3 Causas Principales De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 62 · texto original del banco, sin revisar

Un adolescente de 13 años consulta por aumento de volumen doloroso en relación con la mama derecha. No presenta antecedentes de importancia y sus controles de niño sano han sido normales. Al examen Fsico, se constata aumento de volumen de 3 cm de diámetro retroareolar derecho, sensible a la palpación, y desarrollo puberal genital y pubiano Tanner 3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar ecogra:a mamaria
B) Solicitar niveles plasmá2cos de prolac2na
C) Controlar en 6 meses
D) Solicitar niveles plasmá2cos de testosterona, FSH y LH
E) Realizar biopsia de la lesión

Respuesta C. Tiene una ginecomasGa puberal benigna, la que se observa. Ya Gene desarrollo puberal, lo que es esperable para su edad (pubertad normal en niños comienza entre los 9 y 14 años; en niñas comienza entre los 8 y 13 años). Los signos de alarma en una ginecomasGa son 1. Inicio en adulto o en prepúber (no puberal), 2. Tamaño > 4 cm, 3. Características de cáncer (dura, secreción sanguinolenta, etc.).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 36 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 7 años presenta olor axilar, vello púbico en Tanner 2, testículos de 2 cc de volumen. Se solicita radiografía de mano, que muestra edad ósea acorde con la edad cronológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tumor suprarrenal
B) Pubertad precoz central
C) Pubertad precoz periférica
D) Hiperplasia suprarrenal congénita
E) Adrenarquia normal

Respuesta E. Es una adrenarquia normal (olor axilar y en varones puede haber una ligera pu- barquia). Los testículos pequeños hacían imposible una pubertad precoz central y la pubertar precoz periférica es algo muy raro, que habría tenido alteraciones de la edad ósea.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 16 · texto original del banco, sin revisar

Niño de 13 años con ginecomastia unilateral y masa 3 cm retroareolar, genitales tanner 3: (repetida años anteriores) a. Observar 1 año

B) Eco mamaria
B) Control sano habitual
C) Derivar a especialista
D) Hospitalizar
E) Observación domiciliaria

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (). :::note El metronidazol en monodosis de 2 g es la elección para tricomoniasis, NO para vaginosis. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

2.01.1.073 Diabetes

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH

QUÉ HAY QUE SABER

- DM1: la más frecuente en niños; poliuria, polidipsia, polifagia, baja de peso, enuresis secundaria. Glicemia ≥200 mg/dL con síntomas o ayuno ≥126 mg/dL confirma. DM1 es GES.

- Cetoacidosis diabética (forma de debut frecuente): glicemia >200, pH <7,3 o HCO3 <15, cetonemia/cetonuria; vómitos, dolor abdominal, respiración de Kussmaul, deshidratación.
- Manejo inicial CAD: SF 10-20 ml/kg en 1 h, luego rehidratar en 48 h; insulina cristalina 0,05-0,1 U/kg/h EV tras la primera hora sin bolo; agregar potasio cuando haya diuresis y K <5,5; no usar bicarbonato.
- Riesgo de edema cerebral en CAD (cefalea, bradicardia, compromiso de conciencia): manitol 0,5-1 g/kg o NaCl 3%; evitar rehidratación rápida.
- DM2 en adolescentes obesos con acantosis nigricans; tratar con estilo de vida y metformina, insulina si HbA1c ≥8,5% o cetosis.
- Seguimiento: derivar a endocrinología infantil; insulinoterapia basal-bolo, educación, metas HbA1c <7%; tamizaje de tiroides y celiaquía.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 19

Un paciente de 12 años consulta por un cuadro de malestar general, asociado a bajo de peso, que en las últimas horas se le agrega poliuria importante. Consulta porque en las últimas horas se agrega gran compromiso del estado general, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está taquicárdico, soporoso, con polipnea y signos de deshidratación. En sus exámenes presenta glicemia de 470 mg/dl, sodio de 143 mEq/L, potasio de 4,8 mEq/L, cloro de 97 mEq/L, bicarbonato de 12 mEq/L y pH de 7,05. **¿Qué fluido debe administrarse a este paciente?**

A) Suero glucosado
B) Suerlo glucosalino
C) Solución salina al 0,45%
D) Solución salina al 0,9%
E) Suloción ringer lactato

Respuesta D. Cetoacidosis (glicemia > 250, pH 7,05, HCO_3 12, gap 34) con deshidratación y compromiso de conciencia. La primera medida es expandir con NaCl 0,9%. El suero al 0,45% se decide después de la primera hora según el sodio corregido; el glucosado, cuando la glicemia llega a ≤ 200.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 41

Un niño de 11 años es llevado al servicio de urgencia por sus padres, debido a que presenta compromiso de conciencia desde hace algunos minutos. Sus padres refieren que desde hace 4 días presenta poliuria, polidipsia y malestar general. Al examen físico destaca frecuencia cardíaca: 150 lpm, presión arterial: 100/60 mmHg, temperatura: 37°C y sopor superficial. En la exploración neurológica no tiene signos focales. Entre los exámenes de laboratorio destacan glicemia: 320 mg/dL; gases venosos con pH: 7,11, bicarbonato plasmático: 12 mEq/L, exceso de base: -9, $PaCO_2$: 24 mmHg; cetonemia y cetonuria positivas; sodio plasmático: 145 mEq/L, potasio plasmático: 5,1 mEq/L y creatinina plasmática: 1,8 mg/dL. **¿Cuál es la primera medida a administrar?**

A) Suero fisiológico 20 cc/kg endovenoso
B) Insulina endovenosa
C) Adrenalina endovenosa
D) Cloruro de potasio intravenoso
E) Oxígeno por mascarilla de recirculación

Respuesta A. Cetoacidosis de debut con deshidratación, taquicardia y falla renal prerrenal. La primera medida es el volumen con suero fisiológico (15–20 ml/kg en la primera hora). La insulina va después de iniciar la expansión; el potasio está en 5,1 y no requiere aporte inmediato.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 41

Un niño de 11 años es llevado al servicio de urgencia por compromiso de conciencia desde hace algunos minutos. Sus padres refieren que desde hace 4 días presenta poliuria, polidipsia y malestar general. Al examen físico: FC 150/min, PA 100/60 mmHg, temperatura 37 °C y sopor superficial, sin signos neurológicos focales. Laboratorio: glicemia 320 mg/dL, gases venosos con pH 7,11, bicarbonato 12 mEq/L, exceso de base -9, PaCO2 24 mmHg, cetonemia y cetonuria positivas, Na+ 145 mEq/L, K+ 5,1 mEq/L y creatinina 1,8 mg/dL. **¿Cuál es la primera medida a administrar?**

A) Suero fisiológico 20 mL/kg endovenoso
B) Insulina endovenosa
C) Adrenalina endovenosa
D) Cloruro de potasio endovenoso
E) Oxígeno por mascarilla de recirculación

Respuesta A. Es una cetoacidosis diabética grave (pH menor a 7,1 a 7,2) en un debut de diabetes tipo 1, con deshidratación y taquicardia. La primera medida es expandir volumen con suero fisiológico (10 a 20 mL/kg en la primera hora).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 100 · texto original del banco, sin revisar

Cabro chico dm 1 con CAD, PA 90/60, FC 80, conducta inicial:

A) bolo 20mg kg en 30 min b. bolo 10ml/kg en 1 horas (puse esta porque para los signos vitales a su edad no estaba shockeado)
C) Insulina
C) Observación clínica
D) Derivar a urgencia
E) Control ambulatorio

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: bolo 20mg kg en 30 min b. bolo 10ml/kg en 1 horas (puse esta porque para los signos vitales a su edad no estaba shockeado) (opción A). Comparación de las 3 Patologías De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

2.01.1.074 Hiperplasia suprarrenal congénita

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.13 Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario

QUÉ HAY QUE SABER

- Hiperplasia suprarrenal congénita: déficit de 21-hidroxilasa (>90%), autosómica recesiva; déficit de cortisol y aldosterona con exceso de andrógenos.
- Forma perdedora de sal: crisis suprarrenal a las 1-3 semanas de vida: vómitos, deshidratación, hiponatremia, hiperkalemia, hipoglicemia, shock.
- RN femenino con genitales ambiguos (virilización); varón con genitales normales o hiperpigmentación escrotal, se diagnostica por crisis. Forma no clásica: pubarquia precoz, hirsutismo, aceleración de edad ósea.
- Diagnóstico: 17-OH progesterona elevada; electrolitos y glicemia.
- Manejo inicial de crisis: SF 20 ml/kg, glucosa, hidrocortisona 50-100 mg/m² EV; tratar hiperkalemia. Crónico: hidrocortisona y fludrocortisona por especialista.
- Seguimiento: derivar a endocrinología infantil; genitales ambiguos es urgencia médica y social (no asignar sexo hasta estudio).

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 161

Un niño de 14 años consulta por dolor abdominal y vómitos de 3 días de evolución, con tendencia a la deshidratación. Hace dos meses estuvo hospitalizado por un cuadro similar, para hidratación endovenosa. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 110/70 mmHg, T°: 36,8°C. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 36 mg/dl, sodio: 126 mEq/L, potasio: 5,8 mEq/L, pH: 7,32, bicarbonato: 16 mEq/L. **El examen de elección para confirmar el diagnóstico es:**

A) Niveles plasmáticos de cortisol basal
B) Prueba de tolerancia a la glucosa con curva de insulina
C) Creatinina plasmática
D) Amilasemia
E) Endoscopía digestiva alta

Respuesta A. Vómitos a repetición con deshidratación, hipoglicemia, hiponatremia e hiperkalemia: sospecha de insuficiencia suprarrenal. Se estudia con cortisol basal y, si no es concluyente, con test de estimulación con ACTH. De las opciones, el cortisol basal es la correcta.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 6

Una lactante de 2 meses con cuadro de dolor abdominal y vómitos desde hace semanas que en las últimas horas ha empeorado asociándose fiebre, taquipnea y compromiso de conciencia. Al su ingreso destaca PA: 40/20, FC 130x', examen pulmonar con crépitos difusos. Se solicitan exámenes de laboratorio donde destaca creatinina 0.9, glicemia 40, Na+ 132, K+ 5.7, hemograma con leucocitosis. Se inicia Ceftriaxona y aporte de suero fisiológico en bolo sin respuesta luego de una hora. **El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:**

A) Vancomicina
B) Noradrenalina
C) Hidrocortisona
D) Vasopresina
E) Dopamina

Respuesta C. Hiperplasia suprarrenal congénita con crisis suprarrenal gatillada por una infección: shock que no responde al volumen, hiponatremia, hiperkalemia e hipoglicemia. El fármaco de elección es la hidrocortisona; las aminas no revierten el shock sin cortisol.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 160

Una niña de 7 años, con antecedente de hiperplasia suprarrenal congénita, en tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona, consulta por cuadro de 4 días de diarrea, fiebre y malestar general. Al examen físico tiene leve taquicardia y algunos signos de deshidratación. **Además de la reposición de volumen, ¿qué conducta es la más adecuada?**

A) Fludrocortisona endovenosa
B) Betametasona oral
C) Prednisona oral
D) Hidrocortisona endovenosa
E) Aumentar la dosis de hidrocortisona oral

Respuesta D. Paciente con insuficiencia suprarrenal que se descompensa por una infección con diarrea: se sospecha crisis suprarrenal y se trata con un corticoide de acción rápida por vía endovenosa, la hidrocortisona. La vía oral no asegura la absorción.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 6

Una lactante de 2 meses presenta dolor abdominal y vómitos desde hace semanas, que en las últimas horas han empeorado, asociándose fiebre, taquipnea y compromiso de conciencia. Al ingreso: PA 40/20 mmHg, FC 130/min y crépitos pulmonares difusos. Laboratorio: creatinina 0,9 mg/dL, glicemia 40 mg/dL, Na+ 132 mEq/L, K+ 5,7 mEq/L y leucocitosis. Se inicia ceftriaxona y bolo de suero fisiológico, sin respuesta luego de una hora. **¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo de esta paciente?**

A) Vancomicina
B) Noradrenalina
C) Hidrocortisona
D) Vasopresina
E) Dopamina

Respuesta C. Vómitos de semanas, hipoglicemia, hiponatremia e hiperkalemia con shock refractario a fluidos en un lactante sugieren crisis suprarrenal, probablemente por hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal, descompensada por una infección. El tratamiento es hidrocortisona endovenosa en dosis de estrés (50 a 100 mg/m2), junto con fluidos y corrección de la glicemia; los vasopresores no responden sin cortisol.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 114 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 7 años consulta por dolor abdominal y vómitos de 3 días de evolución, con tendencia a la deshidratación. Hace dos meses estuvo hospitalizado por un cuadro similar, para hidratación endovenosa. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 110/70 mmHg, T°: 36,8°C. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 46 g/dl, sodio: 130 mEq/L, potasio: 5,8 mEq/L, pH: 7,32, bicarbonato: 16 mEq/L. El examen de elección para confirmar el diagnóstico es:

A) Niveles plasmáticos de cortisol basal
B) Insulinemia basal
C) Creatinina plasmática
D) Amilasemia
E) Cetonemia

Respuesta A. La sospecha es una insuficiencia suprarrenal (hiperplasia suprarrenal congénita o HSRC es lo más frecuente en pediatría), por la acidosis metabólica, hipoglicemia, tendencia al compromiso hemodinámico, hiperkalemia e hiponatremia. La mera sospecha obliga a dar corticoides EV. De las opciones, medir el cortisol es lo más correcto, aunque en niños es fundamental, además, medir la 17-OH-progesterona,

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 70 · texto original del banco, sin revisar

Un recién nacido de 28 semanas, comienza con decaimiento y vómitos, desde hace una semana, con tendencia a la deshidratación. Al examen físico, está hipotenso, taquicárdico, con genitales masculinos, sin otros hallazgos. Sus electrolitos muestran Na+: 129 mEq/l, K+: 6,5 mEq/L, Cl: 89 mEq/L. Además, de la solución fisiológica, ¿qué medicamento se debe administrar en el manejo inicial de este paciente?

A) Ondasentrón
B) Omeprazol
C) Calcio
D) Cefotaximo
E) Hidrocortisona

Respuesta E. Tiene una crisis suprarrenal, por hiperplasia suprarrenal congénita (por ser niño). Sugieren esto la clínica, la hipoNa+ y a hiperK+. Se trata con corticoides ev ante la sola sospecha.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 58 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 8 años ingresa por un cuadro de decaimiento y malestar general, con diarrea y vómitos. Está somnoliento y con compromiso hemodinámico, con FC: 120x' y PA: 70/30 mmHg. Se administran dos bolos de suero fisiológico de 20 cc/kg de peso, sin lograr estabilizarlo. En sus exámenes destaca glicemia 62 mg/dl y pH: 7,29, con exceso de base: -16. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

A) Administrar hidrocortisona endovenosa 2mg/kg de peso
B) Administrar un tercer bolo de suero fisiológico 20 cc/Kg de peso
C) Administrar solución glucosalina 1.700 cc/m2 de superficie corporal
D) Administrar plasma fresco 20 cc/kg de peso
E) Administrar bicarbonato de sodio 2 mEq/Kg de peso

Respuesta A. La sospecha es una insuficiencia suprarrenal (hiperplasia suprarrenal congénita es lo más frecuente en pediatría), por la acidosis metabólica, con tendencia a la hipoglicemia y shock refractario. La mera sospecha obliga a dar corticoides EV.

2.01.1.075 Hipotiroidismo

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito · Tema 18.21 Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipotiroidismo congénito: causa prevenible de discapacidad intelectual; tamizaje neonatal universal con TSH en sangre de talón a las 40 h-7 días (programa de pesquisa neonatal).
- Clínica tardía: ictericia prolongada, macroglosia, hernia umbilical, fontanela posterior amplia, hipotonía, constipación, llanto ronco, piel seca.
- TSH elevada en tamizaje: confirmar con TSH y T4 libre en sangre venosa e iniciar levotiroxina 10-15 μg/kg/día de inmediato, sin esperar imágenes.
- Hipotiroidismo adquirido (tiroiditis de Hashimoto, el más frecuente en escolares): disminución de velocidad de crecimiento, bocio, aumento de peso, bajo rendimiento escolar; anticuerpos antiTPO.
- TSH alta con T4 libre baja: hipotiroidismo primario; levotiroxina 2-5 μg/kg/día según edad en adquirido.
- Seguimiento: derivar a endocrinología infantil; controles de TSH/T4L frecuentes en el primer año y evaluación del desarrollo.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 53

Un lactante de 3 meses, diagnosticado de hipotiroidismo congénito, en tratamiento con levotiroxina 25 mg/día. Se solicita TSH que resulta 0,09 UI/L (VN: 0,7 a 5,7) y T4 libre: 2,18 ng/dl (VN: 0,9 a 2,1). **La conducta más adecuada es:**

A) Suspender la levotiroxina
B) Subir la dosis de levotiroxina
C) Repetir la TSH en 6 semanas
D) Disminuir la dosis de levotiroxina
E) Solicitar cintigrafía tiroidea

Respuesta D. TSH suprimida con T4 libre sobre lo normal: el lactante está sobretratado y se disminuye la dosis. El hipotiroidismo congénito no se suspende, porque la glándula no se va a recuperar.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 53

Lactante de 3 meses, diagnosticado de hipotiroidismo congénito, en tratamiento con levotiroxina. TSH: 0,09 (normal 0,7 a 5,7). T4 libre: 2,18 (normal 0,9 a 2,1). **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suspender la levotiroxina
B) Subir la dosis de levotiroxina
C) Repetir la TSH en 6 semanas, sin cambios
D) Disminuir la dosis de levotiroxina
E) Solicitar cintigrafía tiroidea

Respuesta D. La TSH está bajo lo normal y la T4 libre sobre lo normal: el lactante está sobretratado. La conducta es disminuir la dosis de levotiroxina y reevaluar, no suspenderla, porque el tratamiento de por vida sigue siendo necesario.

Pregunta de práctica

Lactante de 1 mes, nacido de término en parto domiciliario rural, sin controles ni tamizaje de talón. La madre lo describe muy tranquilo, duerme todo el día, le cuesta mamar y tiene el abdomen distendido. Al examen: fontanela posterior amplia de 1,5 cm, ictericia leve, macroglosia, llanto ronco y hernia umbilical de 2 cm reducible. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar ecografía de tiroides como primer examen
B) Solicitar TSH y T4 libre en sangre venosa, e iniciar levotiroxina oral
C) Indicar fórmula libre de fenilalanina de forma empírica
D) Control en un mes más, ya que a esta edad puede ser variante normal
E) Solicitar cintigrama tiroideo antes de decidir cualquier tratamiento

Respuesta B. El cuadro reúne los signos tardíos clásicos del hipotiroidismo congénito, que se debió pesquisar con el tamizaje que nunca se tomó. La conducta inmediata es confirmar con TSH y T4 libre en sangre venosa e iniciar levotiroxina oral sin retraso, para minimizar el daño en el desarrollo.

2.01.1.076 Talla baja

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Talla baja: talla < -2 DE (p3) para edad y sexo, o velocidad de crecimiento bajo p25, o talla muy por debajo de la talla diana familiar.
- Variantes normales: talla baja familiar (velocidad y edad ósea normales, padres bajos) y retraso constitucional del crecimiento (edad ósea retrasada, pubertad tardía, talla final normal).
- Patológicas: desproporcionada (displasias óseas) o proporcionada: endocrinas (hipotiroidismo, déficit de GH, Cushing: niño bajo y con sobrepeso), enfermedades crónicas (celiaquía, ERC, cardiopatía), Turner, PEG sin recuperación, desnutrición.
- Estudio inicial: curva de crecimiento, talla diana (talla padre + madre ± 13 cm / 2), proporciones corporales, edad ósea, hemograma, VHS, creatinina, electrolitos, gases venosos, TSH/T4L, antitransglutaminasa IgA, orina completa; cariotipo en niñas.
- Banderas rojas: velocidad de crecimiento baja, talla < -3 DE, desproporción, dismorfias, bajo peso para talla (enfermedad crónica).
- Seguimiento: derivar a endocrinología infantil si estudio alterado o velocidad de crecimiento disminuida; variantes normales se controlan en APS cada 6 meses.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 58

Un niño de 11 años es traído por sus padres por ser el más bajo de su curso. Ha crecido en el percentil 2 para su edad desde hace años según su curva de crecimiento y al examen físico tiene desarrollo puberal Tanner 1, con testículos de 2 cc. Sus padres tienen estatura promedio para la población. La radiografía de carpo muestra edad ósea de 8 años y 6 meses. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Talla baja familiar
B) Hipogonadismo
C) Acondroplasia
D) Enanismo hipofisario
E) Retardo constitucional del crecimiento

Respuesta E. Talla baja con velocidad de crecimiento normal (crece en su carril), pubertad aún no iniciada y edad ósea retrasada más de 2 años respecto de la cronológica, con padres de talla normal, es retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. En la talla baja familiar la edad ósea es acorde a la edad y los padres son bajos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 15 · texto original del banco, sin revisar

Niña de 8 años consulta por talla baja, tiene percentil de crecimiento 4, con velocidad de crecimiento normal, y edad ósea de 7 años 10 meses, madre mide 1.52 y padre 1.65: cual es la conducta a seguir

A) Controlar en 6 meses
B) Pedir GH
C) Pedir TSH y T4 (no era talla baja, es <p3)
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Controlar en 6 meses (opción A). Algoritmo de Manejo De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad. Las opciones alternativas (Pedir GH, Pedir TSH y T4 (no era talla baja, es <p3)) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la present

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 14 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 8 años es traída por su madre, por talla baja. Está creciendo en el percentil 5 para la edad, con velocidad de crecimiento normal. Su madre mide 158 cm y su padre mide 166 cm. Su edad ósea corresponde a 7 años y 10 meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Controlar en 6 meses
B) Frenar la pubertad
C) Solicitar un cariograma
D) Solicitar radiografías de huesos largos
E) Solicitar niveles plasmáticos de hormona de crecimiento

Respuesta A. La niña está en el percentil 5, por encima de los límites de talla baja (menor de p3 o menos 2 desviaciones estándar), crece con velocidad normal y tiene edad ósea concordante con la cronológica y padres de talla baja, es decir, una variante normal con talla baja familiar. Basta con controlar su crecimiento en 6 meses. No se justifica estudio genético ni de hormona de crecimiento, y frenar la pube

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 80 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 12 años, con antecedente de un meduloblastoma de fosa posterior, tratado con quimioterapia y radioterapia cerebral, en remisión completa, desde hace 5 años; consulta por talla baja. Su curva de crecimiento demuestra que ha estado creciendo en una talla equivalente al percentil 2 para la edad y, en su examen físico, presenta desarrollo genital en Tanner 3, con vello púbico en Tanner 4. La talla parental estimada es de 170 cm. ¿Cuál es la causa más probable de su talla baja?

A) Retraso pubertad
B) Recidiva tumoral
C) Hipogonadismo
D) Déficit de hormona de crecimiento
E) Talla baja familiar

Respuesta D. Tiene una talla baja (menor a percentil 3 o -2DS). Tiene desarrollo puberal, así que no es ni retraso puberal ni hipogonadismo. Su talla parental (promedio de talla de madre y padre, ajustada por sexo: se suma 6,5 cm al promedio si el niño tiene sexo masculino y se resta 6,5 cm si tiene sexo femenino) es alta, así que no es TBF. El antecedente de la RT hace que probablemente tenga daño hipofisiari

2.01.1.077 Cefalea

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.6 Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

QUÉ HAY QUE SABER

- Cefalea primaria más frecuente en niños: migraña (bilateral/frontal en niños, pulsátil, náuseas, foto/fonofobia, alivio con sueño, historia familiar) y cefalea tensional (opresiva, sin náuseas).
- Banderas rojas de cefalea secundaria: <3 años, cefalea que despierta o matinal con vómitos, progresiva, cambio de patrón, examen neurológico alterado, papiledema, ataxia, cambio de conducta, aumento de perímetro craneano, fiebre con meningismo.
- Ante banderas rojas: neuroimagen (RM o TC) y derivación urgente (tumor SNC, hipertensión endocraneana, hidrocefalia).
- Crisis migrañosa: ibuprofeno 10 mg/kg o paracetamol 15 mg/kg precoz, reposo en ambiente oscuro; antieméticos si vómitos; evitar uso >2-3 días/semana (cefalea por abuso).
- Medidas: diario de cefalea, sueño regular, hidratación, no saltarse comidas, manejo del estrés; profilaxis (flunarizina, propranolol, amitriptilina) si ≥4 crisis/mes incapacitantes.
- Seguimiento: control en APS con diario; derivar a neurología si banderas rojas, refractaria o requiere profilaxis.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 180

Un paciente de 12 años, consulta por cuadro caracterizado por de visión de destellos hace una hora, tras lo cual evolucionó con cefalea frontotemporal intensa, de tipo pulsátil, asociado a fotofobia y fonofobia. Refiere que desde los cinco años ha presentado cuadros similares, y que durante el último año ha presentado cinco episodios. **El diagnóstico más probable es:**

A) Migraña clásica
B) Cefalea en racimos
C) Cefalea tensional
D) Migraña complicada
E) Tumor cerebral

Respuesta A. Destellos visuales seguidos de cefalea pulsátil con fotofobia y fonofobia, con episodios similares por años: migraña con aura, llamada clásica. No es tensional (pulsátil, con foto y fonofobia) ni tumor (es recurrente desde hace años, sin progresión ni déficit).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 180

Un paciente de 12 años consulta porque hace una hora presentó visión de destellos, tras lo cual evolucionó con cefalea frontotemporal intensa, de tipo pulsátil, asociada a fotofobia y fonofobia. Refiere que desde los 5 años ha presentado cuadros similares, y durante el último año ha tenido cinco episodios. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Migraña con aura (clásica)
B) Cefalea en racimos
C) Cefalea tensional
D) Migraña complicada
E) Tumor cerebral

Respuesta A. Cefalea pulsátil intensa con fotofobia y fonofobia, precedida de aura visual (destellos) que se resuelve antes del dolor, recurrente desde hace años y con examen presumiblemente normal, es migraña con aura. La migraña es la cefalea primaria recurrente más frecuente en niños. La migraña complicada implica déficit persistente; el tumor da cefalea progresiva con signos de alarma.

2.01.1.078 Encefalopatía hipóxico-isquémica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.15 Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Encefalopatía hipóxico-isquémica: síndrome neurológico en RN ≥35 semanas tras asfixia perinatal: acidosis (pH <7,0 o déficit de base ≥12 en cordón), Apgar bajo prolongado, necesidad de reanimación.
- Clasificación de Sarnat: I leve (hiperalerta, buen pronóstico), II moderada (letargia, hipotonía, convulsiones), III grave (coma, flacidez, ausencia de reflejos; alta mortalidad y secuelas).
- Compromiso multiorgánico: renal (oliguria), cardíaco, hepático, coagulopatía, hipoglicemia, hipocalcemia, SIADH.

- Manejo inicial: reanimación adecuada, evitar hipertermia, mantener normoglicemia y ventilación, tratar convulsiones (fenobarbital 20 mg/kg EV), restricción hídrica relativa.
- Hipotermia terapéutica (33-34 °C por 72 h) iniciada en <6 h de vida en EHI moderada-grave: trasladar precozmente a centro con UCI neonatal.
- Seguimiento: derivar a neonatología y neurología; seguimiento del neurodesarrollo (parálisis cerebral, epilepsia, déficit cognitivo).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un recién nacido de 39 semanas nace tras un desprendimiento de placenta, con Apgar 2 al minuto y 4 a los 10 minutos, requiriendo ventilación con presión positiva. El pH de cordón es 6,9 con exceso de base -18. A las 2 horas de vida está letárgico, hipotónico, con succión débil y reflejos disminuidos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Observar en puerperio con su madre
> **B)** Iniciar hipotermia terapéutica antes de las 6 horas de vida
> **C)** Iniciar fenobarbital profiláctico
> **D)** Administrar bicarbonato endovenoso en bolo
> **E)** Calentar activamente hasta 38 °C
>
> Respuesta B. Asfixia perinatal (evento centinela, Apgar bajo prolongado, acidosis grave de cordón) con encefalopatía moderada a grave en un recién nacido de 36 semanas o más es indicación de hipotermia terapéutica (33 a 34 °C por 72 horas), iniciada antes de las 6 horas de vida, porque reduce muerte y discapacidad.

2.01.1.079 Macro y microcefalia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Medir perímetro craneano en cada control hasta los 2-3 años; macrocefalia >p97 o +2 DE, microcefalia <p3 o -2 DE (grave < -3 DE).
- Macrocefalia: lo más frecuente es familiar benigna (padres con PC grande, desarrollo normal). Patológica: hidrocefalia (fontanela abombada, suturas separadas, ojos en sol poniente, vómitos), colecciones subdurales, megalencefalia.
- Microcefalia: primaria (genética, cromosómica) o secundaria (TORCH, Zika, alcohol fetal, EHI, craneosinostosis, desnutrición grave).
- La curva importa más que un valor aislado: cruzar percentiles hacia arriba o hacia abajo obliga a estudio.
- Estudio inicial: medir PC de los padres, evaluar desarrollo psicomotor; ecografía cerebral si fontanela abierta; TC/RM por especialista.
- Seguimiento: derivar a neurología pediátrica/neurocirugía si crecimiento acelerado, signos de hipertensión endocraneana, retraso del desarrollo o microcefalia.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un lactante de 5 meses, en control sano, tiene un perímetro cefálico que ha cruzado dos carriles de percentil, desde p50 al nacer hasta sobre p98 ahora. La fontanela anterior está amplia y tensa, y presenta mirada en sol poniente. Su desarrollo psicomotor muestra pobre sostén cefálico. **¿Cuál es el examen inicial más adecuado?**
>
> **A)** Radiografía de cráneo
> **B)** Ecografía cerebral transfontanelar
> **C)** Electroencefalograma
> **D)** Medición del perímetro cefálico de los padres y control en 3 meses
> **E)** Cariograma
>
> Respuesta B. Macrocefalia progresiva (cruce de percentiles) con fontanela tensa, signo de sol poniente y retraso del desarrollo sugiere hidrocefalia con hipertensión endocraneana. Con fontanela abierta, el examen inicial rápido y sin radiación es la ecografía transfontanelar, seguida de RM. Medir a los padres sirve para la macrocefalia familiar benigna, que crece en su percentil y con desarrollo normal.

2.01.1.080 Retraso del desarrollo SM

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.2 Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Retraso del desarrollo psicomotor: desempeño significativamente bajo lo esperado en ≥1 área (motor grueso, fino, lenguaje, social). Global si ≥2 áreas en <5 años.
- Evaluación en APS: EEDP (0-2 años) y TEPSI (2-5 años); resultado normal, riesgo o retraso. Pauta breve en cada control.
- Banderas rojas: no sostén cefálico a los 4 meses, no sedestación a 9 meses, no marcha a 18 meses, no palabras a 16-18 meses, pérdida de habilidades adquiridas (regresión), asimetría.
- Causas: prematurez, EHI, genéticas (síndrome de Down, X frágil), TORCH, hipotiroidismo, déficit sensorial (hipoacusia, visión), TEA, deprivación psicosocial.
- Manejo inicial: estimulación en sala de estimulación (Chile Crece Contigo), evaluar audición y visión, TSH, reevaluar en 3 meses.
- Seguimiento: derivar a neurología si retraso persistente, regresión o examen neurológico alterado; kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 10 meses, nacido a las 36 semanas de gestación, es traído a su control de salud pendiente de los 8 meses. Al examen no logra sentarse sin apoyo, no transfiere objetos entre sus manos, y solo emite sonidos guturales aislados. Se le aplica la EEDP y obtiene un puntaje de 65 puntos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Reforzar pautas de estimulación y controlar según calendario habitual
B) Derivar a sala de estimulación y reevaluar con EEDP en 60 días
C) Realizar examen neurológico y derivar a pediatría o neurología infantil
D) Calcular su edad corregida por la prematurez y tranquilizar a la familia
E) Indicar control telefónico en 6 meses

Respuesta C. Un puntaje de 65 puntos en la EEDP corresponde a retraso del desarrollo psicomotor (< 70 puntos), que exige evaluación médica y derivación inmediatas. La prematurez de 36 semanas es leve y la edad corregida no alcanza a explicar un retraso de esta magnitud a los 10 meses.

2.01.1.081 Síndrome convulsivo

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 18.14 Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Convulsión febril simple: 6 meses-5 años, generalizada, <15 min, única en 24 h, sin focalidad ni déficit postictal, con fiebre sin infección del SNC. Compleja: focal, >15 min o repetida en 24 h.
- Convulsión febril simple no requiere EEG, neuroimagen ni exámenes de rutina; punción lumbar si signos meníngeos, <12 meses sin vacunas al día o antibiótico previo.
- Crisis activa >5 min: diazepam 0,3-0,5 mg/kg rectal o midazolam 0,2-0,3 mg/kg bucal/intranasal/IM, o lorazepam/diazepam EV; ABC, posición lateral, O2, glicemia.
- Epilepsia: ≥2 crisis no provocadas separadas >24 h; EEG y RM. Epilepsia en <15 años es GES. Ausencias típicas: crisis breves con detención, desencadenadas por hiperventilación, EEG punta-onda 3 Hz.
- Antipiréticos no previenen recurrencia; recurrencia de convulsión febril ~30%; riesgo de epilepsia levemente aumentado solo en las complejas.
- Seguimiento: convulsión febril simple se controla en APS con educación familiar; derivar a neurología si crisis afebriles, focales, complejas o epilepsia.

PREGUNTAS (4)

Pregunta de práctica

Lactante de 18 meses, previamente sano y con vacunas al día. Con fiebre de 39,2 °C por una faringoamigdalitis, presenta una crisis tónico-clónica generalizada, de 3 minutos, que cede sola. Veinte minutos después está afebril, activo, reactivo, se conecta con sus padres, sin rigidez de nuca ni déficit motor. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Diagnosticar convulsión febril simple, tratar el foco infeccioso y educar a los padres
B) Solicitar electroencefalograma antes del alta
C) Hospitalizar en UCI para iniciar fenitoína
D) Realizar punción lumbar de urgencia
E) Iniciar ácido valproico profiláctico

Respuesta A. Edad típica, crisis generalizada breve y única, recuperación completa sin signos meníngeos: es una convulsión febril simple. No requiere EEG, punción lumbar ni fármaco de mantención; se trata el foco infeccioso y se educa a los padres.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 21 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 7 años presenta episodios en los que se queda quieto, mirando fijo, los que luego no recuerda. Han aumentado en frecuencia, hasta suceder 5 veces al día. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síncompes vasovagales
B) Epilepsia mioclónico
C) Crisis de ausencia
D) Epilepsia focal
E) Déficit atencional

Respuesta C. Diagnóstico: Crisis de ausencia (opción C). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 78 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 7 años es traído por su madre, porque presenta mal rendimiento escolar. Tiene un hermano con déficit atencional diagnosticado. Durante el examen, presenta un breve episodio de desconexión con el medio. ¿Con que examen se debe continuar el estudio de este paciente?

A) Psicometría
B) Evaluación psicopedagógica
C) Electroencefalograma
D) TAC cerebral
E) Audiometría

Respuesta C. Tiene una probable epilepsia por crisis de ausencia. Se estudia con EEG, al igual que las demás epilepsias primarias. Su hermano también debería estudiarse.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 77 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 10 años convulsiona a la mañana siguiente, de haber trasnochado jugan- do videojuegos. Además refiere mioclonías matinales frecuentes, desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. ¿Cuál es la me- dida más adecuada?

A) Prohibir por completo los videojuegos
B) Iniciar ácido valproico
C) Iniciar carbamazepina
D) Iniciar fenobarbital
E) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro

Respuesta B. Es una probable epilepsia mioclónica, que se trata preferentemente con ácido val- proico. Sí pueden jugar videojuegos, pero con pantallas e iluminación adecuadas y por ciertos horarios limitados. Es una pregunta que excede los conocimientos de un médico general.

2.01.1.082 Síndrome déficit atencional

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- TDAH: trastorno del neurodesarrollo; ≥6 síntomas de inatención y/o hiperactividad-impulsividad por ≥6 meses (≥5 en ≥17 años), varios presentes antes de los 12 años.

- Requisito clave: síntomas en ≥2 contextos (casa y colegio) con deterioro académico o social; si solo ocurre en un ambiente no es TDAH. Usar cuestionarios de padres y profesores (Conners).
- Presentaciones: combinada (la más frecuente), inatenta (más en niñas, pasa desapercibida) e hiperactiva-impulsiva. Descartar hipoacusia, déficit visual, trastorno de aprendizaje, ansiedad, depresión, apnea del sueño, maltrato.
- Tratamiento multimodal: psicoeducación a familia, manejo conductual, apoyo escolar (PIE); fármaco de primera línea metilfenidato (acción corta o prolongada) en ≥6 años.
- Efectos adversos del metilfenidato: hiporexia (controlar peso y talla), insomnio de conciliación, cefalea, leve taquicardia/alza de PA.
- Seguimiento: derivar a neurología o psiquiatría infantil para confirmar diagnóstico e iniciar fármaco; control periódico de peso, talla y PA.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un niño de 7 años es derivado por su profesora porque no termina sus tareas, se distrae, se levanta constantemente y interrumpe en clases desde hace un año. Los padres refieren que en la casa es igual: pierde sus cosas, no espera turnos y no logra jugar tranquilo. **Para diagnosticar trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿qué elemento es indispensable?**
> **A)** Un electroencefalograma alterado
> **B)** Una resonancia magnética cerebral alterada
> **C)** Síntomas presentes en dos o más contextos, por al menos 6 meses, con inicio antes de los 12 años
> **D)** Una respuesta positiva a una prueba con metilfenidato
> **E)** Rendimiento escolar insuficiente en todas las asignaturas
> Respuesta C. El diagnóstico de TDAH es clínico (DSM-5): síntomas de inatención y/o hiperactividad-impulsividad persistentes por 6 meses o más, presentes en al menos dos ambientes (casa y colegio), iniciados antes de los 12 años y con deterioro funcional, no explicados por otro trastorno. No requiere exámenes. La respuesta al metilfenidato no confirma el diagnóstico.

2.01.1.083 Síndrome hipertónico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.2 Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome hipertónico: aumento del tono muscular por lesión de primera motoneurona; espasticidad (velocidad-dependiente, hiperreflexia, clonus, Babinski persistente) o distonía/rigidez.
- Causa más frecuente: parálisis cerebral (lesión encefálica no progresiva): factores de riesgo prematurez, EHI, infecciones congénitas, kernicterus.
- Signos de alerta en lactante: puños cerrados persistentes después de los 3-4 meses, pulgar incluido, hiperextensión, piernas en tijera, preferencia manual antes de los 12-18 meses, persistencia de reflejos primitivos.
- Distinguir hipertonía fisiológica del RN (flexora) y no confundir con hipertonía transitoria del prematuro.
- Manejo inicial: kinesioterapia y estimulación precoz, evaluación de audición, visión y deglución; buscar regresión (sugiere enfermedad neurodegenerativa).
- Seguimiento: derivar a neurología pediátrica y rehabilitación (Teletón); toxina botulínica o cirugía por especialista.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 159

Un niño de 18 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro de 32 semanas, camina en punta de pies. Logró la marcha independiente hace un mes. Al examen físico tiene aumento del tono muscular de las extremidades inferiores, con hiperreflexia y signo de Babinski. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Estereotipia de la marcha
B) Retraso del desarrollo psicomotor
C) Diplejía espástica
D) Polineuropatía
E) Distrofia muscular

Respuesta C. Un exprematuro con hipertonía, hiperreflexia y Babinski predominantes en extremidades inferiores, con marcha en punta de pies, tiene una parálisis cerebral de tipo diplejía espástica, típica de la leucomalacia periventricular del prematuro. La marcha en punta aislada puede ser normal antes de los 3 años, pero no con signos de primera motoneurona. Las polineuropatías y distrofias dan hiporreflexia.

2.01.1.084 Síndrome hipotónico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.2 Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome hipotónico (lactante flácido): postura en rana, poco tono axial, cabeza que cae en la tracción, deslizamiento en suspensión vertical.
- Central (70-80%): hipotonía con fuerza conservada, reflejos normales o vivos, compromiso de conciencia o retraso global; causas: EHI, síndrome de Down, Prader-Willi, hipotiroidismo, sepsis, metabólicas.
- Periférica: debilidad marcada, arreflexia, fasciculaciones linguales (atrofia muscular espinal), sin compromiso cognitivo; causas: AME, miopatías, distrofia miotónica congénita, botulismo del lactante, miastenia.
- Estudio inicial: glicemia, electrolitos, TSH/T4, CK, cariotipo si dismorfias; evaluar deglución y función respiratoria.
- Banderas rojas: dificultad respiratoria, trastorno de deglución, progresión, debilidad con arreflexia: hospitalizar.
- Seguimiento: derivar a neurología pediátrica; kinesioterapia; AME tiene terapias específicas (nusinersen, terapia génica) por especialista.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un lactante de 4 meses es traído porque no sostiene la cabeza. Al examen está alerta y sigue con la mirada, pero tiene hipotonía generalizada marcada, con postura en batracio, arreflexia osteotendínea, respiración paradojal abdominal y fasciculaciones de la lengua. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Atrofia muscular espinal
B) Síndrome de Down
C) Hipotiroidismo congénito
D) Parálisis cerebral hipotónica
E) Síndrome de Prader-Willi

Respuesta A. Hipotonía con debilidad marcada, arreflexia y fasciculaciones linguales, en un lactante alerta y con buena conexión, indica hipotonía periférica por compromiso de la segunda motoneurona: atrofia muscular espinal tipo 1. La hipotonía central (Down, Prader-Willi, parálisis cerebral, hipotiroidismo) conserva o aumenta los reflejos y suele asociar compromiso de conciencia o del desarrollo cognitivo.

2.01.1.085 Trastornos aprendizaje

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno específico del aprendizaje: dificultad persistente (≥6 meses) en lectura (dislexia), escritura (disortografía) o cálculo (discalculia), con rendimiento bajo lo esperado y CI normal.
- Sospechar en escolar con bajo rendimiento, lectura lenta con errores, inversiones de letras persistentes después de 2º básico, frustración y problemas conductuales secundarios.
- Descartar primero: déficit visual y auditivo, TDAH (comorbilidad frecuente), discapacidad intelectual, depresión/ansiedad, problemas familiares, ausentismo.

- Evaluación: psicopedagógica y psicométrica (descartar discapacidad intelectual); en el colegio, Programa de Integración Escolar (PIE) con adecuaciones curriculares.
- Manejo inicial: apoyo psicopedagógico, comunicación con el colegio, apoyo emocional y refuerzo positivo; no hay fármacos para el trastorno de aprendizaje en sí.
- Seguimiento: derivar a psicopedagogía, neurología o psiquiatría infantil si hay comorbilidad (TDAH) o sospecha de discapacidad intelectual.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 87**
> Un niño de 7 años perdió el año escolar. Presenta dificultades en la lectoescritura, invierte fonemas con frecuencia, es muy lento para leer y le cuesta deletrear. Su padre no terminó el colegio porque tenía problemas similares. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
> **A)** Coeficiente intelectual limítrofe
> **B)** Trastorno oposicionista desafiante
> **C)** Trastorno por déficit atencional
> **D)** Dislexia
> **E)** Trastorno del desarrollo
> Respuesta D. Dificultad específica y persistente en la lectura (lenta, con inversiones y errores de decodificación) y en el deletreo, con antecedente familiar, corresponde a dislexia, el trastorno específico del aprendizaje más frecuente. Su base es fonológica y tiene fuerte componente hereditario. El TDAH afecta el rendimiento global por inatención, no específicamente la decodificación lectora.

2.01.1.086 Trastornos del lenguaje

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.2 Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hitos de lenguaje: balbuceo 6 meses, primeras palabras 12 meses, ≥50 palabras y frases de 2 palabras a los 24 meses, frases de 3 palabras y 75% inteligible a los 3 años.
- Banderas rojas: no balbucea a los 12 meses, no dice palabras a los 16-18 meses, no frases a los 24 meses, regresión del lenguaje a cualquier edad, no responde a su nombre.
- Primera causa a descartar: hipoacusia (siempre pedir evaluación auditiva). Otras: trastorno del espectro autista (déficit social, conductas repetitivas), discapacidad intelectual, deprivación, trastorno específico del lenguaje.
- Dislalias (sustitución de fonemas) y tartamudez fisiológica son frecuentes en preescolares; tartamudez persistente >6 meses o después de los 5 años se deriva.
- Manejo inicial: estimulación del lenguaje en casa (leer, hablar, menos pantallas), audiometría/potenciales evocados, M-CHAT si se sospecha TEA (16-30 meses).
- Seguimiento: derivar a fonoaudiología, ORL y neurología/psiquiatría infantil según causa.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un niño de 2 años es traído porque solo dice 2 palabras. Comprende instrucciones simples cuando lo miran, mantiene contacto visual, juega de forma simbólica y señala lo que quiere. Tuvo varias otitis medias el último año. Su examen físico y el resto del desarrollo son normales. **¿Cuál es el primer examen a solicitar?**
> **A)** Resonancia magnética cerebral
> **B)** Cariograma
> **C)** Electroencefalograma
> **D)** Evaluación auditiva (audiometría o potenciales evocados auditivos)
> **E)** Test de detección de autismo como único estudio
> Respuesta D. A los 2 años se espera un vocabulario de unas 50 palabras y frases de 2 palabras. Ante todo retraso del lenguaje, el primer paso es descartar hipoacusia con una evaluación auditiva objetiva, más aún con otitis a repetición (otitis media con efusión). La buena interacción social y el juego simbólico hacen menos probable un trastorno del espectro autista.

2.01.1.087 Tumores SNC

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.18 Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores del SNC: tumores sólidos más frecuentes en niños (2º cáncer infantil); la mayoría infratentoriales (fosa posterior) entre 1-10 años: meduloblastoma, astrocitoma pilocítico, ependimoma, glioma de tronco.
- Clínica: hipertensión endocraneana (cefalea matinal, vómitos en proyectil, papiledema), ataxia, nistagmo, compromiso de pares craneanos, macrocefalia en lactantes, cambios conductuales.
- Craneofaringioma: alteraciones visuales (hemianopsia bitemporal), talla baja, diabetes insípida.
- Neuroimagen urgente (RM de elección; TC si no disponible) ante cefalea con banderas rojas o examen neurológico alterado.
- Manejo inicial: dexametasona si edema cerebral sintomático, manejo de hipertensión endocraneana (cabeza a 30°), anticonvulsivantes si crisis.
- Cáncer infantil es GES: derivar con urgencia a neurocirugía y oncología pediátrica.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 96

Un niño de 9 años, con antecedente de neurofibromatosis tipo 1, consulta por proptosis izquierda de 6 meses de evolución, progresiva e indolora. Tenía un examen visual normal a los 6 años. Actualmente se observa proptosis izquierda leve, con disminución de la visión de colores del ojo izquierdo y agudeza visual 20/25 en el ojo derecho y 20/30 en el ojo izquierdo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Celulitis orbitaria
B) Retinoblastoma
C) Orbitopatía distiroidea
D) Angiolipoma orbitario
E) Tumor del nervio óptico

Respuesta E. La neurofibromatosis tipo 1 se asocia a glioma de la vía óptica, el tumor del SNC más característico de esta enfermedad. Proptosis unilateral progresiva e indolora con alteración de la visión de colores (disfunción del nervio óptico) orienta a glioma del nervio óptico. Se estudia con resonancia de órbitas y cerebro. La celulitis orbitaria es aguda, dolorosa y febril.

2.01.1.088 Criptorquidia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 13.7 Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

QUÉ HAY QUE SABER

- Criptorquidia: testículo no descendido en el escroto; 3% en RN de término, 30% en prematuros; la mayoría desciende en los primeros 3-6 meses.
- Diferenciar de testículo retráctil (desciende con maniobra y permanece en el escroto, normal) y ascendido.
- Palpable vs no palpable: no palpable bilateral o con hipospadias obliga a descartar desarrollo sexual diferente (hiperplasia suprarrenal congénita en niña virilizada). La ecografía no es necesaria para decidir.
- Tratamiento: orquidopexia entre los 6 y 18 meses (idealmente antes del año); la terapia hormonal no se recomienda.
- Riesgos de no tratar: infertilidad, cáncer testicular (seminoma), torsión y hernia inguinal asociada.
- Seguimiento: derivar a cirugía infantil desde los 6 meses; controlar posición testicular en cada control y autoexamen testicular en adolescencia.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 116

Usted evalúa a un recién nacido de término, en buenas condiciones, que se alimenta con leche materna y tiene examen neurológico normal. Al examen físico segmentario no se palpa ninguno de los testículos en el escroto ni en la zona inguinal. Su pene mide 2 cm de largo. **Además de solicitar una ecografía inguinal, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Controlar en un mes
B) Solicitar niveles plasmáticos de testosterona
C) Realizar exploración quirúrgica inmediata mediante laparoscopía
D) Solicitar cariograma
E) Planificar cirugía de descenso testicular al cumplir un año

Respuesta D. Criptorquidia bilateral no palpable, sobre todo con pene pequeño, es una alteración de la diferenciación sexual hasta demostrar lo contrario: puede ser una recién nacida 46,XX virilizada por hiperplasia suprarrenal congénita (con riesgo de crisis perdedora de sal). Requiere cariograma urgente (y 17-OH-progesterona y electrolitos). Controlar en un mes es adecuado solo para la criptorquidia unilateral aislada.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 20 · texto original del banco, sin revisar

Recién nacido de término sin testículos palpables, pene de 2 cm. Además de solicitar ecografía, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a urología de inmediato
B) Control en un mes
C) Iniciar testosterona tópica
D) Derivar a genética para cariotipo urgente
E) Cirugía correctiva a los 3 meses

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Control en un mes (opción B). Control en un mes. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

2.01.1.089 Fimosis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-27

QUÉ HAY QUE SABER

- Fimosis fisiológica: prepucio no retráctil, normal hasta los 3-5 años y presente en ~10% a los 6 años; adherencias balanoprepuciales normales.
- Fimosis patológica: anillo fibroso cicatricial blanquecino (balanitis xerótica obliterante), balanitis o ITU recurrentes, abombamiento del prepucio al orinar con chorro débil.
- No retraer el prepucio a la fuerza (fisuras, cicatrices, parafimosis); higiene suave en baño.
- Tratamiento: corticoide tópico (betametasona 0,05-0,1%) 2 veces al día por 4-8 semanas con retracción suave; si falla, circuncisión.
- Parafimosis: prepucio retraído que no vuelve, edema del glande: urgencia; reducción manual con compresión y lubricación, si falla derivar.
- Seguimiento: derivar a cirugía infantil si fimosis patológica, falla de corticoide, ITU recurrente o balanitis a repetición.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 21

Niño de 3 años con prepucio estrecho que no permite retraerlo completamente. Logró el control de esfínteres hace 6 meses. No ha tenido infecciones urinarias, balanitis ni dificultad miccional. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Circuncisión inmediata
B) Aplicar corticoide tópico
C) Control en un año
D) Dilatación manual bajo anestesia
E) Derivar a urología pediátrica urgente

Respuesta C. La fimosis es fisiológica en la mayoría de los niños pequeños: el prepucio se va despegando espontáneamente y suele ser retráctil entre los 3 y 5 años o más. Sin complicaciones (balanitis, ITU, obstrucción miccional), la conducta es observar y no retraer a la fuerza. Los corticoides tópicos se usan si persiste más allá de esa edad o es sintomática.

2.01.1.090 Hernia inguinal

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.6 Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Hernia inguinal pediátrica: indirecta (persistencia del conducto peritoneo-vaginal), más frecuente en varones, prematuros y lado derecho.
- Clínica: aumento de volumen inguinal o inguinoescrotal intermitente que aumenta con llanto o esfuerzo; diagnóstico clínico (signo de la seda).
- Diferenciar de hidrocele comunicante (transiluminación positiva, varía de tamaño; observar hasta 1-2 años) y no comunicante.
- Hernia atascada: masa dolorosa irreductible, irritabilidad, vómitos; intentar reducción manual con analgesia si <12 h y sin signos de estrangulación; luego cirugía en 24-48 h.
- Estrangulación (eritema, fiebre, vómitos biliosos, compromiso general): cirugía de urgencia. Riesgo de atascamiento mayor en <1 año y prematuros.
- Seguimiento: derivar a cirugía infantil para herniotomía electiva precoz en todo niño con hernia inguinal; en lactantes, cirugía programada a la brevedad.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 3

Recién nacido de 3 días con protuberancia blanda en la línea media abdominal, de 1 centímetro de diámetro, reductible, sin signos inflamatorios. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Cirugía electiva inmediata
B) Cirugía de urgencia
C) Derivación a cirugía pediátrica urgente
D) Antibióticos profilácticos
E) Observación: la mayoría se cierra sola antes de los 4 años

Respuesta E. La hernia umbilical del recién nacido es fisiológica y se cierra espontáneamente en la gran mayoría de los casos antes de los 4 años. No requiere cirugía ni antibióticos mientras sea reductible y sin signos inflamatorios.

Pregunta de práctica

Un lactante de 3 meses, nacido de término, presenta un aumento de volumen inguinal derecho que aparece con el llanto y desaparece en reposo. Al examen la tumoración es blanda, reductible e indolora, y no transilumina. El testículo derecho está en el escroto. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Observar hasta los 2 años, porque suele cerrarse espontáneamente
B) Puncionar para descartar hidrocele
C) Indicar braguero
D) Cirugía solo si se atasca
E) Cirugía electiva precoz (herniotomía) en los próximos días a semanas

Respuesta E. La hernia inguinal pediátrica es indirecta, por persistencia del conducto peritoneovaginal, y no se cierra sola. Por el alto riesgo de atascamiento en lactantes debe operarse en forma electiva y precoz, apenas se diagnostica. A diferencia de la hernia umbilical y el hidrocele comunicante, no se observa. El braguero no está indicado y la punción está contraindicada.

2.01.1.091 Alteraciones de los pies

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.14 Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Pie plano flexible: normal hasta los 6-8 años, arco aparece al ponerse en puntillas; asintomático no requiere tratamiento ni plantillas.
- Pie plano rígido o doloroso (coalición tarsal, astrágalo vertical): derivar.
- Metatarso aducto: antepié en aducción con borde lateral convexo; flexible se corrige solo o con elongación; rígido: yesos.
- Pie bot (equino varo congénito): equino, varo, aducto y cavo rígido; tratamiento con método de Ponseti (yesos seriados desde las primeras semanas, tenotomía y férula). Buscar displasia de caderas asociada.
- Marcha en puntillas persistente >3 años o asimétrica: descartar parálisis cerebral, distrofia muscular, TEA; marcha con pies hacia dentro suele ser por anteversión femoral o torsión tibial y se corrige espontáneamente.
- Seguimiento: derivar a traumatología infantil pie bot, pie plano rígido/doloroso, metatarso aducto rígido y alteraciones asimétricas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Recién nacido de término, de 2 días de vida, en puerperio. Al examen, el pie derecho está en equino, varo, aducto y cavo, con un pliegue medial profundo, y no se logra llevar a posición neutra con la manipulación suave. El resto del examen, incluidas caderas y columna, es normal. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A) Pie metatarso aducto postural; observar y tranquilizar
B) Pie bot; esperar hasta el año de vida para cirugía
C) Pie plano flexible; plantillas desde el inicio de la marcha
D) Pie talo valgo; ejercicios de elongación por los padres
E) Pie bot (equinovaro congénito); derivar precozmente a traumatología infantil para tratamiento con método de Ponseti (yesos seriados)

Respuesta E. El pie bot o equinovaro congénito tiene equino, varo, aducto y cavo rígidos, que no se corrigen con la manipulación. Debe derivarse en las primeras semanas para el método de Ponseti con yesos seriados, habitualmente con tenotomía del Aquiles y férula de abducción. Las deformidades posturales, en cambio, se corrigen pasivamente.

2.01.1.092 Displasia de caderas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.22 Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik

QUÉ HAY QUE SABER

- Displasia del desarrollo de caderas: factores de riesgo sexo femenino, primogénito, presentación podálica, antecedente familiar, oligoamnios, otras deformidades (tortícolis, pie bot).
- Examen en RN y controles: maniobras de Ortolani (reduce, signo de salida) y Barlow (luxa) hasta los 3 meses; luego limitación de abducción, asimetría de pliegues, signo de Galeazzi, acortamiento.
- Tamizaje GES: radiografía de pelvis AP a los 3 meses a todos los lactantes (índice acetabular, líneas de Hilgenreiner y Perkins, cuadrantes de Putti); ecografía de cadera antes de los 3 meses si hay factores de riesgo o examen alterado.
- Diagnóstico tardío (marcha): cojera, marcha de Trendelenburg, hiperlordosis en displasia bilateral.
- Tratamiento inicial: no usar doble pañal (no tiene evidencia); el especialista indica arnés de Pavlik (<6 meses), reducción cerrada con yeso o cirugía según edad.
- Seguimiento: derivar a traumatología infantil toda sospecha clínica o radiológica; displasia de caderas es GES.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 34

Lactante de 2 meses, con lactancia materna exclusiva y buen incremento de peso, presenta signo de Ortolani y limitación en la abducción de la cadera derecha. Sin antecedentes familiares. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar ecografía de caderas
B) Solicitar resonancia magnética de caderas
C) Indicar doble pañal y control en un mes
D) Realizar radiografía anteroposterior de pelvis de rutina a los 3 meses
E) Realizar cirugía

Respuesta A. Ante un Ortolani positivo antes de los 3 meses, el examen de elección es la ecografía de caderas, porque el núcleo femoral todavía es cartilaginoso y no se ve en radiografía. Esperar a la radiografía de los 3 meses retrasaría la derivación de un hallazgo ya positivo.

2.01.1.093 Infecciones osteoarticulares

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.2 Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- Artritis séptica: urgencia; fiebre, articulación caliente, dolorosa, con impotencia funcional (cadera en flexión, abducción y rotación externa, pseudoparálisis en lactante). S. aureus el principal agente; Kingella kingae en <4 años.
- Criterios de Kocher (cadera): fiebre >38,5 °C, no apoyo, VHS >40 mm/h, leucocitos >12.000 (PCR >2 mg/dL): ≥3 alta probabilidad. Diferencial: sinovitis transitoria (post viral, afebril, buen estado).
- Osteomielitis aguda hematógena: metáfisis de huesos largos, dolor localizado, fiebre, cojera; Rx inicial normal (cambios a los 10-14 días), RM de elección; hemocultivos.
- Estudio: hemograma, VHS, PCR, hemocultivos, ecografía de cadera (derrame) y artrocentesis (>50.000 leucocitos con PMN, Gram y cultivo).
- Manejo inicial: hospitalizar, hemocultivos y cloxacilina o cefazolina EV (+ clindamicina/vancomicina si SAMR); artritis séptica requiere drenaje quirúrgico urgente.
- Seguimiento: derivar a traumatología infantil; completar antibiótico 3-4 semanas (artritis) o 4-6 semanas (osteomielitis) con PCR seriada.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 105

Una niña de 5 años presenta dolor en muslo izquierdo, que luego se ubica en la cadera izquierda y que limita su movimiento. Al examen físico está en buenas condiciones. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Sinovitis transitoria
B) Atritis séptica
C) Artritis reumatoidea
D) Osteomielitis
E) Tumor de Ewing

Respuesta A. Aunque la sinovitis transitoria suele ser en menores de 5 años, la clínica es compatible, porque la niña está en buenas condiciones.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 94

Un niño de 6 años consulta por dolor en el codo derecho de dos días de evolución, asociado a impotencia funcional y fiebre de hasta 39 °C. Al examen físico se observa el codo eritematoso y aumentado de volumen, con dolor intenso a la movilización activa y pasiva. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Staphylococcus aureus
B) Haemophilus influenzae
C) Streptococcus agalactiae
D) Neisseria meningitidis
E) Streptococcus pyogenes

Respuesta A. Monoartritis aguda febril con dolor a la movilización activa y pasiva en un niño es artritis séptica hasta demostrar lo contrario. El agente más frecuente a toda edad pediátrica es Staphylococcus aureus (además Kingella kingae en menores de 4 años). El Haemophilus prácticamente desapareció con la vacuna. Requiere artrocentesis, drenaje y antibióticos endovenosos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 142 · texto original del banco, sin revisar

Lactante de 6 meses, es traída por cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por rechazo alimentario, irritabilidad y decaimiento, asociado a inmovilidad de extremidad inferior izquierda. Al examen se encuentra con temperatura de 38,5ºC y se aprecia cadera izquierda en flexión, con mucho dolor a la movilización. El examen inicial más adecuado en este caso es:

A) Hemograma con VHS
B) Radiografía de pelvis
C) Ecografía de cadera
D) Cintigrafía ósea
E) Resonancia magnética de cadera

Respuesta A. Tiene una artritis séptica, por lo que la respuesta debería ser punción. La pregunta es capciosa. Que diga "examen inicial" hace orientar más al hemograma. Esta niña probablemente irá directo a pabellón. La Eco sirve para guiar la punción. No estoy seguro de cuál es la respuesta correcta.

2.01.1.094 Patología de columna

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.14 Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Escoliosis idiopática del adolescente: la más frecuente, predominio femenino en estirón puberal; tamizaje con test de Adams (giba costal al inclinarse) y escoliómetro.
- Confirmar con radiografía de columna total de pie AP y lateral: escoliosis si ángulo de Cobb ≥10°; idiopática típicamente torácica derecha e indolora.
- Manejo por Cobb y madurez (Risser): <20-25° observación con controles radiológicos cada 4-6 meses; 25-40-45° en crecimiento: corsé; >45-50°: cirugía. Escoliosis idiopática <25 años es GES (cirugía).
- Banderas rojas de escoliosis secundaria: dolor, curva torácica izquierda, progresión rápida, déficit neurológico, manchas café con leche (neurofibromatosis), alteraciones cutáneas lumbosacras: RM.
- Dolor lumbar en niño no es habitual: descartar espondilolisis (deportistas en hiperextensión), espondilodiscitis, tumores (osteoma osteoide: dolor nocturno que cede con AINE), Scheuermann (cifosis rígida).
- Seguimiento: derivar a traumatología infantil escoliosis ≥20° o con banderas rojas; control en APS de curvas menores.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 132

En el examen físico de un recién nacido se evalúa la región lumbosacra en busca de marcadores cutáneos de disrafia espinal. **¿Qué alteración del examen físico obliga a descartar una disrafia espinal de tipo espina bífida oculta?**

A) Melanocitosis dérmica congénita (mancha mongólica)
B) Nevus flammeus sacro
C) Nevo congénito pequeño en la zona sacra
D) Hoyuelo sacro o fosita pilonidal típica
E) Seno dérmico sacrococcígeo

Respuesta E. Un seno dérmico (trayecto que comunica la piel con planos profundos, sobre la zona sacra alta o lumbar) obliga a estudiar disrafia espinal oculta y médula anclada, y tiene riesgo de meningitis. Otros marcadores son hipertricosis localizada, lipoma o hemangioma lumbosacro. La fosita pilonidal simple, baja y con fondo visible, y la mancha mongólica son hallazgos benignos.

2.01.1.095 Conjuntivitis aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.2 Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Conjuntivitis aguda: ojo rojo con secreción, sin dolor intenso, visión y pupilas normales.
- Bacteriana: secreción purulenta, párpados pegados al despertar; tratar con colirio antibiótico (tobramicina o cloranfenicol, ungüento en lactantes) por 5-7 días. Asociada a otitis media (síndrome conjuntivitis-otitis por H. influenzae): amoxicilina-ácido clavulánico oral.

- Viral (adenovirus): secreción acuosa, folículos, adenopatía preauricular, muy contagiosa; manejo con frío local, lágrimas artificiales y lavado de manos. Alérgica: prurito, bilateral, antecedentes atópicos; antihistamínicos tópicos.
- Neonatal: <24 h química; 2-5 días gonocócica (hiperaguda, purulenta: ceftriaxona sistémica, urgencia); 5-14 días Chlamydia (azitromicina o eritromicina oral).
- No usar corticoides tópicos en atención primaria.
- Seguimiento: derivar a oftalmología si dolor, fotofobia, disminución de visión, opacidad corneal, conjuntivitis neonatal o falta de respuesta en 7 días.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 32

Un recién nacido de 20 días de vida, cuyo embarazo no fue controlado y que nació por parto vaginal en su casa, es traído por presentar secreción ocular bilateral desde hace 5 días. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival y escasa secreción bilateral. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Neisseria meningitidis
B) Neisseria gonorrhoeae
C) Streptococcus pneumoniae
D) Streptococcus agalactiae
E) Chlamydia trachomatis

Respuesta E. El gonococo y la clamidia son las dos causas clásicas de conjuntivitis neonatal, pero se distinguen por el tiempo de aparición y la intensidad: el gonococo es muy purulento y aparece en la primera semana; la clamidia demora más, entre una y tres semanas, y es menos purulenta. Con 20 días de vida y secreción escasa, la clamidia es más probable que el gonococo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 32

Un recién nacido de 20 días, cuyo embarazo no fue controlado y que nació por parto vaginal en su casa, es traído por secreción ocular bilateral desde hace 5 días. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival y escasa secreción bilateral. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Neisseria meningitidis
B) Neisseria gonorrhoeae
C) Streptococcus pneumoniae
D) Streptococcus agalactiae
E) Chlamydia trachomatis

Respuesta E. La conjuntivitis neonatal por Chlamydia trachomatis aparece entre los 5 y 14 días de vida o después, con secreción escasa o moderada, y puede asociarse a neumonía afebril. La gonocócica aparece antes (2 a 5 días) con secreción purulenta abundante y riesgo de perforación corneal. Se trata con azitromicina o eritromicina oral, y deben tratarse los padres.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 22 · texto original del banco, sin revisar

Niño con fiebre, odinofagia, ojo rojo bilateral y conjuntivitis. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Aseo ocular con suero fisiológico
B) Colirio antibiótico tópico
C) Aciclovir oftálmico
D) Azitromicina oral
E) Clorfenamina oral

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Aseo ocular con suero fisiológico (opción A). Aseo ocular con suero fisiológico. Ante cualquier signo de alarma, la conducta del médico general es derivar de urgencia al oftalmólogo sin intentar manejo. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 123 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 4 años presenta sensación febril y ojo rojo bilateral, asociado a ardor y lagrimeo, lo que se acompaña de rinorrea y odinofagia. Varios de sus familiares tienen los mismos síntomas. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Chlamydia trachomatis
B) Staphilococcus aureus
C) Streptococcus pyogenes
D) Haemophilus influenzae
E) Adenovirus

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Adenovirus). Es una fiebre faringoconjuntival clásica por ADV.. El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del médico general. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 10 · texto original del banco, sin revisar

Un prescolar de 4 años presenta un cuadro de una semana de evolución de fiebre, hasta 39°C, asociada a odinofagia. Además, se ha asociado ojo rojo, que inició en el lado izquierdo y al día siguiente se extendió al ojo derecho. Al examen físico, tiene faringe eritematosa, ojo rojo bilateral, con secreción mucosa escasa y se palpan adenopatías cervicales bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de sus síntomas oculares?

A) Aseo con suero fisiológico
B) Corticoide tópico
C) Ungüento de tobramicina
D) Colirio de gentamicina
E) Ungüento de cloramfenicol

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Ungüento de cloramfenicol (opción E). Ante cualquier signo de alarma, la conducta del médico general es derivar de urgencia al oftalmólogo sin intentar manejo. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

2.01.1.096 Estrabismo

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Estrabismo: desalineación ocular; normal intermitente hasta los 4-6 meses. Persistente o constante después de esa edad es patológico.
- Evaluar con reflejo corneal de Hirschberg y cover test; diferenciar pseudoestrabismo (epicanto, puente nasal ancho, reflejo corneal simétrico).
- Endotropia (desviación nasal) la más frecuente; endotropia acomodativa en hipermétropes a los 2-3 años, se corrige con lentes.
- Riesgo principal: ambliopía (ojo vago), tratable hasta los 7-8 años con oclusión del ojo sano y corrección óptica; luego es irreversible.
- Banderas rojas: estrabismo de inicio súbito, con leucocoria (retinoblastoma), paresia de nervios craneanos, cefalea o signos de hipertensión endocraneana.
- Seguimiento: derivar a oftalmología infantil todo estrabismo persistente después de los 6 meses; estrabismo en <9 años es GES.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 115

Un lactante de 1 mes acude a control. Al examen físico presenta estrabismo intermitente y asimétrico de ambos ojos. El resto de la inspección ocular es normal, incluido el rojo pupilar. Su crecimiento, desarrollo psicomotor y el resto de su examen físico son normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Derivar a oftalmólogo
B) Mantener los controles habituales del lactante
C) Solicitar RM de cerebro
D) Realizar fondo de ojo
E) Indicar parche ocular alternante

Respuesta B. En los primeros meses la fijación y la coordinación binocular son inmaduras, por lo que un estrabismo intermitente es fisiológico hasta los 4 a 6 meses. Si el resto del examen es normal, se mantienen los controles. Debe derivarse si el estrabismo es constante, persiste después de los 6 meses o hay rojo pupilar alterado.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 26 · texto original del banco, sin revisar

Niño de 1 mes con desviación de la mirada de manera intermitente. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a oftalmología de urgencia
B) Solicitar TAC de cerebro
C) Mantener controles habituales de niño sano
D) Iniciar parche ocular
E) Solicitar fondo de ojo urgente

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Mantener controles habituales de niño sano (opción C). Mantener controles habituales de niño sano. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

2.01.1.097 Ojo rojo

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.1 Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo · Tema 15.5 Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Ojo rojo superficial (conjuntivitis): hiperemia periférica, secreción, visión normal, sin dolor intenso; manejo en APS.
- Ojo rojo profundo (banderas rojas): dolor intenso, fotofobia, disminución de agudeza visual, inyección ciliar periquerática, pupila alterada, opacidad corneal (queratitis, uveítis anterior, glaucoma).
- Uveítis anterior en niños: asociada a artritis idiopática juvenil oligoarticular con ANA+, frecuentemente asintomática: tamizaje oftalmológico periódico.
- Trauma: erosión corneal (fluoresceína), cuerpo extraño, hifema; quemadura química: irrigación abundante inmediata con SF por 15-30 min.
- Hemorragia subconjuntival aislada: benigna; si recurrente o con petequias, estudiar coagulación. No usar corticoides ni anestésicos tópicos de forma ambulatoria.
- Seguimiento: derivar a oftalmología de urgencia ante banderas rojas, trauma penetrante o químico.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Un hombre de 58 años despierta con una mancha roja viva en el sector nasal del ojo derecho. No refiere traumatismo, dolor, pérdida de visión ni secreción ocular. Al examen: hemorragia plana homogénea que oculta los vasos esclerales en la conjuntiva bulbar nasal, agudeza visual normal en ambos ojos, pupilas normales y córnea transparente. **¿Cuál es la conducta indicada?**

A) Indicar ácido tranexámico oral y reposo absoluto
B) Tranquilizar al paciente, explicar que se resolverá en 10 a 14 días y no indicar fármacos tópicos
C) Instilar colirio de fenilefrina para lograr vasoconstricción inmediata
D) Realizar paracentesis conjuntival para evacuar el hematoma
E) Derivar de inmediato para fotocoagulación láser

Respuesta B. Hiposfagma o hemorragia subconjuntival espontánea, sin dolor, con visión y pupilas normales: no tiene ningún signo de alarma. La conducta es expectante, con educación y control de la presión arterial si corresponde. Se reabsorbe sola en una a dos semanas, sin fármacos tópicos.

Pregunta de práctica

Una mujer de 32 años consulta por enrojecimiento sectorial en el ojo derecho de 3 días de evolución, asociado a sensación leve de arenilla, sin dolor intenso ni baja de visión. Al examen: agudeza visual normal bilateral, inyección vascular roja brillante triangular en el sector temporal de la conjuntiva bulbar. Tras instilar una gota de fenilefrina al 2,5%, la hiperemia vascular desaparece casi por completo a los 10 minutos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?**

A) Escleritis necrotizante; iniciar pulsos de metilprednisolona endovenosa
B) Epiescleritis simple; indicar lubricantes oculares o AINE tópico y tranquilizar a la paciente
C) Glaucoma agudo incipiente; indicar pilocarpina al 2% en colirio
D) Uveítis anterior aguda; solicitar resonancia magnética cerebral
E) Queratitis estromal herpética; iniciar aciclovir endovenoso

Respuesta B. El blanqueamiento vascular completo tras la fenilefrina confirma que el plexo comprometido es el superficial: epiescleritis simple. La conducta es sintomática, con resolución espontánea en una a dos semanas.

Pregunta de práctica

Mujer de 52 años con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento con metotrexato consulta por dolor ocular izquierdo muy intenso, de 5 días de evolución, continuo y profundo, que le irradia al hemicráneo y no le deja dormir. Al examen: agudeza visual conservada, hiperemia difusa con marcada coloración violácea en el ojo izquierdo. Se instila fenilefrina al 2,5% y a los 15 minutos el enrojecimiento y el dolor persisten sin cambios. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar colirio de cloranfenicol y control en 1 semana
B) Indicar colirio de dexametasona cada 4 horas
C) Iniciar AINE oral en dosis altas y derivar de urgencia a oftalmología y reumatología
D) Tranquilizar a la paciente e indicar solo lágrimas artificiales
E) Indicar colirio de timolol para bajar la presión ocular

Respuesta C. Dolor terebrante nocturno, ojo violáceo profundo, que no blanquea con fenilefrina, en una paciente con artritis reumatoide, es escleritis. Nunca responde a colirios: se trata con AINE oral en dosis altas o corticoides sistémicos, y se deriva de urgencia a oftalmología y reumatología.

2.01.1.098 Vicios de refracción

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Vicios de refracción: hipermetropía (fisiológica en lactantes), miopía (aparece en edad escolar, ve mal de lejos), astigmatismo y anisometropía (riesgo de ambliopía).
- Sospecha: acercarse a la pantalla o al cuaderno, entrecerrar ojos, cefalea tras esfuerzo visual, bajo rendimiento escolar, frotarse los ojos.
- Tamizaje de agudeza visual con tabla de Snellen o figuras desde los 4 años en control de salud; derivar si visión <0,7 (20/30) en ≥5 años o diferencia de 2 líneas entre ojos.
- Tratamiento: corrección óptica (lentes) indicada por oftalmólogo u optómetra; tratar ambliopía antes de los 7-8 años.
- Programa JUNAEB entrega lentes en escolares y vicio de refracción en ≥65 años es GES; en niños mantener controles anuales.
- Seguimiento: derivar a oftalmología para refracción con cicloplejia y control periódico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un escolar de 9 años refiere que no ve bien la pizarra desde hace meses y entrecierra los ojos para mirar de lejos. Lee bien de cerca. La agudeza visual es 20/80 en ambos ojos y mejora a 20/25 con el agujero estenopeico. El resto del examen ocular es normal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Miopía
B) Hipermetropía
C) Presbicia
D) Ambliopía
E) Catarata congénita

Respuesta A. Mala visión de lejos con buena visión de cerca, que mejora con el agujero estenopeico (indica un defecto refractivo), es miopía, el vicio de refracción más frecuente en escolares. Se corrige con lentes divergentes indicados por oftalmólogo. La hipermetropía afecta más la visión cercana y da astenopia; la ambliopía no mejora con el estenopeico; la presbicia es del adulto.

2.01.1.099 Epistaxis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.11 Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Epistaxis pediátrica: casi siempre anterior, plexo de Kiesselbach; gatillada por grataje, sequedad ambiental, rinitis, cuerpo extraño. Más frecuente 2-10 años.
- Manejo: sentado inclinado hacia adelante, compresión digital de ambas alas nasales por 10-15 min continuos sin soltar; frío local.

- Si persiste: vasoconstrictor tópico (oximetazolina) en algodón y compresión; taponamiento anterior si falla; cauterización química con nitrato de plata en punto sangrante identificado (por ORL).
- Prevención: humidificación, vaselina o suero nasal, cortar uñas, tratar rinitis alérgica.
- Banderas rojas: epistaxis recurrente con otros sangrados o historia familiar (von Willebrand, PTI, hemofilia), unilateral con obstrucción en adolescente varón (nasoangiofibroma juvenil), cuerpo extraño con rinorrea fétida unilateral.
- Seguimiento: control en APS; derivar a ORL si recurrente o refractaria y estudiar coagulación (hemograma, TP, TTPA) si hay sospecha de discrasia.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un niño de 7 años presenta sangrado nasal por la fosa derecha de 5 minutos, tras rascarse la nariz. Está tranquilo, hemodinámicamente estable y no tiene antecedentes de sangrado ni de uso de fármacos. **¿Cuál es la primera medida?**
> **A)** Inclinar la cabeza hacia atrás y aplicar hielo en la frente
> **B)** Taponamiento posterior
> **C)** Compresión digital continua de las alas nasales por 10 minutos, con la cabeza inclinada hacia adelante
> **D)** Cauterización con nitrato de plata como primera medida
> **E)** Solicitar pruebas de coagulación urgentes
> Respuesta C. La epistaxis en niños es casi siempre anterior, del plexo de Kiesselbach, gatillada por grataje o sequedad. La primera medida es comprimir las alas nasales contra el tabique en forma continua por 10 minutos, con la cabeza inclinada hacia adelante para no deglutir sangre. Si persiste o recurre se cauteriza.

2.01.1.100 Hipertrofia adenoidea/amigdalina

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.15 Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipertrofia adenoamigdalina: causa más frecuente de trastorno respiratorio del sueño en niños, peak 3-6 años.
- Clínica: ronquido, pausas respiratorias, sueño inquieto, respiración bucal, voz nasal, facie adenoidea, enuresis, somnolencia o hiperactividad diurna, bajo rendimiento escolar, mal incremento ponderal.
- Clasificar amígdalas (grados 1-4 de Brodsky); adenoides por radiografía de cavum lateral (relación adenoide/nasofaringe) o nasofibroscopía.
- Complicaciones: apnea obstructiva del sueño, hipertensión pulmonar/cor pulmonale, otitis media con efusión recurrente, alteraciones del crecimiento facial.
- Manejo inicial: corticoide intranasal (mometasona) por 6-12 semanas en hipertrofia adenoidea leve-moderada o rinitis asociada; polisomnografía en casos dudosos.
- Seguimiento: derivar a ORL para adenoamigdalectomía si apnea obstructiva del sueño, hipertrofia obstructiva sintomática, otitis recurrente o con efusión persistente.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas constituye una indicación formal para considerar una amigdalectomía en un paciente pediátrico, de acuerdo con los criterios de Paradise? **Elija la alternativa correcta.**
> **A)** Haber presentado 2 episodios de amigdalitis bacteriana en el último año
> **B)** Presentar 7 episodios documentados de faringoamigdalitis bacteriana en el último año tratados con antibióticos
> **C)** Presentar ronquido nasal esporádico únicamente durante los resfriados comunes
> **D)** Presencia de placas de caseum amigdalino fétido en criptas sin fiebre ni odinofagia
> **E)** Un único episodio de amigdalitis viral asociada a conjuntivitis por adenovirus
> Respuesta B. Paradise exige episodios bacterianos documentados y tratados: siete en un año, o cinco por año durante dos años, o tres por año durante tres años. La caseosis amigdalina es benigna y no justifica cirugía.

2.01.1.101 Hipoacusia

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.5 Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipoacusia: tamizaje auditivo neonatal universal con emisiones otoacústicas o potenciales evocados auditivos automatizados (GES para prematuros <32 semanas o <1.500 g; hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro).
- Factores de riesgo: prematurez, UCI neonatal >5 días, TORCH (CMV), hiperbilirrubinemia con exanguinotransfusión, meningitis, ototóxicos (aminoglicósidos), historia familiar, malformaciones craneofaciales.
- Hipoacusia de conducción más frecuente: otitis media con efusión, tapón de cerumen. Neurosensorial: congénita (genética, CMV), post meningitis.
- Sospecha: no reacciona a sonidos, retraso del lenguaje, problemas de atención o rendimiento escolar, preocupación de los padres (siempre considerar).
- Estudio: otoscopía; audiometría desde 4-5 años, impedanciometría, potenciales evocados en lactantes.
- Seguimiento: derivar a ORL; intervención (audífonos, implante coclear) idealmente antes de los 6 meses para preservar el lenguaje.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una madre pregunta por el tamizaje auditivo de su recién nacido de término sano, que no tiene factores de riesgo de hipoacusia. **¿Cuál es el examen de tamizaje auditivo neonatal más utilizado en recién nacidos sanos?**

A) Audiometría tonal
B) Resonancia magnética de oído
C) Impedanciometría
D) Prueba de diapasones
E) Emisiones otoacústicas

Respuesta E. El tamizaje auditivo neonatal busca detectar hipoacusia antes de los 3 meses e intervenir antes de los 6 meses. En recién nacidos sanos se usan las emisiones otoacústicas (rápidas, no invasivas); en prematuros o de alto riesgo se prefieren los potenciales evocados auditivos automatizados, porque detectan neuropatía auditiva. La audiometría tonal requiere cooperación, desde aproximadamente los 4 años.

2.01.1.102 Otitis media recurrente

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.1 Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- Otitis media aguda recurrente: ≥3 episodios en 6 meses o ≥4 en 12 meses (con 1 en los últimos 6 meses).
- Factores de riesgo: sala cuna, tabaquismo pasivo, uso de chupete o mamadera en decúbito, ausencia de lactancia materna, hipertrofia adenoidea, fisura palatina, síndrome de Down, inmunodeficiencia.
- Diagnóstico de cada episodio con otoscopía; distinguir de otitis media con efusión (líquido sin inflamación aguda, hipoacusia).
- Manejo inicial: tratar episodios agudos con amoxicilina en dosis altas, controlar factores de riesgo, vacunas al día (neumocócica, influenza), lactancia materna.
- No se recomienda profilaxis antibiótica prolongada de rutina; evaluar audición.
- Seguimiento: derivar a ORL para evaluar tubos de ventilación (colleras) ± adenoidectomía y estudio auditivo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un lactante de 11 meses presenta su tercer episodio de otitis media aguda supurada en los últimos 4 meses, respondiendo satisfactoriamente a la amoxicilina en cada oportunidad. La madre pregunta cuál es la definición médica de su condición y el paso a seguir. **¿Cuál es la respuesta correcta?**

A) Corresponde a una otitis media crónica supurada y debe iniciar profilaxis antibiótica diaria con cotrimoxazol.
B) Cumple criterios de otitis media recurrente y debe ser derivado al otorrinolaringólogo para evaluación de tubos de ventilación.
C) No cumple criterios de recurrencia porque se requieren al menos 5 episodios en 6 meses.
D) Se trata de una falla inmunológica primaria y requiere inmunoglobulinas endovenosas mensuales.
E) Debe recibir amoxicilina en dosis profiláctica continua durante toda la temporada de invierno.

Respuesta B. OMA recurrente: 3 o más episodios en 6 meses, o 4 o más en 12 meses. Se deriva a ORL para evaluar tubos de ventilación. La quimioprofilaxis prolongada está contraindicada por generar resistencia.

2.01.1.103 Rinitis alérgica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.9 Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

QUÉ HAY QUE SABER

- Rinitis alérgica: estornudos en salva, rinorrea acuosa, prurito nasal, obstrucción; signos: saludo alérgico, pliegue nasal, ojeras alérgicas, mucosa pálida y edematosa. Asocia asma y dermatitis atópica.
- Clasificación ARIA: intermitente vs persistente (≥4 días/semana y ≥4 semanas); leve vs moderada-grave (altera sueño, colegio o actividades).
- Leve intermitente: antihistamínico de 2ª generación (cetirizina 0,25 mg/kg/día, 5 mg en 2-6 años y 10 mg en >6 años; loratadina 5-10 mg/día; desloratadina).
- Persistente o moderada-grave: corticoide intranasal diario (mometasona o fluticasona), el más eficaz; lavado nasal con suero fisiológico.
- Control ambiental de alérgenos (ácaros, epitelios, pólenes, humo de tabaco); evitar vasoconstrictores nasales >5 días.
- Seguimiento: control en APS; derivar a inmunología/ORL si refractaria, para pruebas cutáneas o inmunoterapia.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Un estudiante de 24 años consulta por rinorrea acuosa profusa, prurito ocular y nasal intenso y salvas de estornudos que se presentan durante 5 a 6 días a la semana desde hace 2 meses, coincidiendo con la primavera. Se despierta en la noche con la nariz totalmente obstruida y esto afecta su concentración para estudiar. A la rinoscopía anterior se aprecian cornetes inferiores hipertróficos y pálidos. **De acuerdo con las guías ARIA, ¿cuál es la clasificación de su enfermedad y el tratamiento de primera línea más adecuado?**

A) Rinitis alérgica intermitente leve; clorfenamina oral 4 mg cada 8 horas
B) Rinitis alérgica persistente moderada-severa; corticoide intranasal en spray diario (ej. fluticasona o mometasona)
C) Rinitis vasomotora pura; bromuro de ipratropio nasal según necesidad
D) Rinosinusitis crónica poliposa; amoxicilina oral con ácido clavulánico por 21 días
E) Rinitis alérgica persistente leve; oximetazolina nasal tópica cada 12 horas por 1 mes

Respuesta B. Los síntomas aparecen 4 o más días a la semana por 4 o más semanas: persistente. Hay alteración del sueño y de la concentración: moderada a severa. La primera línea son los corticoides intranasales, superiores a los antihistamínicos orales para la obstrucción nasal.

Pregunta de práctica

Un joven de 19 años consulta por obstrucción nasal bilateral constante, estornudos matinales y goteo nasal transparente desde hace 2 meses. No duerme bien por la nariz tapada y en clases está desconcentrado. Hace 3 semanas se aplica spray de oximetazolina 4 veces al día: al comienzo se destapaba de inmediato, pero ahora el efecto dura una hora y se tapa peor. A la rinoscopía, cornetes inferiores engrosados y eritematosos que contactan el tabique. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar la oximetazolina a cada 4 horas
B) Suspender la oximetazolina e iniciar corticoide intranasal, con lavados nasales
C) Amoxicilina oral por 7 días
D) Solo clorfenamina oral en la noche
E) Cirugía de cornetes inmediata

Respuesta B. Es una rinitis alérgica persistente moderada a severa, con una rinitis medicamentosa por oximetazolina sobre 5 días. Se suspende el descongestionante de inmediato, se inicia corticoide intranasal en dosis plenas por 1 a 2 meses y se asocian lavados nasales.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 167 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 4 años consulta por infecciones recurrentes, habiendo tenido una otitis media aguda, 2 bronquitis y 3 amigdalitis en el último año. Presenta rinorrea con frecuencia, obstrucción nasal, respira por la boca y ronca en la noche. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Rinitis alérgica
B) Inmunodeficiencia primaria por déficit de inmunoglobulinas
C) Hipertrofia de adenoides
D) Fibrosis quística
E) Enfermedad de cilio inmóvil

Respuesta A. La rinitis alérgica es la causa más frecuente de obstrucción nasal, rinorrea y respiración bucal en pediatría. La HT de adenoides sí tiene infecciones recurrentes y obstrucción, aunque le sobra la rinorrea. La B, D y E tendrían infecciones bacterianas, sin obstrucción nasal y la D y E tienden a hacer neumonías, mientras que la B sí hace neumonías, pero también las otitis y sinusitis. El número de

2.01.1.104 Acné

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 16.2 Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína

QUÉ HAY QUE SABER

- Acné: enfermedad del folículo pilosebáceo, peak en adolescencia; comedones (no inflamatorio), pápulas y pústulas (inflamatorio leve-moderado), nódulos y quistes (severo, riesgo de cicatriz).
- Acné leve comedoniano: retinoide tópico (adapaleno 0,1% o tretinoína) nocturno; agregar peróxido de benzoílo 2,5-5% si hay lesiones inflamatorias.
- Moderado papulopustular: retinoide tópico + peróxido de benzoílo + antibiótico oral (doxiciclina 100 mg/día o limeciclina) por 3 meses; no usar antibiótico tópico solo.
- En adolescentes con hiperandrogenismo (SOP) considerar anticonceptivos con antiandrógeno.
- Acné severo, nódulo-quístico, cicatrizal o refractario: isotretinoína oral (teratogénica, requiere anticoncepción doble y control de perfil lipídico y transaminasas) por dermatólogo.
- Seguimiento: control a las 8-12 semanas para evaluar respuesta; derivar a dermatología si severo, refractario o con cicatrices.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una adolescente de 13 años consulta por lesiones en la frente y la nariz desde hace 6 meses. Al examen se observan numerosos comedones abiertos y cerrados, sin pápulas inflamatorias, pústulas ni nódulos. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A) Isotretinoína oral
B) Doxiciclina oral
C) Anticonceptivos orales
D) Retinoide tópico (ej. adapaleno)
E) Corticoide tópico

Respuesta D. Acné comedoniano (no inflamatorio) leve: el tratamiento de elección es un retinoide tópico (adapaleno o tretinoína), que normaliza la queratinización folicular; puede asociarse peróxido de benzoilo. Los antibióticos orales se reservan para acné inflamatorio moderado y la isotretinoína para acné grave, nodular o refractario. Los corticoides tópicos empeoran el acné.

2.01.1.105 Alteraciones pigmentarias

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.4 Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

QUÉ HAY QUE SABER

- Manchas café con leche: ≥6 manchas >5 mm en prepúberes (>15 mm en pospúberes), efélides axilares/inguinales y neurofibromas sugieren neurofibromatosis tipo 1.
- Máculas hipocrómicas en hoja de fresno (luz de Wood), angiofibromas faciales, espasmos infantiles: esclerosis tuberosa.

- Mancha mongólica: mácula gris azulada lumbosacra en RN, benigna, desaparece en la infancia; no confundir con maltrato.
- Vitíligo: máculas acrómicas bien delimitadas, simétricas, asociado a autoinmunidad tiroidea; corticoide o tacrolimus tópico, fototerapia. Pitiriasis alba: máculas hipopigmentadas descamativas en cara de niños atópicos; emolientes y fotoprotección.
- Nevos congénitos grandes (>20 cm) tienen riesgo de melanoma; nevos con cambios (ABCDE) requieren evaluación.
- Seguimiento: derivar a dermatología/neurología si se sospecha síndrome neurocutáneo, nevo congénito gigante o vitíligo extenso.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 3

Un lactante de 12 meses es traído por su madre porque presenta coloración amarillo-anaranjada en las palmas de las manos, las plantas y las mejillas. No tiene otros antecedentes, pesa 9,5 kg, mide 73,5 cm y su examen físico no muestra otras alteraciones; las escleras son blancas. **¿Cuál es la causa de esta alteración?**

A) Hipercolesterolemia
B) Hipertrigliceridemia
C) Hiperbilirrubinemia de predominio directo
D) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
E) Un componente de la dieta

Respuesta E. Coloración amarillo-anaranjada de palmas, plantas y surcos nasogenianos con escleras respetadas, en un lactante sano, es carotenemia por alta ingesta de alimentos ricos en betacarotenos (zanahoria, zapallo). Es benigna y se resuelve al moderar su consumo. La ictericia por hiperbilirrubinemia compromete precozmente las escleras.

2.01.1.106 Candidiasis urogenital

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 20.9 Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Candidiasis del área del pañal: eritema intenso que compromete pliegues, con lesiones satélites (pápulas y pústulas periféricas), favorecida por humedad y antibióticos.
- Tratamiento: clotrimazol o nistatina tópica 2-3 veces al día por 7-14 días, cambio frecuente de pañal y pasta protectora de óxido de zinc.
- Muguet oral asociado: nistatina suspensión oral 4 veces al día; tratar el pezón materno si hay lactancia.
- Vulvovaginitis candidiásica en adolescentes: prurito, flujo blanco grumoso, pH <4,5; clotrimazol óvulo 500 mg dosis única o fluconazol 150 mg VO; en niñas prepúberes es rara (sospechar DM o antibióticos).
- Recurrente o extensa: descartar diabetes, inmunodeficiencia (VIH), uso de corticoides.
- Seguimiento: control si no hay respuesta en 1-2 semanas; candidiasis recurrente o en niña prepúber requiere estudio.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una adolescente de 16 años, sin actividad sexual, terminó hace una semana un tratamiento antibiótico por una faringoamigdalitis. Consulta por prurito vulvar intenso y flujo vaginal blanco, grumoso, sin mal olor. Al examen hay eritema y edema vulvar. El pH vaginal es 4,2. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Metronidazol oral
B) Clotrimazol vaginal
C) Ceftriaxona intramuscular
D) Corticoide tópico de alta potencia
E) Doxiciclina oral

Respuesta B. Prurito intenso, flujo blanco grumoso "como leche cortada", sin mal olor y con pH normal (menor a 4,5), tras uso de antibióticos, es candidiasis vulvovaginal. No es una ITS. Se trata con azol tópico (clotrimazol vaginal) o fluconazol oral en dosis única. El metronidazol es para vaginosis bacteriana y tricomoniasis, que elevan el pH.

2.01.1.107 Dermatitis atópica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.6 Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatitis atópica: eccema pruriginoso crónico y recurrente, historia personal o familiar de atopía. Lactante: mejillas y superficies extensoras (respeta el área del pañal); niño: pliegues flexurales.
- Diagnóstico clínico (criterios de Hanifin-Rajka): prurito, morfología y distribución típica, curso crónico, atopía; xerosis, Dennie-Morgan, pitiriasis alba.
- Base del tratamiento: emolientes diarios abundantes, baño corto con agua tibia, jabón syndet, ropa de algodón, evitar irritantes.
- Brotes: corticoide tópico de baja potencia en cara y pliegues (hidrocortisona 1%) y media potencia en cuerpo (mometasona) 1-2 veces al día por 7-14 días; inhibidores de calcineurina (tacrolimus, pimecrolimus) en zonas sensibles; antihistamínico sedante nocturno para prurito.
- Complicaciones: sobreinfección por S. aureus (costras melicéricas: antibiótico), eccema herpético (vesículas umbilicadas, fiebre: aciclovir urgente).
- Seguimiento: control periódico en APS con terapia proactiva; derivar a dermatología si severa o refractaria.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 79

Una niña de 4 años presenta lesiones cutáneas recurrentes de 2 años de evolución, caracterizadas por pápulas pruriginosas que aparecen en los antebrazos y fosas cubitales, así como en las piernas, fosas poplíteas, cara y cuello. Su madre comenta que pasa por periodos de exacerbación de las lesiones y otros en que son mucho menos intensas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Dermatitis alérgica
B) Urticaria
C) Dermatitis atópica
D) Escabiosis
E) Dermatitis seborreica

Respuesta C. Lesiones crónico recidivantes, pruriginosas, en pliegues flexurales más mejillas, con periodos de exacerbación y remisión en una niña de 4 años, es una dermatitis atópica clásica en su fase infantil.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 12

Un niño de 20 días de edad presenta lesiones eritematosas, con descamación en la cabeza y la zona interciliar, con descamación amarilla, de aspecto oleoso. Se ve de buen aspecto y ha subido de peso. **¿Cuál es la indicación más adecuada?**

A) Administrar fórmula con proteína hidrolizada
B) Crema de betametasona tópica
C) Crema de clotrimazol tópico
D) Vaselina tópica
E) Antibióticos tópicos

Respuesta D. Descamación amarilla y oleosa en cuero cabelludo y zona interciliar en un recién nacido de buen aspecto y con buena curva de peso es dermatitis seborreica del lactante, un cuadro benigno. En niños se prefiere no hacer nada o aplicar vaselina, a diferencia del adulto, donde sí se usan antimicóticos tópicos.

2.01.1.108 Dermatitis del pañal y de contacto

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.7 Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatitis del pañal irritativa: eritema en zonas convexas de contacto que respeta los pliegues; por humedad, orina y deposiciones.
- Tratamiento: cambio frecuente de pañal, aseo con agua tibia sin toallas con alcohol, aire libre, pasta de óxido de zinc en cada muda.
- Compromiso de pliegues con lesiones satélites: sobreinfección por Candida (clotrimazol/nistatina tópica). Descartar dermatitis seborreica (escamas amarillentas en cuero cabelludo y pliegues) y psoriasis.
- Dermatitis de contacto alérgica: lesiones bien delimitadas en zona de contacto (níquel en ombligo, calzado, cosméticos); evitar alérgeno, corticoide tópico de media potencia por 1-2 semanas.
- Dermatitis de contacto irritativa: por jabones, saliva (perioral), detergentes; emolientes y barrera.

- Seguimiento: control si no hay respuesta en 1-2 semanas; derivar a dermatología si persistente o atípica (test de parche).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 118

Lactante con eritema en la zona del pañal que no responde a óxido de zinc. Al examen se observa eritema intenso que compromete los pliegues inguinales, con pápulas y pústulas satélite en la periferia. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Clotrimazol tópico
B) Mupirocina tópica
C) Hidrocortisona tópica al 1%
D) Óxido de zinc en mayor concentración
E) Fluconazol oral

Respuesta A. La dermatitis irritativa del pañal respeta los pliegues; cuando los compromete y aparecen lesiones satélite, se ha sobreinfectado por Candida albicans. El tratamiento es un antifúngico tópico (clotrimazol o nistatina) junto con cambios frecuentes de pañal y barrera. El fluconazol oral no es necesario en la candidiasis cutánea localizada.

2.01.1.109 Ectoparasitosis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Escabiosis (Sarcoptes scabiei): prurito intenso nocturno, pápulas y surcos en espacios interdigitales, muñecas, axilas, cintura y genitales; en lactantes compromiso de palmas, plantas y cara; contagio familiar.
- Escabiosis: permetrina 5% crema de cuello a pies (incluir cuero cabelludo en lactantes) por 8-12 h, repetir a los 7 días; tratar a todos los contactos simultáneamente y lavar ropa a >60 °C. Alternativa ivermectina oral en >15 kg.
- Pediculosis capitis: prurito, liendres adheridas al pelo; permetrina 1% loción, repetir a los 7-10 días, retiro mecánico de liendres con peineta fina; revisar contactos.
- Prurito puede persistir 2-4 semanas tras tratamiento (no implica falla).
- Sobreinfección bacteriana (impétigo) requiere antibiótico; prurigo por picaduras de insectos (pulgas, chinches) es diferencial.
- Seguimiento: control a las 2-4 semanas; fracaso suele deberse a no tratar contactos o mala aplicación.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 144

Niño de 8 años con lesiones eritematosas papulosas en manos, pies, axilas y zona interdigital, muy pruriginosas, que empeoran de noche. También afectados su hermano y su madre. **¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?**

A) Escabiosis: permetrina 5% tópica + tratar a todos los contactos
B) Dermatitis atópica: emolientes y corticoides tópicos
C) Tinea pedis: clotrimazol tópico
D) Erupción por contacto: evitar alérgeno
E) Impétigo: mupirocina tópica

Respuesta A. Prurito nocturno con lesiones papulosas en espacios interdigitales, axilas, manos y pies, que afecta a varios convivientes: escabiosis por Sarcoptes scabiei. El tratamiento es permetrina al 5% en todo el cuerpo, tratando simultáneamente a todos los contactos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 131

Una prescolar de 4 años presenta prurito en la cabeza. Al examen físico se ven abundantes liendres, a menos de 3 cm del cuero cabelludo, sin visualizar piojos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Ivermectina oral
B) Permetrina tópica al 1%
C) Permetrina tópica al 5%
D) Lindano tópico
E) No tratar, mientras no se visualicen piojos

Respuesta B. Liendres a menos de 3 cm del cuero cabelludo indican infestación activa por Pediculus humanus capitis, aunque no se vean piojos adultos. El tratamiento de la pediculosis es permetrina tópica al 1%, distinta a la concentración usada en la escabiosis.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 131

Una preescolar de 4 años presenta prurito en la cabeza. Al examen físico se ven abundantes liendres a menos de 3 cm del cuero cabelludo, sin visualizar piojos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Ivermectina oral
B) Permetrina tópica al 1%
C) Permetrina tópica al 5%
D) Lindano tópico
E) No tratar mientras no se visualicen piojos

Respuesta B. Liendres a menos de 1 a 3 cm del cuero cabelludo son viables y diagnostican pediculosis activa aunque no se vean piojos. El tratamiento de primera línea es permetrina al 1% tópica, repetida a los 7 a 10 días, más remoción mecánica con peineta fina y revisión de contactos.

2.01.1.110 Infecciones micóticas de piel y fanéreos

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Tiña capitis (Microsporum canis la más frecuente): placa alopécica descamativa con pelos cortados; kerion (placa inflamatoria supurativa). Requiere tratamiento oral: griseofulvina 20-25 mg/kg/día por 6-8 semanas o terbinafina.
- Tiña corporis: placa anular con borde activo descamativo y centro claro; tratamiento tópico con clotrimazol, miconazol o terbinafina por 2-4 semanas.
- Tiña pedis e intertrigo: maceración interdigital; antifúngico tópico. Onicomicosis en niños es infrecuente; requiere confirmación con examen micológico y tratamiento oral prolongado.
- Pitiriasis versicolor (Malassezia): máculas hipo o hipercrómicas con descamación fina en tronco de adolescentes; ketoconazol champú o azoles tópicos.
- Confirmar con examen micológico directo y cultivo en casos dudosos; no usar corticoide tópico (tiña incógnita).
- Seguimiento: control al final del tratamiento; tiña capitis hasta cultivo negativo; investigar mascotas (gatos, perros) como fuente.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 6 años, que tiene un perro, presenta desde hace 3 semanas una placa en el cuero cabelludo con pelos cortados a pocos milímetros de la piel y descamación. En los últimos días la lesión se volvió inflamatoria, dolorosa, con pústulas y supuración, y tiene adenopatías occipitales. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Clotrimazol tópico
B) Corticoide tópico
C) Cefadroxilo oral
D) Drenaje quirúrgico
E) Griseofulvina oral por 6 a 8 semanas

Respuesta E. Placa alopécica con pelos cortados y descamación es tiña capitis (Microsporum canis, frecuente por contacto con mascotas). La forma inflamatoria con pústulas y supuración es el querion de Celso, una reacción inmune y no una infección bacteriana. La tiña capitis siempre requiere antifúngico oral (griseofulvina o terbinafina por semanas), porque el tópico no penetra el folículo. El drenaje está contraindicado.

2.01.1.111 Malformaciones vasculares cutáneas

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: derma-17

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemangioma infantil: tumor vascular benigno más frecuente; ausente o pequeño al nacer, crece rápido en los primeros meses (proliferación) e involuciona lentamente en años.
- Malformaciones vasculares: presentes al nacer, crecen proporcionalmente y no involucionan: mancha en vino de Oporto (capilar), venosas, linfáticas, arteriovenosas.
- Mancha salmón (nevus simplex) en nuca o glabela: benigna, frecuente, se aclara.
- Banderas rojas: hemangioma periocular (ambliopía), en vía aérea («en barba», estridor), labio, nariz, ulcerados, múltiples (>5: ecografía hepática), segmentario facial (síndrome PHACE); vino de Oporto en territorio V1 (Sturge-Weber: convulsiones, glaucoma).
- Tratamiento de hemangioma de riesgo: propranolol oral 2-3 mg/kg/día por especialista, idealmente antes de los 3-5 meses.
- Seguimiento: derivar precozmente a dermatología hemangiomas de riesgo y malformaciones vasculares; los no complicados se observan con fotos seriadas.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 83

Un recién nacido de 10 días presenta un hemangioma en el párpado derecho, de 3 cm de diámetro, que cubre parcialmente el eje visual. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?**

A) Administrar propranolol
B) Administrar betametasona
C) Realizar embolización
D) Derivar a cirujano plástico
E) Observar evolución

Respuesta A. La mayoría de los hemangiomas infantiles involucionan solos y se observan, pero los periorbitarios que ocluyen el eje visual tienen riesgo de ambliopía y deben tratarse precozmente, antes de la fase proliferativa máxima. El tratamiento de primera línea es propranolol oral, con evaluación oftalmológica. Los corticoides quedaron como segunda línea y la cirugía deja cicatriz.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 126 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 6 meses presenta ocho hemangiomas infantiles localizados en el tronco, principalmente en la espalda. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

A) Solicitar ecografía abdominal
B) Iniciar propranolol oral
C) Iniciar corticoides intralesionales
D) Solicitar una resonancia magnética nuclear de cerebro
E) Solicitar estudio de neurofibromatosis

Respuesta A. Hemangiomas Infantiles: La presencia de múltiples hemangiomas infantiles obliga a descartar hemangiomas viscerales con una ecografía abdominal. El propranolol oral es el tratamiento de elección para los hemangiomas complicados o deformantes.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 19 · texto original del banco, sin revisar

Niño con 6 hemangiomas en tronco y extremidades. ¿Qué examen solicitar inicialmente?

A) RNM de cerebro
B) TAC de tórax
C) Gammagrafía ósea
D) Ecografía abdominal
E) Angiografía por resonancia

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Ecografía abdominal). Ecografía abdominal. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (RNM de cerebro, TAC de tórax) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 87 · texto original del banco, sin revisar

Un recién nacido de 5 días de vida tiene un hemangioma en el párpado izquierdo, de 1 cm de diámetro, que cubre parcialmente el iris. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Observar evolución
B) Indicar propanolol oral
C) Indicar corticoides orales
D) Biopsiar
E) Derivar a cirujano plástico infantil

Respuesta B. La primera medida ante los hemangiomas infantiles es dar propanolol. Si no involucionan, en casos como este está indicada la cirugía (porque deforma la cara, produce ambliopía, etc).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 41 · texto original del banco, sin revisar

Una recién nacida de 27 días de vida presenta 6 hemangiomas superficiales, en el tronco y extremidades. El resto de su examen físico es normal y no tiene antecedentes de importancia. ¿Cuál examen es más adecuado para proseguir el estudio de esta paciente?

A) Ecografía abdominal
B) Ecografía cerebral
C) Resonancia magnética nuclear espinal
D) Ecografía de partes blandas
E) Resonancia magnética nuclear de cerebro

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Resonancia magnética nuclear espinal). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Ecografía abdominal, Ecografía cerebral) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentaci

2.01.1.112 Alteraciones de la termorregulación

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 18.15 Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Temperatura normal del RN: 36,5-37,5 °C axilar; el RN pierde calor por evaporación, radiación, conducción y convección.
- Hipotermia neonatal (<36,5 °C): mayor riesgo en prematuros y bajo peso; produce hipoglicemia, acidosis, apnea, dificultad respiratoria y aumento de mortalidad.
- Prevención: secado inmediato, contacto piel a piel, sala a 26-28 °C, gorro, cuna radiante o incubadora; bolsa plástica en prematuros <32 semanas.
- Hipertermia en RN: frecuentemente ambiental (exceso de abrigo) o deshidratación; descartar sepsis siempre ante fiebre en RN.
- Manejo: recalentar gradualmente (incubadora), monitorizar glicemia y respiración; desabrigar y evaluar hidratación en hipertermia ambiental.
- Seguimiento: control de temperatura seriado; RN con fiebre real requiere estudio de sepsis y hospitalización.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 100

Un recién nacido de término, de 37 semanas de gestación y peso de 2.900 g, presenta temperatura corporal de 35,5 °C sin otras alteraciones. Se realiza secado de la piel y se indica contacto piel con piel con su madre; sin embargo, persiste con temperatura en dicho rango. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Poner en incubadora a 38 °C
B) Poner en incubadora precalentada y ajustar progresivamente la temperatura
C) Poner en cuna con calor radiante, sin ropa ni cobertor
D) Administrar suero glucosado al 10% por vía endovenosa
E) Cubrir al recién nacido con mantas

Respuesta B. La hipotermia neonatal moderada (32 a 35,9 °C) que no responde a medidas generales (secado, piel con piel, abrigo) se trata con recalentamiento controlado en incubadora precalentada, ajustando la temperatura en forma progresiva y monitorizando glicemia. Un recalentamiento brusco a 38 °C puede causar apneas e hipotensión.

2.01.1.113 Apneas

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.18 Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM

QUÉ HAY QUE SABER

- Apnea: pausa respiratoria ≥20 s, o menor si se acompaña de bradicardia (<100 lpm), cianosis o desaturación.
- Apnea del prematuro: inmadurez del centro respiratorio, frecuente en <34 semanas, inicia en los primeros días y resuelve hacia las 36-40 semanas corregidas.
- Diferencial obligado: sepsis, hipoglicemia, hipocalcemia, hipotermia, anemia, convulsiones, hemorragia intraventricular, reflujo, VRS o coqueluche en lactantes.
- Manejo inicial: estimulación táctil, permeabilizar vía aérea, O2 o ventilación a presión positiva si no cede; estudio de causas secundarias.
- Tratamiento de apnea del prematuro: cafeína (citrato de cafeína carga 20 mg/kg, mantención 5-10 mg/kg/día); CPAP si persiste.
- Seguimiento: hospitalizar en neonatología; derivar al especialista y alta tras 5-7 días sin apneas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un recién nacido prematuro de 29 semanas, al tercer día de vida, presenta episodios repetidos de pausas respiratorias de más de 20 segundos, con bradicardia y desaturación, que ceden con estímulo táctil. Se han descartado hipoglicemia, sepsis, anemia, alteraciones electrolíticas y hemorragia intraventricular. **¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección?**

A) Cafeína (citrato de cafeína)
B) Fenobarbital
C) Salbutamol
D) Surfactante
E) Naloxona

Respuesta A. Las apneas de más de 20 segundos, o menores con bradicardia o desaturación, en un prematuro menor de 34 semanas, tras descartar causas secundarias, corresponden a apnea del prematuro por inmadurez del centro respiratorio. El tratamiento de elección es el citrato de cafeína, un estimulante respiratorio, más medidas de soporte o CPAP si persisten. El fenobarbital deprime la respiración.

2.01.1.114 Asfixia neonatal

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.15 Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Asfixia neonatal: falla del intercambio gaseoso perinatal con hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica. Criterios: pH de cordón <7,0, Apgar ≤3 a los 5 min, encefalopatía y falla multiorgánica.
- Factores de riesgo: desprendimiento placentario, prolapso de cordón, distocias, sufrimiento fetal (bradicardia), infección intraamniótica, RCIU.

- Manejo inicial: reanimación neonatal según algoritmo (pasos iniciales, ventilación a presión positiva efectiva es lo más importante); evitar hiperoxia.
- Post reanimación: monitorización en UCI, normoglicemia, normotermia (evitar hipertermia), balance hídrico, tratar convulsiones con fenobarbital.
- Hipotermia terapéutica antes de las 6 h de vida si encefalopatía moderada-grave en ≥35-36 semanas.
- Seguimiento: derivar a neonatología; seguimiento del neurodesarrollo a largo plazo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Recién nacido de 39 semanas, por cesárea de urgencia por desprendimiento de placenta. Requirió ventilación a presión positiva y masaje cardíaco. Apgar 2 al minuto y 4 a los 5 minutos. Gases de cordón: pH 6,88 y exceso de base –18. A las 2 horas de vida está hipotónico, letárgico, con reflejos primitivos débiles. **¿Cuál es la intervención que más reduce la mortalidad y las secuelas neurológicas en este paciente?**

A) Bicarbonato de sodio endovenoso para corregir la acidosis
B) Fenobarbital profiláctico
C) Hiperventilación para bajar el CO2
D) Hipotermia terapéutica iniciada antes de las 6 horas de vida
E) Hidratación con aporte hídrico alto para mejorar la perfusión renal

Respuesta D. Acidosis grave en cordón, Apgar bajo persistente, reanimación avanzada y encefalopatía moderada a severa definen asfixia neonatal con encefalopatía hipóxico-isquémica. La hipotermia terapéutica, iniciada antes de las 6 horas, es la única intervención que reduce muerte y discapacidad. El bicarbonato y el fenobarbital profiláctico no están indicados.

2.01.1.115 Convulsiones neonatales

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.20 Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato

QUÉ HAY QUE SABER

- Convulsiones neonatales: generalmente sutiles (movimientos de pedaleo, chupeteo, desviación ocular, apneas), clónicas focales o tónicas; diferenciar de temblores (ceden al sujetar la extremidad y son estímulo-sensibles).
- Causa más frecuente: encefalopatía hipóxico-isquémica (primeras 24-48 h); otras: hemorragia intracraneana, infarto, infecciones (meningitis, TORCH), hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, errores innatos del metabolismo, abstinencia.
- Estudio inicial: glicemia capilar inmediata, calcio, magnesio, electrolitos, gases, hemograma, PCR, hemocultivo, punción lumbar, ecografía cerebral; EEG (idealmente continuo).
- Corregir trastornos metabólicos: hipoglicemia con suero glucosado 10% 2 ml/kg EV; hipocalcemia con gluconato de calcio 10% 1-2 ml/kg EV lento.
- Anticonvulsivante de primera línea: fenobarbital 20 mg/kg EV (repetir 10 mg/kg hasta 40 mg/kg); luego levetiracetam o fenitoína.
- Seguimiento: derivar a neonatología y neurología infantil.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Un recién nacido de término, hijo de madre con diabetes gestacional, presenta a las 6 horas de vida movimientos de pedaleo de extremidades y desviación ocular sostenida, de 1 minuto de duración. Está en buenas condiciones generales, sin fiebre. **¿Cuál es la primera medida diagnóstica?**

A) Electroencefalograma
B) Punción lumbar
C) Glicemia capilar
D) Ecografía cerebral
E) Resonancia magnética cerebral

Respuesta C. Ante una convulsión neonatal, lo primero es medir la glicemia capilar, porque la hipoglicemia es una causa frecuente, rápidamente tratable y que deja secuelas si no se corrige; el hijo de madre diabética tiene alto riesgo. Luego se miden calcio, magnesio y electrolitos y se buscan otras causas (encefalopatía hipóxico-isquémica, infección, hemorragia). El EEG y las imágenes vienen después.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 26 · texto original del banco, sin revisar

RN de término convulsión a las 12 hrs de 2 minutos de duración. A la evaluación todo normal hgtes: diagnóstico más probable

A) Epilepsia
B) Hipoglicemia
C) Hipocalcemia
D) Hemorragia intracerebral
E) Accidente cerebrovascular

Respuesta B. Diagnóstico: Hipoglicemia (opción B). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Epilepsia, Hipocalcemia) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paci

2.01.1.116 Enterocolitis necrotizante (ECN)

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 6.3 Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Enterocolitis necrotizante: necrosis isquémica-inflamatoria del intestino, principalmente en prematuros alimentados con fórmula, a las 2-3 semanas de vida.
- Clínica: distensión abdominal, intolerancia alimentaria con residuo gástrico bilioso, deposiciones con sangre, letargia, apneas, inestabilidad térmica, shock.
- Radiografía de abdomen: neumatosis intestinal (signo patognomónico), gas en vena porta; neumoperitoneo indica perforación. Clasificación de Bell.
- Manejo inicial: régimen cero, sonda orogástrica abierta, NPT, hemocultivos y antibióticos EV de amplio espectro (ampicilina + gentamicina + metronidazol), soporte hemodinámico.
- Perforación o deterioro clínico: cirugía (laparotomía o drenaje peritoneal). Prevención: leche materna, alimentación enteral progresiva.
- Seguimiento: derivar a UCI neonatal con cirugía infantil; secuelas estenosis intestinal e intestino corto.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 146

Recién nacido de 10 días de vida, con antecedente de haber nacido prematuro a las 27 semanas, alimentado con fórmula láctea para prematuros por sonda nasogástrica, presenta un cuadro de 2 días de evolución de distensión abdominal y aumento de la retención láctea, objetivada por la sonda. Se solicita radiografía simple de abdomen, que muestra dilatación de asas intestinales, con zonas de engrosamiento de la pared intestinal y visualización de burbujas en algunos segmentos. **Además de suspender la fórmula láctea y asegurar una adecuada hidratación por vía endovenosa, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar resolución quirúrgica inmediata
B) Iniciar alimentación con fórmula hidrolizada de proteínas por sonda nasoenteral
C) Administrar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa
D) Realizar endoscopía digestiva alta
E) Alimentar con suero glucosado por vía oral

Respuesta C. Prematuro con distensión abdominal y retención láctea, más burbujas de aire en la pared intestinal en la radiografía: enterocolitis necrotizante. Ya con régimen cero e hidratación endovenosa en marcha, el paso siguiente es agregar antibióticos de amplio espectro. La cirugía se reserva a la perforación, la necrosis o la falla del tratamiento médico; no se alimenta al niño, ni por sonda ni por boca.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 120 · texto original del banco, sin revisar

RNPT que a los 6 días inicia con vómitos importantes y deposiciones con sangre, abdomen timpánico con RHA disminuidos o ausentes (no recuerdo cual), que se vería en la radiografía:

A) Asas dilatadas con niveles hidroaéreos (esta era la más sugerente de enterocolitis necrotizante)
B) Aire libre intraperitoneal
C) Pared intestinal engrosada
D) Signo de doble burbuja
E) Derrame pleural

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Asas dilatadas con niveles hidroaéreos (esta era la más sugerente de enterocolitis necrotizante)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 30 · texto original del banco, sin revisar

Recién nacido de 35 semanas, de 5 días de vida, con antecedente de depresión neonatal recuperada, inicia cuadro caracterizado por vómitos y distensión abdominal asociado a deposiciones con sangre. Al examen físico se palpa abdomen distendido, con tono aumentado. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

A) Ecografía abdominal
B) Tomografía axial computada de abdomen con contraste
C) Radiografía de abdomen
D) Laparotomía exploradora
E) Colonoscopía

Respuesta C. Diagnóstico: Radiografía de abdomen (opción C). La ECN se estudia con Rx simple.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

2.01.1.117 Estridor congénito

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.17 Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Estridor congénito: laringomalacia es la causa más frecuente (60-70%): estridor inspiratorio desde las primeras semanas, aumenta con llanto, alimentación y decúbito supino, mejora en prono.
- Curso: peak 6-8 meses y resolución espontánea entre 12-24 meses en la mayoría.
- Otras causas: parálisis de cuerdas vocales (llanto débil), estenosis subglótica (post intubación), hemangioma subglótico (estridor progresivo, hemangiomas cutáneos), anillos vasculares (estridor bifásico, disfagia).
- Banderas rojas: apneas, cianosis, dificultad para alimentarse, mal incremento ponderal, retracción importante, estridor bifásico o progresivo.
- Manejo inicial de laringomalacia leve: observación, tranquilizar, tratar reflujo si coexiste.
- Seguimiento: derivar a ORL infantil para nasofibrolaringoscopía si banderas rojas o duda diagnóstica; supraglotoplastía en casos graves.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 162

Un recién nacido de término presenta estridor desde el nacimiento, sin otros síntomas. Al examen físico está en buenas condiciones, sin cianosis ni uso de musculatura accesoria. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Anillo vascular
B) Traqueomalacia
C) Laringomalacia
D) Hendidura laríngea
E) Fístula traqueoesofágica

Respuesta C. La laringomalacia es la causa más frecuente de estridor congénito: estridor inspiratorio que aparece en las primeras semanas, aumenta con el llanto, la alimentación o el decúbito supino, en un lactante con buen estado general. Suele resolverse espontáneamente entre los 12 y 24 meses. La traqueomalacia y el anillo vascular dan estridor espiratorio o bifásico.

2.01.1.118 Hijo madre diabética

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.20 Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato

QUÉ HAY QUE SABER

- Hijo de madre diabética: hiperglicemia materna produce hiperinsulinismo fetal: macrosomía (GEG), visceromegalia y riesgo de trauma obstétrico (distocia de hombros, parálisis braquial, fractura de clavícula).
- Complicaciones metabólicas: hipoglicemia en las primeras horas (el riesgo principal), hipocalcemia, hipomagnesemia, policitemia, hiperbilirrubinemia.
- Otras: síndrome de distrés respiratorio (retraso de maduración pulmonar), miocardiopatía hipertrófica septal, malformaciones (DM pregestacional mal controlada): cardiopatías, síndrome de regresión caudal, colon izquierdo pequeño.
- Manejo: alimentación precoz (primera hora), glicemias seriadas desde la 1ª-2ª hora por 24-48 h; hipoglicemia <45-47 mg/dL: alimentar o bolo de suero glucosado 10% 2 ml/kg y luego infusión.
- Controlar hematocrito, calcio, bilirrubina; ecocardiograma si soplo o dificultad respiratoria.
- Seguimiento: derivar a neonatología si complicaciones; riesgo de obesidad y DM2 a futuro, controles de crecimiento en APS.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Recién nacido de 39 semanas, hijo de madre con diabetes gestacional en tratamiento con insulina. Nace por cesárea, peso 4.350 g. A las 2 horas de vida presenta temblores finos de extremidades, succión débil y tono algo disminuido. El hemoglucotest marca 32 mg/dL, confirmado por glicemia venosa en 30 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Ofrecer pecho materno y controlar la glicemia en 2 horas más
B) Bolo de suero glucosado al 10 % 2 mL/kg en 5 minutos, seguido de infusión continua
C) Bolo rápido de suero glucosado al 50 % 5 mL/kg
D) Observación estricta, sin tratamiento, por ser un hallazgo esperable en un hijo de madre diabética
E) Hidrocortisona endovenosa como primera línea

Respuesta B. Hijo de madre diabética, macrosómico, con hipoglicemia sintomática (temblores, succión débil) y glicemia venosa de 30 mg/dL: es una urgencia. La alimentación sola no corrige rápido ni previene el daño neurológico. El manejo es bolo de suero glucosado al 10 % 2 mL/kg endovenoso en 5 minutos, seguido de infusión continua con carga de 6 a 8 mg/kg/min.

2.01.1.119 Hipocalcemia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.20 Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipocalcemia neonatal: calcio total <8 mg/dL (o <7 en prematuros) o calcio iónico <4 mg/dL (1 mmol/L).
- Precoz (primeras 72 h): prematurez, hijo de madre diabética, asfixia, RCIU. Tardía (5-10 días): aporte alto de fosfato (leche de vaca), hipoparatiroidismo (síndrome de DiGeorge: cardiopatía conotruncal, timo ausente), déficit de vitamina D materna, hipomagnesemia.
- Clínica: frecuentemente asintomática; irritabilidad, temblores, hiperreflexia, convulsiones, apneas; QT prolongado.
- Tratamiento sintomático: gluconato de calcio 10% 1-2 ml/kg EV lento en 10 min con monitor cardíaco (riesgo de bradicardia y necrosis por extravasación); luego mantención.
- Corregir hipomagnesemia concomitante (si no, la hipocalcemia no corrige).
- Seguimiento: derivar a neonatología/endocrinología si hipocalcemia tardía, refractaria o sospecha de hipoparatiroidismo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Recién nacido de 37 semanas, hijo de madre diabética pregestacional, de 30 horas de vida. Presenta temblores de extremidades e irritabilidad. Glicemia 62 mg/dL. Calcio total 6,6 mg/dL. El electrocardiograma muestra un intervalo QT prolongado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Bolo de suero glucosado al 10% 2 mL/kg
B) Fenobarbital endovenoso por sospecha de convulsión
C) Gluconato de calcio en bolo rápido sin monitorización
D) Gluconato de calcio al 10% 1 a 2 mL/kg endovenoso lento, con monitor cardíaco
E) Solo observación, porque es esperable en el hijo de madre diabética

Respuesta D. Calcio bajo 8 mg/dL en un recién nacido de término es hipocalcemia; el hijo de madre diabética es grupo de riesgo. Con síntomas o QT prolongado se trata con gluconato de calcio al 10% endovenoso lento con monitor, porque pasarlo rápido causa bradicardia y arritmias. La glicemia es normal.

2.01.1.120 Hipoglicemia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.20 Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipoglicemia neonatal: glicemia <45-47 mg/dL en RN (umbral operativo); en niños mayores <50-60 mg/dL.
- RN de riesgo: hijo de madre diabética, GEG, PEG, prematuros, asfixia, sepsis, hipotermia; tamizar con glicemias seriadas desde la primera hora.
- Clínica: temblores, irritabilidad, hipotonía, succión débil, apneas, cianosis, convulsiones; puede ser asintomática.
- Manejo: asintomático con glicemia límite: alimentar y repetir; sintomático o <25-30 mg/dL: bolo de suero glucosado 10% 2 ml/kg EV y luego infusión con carga de glucosa 4-8 mg/kg/min.
- Persistente o con requerimiento de carga >10-12 mg/kg/min: hiperinsulinismo, hipopituitarismo, insuficiencia suprarrenal o error innato; tomar muestra crítica (insulina, cortisol, GH, cetonas) durante la hipoglicemia.
- Seguimiento: derivar a neonatología/endocrinología si persistente o recurrente; riesgo de daño neurológico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 150

Recién nacido de término, con antecedente de madre con preeclampsia, pesa 2.600 gramos al nacer. **¿Cuál es la complicación más frecuente durante las primeras horas de vida?**

A) Hipoglicemia
B) Sepsis
C) Hiperbilirrubinemia
D) Anemia
E) Distrés respiratorio

Respuesta A. La preeclampsia materna suele producir un recién nacido pequeño para la edad gestacional, con reservas de glucógeno casi nulas. La complicación más frecuente en las primeras horas es la hipoglicemia, no la anemia ni el distrés respiratorio.

2.01.1.121 Ictericia neonatal y del primer trimestre

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.17 Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Ictericia neonatal: fisiológica aparece después de las 24 h, peak día 3-5, bilirrubina indirecta, RN en buen estado, resuelve antes del día 10-14. Progresión céfalo-caudal (zonas de Kramer).
- Patológica: aparición <24 h (hemólisis por incompatibilidad Rh o ABO: grupo y Rh de madre y RN, Coombs directo), ascenso rápido, bilirrubina directa >1-2 mg/dL o >20%, duración >14 días.
- Conducta según nomograma de Bhutani (bilirrubina total y horas de vida) y factores de riesgo: fototerapia en zona de riesgo; exanguinotransfusión si falla o signos de encefalopatía aguda (kernicterus).
- Ictericia por lactancia ineficaz: corregir técnica, no suspender lactancia. Ictericia por leche materna: tardía, benigna, RN que sube de peso.

- Colestasia (acolia, coluria, bilirrubina directa elevada, ictericia >14 días): urgencia por atresia de vías biliares (cirugía de Kasai antes de los 60 días); ecografía y derivación inmediata.
- Seguimiento: control a las 24-48 h del alta en RN con ictericia; derivar a neonatología si fototerapia o a gastroenterología si colestasia.

PREGUNTAS (11)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 129

Recién nacido de 18 horas de vida con ictericia hasta los muslos. La bilirrubina resulta en 15,3 miligramos por decilitro, con fracción indirecta de 15. La madre es de grupo O, Rh positiva; el niño es de grupo B, Rh negativo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
B) Ictericia hemolítica por incompatibilidad Rh
C) Ictericia fisiológica
D) Hepatitis neonatal
E) Ictericia por lactancia materna

Respuesta A. Solo una madre Rh negativa puede hemolizar a un hijo Rh positivo; aquí es al revés, así que la incompatibilidad Rh queda descartada. En cambio, una madre de grupo O puede hemolizar a un hijo de grupo A o B: es incompatibilidad de grupo clásico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 60

Un recién nacido de 18 horas de vida desarrolla ictericia hasta los muslos. Los niveles plasmáticos de bilirrubina resultan 15,3 mg/dl, con fracción indirecta de 15 mg/dl. La madre es O-IV Rh positiva y el niño es B-I Rh negativo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
B) Ictericia hemolítica por incompatibilidad Rh
C) Ictericia fisiológica
D) Hepatitis neonatal
E) Síndrome de Gilbert

Respuesta A. Ictericia a las 18 horas: patológica. La madre O e hijo B calzan con incompatibilidad ABO. La incompatibilidad Rh exige madre Rh negativo e hijo Rh positivo; aquí es al revés (madre Rh positiva, hijo Rh negativo), así que esa opción queda descartada por definición.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 39

Un lactante de 5 días de vida, alimentado con lactancia materna exclusiva, presenta ictericia en la cara y el tronco, que inició hace 2 días. La bilirrubina plasmática resulta 10 mg/dl, bilirrubina directa de 0,3 mg/dl, hematocrito de 56%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hepatitis neonatal
B) Atresia biliar primaria
C) Ictericia fisiológica
D) Ictericia hemolítica
E) Ictericia por leche materna

Respuesta C. Ictericia que apareció al tercer día, con bilirrubina indirecta moderada y directa normal: patrón fisiológico. El hematocrito alto no cambia el diagnóstico, es parte esperable del recién nacido y no un signo de alarma por sí solo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 154

Un niño de 6 semanas de vida presenta ictericia desde hace 2 semanas. Al examen físico se aprecia ictérico y presenta deposiciones claras en el pañal, sin otras alteraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Estenosis hipertrófica del píloro
B) Atresia biliar primaria
C) Hepatitis viral
D) Síndrome de Crigler Najjar
E) Hipotiroidismo congénito

Respuesta B. Ictericia tardía, de más de dos semanas, con deposiciones claras (acolia): patrón colestásico clásico de atresia biliar. Las otras opciones no explican las deposiciones acólicas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 117

Un lactante de un mes, sin antecedentes perinatales, es traído por presentar ictericia hasta los muslos, resto normal. Su desarrollo psicomotor, crecimiento y alimentación han sido normales. Al preguntar dirigidamente, la madre refiere que también ha presentado orinas oscuras. **¿Cuál es el examen de elección frente a este paciente?**

A) Ecografía abdominal
B) Hormona estimulante de la tiroides
C) Resonancia magnética abdominal
D) Test de Coombs
E) Bilirrubinemia diferenciada

Respuesta E. Ictericia tardía con coluria: sospecha de colestasia. Pero antes de pedir imágenes, el primer paso siempre es medir la bilirrubina diferenciada, para confirmar que el componente directo está elevado. Recién con eso se justifica avanzar a la ecografía.

Pregunta de práctica

Recién nacido de 16 horas de vida, de término, vigoroso, nacido por parto vaginal sin incidentes. La matrona nota ictericia marcada en cara, tronco y abdomen (zona 3 de Kramer). La madre es primigesta, grupo O Rh positivo; el recién nacido es grupo A Rh positivo. La bilirrubina total es de 9,2 mg/dL con bilirrubina directa de 0,4 mg/dL. El hematocrito es de 44%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Dar de alta con control ambulatorio en 7 días
B) Hospitalizar, iniciar fototerapia y solicitar Coombs directo
C) Suspender la lactancia materna por 48 horas
D) Solicitar ecografía abdominal para descartar atresia biliar
E) Indicar fenobarbital oral para inducir la conjugación hepática

Respuesta B. Ictericia a las 16 horas de vida: patológica y hemolítica hasta demostrar lo contrario. La madre grupo O y el hijo grupo A orientan a incompatibilidad ABO. A esa hora de vida, 9,2 mg/dL cae en zona de alto riesgo de Bhutani: fototerapia inmediata más Coombs directo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 176 · texto original del banco, sin revisar

Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un recién nacido de término presenta ictericia a los 7 días de vida. Se solicita bilirrubina total: 14,2 mg/dl y bilirrubina directa: 4,0 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar hemograma, grupo-Rh y prueba de Coombs directo al recién nacido
B) Solicitar hemograma, grupo-Rh y prueba de Coombs directo a la madre
C) Solicitar pruebas hepáticas
D) Solicitar sedimento de orina y urocultivo
E) Fototerapia

Respuesta C. Una bilirrubina directa de 4 mg/dl (más de 1 mg/dl y cerca de 30% de la total) a los 7 días de vida es una hiperbilirrubinemia directa, que no es fisiológica y obliga a descartar colestasis, como atresia de vías biliares o hepatitis neonatal. Lo adecuado es pedir pruebas hepáticas y estudio de la vía biliar. El estudio hemolítico apunta a hiperbilirrubinemia indirecta y la fototerapia no está indi

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 145 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 27 días de vida presenta ictericia, que inició hace una semana. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y no ha tenido otros síntomas. Se solicitan exámenes que muestran una bilirrubina total de 18,8 mg/dl y una bilirrubina directa de 18,0 mg/d. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Ictericia por leche materna
B) Ictericia fisiológica
C) Atresia primaria de las vías biliares
D) Hipotiroidismo congénito
E) Hepatitis neonatal

Respuesta C. Tiene una ictericia tardía y directa, por lo que la atresia biliar primaria es la principal sospecha.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 61 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 5 semanas de vida presenta ictericia, que inició hace una semana. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y no ha tenido otros síntomas. Se solicitan exámenes que muestran una bilirrubina total de 4,3 mg/dl y una bilirrubina directa de 3,6 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Ictericia por lactancia materna
B) Síndrome de Gilbert
C) Atresia primaria de las vías biliares
D) Hipotiroidismo congénito
E) Hepatitis neonatal

Respuesta C. Tiene una ictericia tardía, de predominio directo, por lo que se sospecha una atresia biliar primaria. A, B y D son de predominio indirecto. La hepatitis neonatal es menos importante como diagnóstico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 29 · texto original del banco, sin revisar

Un recién nacido de 2 días de vida, presenta aumento de volumen parietal izquierdo, que deforma la cabeza, limitado a la zona parietal, que no sobrepasa la línea media. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la alteración descrita?

A) Fistulización a la piel
B) Osteomielitis
C) Disección de cuero cabelludo
D) Hiperbilirrubinemia
E) Abscedación

Respuesta D. La hiperbilirrubinemia es la complicación más frecuente del cefalohematoma (descrito en el caso). Las demás pueden ocurrir, pero son infrecuentes.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 154 · texto original del banco, sin revisar

Un neonato de 21 días de vida, con incremento ponderal deficiente, presenta ictericia que se extiende hasta las piernas. El parto fue por vía vaginal y el embarazo transcurrió sin complicaciones. Su bilirrubina total es de 11,2 mg/dL, con una bilirrubina directa de 7,0 mg/dL. El neonato se encuentra alimentándose con lactancia materna exclusiva y no presenta otros síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Atresia de vías biliares
B) Hipotiroidismo congénito
C) Ictericia fisiológica
D) Ictericia por leche materna
E) Síndrome de Gilbert

Respuesta A. Ictericia Neonatal Directa: En un caso de ictericia neonatal tardía de predominio directo, el diagnóstico más probable es atresia de vías biliares. Se debe realizar una ecografía abdominal para confirmar el diagnóstico. Se trata con la cirugía de Kasai.

2.01.1.122 Poliglobulia

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.20 Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato

QUÉ HAY QUE SABER

- Poliglobulia neonatal: hematocrito venoso >65% (o capilar >70%); hiperviscosidad sanguínea con riesgo de hipoperfusión.
- Causas: transfusión placentaria (clampeo tardío), hipoxia crónica intrauterina (RCIU, PEG, preeclampsia, tabaquismo), hijo de madre diabética, transfusión feto-fetal, trisomía 21, hipotiroidismo.
- Clínica: plétora, letargia, temblores, dificultad respiratoria, cianosis, hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, ECN, trombocitopenia.
- Confirmar con hematocrito venoso (el capilar sobreestima); controlar glicemia y bilirrubina.
- Manejo: asintomático con Hto 65-70%: hidratación adecuada y control; sintomático o Hto >70-75%: exanguinotransfusión parcial con suero fisiológico.
- Seguimiento: derivar a neonatología si sintomático o requiere recambio.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un recién nacido de término, pequeño para la edad gestacional, a las 12 horas de vida se ve pletórico, con letargia, temblores y succión débil. Exámenes: hematocrito venoso 71% y glicemia 38 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado de la poliglobulia?**

A) Flebotomía simple sin reposición
B) Exsanguinotransfusión parcial con suero fisiológico
C) Hidratación oral exclusiva y control
D) Transfusión de plaquetas
E) Fototerapia

Respuesta B. Poliglobulia neonatal es un hematocrito venoso mayor a 65%; en pequeños para la edad gestacional se debe a hipoxia crónica intrauterina. Causa hiperviscosidad, con letargia, hipoglicemia, dificultad respiratoria o enterocolitis. Si es sintomática (o el hematocrito es mayor a 70 a 75%), se realiza exsanguinotransfusión parcial con suero fisiológico para bajar el hematocrito a 55%, además de corregir la glicemia.

2.01.1.123 Prematurez

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.16 Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal · Tema 18.18 Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM

QUÉ HAY QUE SABER

- Prematuro: RN <37 semanas; extremo <28, muy prematuro 28-32, moderado/tardío 32-36+6. Principal causa de morbimortalidad neonatal.
- Complicaciones: SDR por déficit de surfactante, apneas, hemorragia intraventricular, ductus persistente, ECN, sepsis, displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, hipotermia, hipoglicemia, ictericia.
- Prevención: corticoides antenatales (betametasona) entre 24-34 semanas, sulfato de magnesio <32 semanas (neuroprotección), traslado in utero a centro con UCI neonatal.
- Manejo inicial: termorregulación (bolsa plástica <32 sem), CPAP precoz y surfactante, alimentación con leche materna, aporte de glucosa.
- Programas GES: retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar e hipoacusia en <1.500 g o <32 semanas; seguimiento en policlínico de prematuros con edad corregida hasta los 2 años (vacunas por edad cronológica).
- Seguimiento: derivar a neonatología y policlínico de seguimiento; nirsevimab/palivizumab en temporada de VRS, suplemento de hierro desde los 2 meses.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Recién nacido de 30 semanas, con peso de nacimiento de 1.250 gramos, hospitalizado en neonatología. Recibió surfactante y oxígeno durante las primeras 2 semanas. Hoy tiene 4 semanas de vida, está estable, sin apoyo ventilatorio y en ganancia de peso. **Según las garantías GES para el prematuro, ¿qué evaluación corresponde realizar ahora?**

A) Electroencefalograma de rutina
B) Cariograma
C) Fondo de ojo por oftalmólogo para pesquisa de retinopatía del prematuro
D) Densitometría ósea
E) Resonancia magnética de cerebro de rutina

Respuesta C. El prematuro menor de 32 semanas o menor de 1.500 gramos tiene garantía GES de pesquisa de retinopatía del prematuro con fondo de ojo por oftalmólogo, habitualmente desde las 4 semanas de vida; el oxígeno recibido es un factor de riesgo adicional. También tiene garantía de pesquisa de hipoacusia.

Pregunta de práctica

Recién nacido de 28 semanas, de 3 días de vida, en CPAP nasal. Presenta episodios repetidos de pausas respiratorias de más de 20 segundos, acompañados de bradicardia y desaturación, que ceden con estimulación táctil. Está normotérmico, con glicemia y hemograma normales y PCR negativa. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Citrato de cafeína endovenoso u oral
B) Ampicilina más gentamicina por 10 días
C) Fenobarbital endovenoso
D) Intubación y ventilación mecánica inmediatas
E) Suspender la alimentación enteral por 1 semana

Respuesta A. Pausas de más de 20 segundos con bradicardia o desaturación en un prematuro, sin otra causa, son apneas del prematuro por inmadurez del centro respiratorio. El tratamiento de elección es la cafeína. Descartada la sepsis, los antibióticos no corresponden, y la intubación queda para la falla del tratamiento.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 122 · texto original del banco, sin revisar

Qué leche le das a un RN prematuro que ya tiene 12 meses:

A) Fórmula 3 de continuación (se da formula prematuros hasta el año de edad corregida)
B) leche de vaca
C) Fórmula para prematuros
D) Leche semidescremada
E) Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Fórmula 3 de continuación (se da formula prematuros hasta el año de edad corregida)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

2.01.1.124 Sepsis neonatal

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.19 Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima

QUÉ HAY QUE SABER

- Sepsis neonatal precoz (<72 h): transmisión vertical; estreptococo grupo B y E. coli (Listeria menos). Factores de riesgo: RPM >18 h, corioamnionitis, fiebre materna, SGB+ sin profilaxis, prematurez.
- Tardía (>72 h): nosocomial (S. coagulasa negativo, S. aureus, gram negativos, Candida) o comunitaria.
- Clínica inespecífica: inestabilidad térmica, letargia, rechazo alimentario, apneas, dificultad respiratoria, ictericia, mala perfusión; alta sospecha.
- Estudio: hemograma (leucopenia, índice inmaduros/totales >0,2), PCR seriada, hemocultivos, punción lumbar si estable, urocultivo en tardía.
- Tratamiento empírico precoz: ampicilina + gentamicina (o cefotaxima si sospecha meningitis); no usar ceftriaxona en RN con hiperbilirrubinemia o calcio EV.
- Prevención: tamizaje de SGB a las 35-37 semanas y profilaxis intraparto con penicilina; seguimiento hospitalizado en neonatología.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 99

Recién nacido de 10 días de vida, sin antecedentes perinatales, inicia desde hace 5 horas cuadro de fiebre hasta 39 ºC asociada a rechazo alimentario e hiporreactividad, sin otros síntomas. Su examen físico resulta normal. La bioquímica de orina muestra leucocitos ++. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar sedimento de orina y decidir conducta según resultados
B) Hospitalizar para estudio y manejo
C) Indicar antipiréticos orales y control en dos días
D) Indicar antibióticos vía oral y control en dos días
E) Solicitar ecografía renal y vesical

Respuesta B. Recién nacido menor de 28 días con fiebre y rechazo alimentario: se hospitaliza siempre para estudio séptico completo y manejo, independiente de que existan hallazgos aislados como los leucocitos en orina.

Pregunta de práctica

Recién nacido de 28 horas de vida, hijo de madre sin controles prenatales regulares, cuyo parto ocurrió tras 22 horas de rotura de membranas con fiebre materna intraparto de 38,4 grados. El niño no quiere mamar, está pálido y frío al tacto. Temperatura axilar de 35,8 grados, frecuencia cardíaca 174 por minuto, llene capilar de 4 segundos. El hemograma muestra 4.100 leucocitos por mm3 con una relación de inmaduros sobre totales de 0,32. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Alta con control ambulatorio en 48 horas
B) Hospitalizar, tomar cultivos e iniciar ampicilina más gentamicina de inmediato
C) Solo antipiréticos y observación por 24 horas
D) Iniciar vancomicina más amikacina de entrada
E) Suero glucosado y control de glicemia exclusivamente

Respuesta B. Menos de 72 horas de vida, con factores de riesgo mayores (RPM prolongada y sospecha de corioamnionitis) y signos de sepsis (hipotermia, mala succión, taquicardia, llene capilar lento) más leucopenia con desviación a la izquierda: sepsis neonatal precoz. Se hospitaliza, se toman cultivos y se inicia ampicilina más gentamicina sin retrasar el tratamiento.

Pregunta de práctica

Un residente propone tratar la sospecha de sepsis neonatal precoz solo con cefotaxima, en lugar de la combinación de ampicilina más un aminoglucósido, argumentando que la cefotaxima ya cubre bien a los gramnegativos. **¿Por qué la ampicilina es obligatoria en el esquema, y no puede reemplazarse por cefotaxima sola?**

A) Porque las cefalosporinas no cubren a Escherichia coli
B) Porque Listeria monocytogenes tiene resistencia intrínseca a todas las cefalosporinas
C) Porque la ampicilina es el único fármaco activo contra Pseudomonas
D) Porque las cefalosporinas están contraindicadas en el recién nacido
E) Por razones exclusivamente de costo

Respuesta B. La Listeria monocytogenes es intrínsecamente resistente a todas las cefalosporinas, incluida la cefotaxima. Por eso la ampicilina es un componente insustituible del esquema empírico de la sepsis neonatal precoz, sin importar cuánto cubra la cefotaxima a los demás gérmenes.

2.01.1.125 Síndrome aspirativo meconial

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.18 Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome aspirativo meconial: RN de término o postérmino con líquido amniótico meconial y sufrimiento fetal; aspiración produce obstrucción, inflamación química e inactivación de surfactante.
- Clínica: dificultad respiratoria precoz, tórax en tonel, piel y uñas teñidas de meconio. Rx: infiltrados gruesos parcheados, hiperinsuflación, atrapamiento aéreo, neumotórax.
- Complicación grave: hipertensión pulmonar persistente del RN (diferencia de saturación pre-post ductal).
- Reanimación: no se recomienda aspiración intraparto ni intubación de rutina para aspirar tráquea en RN deprimido; iniciar ventilación a presión positiva en el primer minuto (aspirar solo si hay obstrucción).
- Manejo: O2, CPAP o ventilación mecánica, surfactante, óxido nítrico inhalado si hipertensión pulmonar, antibióticos si no se descarta infección.
- Seguimiento: derivar a UCI neonatal.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Recién nacido de 41 semanas y 5 días, por parto vaginal con registro fetal alterado y líquido amniótico con meconio espeso. A los 20 minutos de vida presenta taquipnea de 80 rpm, retracción intercostal, tórax en tonel y saturación de 86%. La radiografía muestra infiltrados gruesos y parcheados bilaterales, con zonas de atelectasia alternadas con zonas de hiperinsuflación. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de membrana hialina
B) Taquipnea transitoria del recién nacido
C) Hernia diafragmática congénita
D) Neumonía connatal por estreptococo grupo B
E) Síndrome de aspiración meconial

Respuesta E. Postérmino con sufrimiento fetal y meconio espeso, dificultad respiratoria precoz y tórax hiperinsuflado, con infiltrados gruesos que alternan atelectasias y enfisema, es aspiración meconial: el meconio actúa como válvula. La membrana hialina es del prematuro, con vidrio esmerilado y volumen pulmonar disminuido.

2.01.1.126 Síndrome distress respiratorio

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.18 Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de distrés respiratorio (enfermedad de membrana hialina): déficit de surfactante en prematuros (inversamente proporcional a la edad gestacional); factores de riesgo hijo de madre diabética, cesárea sin trabajo de parto, asfixia, sexo masculino.
- Clínica: dificultad respiratoria progresiva desde el nacimiento (quejido, retracción, aleteo, taquipnea, cianosis), empeora las primeras 48-72 h.
- Rx: infiltrado reticulogranular fino difuso (vidrio esmerilado), broncograma aéreo, volumen pulmonar disminuido.
- Diferencial: taquipnea transitoria del RN (término por cesárea, cisuritis, mejora en 24-72 h), neumonía/sepsis, SAM, cardiopatía.
- Manejo: CPAP precoz, surfactante exógeno (técnicas mínimamente invasivas o intubación), O2 con meta saturación 90-95%, termorregulación; antibióticos hasta descartar sepsis.
- Prevención: corticoides antenatales 24-34 semanas. Seguimiento: hospitalizar en UCI neonatal; riesgo de displasia broncopulmonar.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 177

Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, nacido por cesárea, presenta dificultad respiratoria luego de nacer, con taquipnea, retracción subcostal y crepitantes basales. La radiografía de tórax muestra ambos campos pulmonares con hiperinsuflación, reforzamiento hiliar, aplanamiento de los diafragmas y silueta cardiaca normal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Neumomediastino
B) Neumonía connatal
C) Taquipnea transitoria
D) Enfermedad de membrana hialina
E) Cardiopatía congénita

Respuesta C. Nacido por cesárea, sin antecedentes de asfixia ni prematurez extrema, con radiografía hiperinsuflada y silueta cardiaca normal: taquipnea transitoria. La membrana hialina daría el patrón opuesto, con pulmón hipoinsuflado.

Pregunta de práctica

Un recién nacido de 30 semanas de gestación presenta dificultad respiratoria grave desde el nacimiento, con quejido espiratorio constante, cianosis y retracción costal severa. La radiografía de tórax revela campos pulmonares poco expandidos, con opacificación reticulonodular bilateral difusa y broncograma aéreo visible. **¿Cuál es la etiología y el tratamiento de elección?**

A) Retardo en la reabsorción de líquido alveolar; oxígeno por naricera
B) Déficit de surfactante pulmonar; CPAP nasal e instilación de surfactante exógeno
C) Aspiración masiva de meconio; lavado traqueal con solución fisiológica
D) Neumotórax a tensión bilateral; toracocentesis inmediata
E) Atresia esofágica congénita; sonda con tracción

Respuesta B. Prematuro de 30 semanas, distrés severo desde el nacimiento, con radiografía hipoinsuflada en vidrio esmerilado y broncograma: enfermedad de membrana hialina por déficit de surfactante. Tratamiento: CPAP nasal más surfactante exógeno endotraqueal.

Pregunta de práctica

Recién nacido de 31 semanas de gestación, nace por parto prematuro espontáneo. La madre no recibió corticoides prenatales. Inmediatamente presenta quejido audible a distancia, aleteo nasal y retracción xifoidea acentuada, con una saturación de oxígeno de 82% al aire ambiental. La radiografía muestra pulmones con volumen disminuido, patrón difuso en vidrio esmerilado y broncograma aéreo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Oxígeno por naricera y control en 24 horas
B) CPAP nasal precoz más surfactante exógeno endotraqueal
C) Ventilación mecánica invasiva sin surfactante
D) Antibióticos endovenosos de amplio espectro
E) Observación, porque es un cuadro autolimitado

Respuesta B. Prematuro de 31 semanas, sin corticoides, con dificultad respiratoria desde el nacimiento y radiografía en vidrio esmerilado con broncograma: enfermedad de membrana hialina. Tratamiento estándar: CPAP nasal precoz más surfactante exógeno endotraqueal.

2.01.1.127 TORCH

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

QUÉ HAY QUE SABER

- TORCH: toxoplasmosis, otros (sífilis, VIH, varicela, parvovirus, Zika), rubéola, CMV (la infección congénita más frecuente) y herpes simple.
- Hallazgos comunes: RCIU, microcefalia, hepatoesplenomegalia, ictericia, petequias/trombocitopenia, coriorretinitis, hipoacusia.
- Claves: toxoplasma calcificaciones difusas, hidrocefalia, coriorretinitis; CMV calcificaciones periventriculares e hipoacusia neurosensorial; rubéola cataratas, cardiopatía (ductus), sordera; sífilis rinitis serosanguinolenta, pénfigo palmoplantar, osteocondritis.
- Diagnóstico: CMV con PCR en orina/saliva en las primeras 3 semanas; toxoplasma IgM/IgA y PCR; sífilis VDRL/RPR del RN vs materno (título ≥4 veces) y LCR; herpes PCR.
- Tratamiento inicial: sífilis congénita penicilina G sódica EV 10 días; herpes aciclovir EV; CMV sintomático valganciclovir (especialista); toxoplasma pirimetamina + sulfadiazina + ácido folínico.
- Seguimiento: derivar a infectología/neonatología; evaluación auditiva, oftalmológica y del neurodesarrollo. Prevención: tamizaje de sífilis, VIH y Chagas en embarazo.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 18

RN con microcefalia, calcificaciones periventriculares y coriorretinitis. Madre con serología IgG positiva para CMV y IgM positiva. **¿Cuál es el agente causante de la infección congénita?**

A) Citomegalovirus (CMV)
B) Toxoplasma gondii
C) Virus herpes simplex tipo 2
D) Treponema pallidum
E) Virus de rubéola

Respuesta A. Calcificaciones periventriculares + microcefalia: CMV congénito, la infección congénita viral más frecuente. El Toxoplasma da calcificaciones difusas con hidrocefalia.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 96

Un recién nacido de 38 semanas, presenta hipotonía, dificultad a la succión y circunferencia craneana 26 cm. Al examen tiene ausencia del rojo pupilar bilateral y ambas pupilas se observan de aspecto blanquecino. Además, se ausculta un soplo sistólico eyectivo III/VI, paraesternal. **¿Cuál es el agente más probable?**

A) Virus rubéola
B) Parvovirus B12
C) Citomegalovirus
D) Toxoplasma gondii
E) Virus herpes simplex

Respuesta A. Microcefalia + catarata congénita (leucocoria, sin rojo pupilar) + cardiopatía congénita: rubéola congénita (tríada de Gregg).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 145

Un recién nacido presenta hepatoesplenomegalia e ictericia. Tiene además calcificaciones cerebrales y microcefalia. Evoluciona con coriorretinitis y aumento progresivo del perímetro craneano. **El diagnóstico más probable es:**

A) Infección por VIH
B) Infección por Streptococcus agalactiae
C) Rubeóla congénita
D) Toxoplasmosis congénita
E) Sífilis congénita

Respuesta D. TORCH con calcificaciones cerebrales, coriorretinitis y aumento progresivo del perímetro craneano (hidrocefalia): toxoplasmosis congénita, tétrada de Sabin. La rubéola da catarata, hipoacusia y cardiopatía.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 77 · texto original del banco, sin revisar

Un recién nacido de término, pequeño para la edad gestacional, presenta un cuadro de ictericia y alteración de la termorregulación. Al examen físico tiene un síndrome purpúrico y se palpa hepatoesplenomegalia. Se solicitan exámenes, en los que destaca trombocitopenia. ¿Cuál es el agente más probable?

A) Virus rubéola
B) Citomegalovirus
C) Virus herpes simplex
D) Treponema pallidum
E) Estreptococo betahemolítico grupo B

Respuesta B. Es un TORCH clásico (pequeño para la edad gestacional), cuya causa más frecuente es el CMV. La sepsis (por SGB) puede tener un cuadro similar, pero le sobra lo pequeño para la edad gestacional.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 46 · texto original del banco, sin revisar

Recién nacido de término, con peso bajo para edad gestacional, tiene perímetro cefálico menor a percentil 3 para la edad gestacional y evoluciona después de nacer con ictericia progresiva, más hepatomegalia. ¿Cuál es el agente causal más probable?

A) Citomegalovirus
B) Virus papiloma humano
C) VIH
D) Virus Zika
E) Chlamydia trachomatis

Respuesta A. Es un TORCH clásico por CMV (microcefalia, calcificaciones cerebrales, ictericia y hepatoesplenomeglalia). En Chile no hay Zika. El TORCH por toxoplasma es casi igual al del CMV, pero es más infrecuente y, además, puede cursar con hidrocefalia.

2.01.1.128 RN PEG-GEG

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.16 Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal

QUÉ HAY QUE SABER

- Clasificación por peso y edad gestacional: PEG <p10 (pequeño), AEG p10-p90, GEG >p90 según curvas nacionales (Alarcón-Pittaluga).
- PEG: causas maternas (HTA, preeclampsia, tabaco), placentarias o fetales (genéticas, TORCH). Riesgos: hipoglicemia, hipotermia, policitemia, hipocalcemia, asfixia.
- GEG: hijo de madre diabética u obesa; riesgos de trauma obstétrico, hipoglicemia, policitemia, hiperbilirrubinemia.
- Manejo inicial de ambos: alimentación precoz, glicemias seriadas en las primeras 24-48 h, control de temperatura y hematocrito.
- PEG debe recuperar talla (catch-up) a los 2 años; si no recupera, derivar a endocrinología (candidato a hormona de crecimiento). Mayor riesgo de síndrome metabólico en adultez.
- Seguimiento: controles de crecimiento y desarrollo en APS; derivar si complicaciones o falta de recuperación de talla.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 8

Recién nacido pequeño para la edad gestacional, con un peso de 2.500 gramos. **¿Qué conducta tomas respecto de la alimentación?**

A) Iniciar fórmula láctea hipercalórica
B) Instalar sonda nasogástrica para alimentación
C) Ayuno de 6 horas y luego fórmula de prematuro
D) Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas
E) Suero glucosado al 10% endovenoso

Respuesta D. El recién nacido pequeño para la edad gestacional tiene alto riesgo de hipoglicemia precoz: la conducta es alimentar precozmente al pecho y controlar la glicemia a las 2 horas de vida.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 8

Recién nacido pequeño para la edad gestacional, 2.500 g. **¿Qué conducta tomar en relación a la alimentación?**

A) Iniciar fórmula láctea hipercalórica
B) Instalar sonda nasogástrica para alimentación
C) Ayuno de 6 horas y luego fórmula de prematuro
D) Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas
E) Suero glucosado al 10 % endovenoso

Respuesta D. El recién nacido pequeño para la edad gestacional tiene reservas mínimas de glucógeno, así que es de riesgo aunque nazca sin ningún síntoma. La conducta de entrada no es el suero: es pecho materno precoz, con control de glicemia a las 2 horas, tal como viste en el primer escalón del manejo.

Pregunta de práctica

Recién nacido de sexo masculino, parto vaginal a las 35 semanas, peso de nacimiento de 2.850 gramos. En las curvas de crecimiento intrauterino, ese peso corresponde al percentil 92 para las 35 semanas. **¿Cuál es la clasificación correcta de este paciente?**

A) Recién nacido de término, pequeño para la edad gestacional
B) Recién nacido de término, adecuado para la edad gestacional
C) Recién nacido pretérmino, grande para la edad gestacional
D) Recién nacido pretérmino, adecuado para la edad gestacional
E) Recién nacido postérmino, grande para la edad gestacional

Respuesta C. A las 35 semanas es pretérmino, y un peso en el percentil 92 está sobre el percentil 90, lo que define grande para la edad gestacional: pretérmino GEG.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 73 · texto original del banco, sin revisar

Una niña nace por parto vaginal de término. Su peso al nacer es 2.500 gramos, que es menor al percentil para la edad gestacional. Su Apgar fue 9-9-10, observándose enflaquecida, pero vigorosa. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la alimentación?

A) Administrar suero glucosado al 5% endovenoso y controlar glicemia en 2 horas
B) Administrar suero glucosado al 5% oral
C) Alimentar con fórmula láctea hasta que la madre produzca leche
D) Dar fórmula láctea después de cada toma de leche materna
E) Alimentar inmediatamente al pecho materno y solicitar glicemia a las 2 horas de vida

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Administrar suero glucosado al 5% oral (opción B). RN pretérmino <37 sem, término 37-41+6, postérmino ≥42 semanas de gestación De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

2.01.1.129 Alteraciones menstruales

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.3 Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Ciclos irregulares son normales los primeros 1-2 años post menarquia (anovulación); ciclo normal adolescente 21-45 días, sangrado ≤7 días.
- Amenorrea primaria: sin menarquia a los 15 años con caracteres sexuales secundarios, o a los 13 sin ellos (o 3 años post telarquia). Causas: Turner, agenesia mülleriana, himen imperforado (dolor cíclico, hematocolpos), retraso constitucional.
- Amenorrea secundaria: descartar siempre embarazo (β-hCG); luego anorexia/ejercicio intenso, SOP, hipotiroidismo, hiperprolactinemia.
- Sangrado uterino anormal: lo más frecuente anovulatorio; descartar coagulopatía (von Willebrand en menorragia desde la menarquia), embarazo e ITS. Hemograma, β-hCG, TSH, estudio de coagulación.
- Manejo inicial: dismenorrea primaria con AINE (ibuprofeno, ácido mefenámico) iniciado antes del dolor; sangrado anovulatorio con anemia: hierro, progestágeno o anticonceptivo combinado; hemodinámicamente inestable: hospitalizar.
- Seguimiento: derivar a ginecología infantojuvenil si amenorrea primaria, sangrado con anemia o sospecha de causa orgánica.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una adolescente de 13 años tuvo su menarquia hace 10 meses. Desde entonces sus ciclos son irregulares, cada 25 a 50 días, con duración de 4 a 7 días y sangrado moderado. No tiene anemia, hirsutismo, acné importante ni galactorrea, y su IMC es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar anticonceptivos orales para regular el ciclo
B) Solicitar ecografía pélvica y perfil hormonal completo
C) Solicitar estudio de coagulación
D) Tranquilizar y controlar con calendario menstrual
E) Iniciar progestágeno cíclico

Respuesta D. En los primeros 2 a 3 años tras la menarquia es frecuente la irregularidad menstrual por inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis-ovario (ciclos anovulatorios). Se consideran normales ciclos de 21 a 45 días aproximadamente. Sin anemia, sangrado abundante ni signos de hiperandrogenismo, la conducta es educar, llevar calendario y controlar.

2.01.1.130 Leucorrea y vulvovaginitis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.9 Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Vulvovaginitis inespecífica: la más frecuente en niñas prepúberes; mala higiene (aseo de atrás hacia adelante), ropa ajustada, irritantes, oxiuros. Prurito, eritema vulvar, flujo escaso.

- Específicas en prepúberes: S. pyogenes (vulvitis eritematosa intensa), Shigella (flujo sanguinolento), cuerpo extraño (flujo fétido sanguinolento persistente).
- Tratamiento inespecífica: medidas de higiene, baños de asiento, ropa de algodón, evitar jabones perfumados; tratar oxiuros si hay prurito anal nocturno.
- Adolescente: vaginosis bacteriana (flujo gris, olor a pescado, test de aminas +, pH >4,5: metronidazol 500 mg c/12 h por 7 días), candidiasis, tricomoniasis (flujo amarillo-verdoso espumoso; tratar a la pareja).
- ITS (gonorrea, Chlamydia, Trichomonas, sífilis) en niña prepúber: sospechar abuso sexual y activar protocolo de protección y denuncia.
- Seguimiento: control en 2-4 semanas; derivar a ginecología infantojuvenil si recurrente, sangrado o sospecha de cuerpo extraño.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Una niña de 6 años presenta flujo vaginal amarillento escaso, prurito y eritema vulvar de 2 semanas. Usa ropa interior sintética, se baña en tina con espuma y se limpia de atrás hacia adelante. No hay sangrado, cuerpo extraño visible, lesiones sugerentes de abuso ni oxiuros. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**
>
> **A)** Medidas de higiene: limpieza de adelante hacia atrás, ropa de algodón, evitar baños de espuma
> **B)** Metronidazol oral
> **C)** Vaginoscopía bajo anestesia
> **D)** Óvulos de clotrimazol
> **E)** Ceftriaxona intramuscular
>
> Respuesta A. La vulvovaginitis inespecífica es la causa más frecuente de flujo en niñas prepuberales, por mucosa hipoestrogénica delgada, cercanía al ano y mala higiene. El manejo inicial son medidas higiénicas. La candidiasis es rara antes de la pubertad salvo uso de pañal o antibióticos. Si persiste o hay sangrado, se cultiva el flujo y se descarta cuerpo extraño o abuso.

2.01.1.131 Sinequias vulvares

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: ped-27

QUÉ HAY QUE SABER

- Sinequia de labios menores: fusión adquirida de labios menores en niñas de 3 meses a 6 años por hipoestrogenismo fisiológico e irritación.
- Clínica: generalmente asintomática; puede causar goteo post miccional, ITU, vulvovaginitis o retención urinaria si es completa.
- Examen: línea media translúcida que une los labios menores; diferenciar de imperforación himeneal y genitales ambiguos.
- Asintomática: no requiere tratamiento, resuelve espontáneamente con estrógenos de la pubertad; higiene adecuada.
- Sintomática: estrógeno tópico (estriol o estrógenos conjugados) 1-2 veces al día por 2-4 semanas con tracción suave; luego vaselina para evitar recurrencia. No separar a la fuerza sin anestesia.
- Seguimiento: control al terminar el tratamiento; recurrencia frecuente; derivar a ginecología infantil si falla el tratamiento o retención urinaria.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 154

Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar que une gran parte de los labios menores, por lo que impide ver el introito y el himen. No tiene desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias ni genitales. El resto de su examen físico es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar lavados con ácido acético
B) Aplicar corticoides tópicos
C) Remover las sinequias de manera quirúrgica
D) Realizar separación manual bajo anestesia local
E) Indicar lubricación diaria con vaselina

Respuesta E. Las sinequias de labios menores son frecuentes en niñas prepuberales por el hipoestrogenismo fisiológico y suelen resolverse espontáneamente con la pubertad. Si son asintomáticas se manejan con aseo y lubricación (vaselina); si dan síntomas se usa estrógeno tópico. La separación manual o quirúrgica se reserva para casos complicados (retención urinaria) por la alta recurrencia.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 109 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar parcial, de los labios menores. No tie- ne desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias, ni genitales. El resto de su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

A) Realizar lavados con ácido acéticos
B) Aplicar corticoides tópicos
C) Remover las sinequias de manera quirúrgica
D) Indicar antibióticos
E) Realizar aseo y masajes en la zona

Respuesta E. Es una pregunta difícil, ya que en distintas partes se manejan de manera diferen- te. Sin embargo, la mayor evidencia dice que el aseo es lo más importante para que se resuleva. Los masajes pueden ayudar a que se desprenda antes.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 179 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 2 años de edad es traída por su madre a control de niño sano. Al examen físico se objetivan genitales con labios menores completamente adheridos entre sí en la línea media, lo que impide la visualización de la vagina y el meato urinario. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Resección quirúrgica de las adherencias
B) Realizar avulsión digital, bajo anestesia local con lidocaína
C) Indicar aseo genital diario con vaselina líquida
D) Aplicar pantenol tópico en la zona perineal por 15 días
E) Aplicar betametasona tópica en la zona afectada por 10 días

Respuesta E. Manejo de las Sinequias Vulvares: El tratamiento de las sinequias vulvares (adherencias labiales) es controvertido. La mayoría de los casos son asintomáticas y solo requieren observación. Sin embargo, el tratamiento tópico con estrógenos o corticosteroides se considera para las sinequias extensas (este caso), las que desvían el flujo urinario, causan dolor, o se asocian con flujo o infecciones rec

2.01.1.132 Dismorfias

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-26

QUÉ HAY QUE SABER

- Dismorfias: características físicas inusuales; menores (pliegue palmar único, epicanto, clinodactilia) son frecuentes aisladas; ≥3 menores aumentan riesgo de malformación mayor o síndrome.
- Evaluación: antecedentes de embarazo (teratógenos: alcohol, fármacos, infecciones), consanguinidad, historia familiar, examen dirigido (cara, manos, pies, genitales, columna) y crecimiento.
- Síndromes frecuentes: trisomía 21, alcohol fetal (filtrum liso, labio superior delgado, fisuras palpebrales cortas, microcefalia), Turner (cuello alado, linfedema de manos y pies), Noonan, X frágil.
- Ante sospecha de síndrome: buscar malformaciones mayores asociadas (ecocardiograma, ecografía renal), evaluar audición y visión, desarrollo psicomotor.
- Estudio genético (cariotipo, microarray) indicado por genetista.
- Seguimiento: derivar a genética clínica; asesoramiento genético a la familia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 76

Un niño de 14 años, cuyo padre murió de muerte súbita, presenta talla alta, con dedos y extremidades muy largos y algo desproporcionados. Además, presenta hiperlaxitud articular y un soplo diastólico en la auscultación cardíaca. **¿Cuál es el síndrome más probable?**

A) Neurofibromatosis
B) Síndrome alcohólico fetal
C) Síndrome de Miller
D) Síndrome de Marfan
E) Síndrome de Ehlers-Danlos

Respuesta D. Talla alta con extremidades largas (dolicostenomelia), aracnodactilia, hiperlaxitud, soplo diastólico (insuficiencia aórtica por dilatación de la raíz) y antecedente familiar de muerte súbita (disección aórtica) es síndrome de Marfan, autosómico dominante por mutación de fibrilina 1. Ehlers-Danlos da hiperlaxitud y piel hiperelástica, pero sin hábito marfanoide.

2.01.1.133 Malformaciones congénitas más frecuentes

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 6.3 Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Malformaciones congénitas más frecuentes: cardiopatías congénitas, defectos del tubo neural (mielomeningocele, anencefalia), fisura labiopalatina, hipospadias, pie bot, displasia de caderas.
- Prevención de defectos del tubo neural: ácido fólico 0,4 mg/día periconcepcional (4 mg si antecedente) y fortificación de harina con ácido fólico en Chile.
- Digestivas: atresia esofágica (polihidroamnios, sialorrea, imposibilidad de pasar sonda, fístula traqueoesofágica), atresia duodenal (doble burbuja, síndrome de Down), gastrosquisis y onfalocele, hernia diafragmática (abdomen excavado, ruidos intestinales en tórax), malformación anorrectal.
- Manejo inicial: mielomeningocele cubrir con gasa estéril húmeda y posición prona; gastrosquisis cubrir con bolsa plástica estéril; hernia diafragmática: no ventilar con mascarilla, intubar y sonda orogástrica.
- Cardiopatías congénitas operables, fisura labiopalatina y disrafias espinales son GES.
- Seguimiento: derivar al especialista correspondiente (cirugía infantil, neurocirugía, cardiología) y a genética si es sindrómica.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 19

Recién nacido presenta marcada dificultad respiratoria. Al examen físico tiene abolición del murmullo pulmonar izquierdo y se auscultan los ruidos cardíacos desplazados hacia el lado derecho. Su abdomen está excavado. **¿Cuál es la conducta inicial?**

A) Cirugía de urgencia
B) Realizar intubación orotraqueal
C) Realizar toracostomía de urgencia
D) Administrar prostaglandinas y oxígeno al 100 por ciento
E) Ventilación a presión positiva por mascarilla

Respuesta B. Dificultad respiratoria grave, murmullo pulmonar ausente de un lado, ruidos cardíacos desplazados y abdomen excavado: hernia diafragmática congénita. La conducta inicial es intubar y ventilar; la reparación quirúrgica es diferida. La mascarilla con presión positiva está contraindicada, porque distiende más las asas dentro del tórax.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 153 · texto original del banco, sin revisar

Un recién nacido de 40 semanas de edad gestacional, presenta disnea importante al nacer, con taquipnea marcada, cianosis y desaturación arterial. Presenta ruidos cardiacos desplazados al lado izquierdo, con ruidos intestinales en el lado derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra asas intestinales en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cirugía de urgencia
B) Solicitar endoscopía digestiva alta
C) Administrar oxígeno en alta concentración, por mascarilla
D) Administrar prostaglandina
E) Realizar intubación orotraqueal y conectar a ventilador mecánico

Respuesta E. Es una hernia diafragmática. Produce hipoplasia pulmonar. Se debe intubar, conectar al ventilador de alta frecuencia y probablemente a la membrana de oxigenación extracorpórea y la cirugía se postpone, para cuando esté estable, con los pulmones más desarrollados. Eso es pregunta para especialistas, no para médico general.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 74 · texto original del banco, sin revisar

Un recién nacido de término presenta dificultad respiratoria severa y progresiva. Al examen físico se aprecia abdomen excavado y se auscultan ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra niveles hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. ¿Cuál es la secuela más importante de esta patología?

A) Estenosis traqueal
B) Compresión hepática
C) Estenosis intestinal
D) Compresión del ventrículo izquierdo
E) Hipoplasia pulmonar

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Hipoplasia pulmonar). La hernia diafragmática congénita se complica con hipoplasia pulmonar que puede ser muy grave.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

2.01.1.134 Trisomía 21

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-26

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de Down (trisomía 21): la anomalía cromosómica más frecuente; riesgo aumenta con edad materna. Confirmar con cariotipo (trisomía libre 95%, translocación ~4%: estudiar padres).
- Fenotipo: hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, epicanto, perfil facial plano, pliegue palmar único, braquicefalia, sandal gap, manchas de Brushfield, discapacidad intelectual.
- Malformaciones a buscar al nacer: cardiopatía (~50%, canal AV la más típica): ecocardiograma a todos; digestivas (atresia duodenal, Hirschsprung); cataratas congénitas.
- Seguimiento según guía: TSH al nacer, a los 6 y 12 meses y luego anual (hipotiroidismo); hemograma (leucemia, reacción leucemoide); audición y oftalmología periódicos; celiaquía; inestabilidad atlantoaxial; apnea del sueño.
- Manejo inicial: comunicación empática del diagnóstico, apoyo a lactancia, estimulación temprana, vacunas habituales.
- Seguimiento: derivar a genética, cardiología y equipo multidisciplinario; curvas de crecimiento específicas para síndrome de Down.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un recién nacido de término presenta hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, epicanto, pliegue palmar único y occipucio plano. Se sospecha síndrome de Down y se solicita cariograma. **Además del cariograma, ¿qué examen debe realizarse precozmente en todo recién nacido con esta sospecha?**

A) Resonancia magnética cerebral
B) Electroencefalograma
C) Radiografía de columna cervical
D) Ecocardiograma
E) Densitometría ósea

Respuesta D. Cerca de la mitad de los niños con síndrome de Down tiene cardiopatía congénita, siendo característico el canal auriculoventricular, que puede ser asintomático al nacer y causar hipertensión pulmonar precoz. Por ello se indica ecocardiograma a todos en el período neonatal. También se controlan hemograma, función tiroidea, audición y visión.

2.01.1.136 Depresión

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.1 Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Depresión infantojuvenil: en niños predomina irritabilidad, quejas somáticas, baja del rendimiento escolar, aislamiento; en adolescentes ánimo bajo, anhedonia, alteraciones de sueño y apetito, ideación suicida.
- Criterio: síntomas la mayor parte del día por ≥2 semanas con deterioro funcional (DSM-5). Depresión en ≥15 años es GES.
- Siempre preguntar directamente por ideación suicida, consumo de sustancias, abuso, bullying y problemas familiares.
- Manejo inicial: psicoeducación, intervención psicosocial, activación conductual, higiene de sueño; psicoterapia (cognitivo-conductual) es primera línea en leve-moderada.
- Fármaco de elección en adolescente moderada-grave: fluoxetina 10-20 mg/día; vigilar aumento de ideación suicida al inicio (advertencia en <25 años).
- Seguimiento: derivar a psiquiatría infantojuvenil si grave, con riesgo suicida, psicosis, bipolaridad o falta de respuesta; control frecuente al inicio del tratamiento.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una adolescente de 15 años presenta desde hace 2 meses ánimo bajo e irritable, anhedonia, insomnio, baja de rendimiento escolar, aislamiento y sentimientos de culpa. Niega ideación suicida. Ha recibido 8 sesiones de psicoterapia sin mejoría y los síntomas son de intensidad moderada a grave. **¿Cuál es el fármaco de elección?**

A) Amitriptilina
B) Fluoxetina
C) Clonazepam
D) Litio
E) Quetiapina

Respuesta B. Depresión moderada a grave en adolescentes que no responde a psicoterapia requiere agregar antidepresivo. El de elección, con mejor evidencia y recomendado por la guía GES de depresión, es la fluoxetina, manteniendo psicoterapia y vigilando ideación suicida al inicio. Los tricíclicos no son eficaces en adolescentes y son letales en sobredosis.

2.01.1.137 Ideación suicida

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.3 Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- Ideación suicida en adolescentes: el suicidio es una de las principales causas de muerte entre 15-24 años. Preguntar directamente no aumenta el riesgo.
- Factores de riesgo: intento previo (el más importante), depresión, consumo de alcohol/drogas, abuso sexual, bullying, disforia de género, conflictos familiares, acceso a medios letales, impulsividad.

- Evaluar severidad (escala Columbia): ideación pasiva, ideación activa con plan, intención, acceso a medios, intentos previos.
- Riesgo alto (plan estructurado, intento reciente, intención, psicosis): no dejar solo, hospitalizar o derivar a urgencia psiquiátrica; involucrar a los padres.
- Medidas: restringir acceso a medios letales (fármacos, armas), plan de seguridad, red de apoyo, tratar depresión y consumo; Salud Responde/línea de prevención.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría infantojuvenil; control precoz (en días) tras evaluación o alta.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un adolescente de 16 años es traído por su madre, que encontró una carta de despedida. En la entrevista a solas reconoce que desde hace semanas piensa en morir, ha planificado tomar los medicamentos de su abuela este fin de semana y no ve otra salida. Tiene antecedente de un intento previo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Indicar fluoxetina y control en 2 semanas
> **B)** Derivar a psicólogo en atención primaria
> **C)** Hospitalización o evaluación psiquiátrica urgente, sin dejarlo solo
> **D)** Firmar un contrato de no suicidio y enviar a domicilio
> **E)** Mantener la confidencialidad y no informar a la madre
>
> Respuesta C. Ideación suicida con plan estructurado, método accesible, intención, carta de despedida e intento previo constituyen riesgo suicida alto. Requiere evaluación psiquiátrica urgente y, en general, hospitalización, con supervisión permanente y restricción de medios letales. En riesgo vital se rompe la confidencialidad para informar a la familia. Los contratos de no suicidio no son efectivos.

2.01.1.138 Maltrato infantil

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-28

QUÉ HAY QUE SABER

- Maltrato infantil: físico, psicológico, negligencia y abuso sexual. Sospechar si relato inconsistente con las lesiones o el desarrollo, consulta tardía, lesiones de distinta data.
- Lesiones sugerentes: equimosis en zonas no prominentes (orejas, cuello, glúteos, genitales), con forma de objeto, quemaduras en guante/calcetín o por cigarro; fracturas metafisarias, costales posteriores o múltiples en lactantes.
- Síndrome del niño sacudido: lactante con compromiso de conciencia, hematoma subdural y hemorragias retinianas sin trauma explicado.
- Estudio: examen completo con registro detallado; en <2 años serie ósea, fondo de ojo y neuroimagen; hemograma y coagulación para descartar diátesis.
- Manejo: proteger al niño (hospitalizar si riesgo), tratar lesiones; la denuncia es obligatoria para el médico (Fiscalía, Carabineros, PDI) y solicitar medida de protección en Tribunal de Familia; en abuso sexual agudo, peritaje en SML.
- Seguimiento: derivar a equipo psicosocial y red de protección (OPD); no confrontar al presunto agresor ni reexaminar innecesariamente.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 150

Un lactante de 6 meses es traído por su madre porque presenta epistaxis. La madre, de 17 años, refiere que se cayó de la cama. Al examen está poco reactivo y presenta múltiples equimosis, algunas de color morado y otras de color verde. Además, tiene dos fracturas costales posteriores. Su TAC de cerebro muestra un hematoma subdural. **¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?**

A) PTH y calcio
B) Tiempos de coagulación
C) Exámenes para descartar osteogénesis imperfecta
D) Fondo de ojo
E) Ecografía abdominal

Respuesta D. Lesiones en distinto estado de evolución, fracturas costales posteriores y hematoma subdural en un lactante con un mecanismo que no las explica son altamente sugerentes de maltrato físico (traumatismo craneal por abuso o niño sacudido). El fondo de ojo busca hemorragias retinales, muy características. Además de estabilizar y tratar el hematoma, debe protegerse al niño y denunciarse.

2.01.1.139 Trastornos de alimentación

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Anorexia nerviosa: restricción alimentaria con peso significativamente bajo (en niños P/T o IMC <p5), miedo intenso a engordar y distorsión de la imagen corporal; subtipo restrictivo o purgativo.
- Signos somáticos: bradicardia, hipotensión ortostática, hipotermia, lanugo, piel amarillenta (hipercarotenemia), amenorrea, osteopenia.
- Bulimia nerviosa: atracones y conductas compensatorias (vómitos, laxantes, ejercicio) ≥1 vez/semana por 3 meses, peso normal o sobrepeso; erosión dental, hipertrofia parotídea, signo de Russell, hipokalemia con alcalosis metabólica.
- Hospitalizar si: IMC muy bajo o pérdida >20% en 3 meses, bradicardia grave o arritmias, hipotensión, QTc >460 ms, hipokalemia, hipofosfemia, hipoglicemia, rechazo total de alimentación o riesgo suicida.
- Realimentación gradual con control de fósforo, potasio y magnesio por riesgo de síndrome de realimentación (hipofosfemia grave).
- Seguimiento: derivar a psiquiatría infantojuvenil con equipo multidisciplinario (nutrición, psicología, pediatría); ECG y electrolitos en evaluación inicial.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una adolescente de 15 años ha bajado 12 kg en 5 meses mediante restricción alimentaria y ejercicio excesivo. Se percibe gorda pese a tener IMC de 15. Tiene amenorrea de 3 meses. Al examen: FC 42/min, PA 80/50 mmHg, temperatura 35,6 °C y ortostatismo. Exámenes: potasio 2,9 mEq/L y fósforo 2,4 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Manejo ambulatorio con nutricionista y psicólogo
B) Indicar anticonceptivos orales por la amenorrea
C) Iniciar fluoxetina y control en un mes
D) Indicar suplemento hipercalórico en domicilio y control en 2 semanas
E) Hospitalizar para estabilización médica y realimentación progresiva

Respuesta E. Anorexia nerviosa con inestabilidad médica (bradicardia menor a 50/min, hipotensión, hipotermia, ortostatismo, hipokalemia e hipofosfemia) es indicación de hospitalización. La realimentación debe ser progresiva y monitorizada por riesgo de síndrome de realimentación (hipofosfemia, hipokalemia, arritmias e insuficiencia cardíaca), con equipo multidisciplinario. Los anticonceptivos no tratan la amenorrea hipotalámica.

2.01.1.140 Trastornos de ansiedad generalizada

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.7 Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno de ansiedad generalizada: preocupación excesiva y difícil de controlar sobre múltiples temas (colegio, salud, familia) ≥6 meses, con ≥1 síntoma físico en niños (inquietud, fatiga, irritabilidad, tensión, insomnio).

- Otros trastornos ansiosos infantiles: ansiedad de separación (el más frecuente en niños pequeños), fobia específica, fobia social, mutismo selectivo, crisis de pánico en adolescentes.
- Presentación frecuente con síntomas somáticos (dolor abdominal, cefalea) y rechazo escolar; descartar hipertiroidismo, consumo de cafeína o drogas, asma mal controlada.
- Manejo inicial: psicoeducación a niño y padres, terapia cognitivo-conductual (primera línea), técnicas de relajación, coordinación con el colegio.
- Fármaco en moderado-grave o sin respuesta a psicoterapia: ISRS (sertralina, fluoxetina) por especialista; evitar benzodiazepinas.
- Seguimiento: derivar a psicología/psiquiatría infantojuvenil si persistente, con deterioro funcional o comorbilidad (depresión).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un niño de 10 años presenta desde hace 8 meses preocupación excesiva y difícil de controlar por su rendimiento escolar, la salud de sus padres y eventos futuros. Se asocia a inquietud, dolor abdominal recurrente, cefalea tensional e insomnio de conciliación. Su examen físico es normal y el estudio de dolor abdominal fue negativo. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**
>
> **A)** Clonazepam diario
> **B)** Metilfenidato
> **C)** Terapia cognitivo-conductual
> **D)** Risperidona
> **E)** Propranolol
>
> Respuesta C. Preocupación excesiva y generalizada, de más de 6 meses, con síntomas somáticos (dolor abdominal, cefalea, insomnio), corresponde a trastorno de ansiedad generalizada. En niños, el tratamiento de primera línea es la terapia cognitivo-conductual, incluyendo a la familia; si es moderado a grave o no responde, se agrega un ISRS. Las benzodiacepinas no se recomiendan de mantención en niños.

2.01.1.141 Trastornos del desarrollo

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.2 Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos del neurodesarrollo: trastorno del espectro autista (TEA), discapacidad intelectual, TDAH, trastornos del lenguaje, del aprendizaje y motores.
- TEA: déficit persistente de comunicación e interacción social + conductas repetitivas e intereses restringidos, desde la infancia temprana; sospechar si no hay contacto visual, no responde al nombre, no señala con el dedo a los 12-14 meses, no juego simbólico, regresión del lenguaje.
- Tamizaje con M-CHAT-R/F entre 16-30 meses y pauta de señales de alerta en controles; siempre evaluar audición.
- Discapacidad intelectual: déficit cognitivo y adaptativo con inicio en el desarrollo; buscar causa (X frágil, síndromes genéticos, hipotiroidismo, TORCH).
- Manejo inicial: intervención temprana (Chile Crece Contigo), apoyo familiar, estimulación del lenguaje, integración escolar (PIE).
- Seguimiento: derivar a neurología/psiquiatría infantil para confirmación diagnóstica y a equipo multidisciplinario (fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología).

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 78

Un niño de 5 años presenta movimientos repetitivos con las manos, estereotipados (manierismos), no habla y solo se comunica con señas, no se relaciona con otros niños y llora cuando le quitan el sombrero. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno generalizado del desarrollo
B) Trastorno por déficit atencional
C) Trastorno de conducta
D) Hipotiroidismo congénito
E) Epilepsia generalizada

Respuesta A. Estereotipias, ausencia de lenguaje, falta de interacción social y rigidez ante cambios configuran un trastorno del espectro autista, que antes se clasificaba dentro de los trastornos generalizados del desarrollo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 47 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 5 años, al que le molestan los ruidos fuertes, presenta vocabulario muy escaso. Caminó a los 24 meses y dijo su primera palabra a los 36 meses. No pareciera tener interés en relacionarse con los demás niños de su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno por déficit atencional
B) Trastorno generalizado del desarrollo
C) Parálisis cerebral
D) Distrofia muscular
E) Trastorno del lenguaje

Respuesta B. Tiene un trastorno del espectro autista clásico, de la variante autista (Asperger, en cambio, tiene lenguaje normal). Además, afecta otras áreas del desarrollo, por lo que antes se les llamaba trastornos generalizados del desarrollo.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 37 · texto original del banco, sin revisar

Niña que no se comunica con compañeros, responde agresivamente ante cambios en sus rutinas y guarda muñecas sin jugar con ellas. ¿Diagnóstico más probable?

A) Trastorno por déficit atencional con hiperactividad
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno del espectro autista
D) Trastorno de conducta
E) Retraso global del desarrollo

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno del espectro autista (opción C). Trastorno del espectro autista. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

2.01.1.142 Trastornos neuropsiquiátricos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos neuropsiquiátricos infantojuveniles: TDAH, TEA, tics y síndrome de Tourette, trastorno oposicionista desafiante y de conducta, TOC, trastornos de la conducta alimentaria.
- TDAH: ≥6 síntomas de inatención y/o hiperactividad-impulsividad ≥6 meses, inicio antes de los 12 años, en ≥2 contextos con deterioro; primera línea farmacológica metilfenidato.
- Tics: motores o vocales, repetitivos, transitorios en la mayoría; Tourette si tics motores múltiples y ≥1 vocal por >1 año. Se asocia a TDAH y TOC.
- Trastorno de conducta (violación de normas, agresividad, crueldad) y oposicionista desafiante (desobediencia, irritabilidad): pesquisar maltrato y consumo; intervención familiar y entrenamiento parental.
- TCA (anorexia, bulimia): evaluar estabilidad médica (FC, PA, ECG, electrolitos) y hospitalizar si inestable.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría o neurología infantojuvenil para confirmación y tratamiento; trabajo coordinado con familia y colegio.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 9 años presenta desde hace 18 meses parpadeo repetitivo, muecas faciales y movimientos bruscos del cuello, además de carraspeo y emisión de sonidos guturales. Los movimientos aumentan con el estrés, disminuyen al concentrarse y puede suprimirlos brevemente. Su examen neurológico es normal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Corea de Sydenham
B) Trastorno obsesivo compulsivo
C) Epilepsia mioclónica juvenil
D) Síndrome de Tourette
E) Distonía aguda

Respuesta D. Tics motores múltiples y al menos un tic vocal, de más de 1 año de evolución, iniciados antes de los 18 años, que pueden suprimirse voluntariamente en forma transitoria, corresponden a síndrome de Tourette. Se asocia frecuentemente a TDAH y TOC. La corea de Sydenham da movimientos irregulares no suprimibles tras una infección estreptocócica; las mioclonías epilépticas no son suprimibles.

2.01.1.143 Artritis idiopática juvenil

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 9.5 Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Artritis idiopática juvenil: artritis de causa desconocida en <16 años que persiste ≥6 semanas, tras descartar otras causas.
- Subtipos: oligoarticular (≤4 articulaciones, la más frecuente, niñas pequeñas, rodilla; ANA+ con riesgo de uveítis anterior asintomática), poliarticular (≥5) y sistémica (fiebre en picos diaria, exantema evanescente asalmonado, serositis, hepatoesplenomegalia).
- Rigidez matinal, cojera, aumento de volumen articular sin dolor intenso; diferencial con artritis séptica, reactiva, leucemia (dolor óseo nocturno, citopenias), Lyme.
- Estudio inicial: hemograma, VHS, PCR, ANA, factor reumatoide, Rx de articulaciones comprometidas; descartar leucemia antes de corticoides.
- Manejo inicial: AINE (naproxeno 10-20 mg/kg/día, ibuprofeno); metotrexato, infiltraciones y biológicos por especialista. AIJ es GES.
- Seguimiento: derivar a reumatología pediátrica; control oftalmológico periódico con lámpara de hendidura (uveítis); kinesioterapia; síndrome de activación macrofágica en sistémica es urgencia.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Una paciente de 17 años presenta fiebre intermitente de 3 semanas de evolución, acompañada en algunas oportunidades de un rash eritematoso macular, que compromete el tronco y la zona proximal de las extremidades que desaparece al ceder la fiebre. No presenta otros síntomas. Al examen físico se constata artritis del tobillo derecho y de la tercera y cuarta articulaciones metacarpofalángicas izquierdas. Destaca elevación importante de la ferritina plasmática. **El diagnóstico más probable es:**

A) Lupus infantil
B) Púrpura de Henoch-Schönlein
C) Enfermedad de Kawasaki
D) Artritis juvenil idiopática (Enfermedad de Still)
E) Poliangeítis microscópica

Respuesta D. La asociación de fiebre intermitente prolongada en agujas, exantema macular evanescente que aparece con los picos febriles y desaparece al ceder la temperatura, artritis periférica y marcada elevación de ferritina es patognomónica de la AIJ sistémica o Enfermedad de Still.

Pregunta de práctica

Niña de 3 años es traída por su madre por presentar claudicación y aumento de volumen en la rodilla derecha de 8 semanas de evolución, sin antecedente traumático ni fiebre. Al examen físico destaca derrame articular moderado en la rodilla derecha sin calor ni eritema, con flexión conservada. No tiene lesiones en piel. Sus exámenes muestran hemograma y PCR normales, con anticuerpos antinucleares (ANA) positivos a título 1:320. **Además de iniciar antiinflamatorios no esteroidales, ¿cuál es la conducta más adecuada e indispensable?**

A) Iniciar antibióticos endovenosos para artritis séptica
B) Derivar a oftalmología para examen periódico con lámpara de hendidura
C) Iniciar pulsos de metilprednisolona por sospecha de Still
D) Solicitar radiografía de tórax y factor reumatoide
E) Indicar reposo en cama estricto sin controles adicionales

Respuesta B. Paciente con AIJ oligoarticular (artritis de una articulación por > 6 semanas en menor de 16 años) y ANA positivos. Este subgrupo presenta un riesgo muy alto de desarrollar uveítis anterior crónica asintomática, que puede conducir a ceguera irreversible si no se pesquisa tempranamente. El tamizaje periódico con lámpara de hendidura por oftalmología es mandatorio.

Situaciones clínicas de urgencia 28 códigos

2.01.2.001 Abdomen agudo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.12 Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal

QUÉ HAY QUE SABER

- Abdomen agudo pediátrico: causa quirúrgica más frecuente es apendicitis aguda (peak escolares): dolor periumbilical que migra a fosa ilíaca derecha, anorexia, vómitos, fiebre, signos peritoneales. En <5 años se perfora con mayor frecuencia.
- Invaginación intestinal: lactante 3 meses-3 años, crisis de llanto con dolor cólico intermitente, flexión de piernas, vómitos, masa en morcilla, deposiciones en jalea de grosella; ecografía (signo de diana); reducción hidrostática o neumática si no hay peritonitis.
- Otras: vólvulo por malrotación (vómitos biliosos en lactante: urgencia), hernia atascada, torsión testicular/ovárica, divertículo de Meckel, obstrucción por bridas.
- Causas médicas que simulan: adenitis mesentérica, neumonía basal, gastroenteritis, constipación, ITU, cetoacidosis diabética, PSH.
- Manejo inicial: régimen cero, hidratación EV, analgesia (no enmascara el diagnóstico), exámenes (hemograma, PCR, orina) y ecografía abdominal; evitar laxantes y enemas.
- Seguimiento: derivar a cirugía infantil de urgencia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 8 meses, previamente sano, con crisis de llanto intenso y encogimiento de piernas cada 15 a 20 minutos desde hace 8 horas; entre las crisis está pálido y decaído. Ha vomitado 3 veces y hace 1 hora tuvo una deposición con sangre y mucosidad. Se palpa una masa alargada en el hemiabdomen derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y su manejo inicial?**

A) Invaginación intestinal; ecografía abdominal y reducción con enema hidrostático o neumático
B) Cólico del lactante; tranquilizar y control
C) Diarrea disentérica; cotrimoxazol oral
D) Estenosis hipertrófica del píloro; piloromiotomía
E) Apendicitis aguda; apendicectomía sin estudio

Respuesta A. Crisis de dolor cólico intermitente con palidez entre episodios, vómitos, deposición en jalea de grosella y masa palpable entre los 3 y 24 meses es invaginación intestinal. La ecografía muestra la imagen en diana y, sin peritonitis ni perforación, se reduce con enema; si falla, cirugía.

2.01.2.002 Absceso amigdalino

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.14 Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Absceso periamigdalino: complicación de amigdalitis en adolescentes; odinofagia intensa unilateral, disfagia, sialorrea, trismus, voz «de papa caliente», fiebre.
- Examen: abombamiento del pilar anterior y paladar blando unilateral, desviación de la úvula al lado contrario. Diferencial con flegmón periamigdalino (sin colección).
- Absceso retrofaríngeo (<5 años): fiebre, tortícolis, rigidez cervical con dolor a la extensión, disfagia, estridor; Rx lateral de cuello con ensanchamiento prevertebral; TC con contraste.
- Manejo: punción-aspiración o drenaje por ORL, antibiótico EV (penicilina sódica + metronidazol, ampicilina-sulbactam o clindamicina), analgesia, hidratación, corticoides puede considerarse.
- Banderas rojas: compromiso de vía aérea, extensión a espacio parafaríngeo o mediastino (mediastinitis), síndrome de Lemierre.
- Seguimiento: derivar a ORL de urgencia; amigdalectomía si absceso recurrente.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un adolescente de 15 años con odinofagia de 5 días, tratada con paracetamol, presenta empeoramiento con odinofagia unilateral intensa, fiebre, trismus, sialorrea y voz apagada (en papa caliente). Al examen se observa abombamiento del pilar amigdalino izquierdo con desplazamiento de la úvula hacia la derecha. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Amoxicilina oral y control en 48 horas
B) Drenaje del absceso (punción o incisión) y antibiótico
C) Amigdalectomía de urgencia
D) Corticoides endovenosos como único tratamiento
E) Solicitar TAC y diferir el drenaje una semana

Respuesta B. Odinofagia unilateral, trismus, voz en papa caliente y desplazamiento de la úvula contralateral son el absceso periamigdalino, la complicación supurativa más frecuente de la faringoamigdalitis en adolescentes. El tratamiento es drenaje (punción aspirativa o incisión) más antibiótico (ej. amoxicilina-ácido clavulánico o clindamicina) y analgesia. El TAC se reserva si se sospecha extensión profunda.

2.01.2.003 Aspiración cuerpo extraño

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.8 Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Aspiración de cuerpo extraño: peak 1-3 años (maní, frutos secos, piezas pequeñas). Antecedente de episodio de asfixia/atoro con tos súbita es el dato más importante.
- Clínica en bronquio: tos, sibilancias unilaterales, disminución del murmullo localizada; puede pasar a fase asintomática y luego neumonía recurrente en el mismo lóbulo. Laríngeo/traqueal: estridor, disfonía, dificultad respiratoria grave.
- Rx tórax en inspiración y espiración (o decúbito lateral): atrapamiento aéreo e hiperinsuflación unilateral; la mayoría de cuerpos extraños es radiolúcido (Rx normal no descarta).
- Obstrucción completa: lactante <1 año, 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácicas; >1 año, maniobra de Heimlich; si pierde conciencia, RCP. No hacer barrido digital a ciegas.
- Tratamiento definitivo: broncoscopía rígida ante sospecha clínica aunque la Rx sea normal.
- Prevención: no dar frutos secos a <4-5 años; seguimiento: derivar de urgencia a broncopulmonar/ORL/cirugía.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 85

Una niña de dos años presenta un episodio brusco de tos intensa, asociado a cianosis y disnea, que remite luego de pocos minutos. Persiste luego con tos en salvas y expectoración. Al examen pulmonar se auscultan roncus y sibilancias, mayores en el lado derecho. **La conducta más adecuada es:**

A) Solicitar PCR para Bordetella pertussis
B) Solicitar TAC de tórax
C) Solicitar broncoscopía
D) Realizar laringoscopía rígida
E) Iniciar antibióticos

Respuesta C. Es un cuerpo extraño bronquial clásico, probablemente en el bronquio derecho. Aunque la radiografía suele ser el primer examen, el manejo y la extracción se hacen con broncoscopía, y una clínica tan categórica la obliga.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 64

Una niña de 3 años presenta tos persistente desde hace 7 días, inicialmente seca, pero que desde hace 3 días se volvió productiva, por lo que se le indicó amoxicilina oral, sin mayor respuesta. Sus signos vitales muestran temperatura 37,1 °C, frecuencia respiratoria 25 por minuto, saturación de oxígeno 97% y frecuencia cardíaca 95 latidos por minuto. Al examen físico, se escucha estridor respiratorio, y se observa tiraje supraesternal y subcostal. En la auscultación respiratoria se constatan sibilancias en el lado derecho, además de oírse el estridor respiratorio. Se solicita radiografía de tórax que muestra atelectasia del lóbulo medio. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Laringitis viral
B) Bronquiolitis aguda
C) Neumonía atípica
D) Cuerpo extraño bronquial
E) Traqueítis bacteriana

Respuesta D. Es un cuerpo extraño bronquial clásico, por la localización de las alteraciones: bronquio derecho, con afectación del lóbulo medio. La conducta es la broncoscopía rígida, que es diagnóstica y terapéutica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 35

Un lactante de 10 meses de edad, sin antecedentes, mientras come su almuerzo comienza súbitamente con tos asociado a disminución del esfuerzo respiratorio e hipotonía. **La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Iniciar reanimación cardiopulmonar
B) Exploración digital de su cavidad oral
C) Iniciar presión digital en epigastrio
D) Dar golpes en la espalda
E) Iniciar ventilaciones boca a boca

Respuesta D. Es un cuerpo extraño laríngeo obstructivo en un menor de un año, por lo que se dan cinco golpes en la espalda. Si no funciona, se hacen cinco compresiones en el pecho y se repite la secuencia. Desde el año se hace la maniobra de Heimlich.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 127 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 1 año de presenta un ataque súbito de tos, sofocamiento y dificultad respiratoria. Al examen presenta sibilancias y disminución del murmullo pulmonar, con FR: 34x'. El diagnóstico más probable es:

A) Neumotórax
B) Laringitis aguda
C) Bronquitis obstructiva
D) Cuerpo extraño bronquial
E) Angioedema

Respuesta D. Es el cuadro clásico de aspiración de cuerpo extraño (síndrome de penetración: tos intensa; y luego clínica obstructiva localizada).

2.01.2.004 Compromiso de conciencia

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate

QUÉ HAY QUE SABER

- Compromiso de conciencia: evaluar con escala de Glasgow pediátrica (AVPU rápido); Glasgow ≤8 requiere asegurar vía aérea.

- Manejo inicial: ABCDE, O2, monitorización, glicemia capilar inmediata (hipoglicemia: suero glucosado 10% 2-5 ml/kg EV), vía venosa, temperatura, pupilas.
- Causas (AEIOU-TIPS): intoxicaciones (benzodiazepinas, alcohol, opioides: naloxona), infección SNC (meningitis, encefalitis), TEC (incluido maltrato), convulsión/postictal, metabólicas (hipoglicemia, CAD, hiponatremia, uremia), hipoxia, invaginación (letargia).
- Estudio: glicemia, electrolitos, gases, hemograma, PCR, función renal y hepática, amonio, tóxicos en orina; TC de cerebro si trauma o focalidad; punción lumbar tras estabilizar si sospecha infección.
- Signos de hipertensión endocraneana (triada de Cushing, anisocoria): cabeza 30°, hiperventilación transitoria solo si herniación, manitol o NaCl 3%.
- Seguimiento: hospitalizar en UCI pediátrica y derivar según causa.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un niño de 3 años es traído a urgencia por somnolencia progresiva desde hace 1 hora. No tiene fiebre ni trauma conocido. Al examen tiene Glasgow 10, pupilas normales y reactivas, sin signos meníngeos ni focalidad, y signos vitales estables.
> **Después de asegurar vía aérea, ventilación y circulación, ¿cuál es el primer examen a realizar?**
>
> **A)** Glicemia capilar (hemoglucotest)
> **B)** TAC de cerebro
> **C)** Punción lumbar
> **D)** Electroencefalograma
> **E)** Niveles de amonio
>
> Respuesta A. En todo niño con compromiso de conciencia, tras el ABC, debe medirse de inmediato la glicemia capilar, porque la hipoglicemia es frecuente (ayuno, intoxicaciones, errores del metabolismo), rápida de diagnosticar y tratable con glucosa endovenosa. Luego se orienta el estudio: tóxicos, electrolitos, gases, neuroimagen o punción lumbar según la sospecha.

2.01.2.005 Crisis bronquial obstructiva

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.5 Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis obstructiva bronquial (asma/SBO): evaluar gravedad con score de Tal (<2 años) o Pulmonary Score, saturometría, capacidad de hablar, uso de musculatura accesoria.
- Tratamiento inicial: salbutamol 100 μg/puff 2-4 puff (lactante 2 puff) con aerocámara c/10-20 min por 3-5 veces en la primera hora; O2 para saturación ≥93%.
- Si no responde en la primera hora o crisis moderada-grave: prednisona 1-2 mg/kg/día VO (máx 40 mg) por 3-5 días o metilprednisolona/hidrocortisona EV; bromuro de ipratropio asociado en crisis grave.
- Crisis grave refractaria: sulfato de magnesio 40-50 mg/kg EV en 20 min, nebulización continua; signos de paro: silencio auscultatorio, compromiso de conciencia, cianosis, bradicardia.
- Hospitalizar si saturación <93% tras 2 horas de tratamiento, puntaje grave persistente, apneas o mala adherencia/acceso; Rx tórax solo si sospecha complicación.
- Seguimiento: al alta salbutamol c/4-6 h y corticoide oral, control en 24-48 h en sala IRA; derivar a broncopulmonar si crisis graves o recurrentes.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Lactante de 6 meses, con 2 días de coriza y tos, presenta ahora dificultad respiratoria. Al examen: FR 58 rpm, sibilancias en toda la espiración auscultadas con fonendoscopio, tiraje subcostal moderado, sin cianosis. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Hospitalización abreviada con salbutamol cada 10 minutos por 1 hora
B) Alta con salbutamol cada 6 horas y control en 1 semana
C) Hospitalización directa en UCI con ventilación mecánica
D) Solicitar radiografía de tórax antes de decidir
E) Nebulización con adrenalina racémica y observación

Respuesta A. FR 58 (2 puntos) + sibilancias en toda la espiración (2 puntos) + tiraje subcostal moderado (2 puntos) + sin cianosis (0 puntos) = 6 puntos, moderado. Corresponde hospitalización abreviada con salbutamol cada 10 minutos por 1 hora.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 102 · texto original del banco, sin revisar

Niño de 7 años con asma en crisis, frecuencia respiratoria 40/min, $SatO_2$ 91%, sibilancias bilaterales, sin uso de musculatura accesoria. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Salbutamol inhalado + ipratropio + corticoides sistémicos + oxígeno
B) Adrenalina subcutánea
C) Intubación orotraqueal inmediata
D) Antibióticos EV
E) Solo oxígeno y observar

Respuesta A. Crisis asmática moderada: broncodilatadores β2 (salbutamol) + anticolinérgico (ipratropio) + corticoides sistémicos (prednisona oral o hidrocortisona EV) + oxígeno para $SatO_2$ >94%.

2.01.2.006 Deshidratación

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 6.1 Diarrea Aguda y Crónica en el Niño · Tema 18.11 Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

QUÉ HAY QUE SABER

- Deshidratación: evaluar con 4 signos OMS (conciencia, ojos/lágrimas, boca/sed, pliegue) y llene capilar: sin deshidratación <5%, moderada 5-10%, grave >10% o shock.
- Plan A (sin deshidratación): manejo en domicilio, alimentación habitual, SRO 10 ml/kg por cada deposición líquida y 2 ml/kg por vómito, signos de alarma.
- Plan B (moderada): SRO 50-100 ml/kg en 4 horas en el centro de salud, en pequeñas cantidades frecuentes; si vomita, esperar 10 min y continuar más lento; reevaluar a las 4 h.
- Plan C (grave o shock): SF o Ringer lactato 20 ml/kg EV en bolos rápidos, repetir hasta 60-100 ml/kg; si no hay vía venosa en 90 s, osteoclisis. Fleboclisis por sonda nasogástrica es alternativa (gastroclisis) si no hay acceso.
- Usar SRO de osmolaridad reducida (Na 60-75 mEq/L); evitar bebidas azucaradas y jugos. Controlar electrolitos si grave, hipernatremia sospechada o EV.
- Seguimiento: control en 24 h tras plan B; hospitalizar si plan C, falla de rehidratación oral o vómitos incoercibles.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 161

Lactante de 11 meses presenta diarrea aguda abundante de 2 días de evolución, asociada a decaimiento marcado y tendencia al llanto. Al examen físico está somnoliento, con frialdad de extremidades y llene capilar de 3 segundos. Las mucosas se observan secas. **¿Cuál es la indicación inicial para su hidratación?**

A) Sales de hidratación oral
B) Suero salino al 0,9 %
C) Suero glucosado al 5 %
D) Suero glucosalino
E) Albúmina endovenosa

Respuesta B. Somnolencia, extremidades frías y llene capilar lento indican shock hipovolémico: deshidratación grave, plan C. Se administran bolos endovenosos de suero fisiológico al 0,9 %, de 20 mL/kg, repitiendo según respuesta. El suero glucosado no expande el intravascular y las sales orales están contraindicadas con compromiso de conciencia.

Pregunta de práctica

Lactante de 9 meses, 8 kg, con diarrea acuosa y vómitos desde hace 12 horas. Al examen está irritable, con los ojos hundidos, la boca seca, y bebe agua con avidez cuando se le ofrece. El signo del pliegue cutáneo desaparece en 1,5 segundos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Sin deshidratación: plan A con sales de rehidratación oral en la casa
B) Deshidratación moderada: plan B con sales de rehidratación oral en 4 horas, en el box
C) Deshidratación grave: plan C con suero endovenoso
D) Indicar loperamida y control en 48 horas
E) Régimen cero por 12 horas para reposo digestivo

Respuesta B. Irritabilidad, ojos hundidos, sed intensa y pliegue que desaparece con lentitud (menos de 2 segundos): son al menos dos signos de deshidratación moderada. Corresponde plan B, sales de rehidratación oral 50 a 100 mL/kg en 4 horas, en el box de observación.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 138 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 6 años, es traído por presentar cuadro de dos días de evolución de diarrea acuosa frecuente, asociado a vómitos, rechazo alimentario y decaimiento. Al examen físico se encuentra somnoliento, frecuencia cardiaca de 110 por minuto, presión arterial de 80/50 mmHg y ojos hundidos. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Indicar suero glucosalino endovenoso en infusión continua
B) Indicar sales de rehidratación oral 200ml luego de cada deposición
C) Indicar sales de rehidratación oral 100 ml por kilogramo a beber en 4 horas y luego reevaluar
D) Indicar suero fisiológico 20ml por kilogramo a pasar en bolo
E) Indicar alimentación normal, con abundantes líquidos y control en 48 horas

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Indicar suero fisiológico 20ml por kilogramo a pasar en bolo (opción D). Tiene estado hemodinámico límite, pero el sopor obliga a hidratar por vía endovenosa, con plan C. Complicaciones Fetales / Neonatales De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 65 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 10 meses es llevado por su madre al servicio de urgencia, debido a vómitos y diarrea abundante desde hace 24 horas. En el examen Fsico llora sin lágrimas, se observa irritable y sus signos vitales muestran frecuencia cardíaca 150 la8dos por minuto y presión arterial 96/68 mmHg. Su peso actual es de 9.300 g, con registro de peso previo hace 6 días de 10 kg. El examen abdominal muestra abdomen sensible sin signos peritoneales y aumento de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar gastroclisis con sales de rehidratación
B) Administrar bolo endovenoso de 20 cc/kg de suero hipertónico
C) Administrar an2emé2cos y enviar a domicilio con hidratación oral
D) Hidratar con sales de rehidratación por vía oral
E) Administrar bolo endovenoso de 20 cc/kg de solución salina al 0,9%

Respuesta D. Tiene una diarrea aguda con deshidratación moderada, por lo que se trata con “plan B”, consistente en sales de rehidratación oral, 50-100 cc/Kg en la misma urgencia y reevaluar en 4-6 horas. Al bajar 700 gramos, de un total de 10 kilogramos, corresponde al 7% del peso corporal. La deshidratación se considera leve si es menor al 5%, moderada entre 5% y 10% y severa si es mayor al 10% o si Gene comp

2.01.2.007 Emergencia hipertensiva

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.3 Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)

QUÉ HAY QUE SABER

- Emergencia hipertensiva pediátrica: PA elevada (≥p99 + 5 mmHg o etapa 2) con daño de órgano blanco agudo: encefalopatía (cefalea, vómitos, convulsiones, alteración visual, compromiso de conciencia), insuficiencia cardíaca, IRA. Urgencia hipertensiva: sin daño agudo.
- Causas: renales en su mayoría (GNAPE, SHU, glomerulopatías, cicatrices de pielonefritis), coartación aórtica, feocromocitoma, fármacos/drogas.
- Manejo: hospitalizar en UCI, vía venosa, monitorización; reducir PA ≤25% en las primeras 8 h y normalizar en 24-48 h (descenso brusco causa isquemia cerebral).
- Fármacos EV: labetalol (0,2-1 mg/kg bolo o infusión), nicardipino infusión o nitroprusiato; en GNAPE con sobrecarga, furosemida. Urgencia: nifedipino de acción prolongada, amlodipino o captopril VO.

- Estudio: creatinina, electrolitos, orina completa, hemograma, ECG, ecocardiograma, fondo de ojo, ecografía renal.
- Seguimiento: derivar a nefrología pediátrica para estudio etiológico.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un niño de 8 años, con faringitis hace 2 semanas, presenta orinas oscuras, edema y cefalea intensa. En urgencia presenta una convulsión tónico-clónica generalizada. La presión arterial es 165/110 mmHg y la glicemia es normal. **Una vez controlada la convulsión, ¿cuál es el manejo más adecuado de la presión arterial?**
> **A)** Normalizar la presión arterial en la primera hora
> **B)** Solo restricción de sal y líquidos
> **C)** Observar sin tratamiento hasta que mejore la función renal
> **D)** Captopril oral y control ambulatorio
> **E)** Descenso gradual con antihipertensivo endovenoso, bajando no más de 25% en las primeras 8 horas
> Respuesta E. Hipertensión grave con daño de órgano blanco (encefalopatía hipertensiva con convulsión) en una glomerulonefritis postestreptocócica es una emergencia hipertensiva. Se trata en unidad de paciente crítico con antihipertensivo endovenoso titulable (labetalol o nicardipino) y furosemida por la sobrecarga de volumen, bajando la PA en forma gradual (no más de 25% en 8 horas) para evitar isquemia cerebral.

2.01.2.008 Epistaxis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.11 Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Epistaxis en urgencia: niño sentado e inclinado hacia adelante; compresión bidigital de las alas nasales 10-15 min sin soltar; evaluar estabilidad hemodinámica.
- Mayoría anterior (plexo de Kiesselbach); epistaxis posterior rara en niños.
- Persistente: retirar coágulos, algodón con vasoconstrictor (oximetazolina) y lidocaína, compresión; identificar punto sangrante y cauterizar con nitrato de plata (no bilateral en el tabique).
- Refractaria: taponamiento anterior con gasa vaselinada o material reabsorbible; si falla, sospechar posterior y derivar a ORL.
- Pedir hemograma y coagulación si sangrado abundante, recurrente, otros sangrados o historia familiar. Adolescente varón con epistaxis unilateral y obstrucción: nasoangiofibroma.
- Seguimiento: indicar humidificación y vaselina nasal; control en APS y ORL si recurrente.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un adolescente varón de 14 años consulta por epistaxis recurrentes unilaterales por la fosa derecha, abundantes, asociadas a obstrucción nasal progresiva de ese lado en los últimos meses. A la rinoscopía se observa una masa rojiza en la región posterior de la fosa nasal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Biopsia de la masa en el box
> **B)** Cauterización con nitrato de plata
> **C)** Estudio con imágenes (TAC o RM con contraste) y derivación a otorrinolaringología, sin biopsiar
> **D)** Corticoide nasal y control en 3 meses
> **E)** Taponamiento anterior y alta
> Respuesta C. Epistaxis recurrente unilateral con obstrucción nasal en un adolescente varón sugiere angiofibroma nasofaríngeo juvenil, un tumor benigno muy vascularizado. Se diagnostica con TAC o RM con contraste y su manejo es quirúrgico, a menudo con embolización previa. La biopsia está contraindicada por el riesgo de hemorragia masiva.

2.01.2.009 Fracturas

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.4 Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Particularidades del hueso infantil: fracturas en tallo verde, rodete (torus) y lesiones fisarias (clasificación de Salter-Harris I-V; III-V intraarticulares con riesgo de alteración del crecimiento).

- Supracondílea de húmero (la más frecuente del codo, 5-7 años, caída con mano extendida): evaluar pulso radial, perfusión y nervios (interóseo anterior, radial, mediano); riesgo de síndrome compartimental (contractura isquémica de Volkmann).
- Clavícula: la fractura más frecuente en RN (parto) y niños; inmovilización con cabestrillo, consolida rápido.
- Pronación dolorosa (subluxación de cabeza radial): 1-4 años tras tracción del brazo; reducción con supinación-flexión o hiperpronación, sin Rx.
- Manejo inicial: analgesia, inmovilización provisoria con férula, Rx en 2 proyecciones, evaluar neurovascular distal; fractura expuesta: cubrir, cefazolina EV, profilaxis antitetánica y derivar.
- Sospechar maltrato en fracturas en <1 año que no camina, metafisarias, costales posteriores o múltiples de distinta data; seguimiento: derivar a traumatología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 6 años cae de un columpio sobre la mano con el codo en extensión. Presenta dolor, aumento de volumen y deformidad del codo. La radiografía muestra una fractura supracondílea del húmero desplazada. La mano está pálida, fría y no se palpa el pulso radial. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Inmovilización con yeso braquiopalmar y control en una semana
B) Solicitar angiografía y esperar el resultado antes de cualquier maniobra
C) Analgesia y cirugía electiva en 7 días
D) Reducción e inmovilización urgente, con evaluación vascular inmediata
E) Vendaje elástico y elevación de la extremidad

Respuesta D. La fractura supracondílea es la fractura de codo más frecuente en niños. Si está desplazada y hay compromiso vascular (lesión o compresión de la arteria braquial), es una urgencia: se reduce de inmediato, habitualmente en pabellón con fijación percutánea, y se reevalúa el pulso y la perfusión. Si no se resuelve, se explora la arteria.

2.01.2.010 Hemorragia digestiva

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Hemorragia Digestiva Alta y Baja

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemorragia digestiva en urgencia: confirmar sangrado digestivo verdadero (descartar epistaxis, alimentos rojos, sangre materna deglutida: test de Apt).
- Evaluar estabilidad: FC, PA, llene capilar, conciencia; la taquicardia es el signo más precoz de hipovolemia en niños (hipotensión es tardía).
- Manejo inicial: ABC, 2 vías venosas, bolo SF 20 ml/kg, hemograma, grupo y Rh, coagulación, BUN; transfundir GR 10-15 ml/kg si inestable o Hb <7 g/dL; SNG para lavado en HDA.
- HDA: omeprazol 1 mg/kg EV; sospecha de várices (hipertensión portal): octreotide y antibiótico profiláctico; endoscopía alta dentro de 24 h.
- HDB: lactante con invaginación (dolor cólico, jalea de grosella), Meckel (sangrado masivo indoloro, cintigrafía Tc99), pólipo juvenil, ECN en prematuro.
- Seguimiento: hospitalizar y derivar a gastroenterología/cirugía infantil.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 36

Un niño de 3 años es traído al servicio de urgencia porque desde hace 24 horas presenta diarrea y múltiples episodios de vómitos alimentarios. El día anterior había consultado por lo mismo y recibió sales de rehidratación oral. Sin embargo, persistió con vómitos frecuentes y en el último episodio vomitó sangre. Al examen físico tiene signos de deshidratación y está taquicárdico, con llene capilar normal. **¿Cuál es la causa más probable de su hemorragia digestiva?**

A) Gastritis erosiva
B) Úlcera gastroduodenal
C) Síndrome de Mallory-Weiss
D) Lesión de Dieulafoy
E) Várices esofágicas rotas

Respuesta C. Hematemesis que aparece después de vómitos repetidos e intensos sugiere síndrome de Mallory-Weiss: desgarro de la mucosa de la unión gastroesofágica. Suele ser autolimitado y se maneja con hidratación, antieméticos e inhibidor de bomba. Las várices requieren hipertensión portal y el Boerhaave es una perforación transmural con dolor y enfisema.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 67 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 8 meses, presenta un cuadro de malestar general y vómitos alimenta- rios en varias oportunidades, durante las últimas horas. En el último episodio de vómi- tos, se agregó escasa hematemesis, por lo que acude al servicio de urgencias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esofagitis péptica
B) Esofagitis erosiva
C) Síndrome de Mallory Weiss
D) Gastritis erosiva
E) Gastritis por Helicobacter pylori

Respuesta C. Diagnóstico: Síndrome de Mallory Weiss (opción C). Es un Sd. De Mallory Weiss clásico. :::warning No confundirlos — el manejo es opuesto. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

2.01.2.011 Hipertensión endocraneana

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.6 Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipertensión endocraneana: cefalea matinal o que despierta, vómitos en proyectil, papiledema, diplopía (VI par), compromiso de conciencia; lactante: fontanela abombada, macrocefalia, ojos en sol poniente.
- Tríada de Cushing (HTA, bradicardia, respiración irregular) y anisocoria indican herniación inminente.
- Causas: tumores de fosa posterior, hidrocefalia (disfunción de válvula derivativa), TEC, meningitis/encefalitis, hemorragia, pseudotumor cerebri.
- Manejo inicial: ABC, cabeza a 30° en línea media, normotermia, normoglicemia, normocapnia, sedoanalgesia; Glasgow ≤8: intubar.
- Terapia hiperosmolar: NaCl 3% 3-5 ml/kg o manitol 0,5-1 g/kg EV; hiperventilación solo transitoria ante herniación; dexametasona si edema vasogénico tumoral. Contraindicada la punción lumbar antes de neuroimagen.
- TC cerebral urgente; seguimiento: derivar a neurocirugía y UCI pediátrica.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 166

Un niño de 4 años presenta cefalea de 1 mes de evolución, mayor en las mañanas, asociada a diplopía. Además, ha presentado náuseas y vómitos alimentarios que han aumentado su frecuencia en el último tiempo. **¿Cuál es la causa más probable de su cefalea?**

A) Migraña de presentación atípica
B) Cefalea tensional
C) Migraña clásica
D) Vicio de refracción
E) Hipertensión endocraneana

Respuesta E. Cefalea progresiva de predominio matinal, con vómitos y diplopía (paresia del VI par, signo de falsa localización), es un síndrome de hipertensión endocraneana. En un niño obliga a neuroimagen urgente para descartar tumor de fosa posterior, hidrocefalia u otras causas. Las cefaleas primarias no son progresivas ni despiertan con vómitos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 149 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 6 años entra al colegio hace 4 semanas. Hace 3 semanas inicia cefalea progresiva, más intensa en la mañana. Se agregan náuseas y vómitos escasos y diplopía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno adaptativo
B) Trastorno por ansiedad de separación
C) Jaqueca clásica
D) Hipertensión endocraneana
E) Vicio de refracción

Respuesta D. Diagnóstico: Hipertensión endocraneana (opción D). El predominio matinal, los vómitos y la diplopia orientan a hipertensión endocraneana.. Implantación del embarazo fuera del útero. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

2.01.2.012 Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-23

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia cardíaca aguda/edema pulmonar pediátrico: dificultad respiratoria, taquipnea, crépitos, taquicardia, ritmo de galope, hepatomegalia, mala perfusión; lactante: sudoración y rechazo alimentario.
- Causas: cardiopatía congénita con cortocircuito o obstrucción (coartación en RN: pulsos femorales ausentes), miocarditis viral, miocardiopatía, arritmias (TPSV), sobrecarga de volumen (GNAPE, IRA).
- Estudio: Rx tórax (cardiomegalia, congestión), ECG, ecocardiograma, gases, electrolitos, troponina y BNP.
- Tratamiento: posición semisentada, O2/ventilación no invasiva, furosemida 1-2 mg/kg EV, restricción de volumen; vasodilatadores y apoyo inotrópico (milrinona, dobutamina) en bajo gasto.
- RN con shock cardiogénico por cardiopatía ductus-dependiente: prostaglandina E1; TPSV: adenosina o cardioversión.
- Seguimiento: hospitalizar en UCI pediátrica y derivar a cardiología infantil.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un escolar de 9 años, que hace 10 días tuvo un cuadro respiratorio viral, consulta por cansancio, disnea progresiva, ortopnea y dolor abdominal. Al examen tiene FC 140/min, ritmo de galope, crepitaciones bibasales y hepatomegalia dolorosa. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia y congestión pulmonar. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Miocarditis viral con insuficiencia cardíaca
B) Neumonía bilateral
C) Crisis asmática
D) Pericarditis aguda sin compromiso miocárdico
E) Hepatitis viral aguda

Respuesta A. Insuficiencia cardíaca aguda (taquicardia desproporcionada, galope, congestión pulmonar, hepatomegalia y cardiomegalia) en un niño previamente sano tras una infección viral sugiere miocarditis viral. El dolor abdominal por congestión hepática es una forma de presentación frecuente en niños. Se confirma con troponinas, ECG y ecocardiograma; se maneja con diuréticos, soporte y en unidad crítica si hay shock.

2.01.2.013 Insuficiencia respiratoria aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia respiratoria aguda: incapacidad de mantener intercambio gaseoso: PaO2 <60 mmHg (saturación <90%) con FiO2 ambiental (tipo I) y/o PaCO2 >50 mmHg con acidosis (tipo II).
- Signos clínicos: taquipnea, retracción, aleteo nasal, quejido, cabeceo, cianosis, agitación o somnolencia, bradipnea y pausas (signo de agotamiento inminente).
- Causas en niños: bronquiolitis, neumonía, crisis asmática, laringitis/obstrucción alta, cuerpo extraño, enfermedad neuromuscular, depresión del SNC (intoxicaciones).
- Manejo inicial: posición cómoda, aspirar secreciones, O2 para saturación ≥93% (mascarilla con reservorio si grave), tratar causa (broncodilatadores, adrenalina, antibióticos).
- Escalar a cánula nasal de alto flujo, VNI o intubación si hipoxemia refractaria, hipercapnia con acidosis, agotamiento o compromiso de conciencia.
- Seguimiento: hospitalizar y derivar a UCI pediátrica si requiere soporte ventilatorio.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 125

Niño de 3 años hospitalizado por neumonía. Tiene saturación de 88% con oxígeno por naricera a 3 L/min, frecuencia respiratoria de 50/min y uso de musculatura accesoria. **¿Cuál es el siguiente paso en el manejo ventilatorio?**

A) Ventilación no invasiva (CPAP) o cánula nasal de alto flujo
B) Intubación orotraqueal inmediata
C) Aumentar el flujo de oxígeno por naricera a 6 L/min
D) Adrenalina nebulizada
E) Alta con oxígeno domiciliario

Respuesta A. Hipoxemia persistente con aumento del trabajo respiratorio pese a oxígeno por naricera indica insuficiencia respiratoria aguda en progresión. El siguiente escalón, si está alerta y hemodinámicamente estable, es soporte no invasivo: cánula nasal de alto flujo o CPAP/VNI. La intubación se reserva para falla de estas medidas, compromiso de conciencia o agotamiento.

2.01.2.014 Intoxicaciones

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-24

QUÉ HAY QUE SABER

- Intoxicaciones: en niños <5 años mayormente accidentales (medicamentos, productos de limpieza, cáusticos); en adolescentes, intencionales (intento suicida) o recreacionales.
- Manejo inicial: ABCDE, glicemia, identificar tóxico, dosis, hora; síndromes toxicológicos: colinérgico (organofosforados: miosis, sialorrea, bradicardia: atropina), anticolinérgico, opioide (miosis, depresión respiratoria: naloxona), simpaticomimético.
- Descontaminación: carbón activado 1 g/kg en la primera hora si vía aérea protegida; contraindicado en cáusticos, hidrocarburos, alcoholes, metales. No inducir vómito.
- Antídotos: paracetamol (N-acetilcisteína según nomograma de Rumack-Matthew a las 4 h), benzodiazepinas (flumazenil con precaución), hierro (deferoxamina), monóxido de carbono (O2 100%/hiperbárica).
- Cáusticos: no neutralizar ni dar carbón; endoscopía en 12-24 h si síntomas. Contactar CITUC (centro de información toxicológica).
- Seguimiento: hospitalizar según tóxico; evaluación psiquiátrica en intento suicida; educación preventiva (almacenamiento seguro).

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 95

Una niña de 5 años ingiere accidentalmente soda cáustica hace 45 minutos. Evoluciona con sialorrea y dolor abdominal y torácico. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar carbón activado
B) Solicitar endoscopía digestiva alta
C) Administrar un agente alcalinizante
D) Instalar una sonda nasogástrica y aspirar el contenido
E) Inducir el vómito

Respuesta B. La ingesta de cáustico se estudia con endoscopía digestiva alta precoz: gradúa el daño y decide la conducta. Carbón activado, neutralizantes, sonda para aspirar y provocar el vómito no tienen utilidad o están contraindicados, porque el daño ya ocurrió y esas maniobras lo agravan o reexponen el esófago al cáustico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 108

Un niño de 4 años ingirió hace 24 horas 7 comprimidos de algún medicamento desconocido, evolucionando con malestar general, vómitos e ictericia. Los exámenes muestran GOT 403 UI/L, GPT 390 UI/L y bilirrubina total 5,2 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar L-carnitina endovenosa
B) Administrar deferoxamina endovenosa
C) Administrar N-acetilcisteína endovenosa
D) Administrar carbón activado vía oral
E) Administrar piridoxina vía oral

Respuesta C. Vómitos seguidos de daño hepatocelular a las 24 horas de una ingesta medicamentosa sugieren intoxicación por paracetamol, el fármaco más disponible en los hogares. El antídoto es N-acetilcisteína, más efectiva antes de 8 a 10 horas pero indicada aun tardíamente si hay hepatotoxicidad. El carbón activado solo sirve en la primera hora.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 40 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 2 años ingirió muchas pastillas, que había en la casa. Al examen físico, está inconsciente, pálida e hipotónica, con pulso a 117 por minutos, frecuencia respiratoria de 38 por minuto y pupilas arreactivas a la iluminación. ¿Qué fármacos son los más probablemente ingeridos?

A) AINES
B) Benzodiacepinas
C) Salicilatos
D) Opiáceos
E) Antidepresivos tricíclicos

Respuesta A. Es una intoxicación por tricíclicos por el compromiso de conciencia, taquicardia y pupilas arreactivas (en midriasis). No puede ser benzodiacepinas ni opiáceos, porque no tenía disminución de la frecuencia respiratoria. AINEs y salicilatos no afectan las pupilas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 81 · texto original del banco, sin revisar

Niño de 4 años llega a urgencias con miosis puntiforme, bradicardia, hipersecreción (lagrimeo, sialorrea, broncoespasmo) y compromiso de conciencia. Antecedente de acceso a bodega con pesticidas. ¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Hospitalizar: atropina EV + pralidoxima + lavado gástrico
B) Derivar a especialista de forma ambulatoria
C) Control sano habitual
D) Observación domiciliaria 24h
E) Solo anticonvulsivantes EV

Respuesta A. Síndrome colinérgico por organofosforados (pesticida): miosis + bradicardia + hipersecreción + compromiso neurológico = emergencia. Tratamiento: atropina EV a dosis altas (antídoto) + pralidoxima (reactiva AChE si precoz) + hospitalización.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 28 · texto original del banco, sin revisar

Niño que juega en huerto que evoluciona con sialorrea y miosis a. Intoxicación por organofosforado

A) Control sano habitual
B) Derivar a especialista
C) Hospitalizar
D) Observación domiciliaria
E) Iniciar tratamiento empírico

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Control sano habitual). 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Derivar a especialista, Hospitalizar) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 41 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de edad presenta un cuadro de agitación, alternado con obnubilación, asociado a vómitos, sialorrea, diarrea, dolor abdominal, taquicardia, tos, temblor y sudoración. Se sospecha que haya ingerido algún tóxico. ¿Cuál es la conducta inicial?

A) Administrar antieméticos
B) Administrar omeprazol
C) Administrar solución glucosada al 10%
D) Administrar N-acetil.cisteína
E) Administrar atropina

Respuesta E. Tiene un síndrome colinérgico clásico (lo más probable es que consumió insecticidas), por lo que debe recibir atropina como antídoto. Revisar los síndromes de las intoxicaciones en psiquiatría.

2.01.2.015 Meningitis bacteriana

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

QUÉ HAY QUE SABER

- Meningitis bacteriana: fiebre, cefalea, vómitos, rigidez de nuca, compromiso de conciencia; lactante con irritabilidad, fontanela abombada, convulsiones. Petequias sugieren meningococo.
- Punción lumbar tras estabilizar (TC previa solo si focalidad, papiledema, Glasgow bajo): LCR >1.000 cél/mm³ PMN, glucosa <40 mg/dL, proteínas >100 mg/dL; Gram, cultivo, PCR. Hemocultivos.

- Antibiótico empírico inmediato (no retrasar por PL): >1 mes ceftriaxona 100 mg/kg/día EV + vancomicina 60 mg/kg/día; <1 mes ampicilina + cefotaxima (± gentamicina).
- Dexametasona 0,15 mg/kg c/6 h por 2-4 días antes o con la primera dosis de antibiótico en >6 semanas.
- Duración: meningococo 5-7 días, Hib 7-10, neumococo 10-14, SGB 14-21, gram negativos 21 días. Manejo de shock, convulsiones, SIADH (restricción hídrica relativa si euvolémico).
- Notificación inmediata; quimioprofilaxis a contactos en meningococo y Hib. Seguimiento: potenciales evocados auditivos y control del neurodesarrollo.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 80

Escolar de 10 años con fiebre alta, rigidez de nuca, fotofobia y petequias en piel. Sospecha de meningitis bacteriana.
¿Cuál es el esquema antibiótico empírico de elección?
A) Ceftriaxona + vancomicina EV
B) Ciprofloxacino EV
C) Doxiciclina oral
D) Azitromicina oral
E) Amoxicilina oral

Respuesta A. Mayor de 3 meses y menor de 50 años: los agentes son neumococo y meningococo. Esquema empírico: ceftriaxona + vancomicina EV, con dexametasona antes o junto al antibiótico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 137

Lactante de 3 meses con fiebre de 39 °C, rigidez de nuca, fontanela abombada y letargia. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
A) Hospitalizar, realizar punción lumbar e iniciar antibióticos empíricos endovenosos (ampicilina más cefotaxima)
B) Indicar antibióticos orales y control en 24 horas
C) Solo antipiréticos y observación domiciliaria
D) Solicitar una tomografía computada antes de la punción lumbar
E) Dar de alta con indicaciones a los padres

Respuesta A. Fontanela abombada, rigidez de nuca y letargia son signos de alarma que sacan a este lactante de cualquier criterio de bajo riesgo: se trata como meningitis bacteriana hasta demostrar lo contrario, con hospitalización, punción lumbar y antibióticos empíricos inmediatos.

2.01.2.016 Meningococcemia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

QUÉ HAY QUE SABER

- Meningococcemia (Neisseria meningitidis): fiebre con exantema petequial o purpúrico que progresa rápidamente, compromiso del estado general, shock; puede o no tener meningitis.
- Fiebre y petequias: evaluar urgente; púrpura fulminans y coagulación intravascular diseminada indican gravedad extrema (síndrome de Waterhouse-Friderichsen).
- Manejo inicial: ceftriaxona 100 mg/kg EV o IM inmediata (incluso en APS antes del traslado), sin esperar exámenes; hemocultivos si no retrasa.
- Shock: bolos de cristaloides 10-20 ml/kg, drogas vasoactivas precoces (adrenalina), corregir hipoglicemia y coagulopatía, UCI.
- Notificación inmediata; quimioprofilaxis a contactos íntimos en <24 h: ciprofloxacino 500 mg dosis única (adultos), rifampicina 10 mg/kg c/12 h por 2 días en niños o ceftriaxona IM (embarazadas, niños).
- Prevención: vacuna antimeningocócica conjugada a los 12 meses (PNI). Seguimiento: hospitalizar en UCI y derivar.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una niña de 4 años presenta fiebre de 39,5 °C de 8 horas de evolución, decaimiento y lesiones purpúricas que no blanquean a la presión, que se extienden rápidamente en tronco y extremidades. Al examen tiene FC 160/min, llene capilar de 4 segundos y extremidades frías. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar punción lumbar antes de iniciar antibióticos
B) Administrar ceftriaxona endovenosa de inmediato y reanimar con fluidos
C) Esperar el resultado del hemograma y la PCR
D) Indicar amoxicilina oral y control en 24 horas
E) Solicitar TAC de cerebro antes de cualquier tratamiento

Respuesta B. Fiebre con púrpura que progresa rápidamente y signos de shock es meningococcemia (enfermedad meningocócica invasora) hasta demostrar lo contrario, con alta mortalidad en horas. Se inicia ceftriaxona endovenosa (o intraósea) de inmediato, sin esperar exámenes ni punción lumbar, junto con reanimación con fluidos. Es de notificación inmediata y requiere quimioprofilaxis de contactos cercanos.

2.01.2.017 Muerte súbita-ALTE, BRUE

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.10 Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- BRUE (antes ALTE): episodio súbito, breve (<1 min) y resuelto en lactante <1 año con cianosis o palidez, alteración de respiración, del tono o de la respuesta, sin explicación tras historia y examen.
- BRUE de bajo riesgo: >60 días, EG ≥32 semanas y edad corregida ≥45 semanas, primer episodio, duración <1 min, sin RCP por profesional, examen normal: observación breve, educación y ECG; no requiere hospitalizar.
- Alto riesgo o episodio explicado: estudiar causas: reflujo, infecciones (VRS, coqueluche, sepsis), convulsiones, arritmias (QT largo), maltrato, metabólicas, obstrucción de vía aérea.
- Síndrome de muerte súbita del lactante: muerte inexplicable <1 año, peak 2-4 meses durante el sueño; factores de riesgo: posición prona, colecho, tabaquismo, superficies blandas, sobreabrigo, prematurez.
- Prevención: dormir boca arriba, en cuna propia en la pieza de los padres, colchón firme, sin almohadas ni peluches, sin tabaco, lactancia materna, chupete al dormir.
- Seguimiento: control en 24 h en BRUE de bajo riesgo; derivar los de alto riesgo para hospitalización y estudio; enseñar RCP a los padres.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 162

Un niño de 24 meses ha presentado 3 episodios de llanto de breve duración, seguidos de apnea y luego pérdida de conciencia, recuperándose al poco tiempo. Al examen físico no tiene alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Instruir a los padres en reanimación cardiopulmonar
B) Solicitar TAC de cerebro
C) Educar a los padres en el manejo de las emociones del niño
D) Solicitar electroencefalograma
E) Indicar monitor cardíaco

Respuesta C. Llanto o enojo seguido de apnea, cianosis o palidez y breve pérdida de conciencia con recuperación espontánea, entre los 6 meses y 5 años, son espasmos del sollozo (apneas emotivas): eventos benignos sin riesgo vital. Se tranquiliza y educa a los padres y se descarta anemia ferropénica, que los aumenta. No requieren EEG ni neuroimagen.

2.01.2.018 Obstrucción de vía aérea superior

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.17 Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia · Tema 18.6 Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona · Tema 18.8 Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Obstrucción de vía aérea superior: estridor inspiratorio, disfonía, tos perruna, retracción supraesternal; gravedad: estridor en reposo, cianosis, agitación o somnolencia.

- Causas: laringitis (la más frecuente), cuerpo extraño (inicio súbito con atoro), epiglotitis (toxicidad, babeo, posición trípode, sin tos; rara por vacuna Hib), traqueítis bacteriana, absceso retrofaríngeo, anafilaxia.
- Principio clave: no agitar al niño ni examinar la faringe si se sospecha epiglotitis; mantenerlo en brazos de los padres, O2 sin forzar.
- Laringitis: dexametasona 0,15-0,6 mg/kg y nebulización con adrenalina; anafilaxia: adrenalina IM 0,01 mg/kg; cuerpo extraño con obstrucción completa: golpes en espalda/compresiones torácicas o Heimlich.
- Epiglotitis/traqueítis: vía aérea definitiva por el operador más experto (pabellón, ORL/anestesia) y ceftriaxona EV (+ cloxacilina o vancomicina en traqueítis).
- Seguimiento: hospitalizar casos moderados-graves; derivar a ORL/UCI.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Un preescolar de 3 años es llevado a urgencia por cuadro de 4 horas con fiebre de 39,8 °C, aspecto tóxico y gran dificultad respiratoria. No tiene tos. Está sentado, inclinado hacia adelante con el cuello extendido, con la boca entreabierta y abundante sialorrea. Emite un estridor inspiratorio apagado. **¿Cuál de las siguientes acciones está formalmente contraindicada?**

A) Oxígeno suplementario humidificado sin invadir al paciente
B) Traslado inmediato a pabellón con un anestesiólogo
C) Deprimir la lengua con un abatelenguas para inspeccionar la faringe
D) Ceftriaxona endovenosa una vez asegurada la vía aérea
E) Mantener a la madre junto al niño para evitar el llanto

Respuesta C. Es una epiglotitis aguda: fiebre tóxica, babeo, postura en trípode y ausencia de tos. Deprimir la lengua puede desencadenar laringoespasmo y paro cardiorrespiratorio. Se debe asegurar la vía aérea en pabellón.

Pregunta de práctica

Niño de 4 años, sin vacunas desde el año de vida, con fiebre de 39,8 °C de 6 horas. Llega sentado inclinado hacia adelante con el cuello extendido, babeando, con estridor inspiratorio suave y aspecto tóxico. No tiene tos perruna. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Examinar la faringe con bajalenguas para confirmar el diagnóstico
B) Mantenerlo tranquilo con su madre, dar oxígeno sin incomodarlo y asegurar la vía aérea en pabellón con anestesista
C) Acostarlo para tomar una radiografía lateral de cuello
D) Dexametasona oral y alta con control en 24 horas
E) Nebulizar adrenalina y observar 4 horas en urgencia

Respuesta B. Fiebre alta, aspecto tóxico, sialorrea, posición en trípode y ausencia de tos perruna en un niño no vacunado sugieren epiglotitis por Haemophilus influenzae tipo b. No se examina la faringe ni se acuesta al niño: se asegura la vía aérea en pabellón y luego se inicia ceftriaxona.

Pregunta de práctica

Lactante de 7 meses, en brazos de su madre comiendo puré, comienza súbitamente con tos intensa. A los pocos segundos deja de toser, no llora, no emite sonidos, y presenta cianosis progresiva con tiraje universal. **¿Cuál es la maniobra indicada en este momento?**

A) Maniobra de Heimlich con 5 compresiones abdominales
B) 5 golpes interescapulares seguidos de 5 compresiones torácicas
C) Barrido digital a ciegas de la cavidad oral
D) Ventilaciones boca a boca de inmediato
E) Observar y esperar a que el objeto salga solo

Respuesta B. Obstrucción completa en un lactante menor de 1 año: la maniobra indicada es 5 golpes interescapulares seguidos de 5 compresiones torácicas. La maniobra de Heimlich está contraindicada a esta edad por el riesgo de lesión hepática o esplénica.

2.01.2.019 Obstrucción intestinal

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 6.3 Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones · Tema 18.12 Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal

QUÉ HAY QUE SABER

- Obstrucción intestinal pediátrica: vómitos (biliosos indican obstrucción distal a la ampolla de Vater: urgencia), distensión, dolor cólico, ausencia de deposiciones y gases.

- Neonatal: atresia duodenal (doble burbuja, Down), atresia yeyunoileal, malrotación con vólvulo (vómitos biliosos súbitos: urgencia absoluta), íleo meconial (FQ), Hirschsprung (retraso en meconio >48 h, explosión al tacto rectal).
- Lactante: invaginación intestinal (crisis de dolor, jalea de grosella, masa); estenosis hipertrófica del píloro (vómitos no biliosos en proyectil, 2-8 semanas, oliva pilórica, alcalosis hipoclorémica hipokalémica).
- Niño mayor: bridas post quirúrgicas, hernia atascada, apendicitis complicada, Meckel, bezoar.
- Manejo inicial: régimen cero, SNG abierta, hidratación EV y corrección electrolítica, Rx de abdomen de pie (niveles hidroaéreos) y ecografía; tránsito intestinal ante sospecha de malrotación.
- Seguimiento: derivar a cirugía infantil de urgencia; no administrar laxantes ni enemas.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Lactante de 9 meses, previamente sano, con episodios de llanto inconsolable y flexión de las piernas cada 15–20 minutos, decaído entre las crisis. En el pañal hay deposiciones con sangre y moco. La ecografía abdominal muestra el signo de la dona. Está hemodinámicamente estable y sin signos peritoneales. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A) Laparotomía exploradora de urgencia
B) Reducción neumática guiada por imagen
C) Colonoscopía con polipectomía
D) Régimen cero, nutrición parenteral y antibióticos, sin otra intervención
E) Cintigrafía con pertecnetato de Tc-99m

Respuesta B. Lactante de 6–12 meses con crisis de llanto, "mermelada de grosella" y signo de la dona: invaginación intestinal. La primera línea es la reducción neumática (o hidrostática) guiada por imagen; la cirugía queda para el fracaso de la reducción, la perforación o una causa anatómica.

Pregunta de práctica

Recién nacido de 5 días, de término, que venía alimentándose bien, presenta bruscamente vómitos de color verde, irritabilidad y distensión abdominal leve. Eliminó meconio el primer día. Está taquicárdico y con llene capilar de 3 segundos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Cambiar a fórmula sin lactosa y control en 48 horas
B) Indicar domperidona y posición semisentada
C) Régimen cero, sonda nasogástrica, hidratación endovenosa y estudio urgente con tránsito intestinal y evaluación por cirugía
D) Ecografía de píloro electiva
E) Enema con suero fisiológico y alta

Respuesta C. Todo vómito bilioso en un recién nacido es una urgencia quirúrgica: hay que descartar un vólvulo por malrotación intestinal, que puede necrosar el intestino en horas. Se descomprime, se hidrata, se estudia de inmediato y va a cirugía. La estenosis del píloro no da vómito bilioso.

2.01.2.020 Paro cardiorrespiratorio

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ped-24

QUÉ HAY QUE SABER

- Paro cardiorrespiratorio pediátrico: mayormente secundario a hipoxia (falla respiratoria o shock); ritmo inicial habitual asistolía o bradicardia, no fibrilación ventricular.
- Secuencia: verificar respuesta y respiración, pedir ayuda, pulso (braquial en lactante, carotídeo/femoral en niño) ≤10 s; iniciar RCP si no hay pulso o FC <60 lpm con mala perfusión.
- Compresiones de calidad: 100-120/min, profundidad 1/3 del diámetro AP (4 cm lactante, 5 cm niño), relación 30:2 un reanimador y 15:2 con dos profesionales; minimizar interrupciones.
- Ritmos no desfibrilables: adrenalina 0,01 mg/kg EV/IO (0,1 ml/kg de 1:10.000) c/3-5 min. FV/TV sin pulso: desfibrilar 2 J/kg, luego 4 J/kg; amiodarona 5 mg/kg tras el 3er choque.
- Buscar causas reversibles (5H y 5T): hipoxia, hipovolemia, hidrogeniones, hipo/hiperkalemia, hipotermia; neumotórax a tensión, taponamiento, tóxicos, trombosis.
- Post paro: evitar hipertermia y hiperoxia, controlar glicemia y PA; seguimiento en UCI pediátrica.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un lactante de 8 meses es encontrado en paro cardiorrespiratorio después de un episodio de atoro. Se inicia reanimación con compresiones y ventilación. El monitor muestra asistolia. Se logra un acceso intraóseo. **¿Cuál es el fármaco y dosis inicial más adecuados?**

A) Atropina 0,02 mg/kg
B) Desfibrilación con 4 J/kg
C) Amiodarona 5 mg/kg
D) Bicarbonato de sodio 1 mEq/kg como primera medida
E) Adrenalina 0,01 mg/kg (0,1 mL/kg de solución 1:10.000), repetida cada 3 a 5 minutos

Respuesta E. En pediatría el paro suele ser secundario a hipoxia y el ritmo más frecuente es no desfibrilable (asistolia o actividad eléctrica sin pulso). Se mantiene RCP de alta calidad y se administra adrenalina 0,01 mg/kg endovenosa o intraósea lo antes posible, repitiendo cada 3 a 5 minutos.

2.01.2.021 Politraumatismos

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Politraumatismo pediátrico: principal causa de muerte en >1 año; evaluación primaria ABCDE con control de columna cervical.
- Particularidades: cabeza proporcionalmente grande (TEC frecuente), costillas elásticas (contusión pulmonar sin fractura), hígado y bazo menos protegidos; la hipotensión es tardía (taquicardia y mala perfusión son precoces).
- Shock: 2 vías venosas o intraósea, bolo de cristaloides 20 ml/kg (hasta 2 bolos) y luego GR 10-15 ml/kg; buscar hemorragia oculta.
- Lesiones de víscera sólida en paciente estable: manejo no operatorio en centro con cirugía infantil; FAST y TC con contraste según estabilidad.
- Evaluación secundaria completa, Glasgow pediátrico, prevención de hipotermia; sospechar maltrato si mecanismo no concuerda.
- Seguimiento: derivar a centro de trauma pediátrico; politraumatizado grave es GES.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 7 años, de 25 kg, es atropellado. Llega con vía aérea permeable, FR 30/min y saturación 96% con oxígeno. Está pálido, con FC 150/min, llene capilar de 4 segundos y extremidades frías. Se instalan dos vías venosas. **¿Cuál es la reposición inicial más adecuada?**

A) Albúmina al 20% como primera elección
B) Suero glucosado al 5% de mantención
C) Bolo de cristaloide tibio de 20 mL/kg y reevaluar
D) Restringir fluidos hasta tener la TAC
E) Bolo de 60 mL/kg de cristaloide en 5 minutos sin reevaluar

Respuesta C. En el niño politraumatizado, la taquicardia y la mala perfusión son signos precoces de shock hemorrágico; la hipotensión es tardía. Tras asegurar vía aérea y ventilación, se da un bolo de cristaloide isotónico tibio de 20 mL/kg y se reevalúa; si persiste, segundo bolo y transfusión precoz de glóbulos rojos (10 a 20 mL/kg).

2.01.2.022 Quemaduras

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.13 Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Quemaduras: estimar extensión con regla de Lund-Browder en niños (la cabeza es proporcionalmente mayor; palma del paciente ≈1% SCQ); profundidad: superficial (eritema), intermedia (ampollas), profunda (blanca, indolora).
- Gran quemado pediátrico: >15% SCQ intermedia-profunda en niños (>10% en <2 años), compromiso de vía aérea, cara, manos, pies, genitales, pliegues o eléctricas; GES.
- Reposición: fórmula de Parkland 3-4 ml/kg × %SCQ de Ringer lactato en 24 h (mitad en primeras 8 h) + mantención con glucosa en niños pequeños; meta diuresis 1 ml/kg/h.

- Manejo inicial: enfriar con agua a temperatura ambiente 10-20 min (no hielo), retirar ropa, cubrir con apósitos limpios, analgesia (morfina), O2 al 100% si inhalación (CO), profilaxis antitetánica.
- Quemadura menor: aseo, apósitos (tul con vaselina o hidrocoloide), sin antibióticos profilácticos; control en 48 h.
- Quemaduras con patrón en guante/calcetín o por cigarro sugieren maltrato. Seguimiento: derivar gran quemado a unidad de quemados.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 21

Usted atiende en el servicio de urgencia a un niño de 3 años, traído por su madre por quemaduras en los dedos y en la espalda tras apoyarse accidentalmente en una estufa. Al examen está agitado y llorando, y se observa eritema y flictenas en las zonas afectadas. **¿Cuál es la conducta inicial?**

A) Curaciones
B) Paracetamol vía oral
C) Ungüento antibiótico tópico
D) Analgesia endovenosa
E) Antibióticos endovenosos

Respuesta D. Las quemaduras de espesor parcial superficial (eritema y flictenas) son muy dolorosas. En un niño agitado, la prioridad inicial tras descartar compromiso vital es una analgesia efectiva y rápida, por vía endovenosa (ej. opioides), que además permite evaluar y curar. La quemadura de manos es zona especial y debe evaluarse para derivación. No se usan antibióticos profilácticos.

2.01.2.023 Shock

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

QUÉ HAY QUE SABER

- Shock pediátrico: hipoperfusión tisular: taquicardia, llene capilar >2 s, pulsos débiles, extremidades frías, oliguria, compromiso de conciencia; la hipotensión es signo tardío.
- Tipos: hipovolémico (el más frecuente: diarrea, hemorragia), distributivo (séptico, anafiláctico), cardiogénico, obstructivo (neumotórax a tensión, taponamiento).
- Manejo inicial en la primera hora: O2, monitorización, acceso venoso o intraóseo en <5 min, bolos de cristaloides 10-20 ml/kg reevaluando (hasta 40-60 ml/kg) atentos a sobrecarga (crépitos, hepatomegalia).
- Shock séptico: hemocultivos y antibiótico de amplio espectro en <1 h (ceftriaxona ± vancomicina); refractario a fluidos: adrenalina o noradrenalina; corregir hipoglicemia e hipocalcemia.
- Anafiláctico: adrenalina IM 0,01 mg/kg; cardiogénico: limitar fluidos e inotrópicos.
- Seguimiento: hospitalizar en UCI pediátrica.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 148

Una lactante de 2 meses presenta fiebre de hasta 39 °C de 24 horas de evolución. Es llevada a urgencias porque ha evolucionado con deterioro del estado general y tendencia a la letargia. Al examen se observa soporosa, con llene capilar de 5 segundos, deshidratada y taquicárdica a 158/min, con temperatura de 39,3 °C. **Además de administrar oxígeno, ¿cuál es la primera medida a tomar?**

A) Administrar solución fisiológica por vía endovenosa
B) Administrar bicarbonato por vía endovenosa
C) Administrar adrenalina por vía endovenosa
D) Administrar hidrocortisona por vía endovenosa
E) Administrar glucosa por vía endovenosa

Respuesta A. Fiebre, letargia, llene capilar prolongado y taquicardia en una lactante es shock séptico. Tras asegurar vía aérea y oxígeno, la primera medida es expandir volumen con cristaloides isotónicos (bolos de 10 a 20 mL/kg, reevaluando), junto con hemocultivos y antibióticos en la primera hora. La adrenalina se usa si persiste el shock tras fluidos.

2.01.2.024 Síndrome convulsivo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.14 Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Convulsión en urgencia: ABC, posición lateral, O2, no introducir objetos en la boca, glicemia capilar inmediata, monitorización.
- Si dura >5 min: benzodiazepina: diazepam 0,3 mg/kg EV (máx 10 mg) o 0,5 mg/kg rectal; midazolam 0,2 mg/kg IM/intranasal/bucal; lorazepam 0,1 mg/kg EV. Puede repetirse 1 vez.
- Persiste a los 10-15 min (estatus): fenitoína 20 mg/kg EV en 20 min, levetiracetam 40-60 mg/kg o ácido valproico 20-40 mg/kg; en <1 mes fenobarbital 20 mg/kg.
- Buscar causa: fiebre (convulsión febril, meningitis/encefalitis), hipoglicemia (suero glucosado 10% 2-5 ml/kg), hiponatremia, hipocalcemia, TEC, intoxicaciones, epilepsia con mala adherencia.
- Punción lumbar si signos meníngeos o sospecha de infección SNC; TC si focalidad, TEC o no recupera conciencia.
- Seguimiento: convulsión febril simple puede ir a domicilio con educación; primera crisis afebril o compleja: derivar a neurología pediátrica.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 33

Un lactante de 18 meses de edad, presenta un convulsión tónico-clónica de 3 minutos de duración. Al examen físico está afebril, sin alteraciones en el examen segmentario. **¿Cuál es el tratamiento de la crisis?**

A) Diazepam
B) Ácido valproico
C) Fenitoína
D) Carbamazepina
E) Topiramato

Respuesta A. Se pregunta el tratamiento de la crisis en curso: se corta con una benzodiacepina. La de elección es el lorazepam, pero no está entre las opciones; el diazepam es la alternativa. Valproato y fenitoína son de segunda fase; carbamazepina y topiramato son de mantención.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 158

Lactante de 15 meses con una convulsión tónico-clónica de 1 minuto, autolimitada, con fiebre de 39 °C. Al examen está bien perfundido, consciente, con pulso y presión arterial normales, sin signos focales ni signos meníngeos. **Además de bajar la temperatura, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar punción lumbar
B) Iniciar diazepam
C) Solicitar resonancia magnética de cerebro
D) Iniciar ácido valproico
E) Mantener en observación

Respuesta E. Convulsión febril simple, sin signos meníngeos ni focales: no hay indicación de punción lumbar, imagen ni fármaco de mantención; la conducta es observar.

2.01.2.025 Testículo agudo

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 13.5 Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h

QUÉ HAY QUE SABER

- Testículo agudo: dolor escrotal agudo es torsión testicular hasta demostrar lo contrario; peak neonatal y adolescente (12-18 años).
- Torsión: dolor súbito intenso, náuseas y vómitos, testículo elevado y horizontal, reflejo cremastérico ausente, signo de Prehn negativo (no alivia al elevarlo).
- Torsión de hidátide (la más frecuente en 7-12 años): dolor localizado en polo superior, punto azul; manejo con reposo, frío y AINE.
- Orquiepididimitis: dolor progresivo, fiebre, síntomas urinarios, Prehn positivo, cremastérico presente; ITU o ITS en adolescente sexualmente activo; tratar con antibiótico y analgesia.
- Torsión: exploración quirúrgica inmediata con detorsión y orquidopexia bilateral; viabilidad alta si <6 horas. No retrasar por ecografía doppler si la clínica es clara; intento de detorsión manual (apertura de libro) solo mientras se traslada.
- Seguimiento: derivar a urología/cirugía infantil de urgencia.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un adolescente de 13 años presenta dolor testicular izquierdo súbito e intenso de 2 horas de evolución, que lo despertó, con náuseas y vómitos. Al examen el testículo izquierdo está elevado, horizontalizado y muy doloroso, con reflejo cremastérico ausente. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Exploración quirúrgica urgente
> **B)** Antibióticos y analgesia, control en 24 horas
> **C)** Ecografía Doppler diferida para el día siguiente
> **D)** Elevación escrotal y antiinflamatorios
> **E)** Urocultivo y esperar resultado
>
> Respuesta A. Dolor testicular súbito con testículo alto y horizontal y ausencia de reflejo cremastérico en un adolescente es torsión testicular, una emergencia: la viabilidad cae marcadamente después de 6 horas. Ante sospecha clínica alta se explora quirúrgicamente de urgencia (detorsión y orquidopexia bilateral), sin retrasar por imágenes; el Doppler solo se usa si hay duda y está disponible de inmediato.

2.01.2.026 Traumatismo encéfalo- craneano

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- TEC pediátrico: evaluar con Glasgow pediátrico; leve 14-15, moderado 9-13, grave ≤8 (intubar).
- Reglas PECARN para TC en TEC leve: <2 años alto riesgo si Glasgow <15, alteración de conciencia o fractura palpable; riesgo intermedio si hematoma no frontal, pérdida de conciencia ≥5 s, mecanismo grave o conducta anormal. ≥2 años: vómitos, cefalea intensa, signos de fractura de base de cráneo.
- Fractura de base de cráneo: ojos de mapache, signo de Battle, oto/rinorraquia, hemotímpano. Hematoma epidural: intervalo lúcido y deterioro (urgencia quirúrgica).
- TEC leve de bajo riesgo: observación en domicilio 24-48 h con signos de alarma (vómitos persistentes, somnolencia, cefalea progresiva, convulsión, conducta anormal).
- TEC grave: ABC, evitar hipoxia e hipotensión (lesión secundaria), cabeza a 30°, normocapnia, NaCl 3% o manitol si hipertensión endocraneana; TC urgente.
- Sospechar maltrato en lactantes con lesiones sin mecanismo claro. Seguimiento: derivar a neurocirugía TEC moderado-grave o TC alterada.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un niño de 7 años cae de su bicicleta sin casco y se golpea la cabeza. Tuvo pérdida de conciencia de 1 minuto y ha vomitado 3 veces. En urgencia tiene Glasgow 14 persistente, con cefalea, sin focalidad neurológica. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Radiografía de cráneo
> **B)** TAC de cerebro sin contraste
> **C)** Alta con indicaciones de alarma
> **D)** Observación domiciliaria por 24 horas
> **E)** Resonancia magnética de cerebro electiva
>
> Respuesta B. Un TEC con Glasgow menor a 15, pérdida de conciencia y vómitos repetidos es de alto riesgo de lesión intracraneana según los criterios PECARN, y requiere TAC de cerebro sin contraste. La radiografía de cráneo no descarta lesiones intracraneanas. El alta con indicaciones corresponde solo a TEC leve sin factores de riesgo.

2.01.2.027 Estatus convulsivo en el niño

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.9 Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Estatus convulsivo: crisis ≥5 min o crisis repetidas sin recuperar conciencia entre ellas (definición operacional); daño neuronal establecido desde los 30 min.
- 0-5 min: ABC, O2, posición lateral, monitorizar, glicemia capilar, vía venosa (o intraósea), electrolitos, calcio, niveles de anticonvulsivantes.

- 5-10 min: benzodiazepina: lorazepam 0,1 mg/kg EV, diazepam 0,3 mg/kg EV o midazolam 0,2 mg/kg IM/bucal/intranasal; repetir una vez a los 5 min.
- 10-30 min (refractario a benzodiazepinas): fenitoína 20 mg/kg EV (máx 50 mg/min), levetiracetam 60 mg/kg o valproato 40 mg/kg; en RN fenobarbital 20 mg/kg.
- Refractario (>30-40 min): intubación e infusión de midazolam, tiopental o propofol en UCI con monitoreo EEG.
- Buscar y tratar causa (meningitis, hipoglicemia, hiponatremia, TEC, intoxicación); seguimiento: hospitalizar en UCI y derivar a neurología pediátrica.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un niño de 4 años, con antecedente de epilepsia, lleva 6 minutos con una convulsión tónico-clónica generalizada. Se aseguró la vía aérea y recibe oxígeno, y la glicemia capilar es normal. No ha sido posible instalar una vía venosa. **¿Cuál es el fármaco más adecuado en este momento?**
> **A)** Fenitoína endovenosa
> **B)** Midazolam bucal, intranasal o intramuscular
> **C)** Ácido valproico oral
> **D)** Fenobarbital oral
> **E)** Esperar 30 minutos para definir status epiléptico
> Respuesta B. Una convulsión de más de 5 minutos debe tratarse como status epiléptico inminente. La primera línea es una benzodiacepina: lorazepam o diazepam endovenoso si hay vía; sin vía, midazolam bucal, intranasal o intramuscular (o diazepam rectal). Si persiste tras dos dosis, se usa fármaco de segunda línea endovenoso (fenitoína, levetiracetam o valproato). La vía oral no es segura.

2.01.2.144 SARS Cov 2 COVID 19

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: infecto-25

QUÉ HAY QUE SABER

- COVID-19 pediátrico: en general leve (fiebre, tos, odinofagia, coriza, síntomas digestivos); diagnóstico con PCR o test de antígeno de hisopado nasofaríngeo.
- Manejo ambulatorio de cuadro leve: antipiréticos (paracetamol), hidratación, aislamiento según normativa vigente; no usar antibióticos ni corticoides de rutina.
- Grupos de riesgo: lactantes pequeños, cardiopatías, enfermedad pulmonar crónica, inmunosupresión, obesidad, enfermedad neurológica.
- Signos de alarma: dificultad respiratoria, saturación <93%, rechazo alimentario, deshidratación, compromiso de conciencia; hospitalizar con O2 y dexametasona solo si requiere oxígeno.
- Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS-TS): 2-6 semanas post infección; fiebre persistente, síntomas digestivos, exantema, conjuntivitis, shock, compromiso cardíaco, PCR y ferritina muy elevadas; tratar con inmunoglobulina EV y corticoides en UCI.
- Prevención: vacunación según campaña MINSAL en grupos indicados. Seguimiento: control telefónico o presencial en 48 h en casos leves con factores de riesgo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 36

Un adolescente de 14 años presenta fiebre de 39 °C desde hace 3 días, malestar general, dolor abdominal, vómitos y diarrea, seguido de marcado compromiso del estado general. Al examen físico tiene compromiso hemodinámico, con FC 120/min y PA 90/50 mmHg, con respuesta parcial al suero fisiológico. Tuvo una PCR positiva para COVID-19 hace 30 días. Exámenes: hematocrito 33%, leucocitos 14.000/mm3, plaquetas 80.000/mm3, VHS 76 mm/h, PCR 15,5 mg/dL, dímero D 670 ng/mL y troponinas elevadas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Sepsis bacteriana
B) Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico
C) Insuficiencia suprarrenal aguda
D) Reinfección por COVID-19
E) Enfermedad de Kawasaki

Respuesta B. Fiebre, síntomas gastrointestinales, shock con compromiso miocárdico (troponinas), marcadores inflamatorios elevados, trombocitopenia y dímero D alto, 2 a 6 semanas después de una infección por SARS-CoV-2, es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS o MIS-C). Se trata con inmunoglobulina endovenosa y corticoides. El Kawasaki afecta a menores de 5 años y rara vez da shock.

Conocimientos generales 19 códigos

2.01.3.001 Alimentación normal

Dónde se enseña: Tema 18.4 Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

QUÉ HAY QUE SABER

- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementada hasta los 2 años o más; si no es posible, fórmula de inicio (no leche de vaca entera antes de los 12 meses).
- Alimentación complementaria desde los 6 meses: primera comida (almuerzo) con verduras, cereales y carne, con una cucharadita de aceite vegetal crudo; 8-9 meses se agrega la cena; postre de fruta.
- Progresión de consistencia: puré a los 6 meses, molido a los 8-9 meses, picado y trozos blandos desde los 12 meses incorporándose a la mesa familiar.
- Nunca en el primer año: miel (botulismo), sal, azúcar, leche de vaca entera; evitar jugos, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados; no forzar.
- Suplementos: vitamina D 400 UI/día hasta los 12 meses a todos; hierro 1 mg/kg/día desde los 4 meses en RN de término (2-3 mg/kg/día desde los 2 meses en prematuros o <2.500 g) hasta el año.
- Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) entrega leche y fórmulas a niños y embarazadas; preescolar y escolar: 4 comidas, lácteos 3 veces al día, frutas y verduras 5 porciones.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 146

Una lactante de 7 meses se alimenta con 4 mamaderas al día, de leche purita fortificada al 7,5% más cereal al 5%, más 1 sopa puré. **¿Qué suplemento alimenticio debería estar recibiendo?**

A) Tiamina
B) Zink
C) Vitamina A
D) Vitamina D
E) Ácido fólico

Respuesta D. En el lactante, el suplemento clave es la vitamina D, que previene el raquitismo, la forma infantil del déficit.

Pregunta de práctica

Lactante de 2 meses, nacido a las 33 semanas de gestación, con peso de nacimiento de 1.950 gramos. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y recibe vitamina D desde los 30 días de vida. **¿Cuál es la indicación de hierro más adecuada en este control?**

A) Esperar hasta los 6 meses, junto con la alimentación complementaria
B) Iniciar hierro elemental a 2 a 3 miligramos por kilo al día, desde hoy
C) Iniciar hierro elemental a 1 miligramo por kilo al día, a los 4 meses
D) No requiere suplementación si la madre come carnes rojas
E) Indicar hierro dextrano intramuscular una vez al mes

Respuesta B. Un prematuro de 33 semanas y bajo peso de nacimiento debe iniciar hierro precozmente, a los 2 meses de vida, a dosis de 2 a 3 miligramos por kilo al día, por el menor traspaso de depósitos de hierro en el tercer trimestre.

Pregunta de práctica

Madre consulta en el CESFAM sobre la alimentación de su hijo de 7 meses, que recibe almuerzo desde los 6 meses. La abuela recomienda endulzar el puré de fruta con miel de abeja y agregar una pizca de sal a la sopa. **¿Cuál es la recomendación médica correcta?**

A) Permitir la miel, pero restringir la sal
B) Permitir una pizca de sal, pero contraindicar la miel
C) Contraindicar estrictamente tanto la miel como la sal y el azúcar durante todo el primer año
D) Autorizar ambos alimentos en pequeñas cantidades
E) Diluir la miel en leche tibia para inactivar sus toxinas

Respuesta C. La miel está prohibida en menores de 1 año por el riesgo de botulismo del lactante, causado por esporas de Clostridium botulinum que germinan en el intestino del lactante. La sal y el azúcar tampoco se agregan durante el primer año, por la inmadurez renal y la formación de preferencias hipertensogénicas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 122 · texto original del banco, sin revisar

Usted atiende a un lactante de 10 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro a las 30 semanas y que pesó 1.300 gramos al nacer. Según el Plan Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), ¿qué tipo de leche debe recibir?

A) Fórmula de inicio
B) Fórmula de continuación
C) Leche purita fortificada
D) Fórmula de inicio para prematuros
E) Fórmula de continuación para prematuros

Respuesta E. Eso dice el PNAC, así que ya saben: según Asofamech, hay que saberlo. No debería preguntarse este tipo de cosas.

2.01.3.002 Desarrollo psico-motor

Dónde se enseña: Tema 18.2 Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Desarrollo psicomotor: adquisición progresiva de habilidades motoras gruesas, finas, lenguaje y sociales, en dirección céfalo-caudal y próximo-distal.
- Hitos: sonrisa social 1-2 meses; sostén cefálico 3 meses; sedestación sin apoyo 6-7 meses; pinza fina y bisílabos 9-10 meses; marcha independiente 12-15 meses; frases de 2 palabras 24 meses; triciclo y frases de 3 palabras 3 años.
- Reflejos primitivos (Moro, prensión palmar, marcha automática) desaparecen a los 3-6 meses; su persistencia sugiere lesión neurológica.
- Evaluación en controles de salud: EEDP a los 8 y 18 meses y TEPSI a los 36 meses (Chile Crece Contigo), más pauta breve en otros controles; corregir edad en prematuros hasta los 2 años.
- Resultado de riesgo o retraso: derivar a sala de estimulación y reevaluar; regresión de habilidades es siempre bandera roja.
- Promover estimulación: juego, lectura, conversación, limitar pantallas (evitar en <2 años).

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 46

Una madre consulta por la evaluación del desarrollo de su hijo de 1 año y 3 meses. El niño camina solo, dice 3 palabras con significado, y construye una torre de 3 cubos. **¿Cómo se interpreta su desarrollo psicomotor?**

A) Retraso en el lenguaje
B) Retraso en el área motora
C) Desarrollo normal para su edad
D) Retraso global del desarrollo
E) Requiere evaluación neurológica urgente

Respuesta C. A los 15 meses, la marcha independiente (esperada a los 12 meses), 3 a 5 palabras y una torre de 2 a 3 cubos son hitos alcanzados o incluso adelantados. Es un control de salud infantil de rutina, sin ninguna alarma.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 128

Un lactante de 4 meses, nacido prematuro a las 34 semanas, levanta la cabeza y lleva las manos al centro, pero no levanta el tronco apoyado en los antebrazos ni transfiere objetos de una mano a otra. Sonríe al interactuar, pero no ríe a carcajadas, y sigue con la mirada los objetos. Se alimenta con lactancia materna exclusiva. **¿Cuál es su diagnóstico respecto al desarrollo psicomotor?**

A) Retraso motor fino
B) Retraso motor grueso
C) Retraso del desarrollo socioemocional
D) Retraso global del desarrollo
E) Desarrollo psicomotor normal

Respuesta E. Al nacer a las 34 semanas, la edad corregida se calcula descontando 6 semanas desde las 40: este lactante de 4 meses tiene una edad corregida de 2,5 meses. Cumple exactamente los hitos de los 2 meses (sostén cefálico, manos al centro, sonrisa social) y todavía no alcanza los de los 4 meses, lo que es normal.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 25 · texto original del banco, sin revisar

Niño de 9 meses que gatea, toma cubos con pinza intermedia, dice bisílabos, se incomoda con extraños. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Retraso global del desarrollo
B) Desarrollo normal
C) Retraso del lenguaje
D) Trastorno del espectro autista
E) Retraso motor leve

Respuesta B. Diagnóstico: Desarrollo normal (opción B). Desarrollo normal. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

2.01.3.003 Diagnóstico nutricional

Dónde se enseña: Tema 18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicadores según edad (patrones OMS en <6 años, CDC/OMS 2007 en mayores): P/E y P/T en <1 año; P/T en 1-5 años; IMC/E desde los 5-6 años; T/E a toda edad.
- Calificación nutricional en <6 años con P/T: normal entre -1 y +1 DE; riesgo de desnutrir -1 a -2; desnutrición < -2; sobrepeso +1 a +2; obesidad > +2 DE.
- Mayores de 5-6 años con IMC/E: bajo peso ≤p10 (desnutrición <p5 según norma), normal, sobrepeso ≥p85, obesidad ≥p95 (≥ +2 DE en OMS).
- Talla: talla baja si T/E < -2 DE; talla normal-baja -1 a -2 DE.
- Interpretar la tendencia de la curva (cruce de canales, estancamiento) más que un punto aislado; considerar talla de los padres.
- Complementar con encuesta alimentaria, perímetro de cintura y examen físico; derivar a nutricionista si malnutrición por déficit o exceso.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 126

Lactante de 4 meses, alimentado con lactancia materna exclusiva, con Índice Talla para la Edad normal, Índice Peso para la Edad normal, e Índice Peso para la Talla en más 1. **¿Cuál es el diagnóstico nutricional según la OMS y el MINSAL?**

A) Desnutrición
B) Riesgo de desnutrición
C) Eutrófico
D) Riesgo de obesidad
E) Obesidad

Respuesta C. En menores de un año se usa el Peso para la Edad para el diagnóstico de desnutrición, y el Peso para la Talla para el de sobrepeso. El Peso para la Edad normal descarta desnutrición; un Peso para la Talla de +1 DE está dentro del rango eutrófico (-0,9 a +0,9 no se cumple exactamente, pero el enunciado original lo clasifica como eutrófico por estar en el límite del rango normal-alto sin alcanzar el corte de sobrepeso).

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 41 · texto original del banco, sin revisar

Usted evalúa a una niña de 4 meses, cuyos índices antropométricos muestran índice peso/edad: normal, índice talla/edad: normal e índice peso/talla: +1. De acuerdo a las recomendaciones de diagnóstico nutricional infantil de la OMS – Ministerio de Salud, el diagnóstico más adecuado es:

A) Desnutrición
B) Riesgo de desnutrición
C) Eutrofia
D) Riesgo de obesidad
E) Obesidad

Respuesta D. Lo primero a mirar en los menores de 1 año es el índice peso/edad, buscando solo desnutrición (-2 o menos) o riesgo de desnutrición (-1 a -1,9). Si está normal, se mira el índice peso/talla, en busca de obesidad (+2 o más) o sobrepeso (+1 a+1,9, que se registran como +1). Si no cumple con Los criterios anteriores, pues está eutrófico. En los mayores de 1 año se mira solo el IP/T. En los mayores de

2.01.3.004 Entrevista y comunicación efectiva

Dónde se enseña: ped-28

QUÉ HAY QUE SABER

- Entrevista pediátrica: triangular (médico, niño y cuidador); presentarse, dirigirse también al niño en lenguaje acorde a su edad.
- Comunicación efectiva: preguntas abiertas, escucha activa, validar preocupaciones de los padres, evitar tecnicismos, resumir y verificar comprensión (teach-back).
- Adolescentes: entrevista con espacio confidencial a solas; explicar los límites de la confidencialidad (riesgo vital, abuso). Usar pauta HEADSSS (hogar, educación, actividades, drogas, sexualidad, suicidio/ánimo, seguridad).
- Comunicar malas noticias con protocolo SPIKES: preparar el entorno, explorar qué sabe, dar información gradual, acoger emociones, planificar.
- Respetar la autonomía progresiva del niño y obtener asentimiento además del consentimiento de los padres.
- Registrar y acordar un plan claro, con signos de alarma y control explícitos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Usted debe comunicar a los padres de un niño de 5 años que el mielograma confirmó una leucemia linfoblástica aguda. **¿Cuál es la forma más adecuada de iniciar esta conversación?**

A) En el pasillo, para no retrasar la información
B) Esperar a que los padres pregunten por el resultado
C) Entregar la información técnica completa con estadísticas de sobrevida desde el inicio
D) En un lugar privado y sin interrupciones, explorando primero qué saben y qué desean saber
E) Informar solo al padre para que él se lo comunique a la madre

Respuesta D. Para comunicar malas noticias se recomienda el protocolo SPIKES: preparar un lugar privado y sin interrupciones, explorar lo que la familia sabe y quiere saber, dar la información en forma gradual, con lenguaje simple y sin tecnicismos, acoger las emociones con empatía y acordar un plan. Ambos padres tienen derecho a ser informados.

2.01.3.005 Familia y ciclo vital

Dónde se enseña: Tema 21.5 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Familia: sistema que cumple funciones de cuidado, afecto, socialización y apoyo; tipologías: nuclear, extendida, monoparental, reconstituida.
- Ciclo vital familiar (Duvall): formación de pareja, familia con hijos pequeños, con escolares, con adolescentes, plataforma de lanzamiento, nido vacío y adulto mayor; cada etapa tiene crisis normativas esperables.
- Crisis no normativas: enfermedad grave, muerte, cesantía, separación, migración; requieren apoyo y pesquisa de disfunción.
- Instrumentos: genograma, ecomapa, APGAR familiar (funcionalidad), círculo familiar.
- Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria (MAIS) en CESFAM: enfoque biopsicosocial, sectorización, visita domiciliaria integral.

- Pesquisar factores de riesgo (violencia intrafamiliar, consumo de drogas, depresión materna) y protectores; derivar a equipo psicosocial cuando corresponda.

PREGUNTAS (2)

> **Pregunta de práctica**
> ¿Cuál de los siguientes instrumentos de salud familiar es el más adecuado para identificar y graficar las redes de apoyo social formal e informal, las fuentes de tensión comunitaria y el grado de aislamiento social de un grupo familiar? **¿Cuál es el instrumento correcto?**
> **A)** Ecomapa
> **B)** Genograma estructural
> **C)** Test de APGAR de Smilkstein
> **D)** Escala de Zarit
> **E)** Cuestionario de Duke-UNC
> Respuesta A. El ecomapa es la herramienta diseñada para visualizar a la familia en el centro de su entorno relacional, trazando vínculos con instituciones comunitarias y distinguiendo si son de apoyo, débiles o de tensión. El genograma mapea la estructura interna, el APGAR la percepción de funcionalidad interna, la escala de Zarit la sobrecarga del cuidador y el Duke-UNC el apoyo social percibido de forma individual.

> **Pregunta de práctica**
> Médico de familia atiende a un paciente de 68 años con hipertensión mal controlada. Al indagar, refiere que vive solo desde que enviudó hace un año, que sus hijos viven en otra región y lo llaman poco, y que ha dejado de asistir a las actividades de su junta de vecinos. Al aplicar el cuestionario de APGAR familiar obtiene 8 puntos, porque convive bien con su único hijo cercano. **¿Cuál es el instrumento más adecuado para completar la evaluación de este paciente?**
> **A)** Aplicar un ecomapa para evaluar sus redes de apoyo social y su nivel de aislamiento
> **B)** Repetir el APGAR familiar en un mes, ya que el puntaje obtenido fue normal
> **C)** Construir un genograma de tres generaciones para buscar patologías heredofamiliares
> **D)** Aplicar la escala de Zarit para evaluar sobrecarga del cuidador
> **E)** No se requiere ningún instrumento adicional, ya que el control es solo de la hipertensión
> Respuesta A. El APGAR familiar normal solo refleja la relación con el hijo cercano; no captura el aislamiento social del paciente, que vive solo, con hijos lejanos y sin participación comunitaria. El ecomapa es el instrumento diseñado justamente para graficar esas redes de apoyo externas y detectar el aislamiento.

2.01.3.006 Inmunizaciones en Chile (PNI y extra PNI)

Dónde se enseña: Tema 18.3 Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

QUÉ HAY QUE SABER

- PNI Chile: RN BCG y hepatitis B; 2 y 4 meses hexavalente y neumocócica conjugada; 6 meses hexavalente; 12 meses tresvírica (SRP), meningocócica conjugada y refuerzo neumocócico; 18 meses hexavalente, hepatitis A y varicela.
- Etapa preescolar/escolar: 2ª dosis de tresvírica y de varicela según calendario vigente, dTpa en 1º básico, VPH en 4º y 5º básico y dTpa en 8º básico. Embarazadas: dTpa desde las 28 semanas e influenza.
- Campañas anuales: influenza (6 meses a escolares, embarazadas, crónicos, ≥60 años) y nirsevimab (anticuerpo monoclonal anti VRS) a RN y lactantes en su primera temporada.
- Vacunas vivas: BCG, SRP, varicela, rotavirus, fiebre amarilla; contraindicadas en embarazo e inmunosupresión grave. Entre 2 vivas parenterales no simultáneas esperar 4 semanas.
- Falsas contraindicaciones: resfrío o fiebre baja, antibióticos en curso, prematurez (se vacuna por edad cronológica), alergia al huevo (no contraindica SRP ni influenza), lactancia.
- ESAVI deben notificarse; anafilaxia a dosis previa es contraindicación real de esa vacuna. Extra PNI: rotavirus, meningococo B, hepatitis A adicional, según indicación.

PREGUNTAS (17)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 93

Niño de 7 años es mordido por un perro callejero en el brazo derecho. **Además del manejo de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada respecto a la profilaxis de la rabia?**

A) Observar al niño por 10 días
B) Vacunar al niño solo si el perro presenta síntomas
C) Administrar la vacuna antirrábica al niño
D) Vacunar al niño solo si el perro muere
E) Administrar inmunoglobulina antirrábica al niño

Respuesta C. La normativa vigente indica vacunar de inmediato cuando el animal agresor no es observable, como ocurre con un perro callejero, independiente de si hubo o no provocación. La observación por 10 días se reserva para animales identificables y con dueño conocido.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 93

Un niño de 7 años es mordido por un perro callejero en el brazo derecho. **Además del manejo de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada respecto a la profilaxis de la rabia?**

A) Observar al niño por 10 días
B) Vacunar al niño solo si el perro presenta síntomas
C) Administrar la vacuna antirrábica al niño
D) Vacunar al niño solo si el perro muere
E) Administrar inmunoglobulina antirrábica al niño

Respuesta C. Perro callejero: no es ubicable ni se puede observar, así que se vacuna al niño de inmediato (esquema de 5 dosis). La inmunoglobulina se reserva para la exposición grave, como el contacto con murciélago.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 24

Niño con reacción anafiláctica al huevo hace 1 mes. **¿Qué vacuna está contraindicada?**

A) Triple viral (SRP)
B) Influenza inactivada
C) Hepatitis A
D) Varicela
E) Fiebre amarilla

Respuesta E. La vacuna antiamarílica se produce en huevo embrionado: la anafilaxia al huevo la contraindica. La triple viral se puede administrar en alérgicos al huevo.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 151

Un niño de 2 meses, con antecedente de haber nacido a las 34 semanas de gestación, acude a control. **¿En qué momento debe administrarse la vacuna antineumocócica conjugada?**

A) En este momento
B) En 4 semanas más
C) En 6 semanas más
D) A los 12 meses de edad
E) No debe administrarse

Respuesta A. El calendario de vacunas se administra según la edad cronológica, no la edad corregida por prematurez. La única excepción es la BCG, que espera a que el niño alcance un peso mínimo de 2.000 gramos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 67

Un niño de 9 meses debe vacunarse por primera vez contra la influenza. Tiene el antecedente de haber desarrollado un rash eritematoso en las dos oportunidades en que se le dio a probar huevo. **¿Cuál es la conducta más adecuada para su vacunación?**

A) Vacunar, de acuerdo al programa, sin cambios
B) Prohibir permanentemente la vacunación contra la influenza
C) Esperar la reacción ante la vacuna trivírica y decidir según aquello
D) Postergar la vacunación hasta que cumpla 24 meses
E) Realizar test cutáneo de alergia y decidir según resultado

Respuesta A. La alergia al huevo es una falsa contraindicación para las vacunas actuales contra la influenza y para la tresvírica. Solo son contraindicaciones reales las reacciones adversas graves a una dosis previa o la alergia grave y conocida a un componente de la vacuna.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 103

Un niño de 12 meses recibe sus vacunas según el Plan Nacional de Inmunizaciones, más una dosis de la vacuna pentavalente que estaba atrasada. Diez días después, presenta fiebre hasta 38 grados. **¿Qué vacuna es la responsable de la fiebre, con mayor probabilidad?**

A) Antimeningocócica
B) Antineumocócica
C) Trivírica
D) Pertusis
E) Anti-Haemophilus

Respuesta C. La pertusis, por ser un componente inactivado, produce fiebre de inmediato o al día siguiente. La trivírica, por ser de virus vivo, puede producir un cuadro febril entre 7 y 10 días después de administrada.

Pregunta de práctica

Lactante de 18 meses, con antecedente de haber nacido prematuro, está en tratamiento con corticoides sistémicos por un cuadro obstructivo bronquial recurrente severo. Su última vacuna fue la BCG, al nacer. La madre consulta para regularizar su calendario, que está atrasado desde entonces. **¿Qué vacuna está contraindicada mientras el niño reciba corticoides?**

A) Antineumocócica
B) Antimeningocócica
C) Tresvírica
D) Virus hepatitis A
E) Hexavalente

Respuesta C. Mientras el paciente reciba corticoides sistémicos en dosis inmunosupresoras, están contraindicadas las vacunas de virus vivo atenuado: tresvírica, varicela, fiebre amarilla y rotavirus oral. Las inactivadas, incluida la hexavalente, la antineumocócica, la antimeningocócica y la hepatitis A, se administran sin problema.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 123 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 2 meses, es traído por su madre a vacunarse. ¿Qué vacuna, fuera de las del Plan Nacional de Inmunizaciones, se le puede recomendar?

A) Rotavirus
B) Varicela
C) Pneumocócica polisacárida
D) Hepatitis A
E) Trivírica

Respuesta A. La varicela y hepatitis A sí se recomiendan, pero al año de edad. La neumocócica polisacárida, no sirve en niños menores de 2 años (por eso se da la conjugada).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 131 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 18 meses, con antecedente de haber nacido prematuro, está en tratamiento con cor8coides sistémicos debido a un cuadro de síndrome bronquial obstruc8vo recurrente severo. Su úl8ma vacunación fue con vacuna BCG, la que recibió poco 8empo después de nacer, por lo que su madre consulta para regularizar su calendario de vacunas. ¿Qué vacuna está contraindicada mientras permanezca u8lizando cor8coides?

A) An2neumocócica
B) An2meningocócica
C) Tres vírica
D) Virus hepa22s A
E) Hexavalente

Respuesta C. Están contraindicadas las vacunas a microorganismo vivo (tresvírica, varicela, fiebre amarilla, rotavirus oral). Sobre el esquema para ponerse al día en su calendario, se resume en “se ponen todas las vacunas pendientes juntas, esperando un mes para los refuerzos”. Por tanto, le corresponden las de los 2 meses, 12 meses y 18 meses (antineumocócica, hexavalente, antimeningocócica, hepaGGs A, con con

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 150 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 12 meses ha presentado un exantema eritematoso generalizado, en las dos ocasiones en que se ha introducido huevo a su dieta. No tiene otros antecedentes. ¿Qué conducta es la más adecuada, respecto a la vacuna trivírica?

A) Administrarla en este momento
B) Eliminarla de su esquema de vacunación
C) Administrarla a los 18 meses
D) Esperar a los 4 años para administrarla
E) Esperar a que esté en primero básico para administrarla

Respuesta A. La vacuna trivírica se administra a los 12 meses y luego se refuerza en primera básico (6 años, aunque desde el 2022 se cambió el refuerzo a los 3 años, junto con el de la varicela, cuya primera dosis es a los 18 meses). La alergia al huevo no contraindica ninguna vacuna actualmente.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 71 · texto original del banco, sin revisar

Un niño recibe sus vacunas a los 2 meses. Algunas horas después evoluciona con decaimiento, hiporreactividad, hipotonía, fiebre de 37,7°C, seguido de convulsiones generalizadas, autolimitadas, con palidez y llene capilar menor a 1 segundo. El cuadro dura dos horas y luego se recupera por completo. ¿Qué componente de la vacuna es causante de esta reacción, con mayor probabilidad?

A) Toxoide tetánico
B) Toxoide diftérico
C) VPO
D) VHIB
E) Pertusis celular

Respuesta E. La vacuna pertusis celular ya no se usa en Chile, precisamente porque tenía efectos adversos muy graves, como los ahí descritos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 67 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 4 meses acude a su control de niño sano. Tiene antecedente de una invaginación intestinal a los 2 meses, ¿cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en este paciente?

A) VPO
B) VPI
C) Rotavirus oral
D) Toxoide tetánico
E) Toxoide diftérico

Respuesta C. La opción correcta es la C (Rotavirus oral). En este escenario clínico, rotavirus oral se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 68 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 12 meses ha comido huevo en dos oportunidades y en ambas ha presentado un exantema eritematoso generalizado, sin otras manifestaciones. ¿Qué conducta es la más adecuada, respecto a la vacuna trivírica?

A) Administrarla en este momento
B) Eliminarla de su esquema de vacunación
C) Administrarla a los 18 meses
D) Esperar a los 4 años para administrarla
E) Esperar a que esté en primero básico para administrarla

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Administrarla en este momento (opción A). La alergia al huevo no contraindica ninguna vacuna.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 87 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 12 meses de edad, que a los 9 meses presentó un exantema, al introducir huevo a su alimentación por lo que fue suspendido, sin haberlo comido de nuevo. ¿Cuál es la conducta a tomar con repecho a la vacuna trivírica?

A) Aplicar a los 12 meses
B) Contraindicar la vacuna
C) Aplicar a los 18 meses
D) Diferir hasta los 2 años
E) Realizar IgE específica del huevo y decidir según resultado

Respuesta A. La alergia al huevo actualmente no es contraindicación de la vacuna trivírica, a menos que haya requerido hospitalización, caso en el que igualmente se da la vacuna, pero en el hospital, bajo observación.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 15 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 2 meses de edad, sin antecedentes perinatales, acude a control donde se le administran sus vacunas según el programa nacional de inmunizaciones, doce horas después presenta convulsión tonicoclónica generalizada que dura tres minutos evolucionando posteriormente en buenas condiciones. A futuro la conducta más adecuada con este paciente es:

A) No volver a vacunar.
B) Vacunar con DPT al año de vida
C) Continuar calendario de vacunación de forma normal
D) Indicar paracetamol durante la próxima vacunación
E) Reemplazar DPT con DPT acelular.

Respuesta E. Fue una reacción a la Pertusis celular. Se debe cambiar por acelular. Hoy se usa la pentavalente y no la DPT, sin embargo es la única respuesta correcta.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 2 · texto original del banco, sin revisar

¿Qué vacuna está contraindicada en un niño con antecedente de anafilaxia en relación a la ingesta de huevo?

A) Vacuna neumocócica conjugada
B) Vacuna tres vírica
C) Vacuna antimeningocócica
D) Vacuna antirrábica
E) Vacuna contra la fiebre amarilla

Respuesta C. La opción correcta es la C (Vacuna antimeningocócica). En este escenario clínico, vacuna antimeningocócica se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 37 · texto original del banco, sin revisar

67) Un lactante de 4 meses acude a su control de niño sano. Tiene antecedente de una invaginación intestinal a los 2 meses, ¿cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en este paciente?

A) VPO
B) VPI
C) Rotavirus oral
D) Toxoide tetánico
E) Toxoide diftérico

Respuesta C. La opción correcta es la C (Rotavirus oral). En este escenario clínico, rotavirus oral se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

2.01.3.007 Lactancia materna

Dónde se enseña: Tema 18.4 Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

QUÉ HAY QUE SABER

- Lactancia materna exclusiva 6 meses y complementada hasta los 2 años o más; inicio en la primera hora de vida con contacto piel a piel.
- Beneficios: niño (menos infecciones, diarrea, otitis, muerte súbita, obesidad, mejor desarrollo); madre (menos cáncer de mama y ovario, menor hemorragia posparto, espaciamiento de embarazos).
- Técnica: libre demanda (8-12 veces/día), buen acople (boca bien abierta, labio inferior evertido, más areola visible arriba, mentón tocando la mama); vaciar un pecho antes de ofrecer el otro.

- Problemas: grietas (corregir acople), congestión (vaciamiento frecuente), mastitis (continuar lactancia, cloxacilina o cefadroxilo + AINE), absceso (drenaje); hipogalactia: aumentar frecuencia.
- Contraindicaciones reales: VIH materno (en Chile), HTLV-1, galactosemia en el niño, quimioterapia, drogas de abuso; la mayoría de fármacos son compatibles. Hepatitis B, mastitis y fiebre no contraindican.
- Ley chilena: posnatal de 12 semanas + posnatal parental de 12 semanas; derecho a 1 hora diaria para alimentar hasta los 2 años; extracción y conservación de leche (refrigerador 3-5 días).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 109

Lactante de 3 meses, que pesa 7 kilos, alimentado con lactancia materna exclusiva a libre demanda. Su Peso para la Edad está en más 1 DE y su Peso para la Talla en más 2 DE. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Dar fórmula de relleno
B) Amamantar cada 4 horas
C) Dar agua entre cada toma
D) Mantener la lactancia materna a libre demanda
E) Suspender la lactancia nocturna

Respuesta D. Un Peso para la Talla de +2 DE corresponde a obesidad según los cortes de la OMS y el MINSAL. Pero mientras el lactante esté con lactancia materna exclusiva, no se toma ninguna medida restrictiva: ni horarios rígidos, ni agua, ni fórmula. Se mantiene la lactancia a libre demanda hasta los 6 meses.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 99 · texto original del banco, sin revisar

Usted atiende a un recién nacido de 10 días de vida, junto a su madre. Nació por parto vaginal sin complicaciones, pesando 3.200 gramos al nacer y 3.050 gramos al momento del alta. La madre refiere que presenta llanto frecuente y permanece constantemente prendido al pecho, por lo que sospecha que tiene dolor abdominal. Al examen físico, el niño llora vigorosamente y se observa en buen estado general. Su peso actual es de 3.350 gramos. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?

A) Agregar fórmula láctea después de cada toma
B) Indicar a la madre que suspenda el consumo de lácteos y reevaluar al niño
C) Citar a control en 24 horas
D) Reforzar la técnica de lactancia materna
E) Prescribir lactobacillus reuteri

Respuesta D. Peso en Recién Nacidos: Es normal que un recién nacido pierda hasta un 10% de su peso durante los primeros días de vida, el cual se recupera al cumplir los 7 días. Luego de la baja inicial, el incremento norma es de 20 a 25 g al día o más. En este caso, el recién nacido ha subido de peso adecuadamente, lo que sugiere que es un recién nacido normal. Por estar prendido al pecho todo el día, se asume

2.01.3.008 Prevención de accidentes

Dónde se enseña: ped-24

QUÉ HAY QUE SABER

- Accidentes (lesiones no intencionales): principal causa de muerte en niños >1 año en Chile; tipo según edad.
- Lactante: asfixia (sueño seguro boca arriba, sin objetos en cuna), caídas (mudador, camas), quemaduras por líquidos calientes; no dejar solo en tina.
- Preescolar: intoxicaciones (medicamentos y productos de limpieza bajo llave y en envases originales), ahogamiento por inmersión (piscinas cercadas, supervisión permanente), aspiración de cuerpos extraños (no frutos secos <4-5 años), caídas desde altura (mallas en ventanas).
- Escolar y adolescente: accidentes de tránsito (silla de auto según peso y talla hasta ~1,35-1,50 m y asiento trasero hasta 12 años; casco en bicicleta), lesiones deportivas, consumo de alcohol.
- Silla de auto mirando hacia atrás el mayor tiempo posible (al menos hasta los 2 años); ley chilena de sillas obligatoria según edad/talla.
- Consejería anticipatoria en cada control de salud según etapa del desarrollo; CITUC para orientación en intoxicaciones.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En el control de salud de un lactante de 6 meses, los padres preguntan cómo deben trasladarlo en el automóvil. **¿Cuál es la recomendación correcta?**

A) En brazos de un adulto en el asiento trasero
B) En silla de auto en el asiento delantero frente al airbag
C) En silla de auto mirando hacia adelante, en el asiento delantero
D) Con el cinturón de seguridad del adulto
E) En silla de auto mirando hacia atrás, en el asiento trasero

Respuesta E. Los accidentes son una causa principal de muerte en niños mayores de 1 año. Los lactantes deben viajar en un sistema de retención infantil mirando hacia atrás, en el asiento trasero, idealmente hasta los 2 años o más, porque protege cabeza y cuello. Nunca en brazos ni frente a un airbag activo.

2.01.3.009 Prevención de conductas de riesgo

Dónde se enseña: ped-28

QUÉ HAY QUE SABER

- Conductas de riesgo en adolescentes: consumo de tabaco, alcohol y drogas (marihuana), sexualidad no protegida, conducción riesgosa, violencia, conductas alimentarias de riesgo, uso problemático de pantallas.
- Pesquisa en control de salud del adolescente con entrevista confidencial (HEADSSS) y tamizaje CRAFFT para consumo de sustancias.
- Factores protectores: vínculo familiar, supervisión parental, escolaridad, actividades deportivas y recreativas, proyecto de vida, pares positivos.
- Salud sexual: educación, anticoncepción y preservativo (doble protección), acceso a consejería confidencial; anticoncepción de emergencia disponible.
- Intervención breve motivacional ante consumo; derivar a programa de salud mental o tratamiento de drogas (GES consumo perjudicial de alcohol y drogas en <20 años) si dependencia.
- Promoción: espacios amigables para adolescentes en APS, programa escolar de prevención (SENDA).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un adolescente de 15 años acude a control de salud. En la entrevista a solas, refiere que consume alcohol los fines de semana con sus amigos. No tiene síntomas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Informar inmediatamente a los padres
B) No abordar el tema porque no tiene síntomas
C) Derivar directamente a un centro de rehabilitación
D) Realizar tamizaje estructurado de consumo (ej. CRAFFT) e intervención breve motivacional
E) Solicitar test de drogas en orina sin su consentimiento

Respuesta D. La prevención de conductas de riesgo en adolescentes se basa en la entrevista confidencial (HEADSSS), el tamizaje estructurado de consumo de sustancias (CRAFFT) y la intervención breve con enfoque motivacional, ajustando el seguimiento al riesgo. La confidencialidad se mantiene salvo riesgo vital. Derivar a rehabilitación sin evaluar el nivel de consumo es desproporcionado.

2.01.3.010 Prevención de maltrato y abuso infantil

Dónde se enseña: Tema 21.13 Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

QUÉ HAY QUE SABER

- Maltrato infantil: físico, psicológico, negligencia, abuso sexual y exposición a violencia intrafamiliar; la prevención busca factores de riesgo antes de que ocurra.
- Factores de riesgo: padres jóvenes, depresión materna, consumo de alcohol/drogas, violencia en la pareja, aislamiento social, pobreza, embarazo no deseado; niño prematuro, con discapacidad o enfermedad crónica.
- Prevención primaria: Chile Crece Contigo (visitas domiciliarias, talleres de habilidades parentales «Nadie es Perfecto»), crianza respetuosa, apoyo a la lactancia y al vínculo.
- Educar en autocuidado corporal y diferenciar secretos buenos y malos; enseñar a pedir ayuda.
- Pesquisa en controles: lesiones no explicadas, cambios conductuales, retraso del desarrollo, inasistencia a controles.

- Ante sospecha: proteger, registrar y denunciar (obligación legal del médico) y activar la red (OPD, Tribunal de Familia, Fiscalía).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Una niña de 6 años es traída por su madre, quien relata que la niña le contó que un familiar le tocó los genitales. Al examen no hay lesiones físicas. **¿Cuál es la conducta más adecuada del médico?**
> **A)** Interrogar a la niña en detalle varias veces para confirmar el relato
> **B)** Descartar el abuso por la ausencia de lesiones
> **C)** Proteger a la niña, registrar el relato textual y realizar la denuncia dentro de las 24 horas
> **D)** Citar al familiar para confrontarlo
> **E)** Esperar a que la madre decida si denuncia
> Respuesta C. Ante sospecha de abuso sexual infantil, el médico debe proteger al niño, registrar textualmente lo relatado sin interrogatorios repetidos (para evitar revictimización) y denunciar: el Código Procesal Penal obliga a los profesionales de salud a hacerlo dentro de 24 horas. La ausencia de lesiones no descarta el abuso, que con frecuencia no deja hallazgos.

2.01.3.011 Promoción de salud y estilos de vida saludables

Dónde se enseña: Tema 18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Promoción de estilos de vida saludables: alimentación saludable (guías alimentarias chilenas), actividad física, sueño suficiente, salud mental y entornos libres de tabaco.
- Actividad física: ≥60 min/día de intensidad moderada a vigorosa en escolares y adolescentes; preescolares ≥3 h/día de actividad lúdica.
- Pantallas: evitar en <2 años; máximo 1 h/día en 2-5 años; limitar y supervisar en mayores; sin pantallas en el dormitorio ni antes de dormir.
- Alimentación: lactancia materna, evitar bebidas azucaradas y ultraprocesados (ley de etiquetado con sellos «alto en»), 5 porciones de frutas y verduras, agua como bebida principal.
- Sueño recomendado: lactantes 12-16 h, preescolares 10-13 h, escolares 9-12 h, adolescentes 8-10 h.
- Programas: Elige Vivir Sano, Chile Crece Contigo, escuelas promotoras de salud; consejería en cada control de salud.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> En el control de salud de un escolar de 8 años, la madre pregunta cuánta actividad física y tiempo frente a pantallas son recomendables. **¿Cuál es la recomendación correcta?**
> **A)** Al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa y limitar el tiempo recreativo frente a pantallas
> **B)** 30 minutos de actividad física 2 veces por semana
> **C)** Actividad física solo si tiene sobrepeso
> **D)** Pantallas sin límite si realiza deporte
> **E)** Evitar la actividad vigorosa antes de los 12 años
> Respuesta A. La OMS y MINSAL recomiendan que niños y adolescentes de 5 a 17 años realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa, incluyendo actividades de fortalecimiento muscular 3 veces por semana, y limitar el tiempo sedentario recreativo frente a pantallas (idealmente menos de 2 horas al día).

2.01.3.012 Psiquiatría de enlace

Dónde se enseña: ped-28

QUÉ HAY QUE SABER

- Psiquiatría de enlace pediátrica: atención de salud mental del niño hospitalizado o con enfermedad médica, y de su familia.
- Situaciones frecuentes: delirium (fluctuación de conciencia, inatención; tratar causa médica, medidas ambientales, haloperidol/risperidona en agitación), ansiedad y depresión en enfermedad crónica, intento suicida, trastornos de la conducta alimentaria, síntomas somáticos sin explicación médica.
- Trastornos de síntomas somáticos y conversivos: síntomas reales no explicados por enfermedad; evitar estudios excesivos, validar, rehabilitación funcional y psicoterapia.

- Adherencia a tratamiento en enfermedades crónicas (DM1, FQ, oncológicos): evaluar factores psicosociales y familiares.
- Preparación para procedimientos dolorosos, manejo del dolor y acompañamiento de los padres; cuidados paliativos pediátricos cuando corresponda.
- Interconsultar a psiquiatría infantojuvenil ante riesgo suicida, psicosis, delirium refractario o patología psiquiátrica que interfiere con el tratamiento médico.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Una adolescente de 14 años con diabetes mellitus tipo 1 ha tenido tres hospitalizaciones por cetoacidosis en 6 meses. Reconoce que omite dosis de insulina. Refiere ánimo bajo, aislamiento y conflictos familiares desde el diagnóstico. **Además de reforzar la educación en diabetes, ¿cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Aumentar la dosis de insulina basal
> **B)** Hospitalizar hasta que cumpla 18 años
> **C)** Indicar que cumpla mejor el tratamiento y control en 3 meses
> **D)** Cambiar a hipoglicemiantes orales
> **E)** Solicitar interconsulta a salud mental (psiquiatría de enlace) para evaluación integral
>
> Respuesta E. La mala adherencia en adolescentes con enfermedades crónicas se asocia frecuentemente a depresión, trastornos de la conducta alimentaria (omisión de insulina para bajar de peso) y conflictos familiares. La psiquiatría de enlace evalúa y trata en conjunto con el equipo tratante, mejorando el control metabólico.

2.01.3.013 Relación médico-paciente-familia

Dónde se enseña: Tema 21.11 Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Relación médico-paciente en pediatría es triangular: niño, familia y médico; los padres son los representantes legales, pero se respeta la autonomía progresiva del niño.
- Modelos: paternalista, informativo, deliberativo; preferir el modelo deliberativo/centrado en la familia con decisiones compartidas.
- Ley 20.584 de derechos y deberes de los pacientes: información veraz y comprensible, consentimiento informado, confidencialidad, trato digno, acompañamiento.
- Consentimiento informado de los padres y asentimiento del niño según su madurez; adolescente puede recibir consejería confidencial en salud sexual.
- Conflictos (rechazo de tratamiento vital, vacunas): dialogar, informar riesgos, buscar consenso; ante riesgo vital del niño, recurrir al comité de ética o tribunales.
- Empatía, comunicación clara, manejo de expectativas y continuidad de la atención fortalecen la adherencia.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un niño de 8 años llega a urgencia con hemorragia masiva tras un accidente y requiere transfusión inmediata para salvar su vida. Sus padres, por motivos religiosos, se oponen a la transfusión. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Respetar la decisión de los padres y no transfundir
> **B)** Transfundir, ya que en una urgencia con riesgo vital de un menor prima su derecho a la vida, informando y dejando registro
> **C)** Esperar una orden judicial antes de cualquier acción
> **D)** Trasladar al niño a otro centro
> **E)** Pedir al niño que decida
>
> Respuesta B. Los padres representan a sus hijos, pero su decisión debe resguardar el mejor interés del niño. La Ley 20.584 permite actuar sin consentimiento ante una urgencia con riesgo vital inminente. Se debe intentar dialogar con la familia, transfundir, registrar en la ficha y, si la situación no es urgente, solicitar autorización judicial o del comité de ética.

2.01.3.014 Salud infantil en Chile y el mundo

Dónde se enseña: Tema 21.7 Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Chile tiene indicadores de salud infantil comparables a países desarrollados: mortalidad infantil ~6-7 por 1.000 nacidos vivos, explicada principalmente por mortalidad neonatal.

- Causas de mortalidad infantil: afecciones perinatales (prematurez) y malformaciones congénitas; en >1 año, causas externas (accidentes) y cáncer.
- Logros históricos: control de enfermedades infecciosas y desnutrición gracias a PNI, PNAC, atención profesional del parto, saneamiento y educación materna.
- Problemas actuales: obesidad infantil (alta prevalencia en escolares, mapa nutricional JUNAEB), salud mental, maltrato, bajos indicadores de lactancia sostenida.
- Globalmente: principales causas de muerte en <5 años son complicaciones neonatales, neumonía, diarrea y malaria; Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir mortalidad neonatal y de <5 años.
- Programas chilenos: Chile Crece Contigo (sistema de protección integral a la infancia), programa nacional de salud de la infancia, GES pediátricos.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> En un informe sobre salud infantil en Chile se analiza la tasa de mortalidad infantil, que actualmente es cercana a 6 por 1.000. **¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad infantil y cuál es su principal causa en Chile?**
>
> **A)** Muertes de menores de 5 años por 1.000 habitantes; causa principal: infecciones respiratorias
> **B)** Muertes de menores de 1 año por 1.000 habitantes; causa principal: diarrea
> **C)** Muertes de menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos; causa principal: afecciones originadas en el período perinatal
> **D)** Muertes de menores de 28 días por 1.000 nacidos vivos; causa principal: accidentes
> **E)** Muertes fetales por 1.000 partos; causa principal: malformaciones
>
> Respuesta C. La tasa de mortalidad infantil es el número de muertes de menores de 1 año en un período, dividido por los nacidos vivos del mismo período, por 1.000. Chile tiene una de las tasas más bajas de Latinoamérica. Sus principales causas son las afecciones originadas en el período perinatal (prematurez) y las malformaciones congénitas; las infecciones disminuyeron drásticamente.

2.01.3.015 Salud oral

Dónde se enseña: Tema 21.2 Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos

QUÉ HAY QUE SABER

- Caries: enfermedad infecciosa (Streptococcus mutans) multifactorial, muy prevalente en Chile; caries temprana de la infancia asociada a mamadera nocturna con líquidos azucarados.
- Higiene: limpiar encías desde el nacimiento; cepillado desde la erupción del primer diente con pasta fluorada (≥1.000 ppm), cantidad tamaño grano de arroz en <3 años y arveja en ≥3 años, 2 veces al día, supervisado por adulto.
- Dieta: evitar azúcar y bebidas azucaradas, no dormir con mamadera, retirar mamadera cerca de los 12-18 meses.
- Fluoración del agua potable, barniz de flúor y sellantes en programas escolares; primer control odontológico desde la erupción o al año.
- Programa CERO (control con enfoque de riesgo odontológico) en <20 años y GES salud oral integral para niños de 6 años y embarazadas.
- Erupción: primer diente ~6 meses, dentición temporal completa (20) a los 2-3 años; primer molar definitivo a los 6 años; derivar si traumatismo dentario (avulsión de diente definitivo: reimplantar o transportar en leche).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Una madre consulta qué atención dental cubre el GES para su hijo. **¿Qué grupo de edad pediátrico tiene garantizada por el GES la salud oral integral?**
>
> **A)** Preescolares de 4 años solamente
> **B)** Lactantes de 6 meses
> **C)** Adolescentes de 15 años
> **D)** Todos los menores de 18 años
> **E)** Niños y niñas de 6 años
>
> Respuesta E. El GES incluye "Salud oral integral para niños y niñas de 6 años", que cubre examen, educación, prevención (sellantes, flúor) y tratamiento de caries, en el momento en que erupcionan los primeros molares definitivos. Otras garantías odontológicas son la salud oral de la embarazada y la urgencia odontológica ambulatoria.

2.01.3.016 Supervisión de salud- adolescente

Dónde se enseña: Tema 21.12 Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad

QUÉ HAY QUE SABER

- Control de salud integral del adolescente (10-19 años): anual en APS o en espacio amigable, con entrevista confidencial y ficha CLAP.
- Evaluar: crecimiento y estado nutricional (IMC), PA, desarrollo puberal (Tanner), agudeza visual, escoliosis (test de Adams), acné, salud oral.
- Pauta HEADSSS: hogar, educación, actividades, drogas (CRAFFT), sexualidad, suicidio/ánimo (tamizaje de depresión), seguridad (violencia, bullying, ciberacoso).
- Consejería: salud sexual y reproductiva (preservativo, anticoncepción), prevención de consumo de sustancias, alimentación y actividad física, uso de pantallas y sueño.
- Vacunas: dTpa en 8º básico, VPH, influenza según grupo; revisar esquema.
- Derivar ante riesgo suicida, consumo problemático, trastorno de conducta alimentaria, embarazo, violencia o abuso.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una adolescente de 15 años acude a control de salud con su madre. Usted planea aplicar la entrevista psicosocial HEADSSS. **¿Cuál es la forma más adecuada de realizar la entrevista?**

A) Una parte a solas con la adolescente, explicando la confidencialidad y sus límites
B) Siempre con la madre presente para validar la información
C) Solo con la madre, porque la adolescente es menor de edad
D) Por escrito, sin conversación
E) Prometer confidencialidad absoluta en cualquier circunstancia

Respuesta A. En el control de salud del adolescente se entrevista primero con el acompañante y luego a solas, explicando que la información es confidencial excepto si existe riesgo para su vida o la de otros, o abuso. La entrevista HEADSSS explora hogar, educación, actividades, drogas, sexualidad, suicidio y seguridad. Prometer confidencialidad absoluta es incorrecto.

2.01.3.017 Supervisión de salud- escolar

Dónde se enseña: Tema 18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Supervisión de salud del escolar (6-9 años): controles periódicos (al menos a los 6, 7, 8 y 9 años en APS o en el colegio, programa JUNAEB de salud escolar).
- Evaluar crecimiento (talla, IMC/E, curva), PA, agudeza visual (Snellen), audición, salud oral, postura y columna, desarrollo puberal precoz.
- Pesquisar rendimiento escolar, problemas de aprendizaje y atención (TDAH), conducta, bullying, ánimo, sueño y uso de pantallas.
- Vacunas escolares: dTpa en 1º y 8º básico y VPH en 4º-5º básico (revisar que tenga 2ª dosis de tresvírica y varicela); influenza según campaña.
- Consejería: alimentación saludable (colaciones sin ultraprocesados), ≥60 min/día de actividad física, prevención de accidentes (silla elevadora, casco), higiene dental, sexualidad y autocuidado.
- Derivar si talla baja, obesidad con comorbilidad, HTA, déficit visual/auditivo, problemas de aprendizaje o conducta.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En el control de salud de un niño de 7 años, sano, se revisan los exámenes y mediciones que deben realizarse. **¿Cuál de las siguientes mediciones debe incluirse en el control de salud del escolar?**

A) Radiografía de columna anual
B) Electrocardiograma anual
C) Hemograma anual
D) Presión arterial, al menos una vez al año desde los 3 años
E) Glicemia de ayuno anual

Respuesta D. El control de salud escolar incluye antropometría con diagnóstico nutricional, presión arterial (desde los 3 años, anual), agudeza visual y auditiva, salud bucal, desarrollo puberal, evaluación de escoliosis al examen físico y aspectos psicosociales y escolares. Los exámenes de laboratorio o radiografías no se solicitan de rutina en un niño sano.

2.01.3.018 Supervisión de salud- lactante

Dónde se enseña: Tema 18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Supervisión de salud del lactante: controles frecuentes (díada a los 7-10 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 18 meses) en el programa de salud infantil.
- Evaluar: antropometría con curvas OMS (peso, talla, perímetro craneano), desarrollo psicomotor (EEDP 8 y 18 meses), alimentación, examen físico completo.
- Pesquisas específicas: displasia de caderas (Ortolani-Barlow; Rx de pelvis a los 3 meses), reflejo rojo (cataratas, retinoblastoma), testículos, soplos, hernias; depresión posparto (Edimburgo a los 2 y 6 meses).
- Suplementos: vitamina D 400 UI/día hasta 12 meses; hierro desde los 4 meses (2 meses en prematuros); vacunas a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses; PNAC.
- Consejería: lactancia materna exclusiva, sueño seguro boca arriba, prevención de accidentes, estimulación, alimentación complementaria desde los 6 meses.
- Derivar ante falla de crecimiento, retraso del desarrollo, alteraciones del examen o factores de riesgo psicosocial (Chile Crece Contigo).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 17

Un lactante de 11 meses acude a control de niño sano, constatándose que aún no tiene ningún diente. El resto de su examen físico, así como su desarrollo psicomotor, es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Derivar al odontopediatra
B) Solicitar radiografía panorámica dentaria
C) Solicitar TSH plasmática
D) Solicitar niveles plasmáticos de vitamina D
E) Observar evolución y controlar en 2 meses

Respuesta E. La erupción del primer diente suele ocurrir alrededor de los 6 meses, pero tiene amplia variabilidad y puede retrasarse hasta los 12 a 15 meses en niños sanos. Con crecimiento y desarrollo normales, la conducta es observar. Se estudia (radiografía, causas sistémicas como hipotiroidismo o raquitismo) si no hay dientes a los 15 a 18 meses o hay otros hallazgos.

2.01.3.019 Supervisión de salud- pre-escolar

Dónde se enseña: Tema 18.2 Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Supervisión de salud del preescolar (2-5 años): controles a los 2, 3, 4 y 5 años en programa de salud infantil.
- Evaluar: crecimiento (P/T hasta 5 años y luego IMC/E, T/E), PA desde los 3 años, desarrollo psicomotor (TEPSI a los 3 años), lenguaje, conducta y control de esfínteres.
- Pesquisas: agudeza visual desde los 4 años (estrabismo, ambliopía), audición, salud oral (programa CERO), pie plano, fimosis, criptorquidia.
- Consejería: alimentación familiar saludable sin bebidas azucaradas, actividad física diaria, pantallas ≤1 h/día, sueño 10-13 h, prevención de accidentes (intoxicaciones, ahogamiento, silla de auto), crianza respetuosa.
- Revisar vacunas (incluida campaña influenza) y suplementación según necesidad.

- Derivar si retraso del desarrollo o lenguaje, malnutrición, problemas de conducta (berrinches extremos, TEA) o déficit sensorial.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un niño de 3 años acude a su control de salud en atención primaria. Corresponde evaluar su desarrollo psicomotor con un instrumento estandarizado. **¿Qué instrumento corresponde aplicar a esta edad?**
> **A)** EEDP (Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor)
> **B)** TEPSI (Test de Desarrollo Psicomotor)
> **C)** Test de Denver como único instrumento obligatorio
> **D)** Escala de Wechsler
> **E)** Score de Apgar
> Respuesta B. En Chile, el desarrollo psicomotor se evalúa con EEDP entre los 0 y 2 años (en controles de 8 y 18 meses) y con TEPSI entre los 2 y 5 años (en el control de 3 años), que evalúa coordinación, lenguaje y motricidad. Un resultado de riesgo o retraso requiere estimulación y reevaluación o derivación.

Exámenes e imagenología 26 códigos

2.01.4.001 Radiografía de tórax

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 18.7 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: sospecha de neumonía con dudas o gravedad, hospitalización, evolución tórpida, sospecha de complicación (derrame, neumotórax), cuerpo extraño, cardiopatía. No se requiere en NAC leve ambulatoria ni en bronquiolitis típica.
- Técnica: AP/PA de pie en mayores y AP en decúbito en lactantes; evaluar calidad (inspiración: 6 arcos anteriores, rotación, penetración).
- Hallazgos: condensación lobar con broncograma aéreo (neumococo), infiltrado intersticial difuso (virus, Mycoplasma), hiperinsuflación y atelectasias (bronquiolitis, asma), velamiento del seno costofrénico (derrame; decúbito lateral para cuantificar).
- Particularidades pediátricas: timo normal en lactantes (signo de la vela) no debe confundirse con condensación; neumonía redonda en niños.
- Cuerpo extraño: Rx en inspiración-espiración con atrapamiento aéreo unilateral; cardiopatías: cardiomegalia (índice cardiotorácico >0,6 en lactantes, >0,5 en niños), flujo pulmonar aumentado o disminuido, corazón en bota (Fallot), huevo en hilo (TGA).
- No pedir Rx de control de rutina en neumonía con buena evolución; solo si persisten síntomas, neumonía complicada o recurrente.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Niño de 3 años con diagnóstico clínico de neumonía, en tratamiento con amoxicilina oral en dosis alta. Tras 48 horas persiste con fiebre de 39 °C y dolor en el costado derecho. Al examen: FR 40 rpm, saturación 94%, matidez y murmullo pulmonar disminuido en la base derecha. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Cambiar a azitromicina oral y control en 48 horas
> **B)** Solicitar TAC de tórax ambulatoria
> **C)** Mantener la amoxicilina y esperar 48 horas más
> **D)** Agregar salbutamol inhalado
> **E)** Hospitalizar y solicitar radiografía de tórax por sospecha de derrame pleural
> Respuesta E. La radiografía de tórax no es de rutina en la neumonía infantil, pero está indicada si no hay respuesta a las 48 horas o se sospecha una complicación. Fiebre persistente con matidez y murmullo disminuido sugieren derrame pleural paraneumónico, que obliga a hospitalizar.

2.01.4.002 Radiografía de abdomen simple

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 6.3 Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: sospecha de obstrucción intestinal, perforación (neumoperitoneo), enterocolitis necrotizante, cuerpo extraño radioopaco ingerido, malformaciones digestivas neonatales.
- Proyecciones: AP en decúbito y de pie (o decúbito lateral con rayo horizontal en lactantes) para niveles hidroaéreos y aire libre.
- Obstrucción: asas dilatadas con niveles hidroaéreos y ausencia de gas distal; doble burbuja (atresia duodenal), triple burbuja (atresia yeyunal), ausencia de gas rectal (Hirschsprung, atresias).
- ECN: neumatosis intestinal (patognomónica), gas en vena porta, asa fija; neumoperitoneo (perforación) requiere cirugía.
- Invaginación: puede mostrar masa de partes blandas y escaso gas en fosa ilíaca derecha, pero la ecografía es el examen de elección. Constipación: no se requiere Rx para diagnosticar.
- Cuerpo extraño: pila de botón en esófago (doble halo) es urgencia endoscópica; imanes múltiples también.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un recién nacido con síndrome de Down presenta, a las 12 horas de vida, vómitos biliosos sin distensión abdominal. La madre tuvo polihidroamnios. La radiografía simple de abdomen muestra dos burbujas de aire (estómago y duodeno proximal) sin aire distal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Atresia duodenal
B) Estenosis hipertrófica del píloro
C) Enfermedad de Hirschsprung
D) Íleo meconial
E) Enterocolitis necrotizante

Respuesta A. El signo de la doble burbuja sin aire distal en la radiografía simple de abdomen, con vómitos biliosos precoces, polihidroamnios y síndrome de Down (asociación frecuente) es atresia duodenal. Se maneja con sonda nasogástrica, hidratación y duodeno-duodenostomía. La estenosis pilórica da vómitos no biliosos a las 3 a 6 semanas; Hirschsprung e íleo meconial dan distensión y múltiples asas dilatadas.

2.01.4.003 Ecotomografía abdominal

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de primera línea en pediatría: no irradia, no requiere sedación y está disponible.
- Indicaciones: dolor abdominal localizado (apendicitis: apéndice >6 mm no compresible), invaginación intestinal (signo de diana o pseudoriñón), estenosis hipertrófica del píloro (grosor muscular ≥3-4 mm, longitud ≥15-17 mm), masa abdominal.
- Riñón y vía urinaria: tras primera ITU febril (hidronefrosis, malformaciones, dilatación ureteral), hidronefrosis antenatal (realizar después de 48-72 h de vida), HTA, hematuria.
- Hígado y vía biliar: colestasia del lactante (signo del cordón triangular, vesícula ausente o pequeña en atresia de vías biliares), hepatomegalia, litiasis.
- Trauma abdominal: FAST para líquido libre en paciente inestable; TC en estables con sospecha de lesión de víscera sólida.
- Masa: diferenciar quística vs sólida, órgano de origen (Wilms renal vs neuroblastoma suprarrenal); el informe orienta la derivación a especialista.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 10 meses, sin antecedentes, con su primer episodio de infección urinaria febril, confirmado por urocultivo tomado por sondeo vesical. Evolucionó afebril a las 36 horas de tratamiento y completó el antibiótico. No tiene antecedentes prenatales de malformaciones. **¿Cuál es el estudio de imágenes más adecuado?**

A) Ninguno, porque respondió bien al tratamiento
B) Ecografía renal y vesical
C) Uretrocistografía miccional como primer examen
D) TAC de abdomen y pelvis
E) Radiografía simple de abdomen

Respuesta B. A todo niño con una primera infección urinaria febril comprobada se le pide ecografía renal y vesical, para buscar malformaciones y dilatación de la vía urinaria. La uretrocistografía se reserva para cuando la ecografía sale alterada o el cuadro es atípico o recurrente.

2.01.4.004 Radiografía de cavum

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 14.15 Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Radiografía de cavum (lateral de nasofaringe): evalúa el tamaño del tejido adenoideo en relación con el espacio aéreo nasofaríngeo.
- Indicación: sospecha de hipertrofia adenoidea con respiración bucal, ronquido, voz nasal, otitis media recurrente o con efusión, sinusitis recurrente; en niños >2-3 años.
- Interpretación del informe: relación adenoide/nasofaringe (A/N): >0,6-0,7 indica hipertrofia obstructiva significativa.
- Limitaciones: imagen estática, irradia; la nasofibroscopía es el estándar para evaluar obstrucción dinámica.
- Hipertrofia significativa sintomática: derivar a ORL para evaluar adenoidectomía; leve-moderada: corticoide intranasal por 6-12 semanas.
- No reemplaza la polisomnografía para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 4 años ronca todas las noches, respira por la boca, tiene voz nasal y rinorrea persistente. Sus padres han notado pausas respiratorias durante el sueño. A la orofaringe las amígdalas son pequeñas. **¿Qué examen permite evaluar el tamaño del tejido adenoideo?**

A) Radiografía de senos paranasales
B) Radiografía de tórax
C) Radiografía lateral de cavum
D) TAC de cerebro
E) Audiometría

Respuesta C. Ronquido, respiración bucal, voz nasal y apneas con amígdalas pequeñas sugieren hipertrofia adenoidea. La radiografía lateral de cavum permite estimar la relación adenoides/nasofaringe y la obstrucción de la vía aérea; también puede usarse la nasofibroscopía. Con SAHOS y adenoides obstructivos, el tratamiento es la adenoidectomía (o adenoamigdalectomía).

2.01.4.005 Radiografía de cráneo

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- Rx de cráneo tiene utilidad limitada; en TEC la TC es el examen de elección cuando está indicada (reglas PECARN).
- Indicaciones actuales: evaluación de craneosinostosis (cierre prematuro de suturas, forma craneal anormal), serie ósea en sospecha de maltrato en <2 años, sospecha de fractura deprimida en lactante cuando no se dispone de TC.
- Hallazgos en el informe: fracturas lineales o deprimidas, suturas cerradas o diastasadas (hipertensión endocraneana), lesiones líticas (histiocitosis de células de Langerhans), calcificaciones.

- Una Rx normal no descarta lesión intracraneana: no usar para decidir alta en TEC con criterios de riesgo.
- Fractura de cráneo en lactante sin mecanismo explicado: sospechar maltrato y completar estudio (TC, fondo de ojo, serie ósea).
- Plagiocefalia posicional (aplanamiento occipital con oreja desplazada hacia adelante) es clínica y no requiere Rx; craneosinostosis sí se deriva a neurocirugía.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un niño de 3 años se cae de una silla de 50 cm de altura y se golpea la frente. No perdió la conciencia, no ha vomitado, está activo, juega con normalidad, tiene Glasgow 15 y solo un pequeño hematoma frontal. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la radiografía de cráneo?**
>
> **A)** Solicitar radiografía de cráneo para descartar fractura
> **B)** Solicitar radiografía y TAC de cerebro
> **C)** Solicitar radiografía de cráneo y, si es normal, dar el alta
> **D)** Solicitar radiografía de cráneo y columna cervical
> **E)** No solicitar radiografía: observar y dar indicaciones de alarma
>
> Respuesta E. La radiografía de cráneo no se recomienda en el TEC pediátrico: una radiografía normal no descarta lesión intracraneana y una fractura no siempre la implica. En un TEC leve de bajo riesgo (mecanismo menor, Glasgow 15, sin pérdida de conciencia, vómitos ni hematoma no frontal), se observa y se educa sobre signos de alarma.

2.01.4.006 Radiografía de edad ósea

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Radiografía de mano y muñeca izquierda AP: estima la maduración ósea comparando con atlas (Greulich y Pyle) o método TW.
- Indicaciones: talla baja, talla alta, pubertad precoz o retrasada, evaluación del crecimiento remanente.
- Edad ósea retrasada (>2 DE o >2 años): retraso constitucional del crecimiento, hipotiroidismo, déficit de GH, desnutrición, enfermedades crónicas, Cushing.
- Edad ósea concordante con edad cronológica: talla baja familiar (variante normal). Adelantada: pubertad precoz, hiperplasia suprarrenal congénita, obesidad, hipertiroidismo.
- Permite predecir la talla adulta y el potencial de crecimiento remanente.
- Interpretación junto con curva de crecimiento y talla diana; derivar a endocrinología infantil si discordancia patológica.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un niño de 10 años consulta por talla baja. Crece en el percentil 3 con velocidad de crecimiento normal y está sano. Su padre mide 160 cm y su madre 148 cm. Se solicita radiografía de carpo para edad ósea. **Si el diagnóstico es talla baja familiar, ¿cuál es el resultado esperado de la edad ósea?**
>
> **A)** Retrasada en más de 2 años respecto de la edad cronológica
> **B)** Muy retrasada con epífisis abiertas e irregulares
> **C)** Adelantada en más de 2 años
> **D)** Acorde a la edad cronológica
> **E)** No es posible estimarla antes de la pubertad
>
> Respuesta D. La edad ósea ayuda a diferenciar las variantes normales de talla baja. En la talla baja familiar la edad ósea concuerda con la cronológica, la velocidad de crecimiento es normal y la talla es acorde a la talla diana. En el retraso constitucional la edad ósea está retrasada y la pubertad será tardía.

2.01.4.007 Radiografía de pelvis anteroposterior

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 18.22 Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik

QUÉ HAY QUE SABER

- Radiografía de pelvis AP: tamizaje universal de displasia del desarrollo de caderas a los 3 meses en Chile (GES), cuando aparece el núcleo de osificación o se puede medir el acetábulo.
- Antes de los 3 meses la ecografía es de elección (cabeza femoral cartilaginosa) si hay factores de riesgo o examen alterado.
- Parámetros: línea de Hilgenreiner (horizontal por cartílagos trirradiados) y Perkins (vertical por borde acetabular): cuadrantes de Putti; cabeza en cuadrante superoexterno indica luxación.
- Índice acetabular aumentado (>30° a los 3 meses) indica displasia; arco de Shenton roto sugiere subluxación/luxación; retraso o asimetría del núcleo de osificación.
- Otras indicaciones: cojera en niños mayores (Perthes: necrosis avascular de la cabeza femoral en 4-8 años; epifisiólisis en adolescentes obesos: pedir también proyección de Lauenstein/rana).
- Informe alterado: derivar a traumatología infantil.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Lactante femenina de 3 meses, nacida de término en presentación podálica. En su control sano, la cadera está estable al examen, sin resaltos. Se toma radiografía de pelvis por la Garantía Explícita en Salud: cadera derecha con núcleo en cuadrante ínfero-interno e índice acetabular de 26 grados; cadera izquierda con núcleo en cuadrante súpero-externo, índice acetabular de 38 grados y arco de Shenton roto. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Mantener controles habituales, ya que el examen físico es normal
> **B)** Derivar a traumatología infantil e instalar correas de Pavlik
> **C)** Indicar doble pañal y control ecográfico en un mes
> **D)** Solicitar resonancia magnética de caderas antes de decidir
> **E)** Programar osteotomía femoral de urgencia
>
> Respuesta B. La radiografía muestra displasia franca en la cadera izquierda (núcleo súpero-externo, índice acetabular sobre 30 y arco de Shenton roto), a pesar de que el examen físico ya no la detecta a esta edad. La conducta es derivar y comenzar de inmediato con correas de Pavlik, el estándar en menores de 6 meses.

2.01.4.008 Radiografía de senos paranasales

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 14.10 Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Rx de senos paranasales (Waters) tiene baja sensibilidad y especificidad; no se recomienda de rutina para diagnosticar sinusitis aguda, que es clínica.
- Desarrollo de senos: etmoidales y maxilares presentes desde el nacimiento (visibles radiológicamente después de 1 año en maxilares), esfenoidales hacia los 5 años y frontales a los 6-10 años; no interpretar senos frontales en niños pequeños.
- Hallazgos compatibles con sinusitis: nivel hidroaéreo, opacificación completa o engrosamiento mucoso >4 mm; pueden encontrarse en resfrío común.
- Indicaciones limitadas: sinusitis recurrente o crónica (preferir TC), sospecha de complicación (TC con contraste de órbita y senos), cuerpo extraño.
- Celulitis orbitaria o complicación intracraneana: TC urgente, no Rx.
- Interpretar siempre en contexto clínico: imagen anormal sin síntomas no indica antibiótico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 6 años presenta rinorrea purulenta y tos diurna persistente de 12 días de evolución, sin mejoría. Está afebril y en buenas condiciones generales, sin edema periorbitario. La madre pide una radiografía de senos paranasales. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la radiografía?**

A) Solicitarla para confirmar el diagnóstico de sinusitis
B) Solicitar radiografía y esperar el resultado para indicar antibiótico
C) Solicitar TAC de senos paranasales
D) No solicitarla: el diagnóstico de rinosinusitis aguda es clínico
E) Solicitar resonancia magnética

Respuesta D. La rinosinusitis bacteriana aguda en niños se diagnostica clínicamente: síntomas persistentes más de 10 días sin mejoría, empeoramiento tras mejoría inicial o inicio grave. La radiografía de senos paranasales no se recomienda porque tiene baja especificidad (se altera en resfríos comunes) y los senos están en desarrollo. La TAC se reserva para sospecha de complicaciones orbitarias o intracraneanas.

2.01.4.009 Radiografía esófago- estómago- duodeno

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 6.3 Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Esófago-estómago-duodeno (EED) con contraste baritado: evalúa anatomía del tubo digestivo alto, no es el examen diagnóstico de reflujo.
- Indicaciones: sospecha de malrotación intestinal (ángulo de Treitz mal posicionado; vólvulo en «tirabuzón»), vómitos persistentes o biliosos, disfagia, estenosis esofágica, anillos vasculares (impronta posterior), acalasia, fístula traqueoesofágica en H.
- Reflujo gastroesofágico: el EED puede mostrar reflujo, pero su presencia no confirma ERGE; diagnóstico es clínico o con pH-impedanciometría.
- Estenosis hipertrófica del píloro: signo de la cuerda, aunque la ecografía es de elección.
- Contraindicado en sospecha de perforación (usar contraste hidrosoluble); precaución con aspiración en lactantes con trastorno de deglución.
- Malrotación con vólvulo en informe es urgencia quirúrgica: derivar de inmediato a cirugía infantil.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un lactante de 3 semanas, previamente sano, presenta en forma brusca vómitos biliosos (verdes), irritabilidad y leve distensión abdominal. Está hemodinámicamente estable. **¿Cuál es el examen más adecuado para descartar la causa más grave?**

A) Radiografía de esófago, estómago y duodeno con contraste (tránsito intestinal alto)
B) Ecografía pilórica
C) pH-metría esofágica
D) Endoscopía digestiva alta
E) Control ambulatorio en 48 horas

Respuesta A. Vómitos biliosos en un lactante son una emergencia quirúrgica hasta descartar malrotación intestinal con vólvulo del intestino medio, que puede llevar a necrosis intestinal en horas. El examen de elección, si el paciente está estable, es la radiografía de esófago, estómago y duodeno con contraste, que muestra la posición anormal del ángulo de Treitz o la imagen en sacacorchos.

2.01.4.010 Citoquímico de líquido cefaloraquídeo y pleural

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

QUÉ HAY QUE SABER

- LCR normal (>2 meses): <5 leucocitos/mm³ (hasta 20-30 en RN), glucosa >40 mg/dL o >60% de la glicemia, proteínas <40 mg/dL (hasta 150 en RN).
- Meningitis bacteriana: >1.000 células con predominio PMN, glucosa baja, proteínas altas; Gram, cultivo, látex o PCR. Viral: <500 células con predominio mononuclear (puede iniciar con PMN), glucosa normal, proteínas normales o levemente altas.

- Tuberculosa: pleocitosis linfocitaria, glucosa muy baja, proteínas muy altas (>100), ADA elevada; punción traumática: corregir 1 leucocito por cada 500-1.000 GR.
- Líquido pleural: criterios de Light para exudado (proteínas pleura/suero >0,5, LDH pleura/suero >0,6 o LDH >2/3 del límite normal sérico).
- Derrame paraneumónico complicado/empiema: pH <7,2, glucosa <40 mg/dL, LDH >1.000 UI/L, pus o Gram/cultivo positivo: requiere drenaje pleural.
- Interpretar con glicemia simultánea y antes de antibióticos; enviar citoquímico, Gram y cultivo siempre.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un niño de 5 años con neumonía en tratamiento antibiótico persiste febril al cuarto día. La radiografía muestra derrame pleural moderado. Se realiza toracocentesis, que obtiene líquido turbio con pH 7,0, glucosa 25 mg/dL y LDH 1.800 UI/L. La tinción de Gram muestra cocáceas grampositivas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Mantener el mismo antibiótico y controlar con radiografía en 1 semana
> **B)** Agregar corticoides sistémicos
> **C)** Instalar drenaje pleural y mantener antibiótico endovenoso
> **D)** Repetir la toracocentesis en 1 semana
> **E)** Cambiar a antibiótico oral y alta
>
> Respuesta C. Un líquido pleural con pH menor a 7,2, glucosa menor a 40 mg/dL, LDH muy elevada o gérmenes en el Gram (o pus) corresponde a derrame paraneumónico complicado o empiema. Requiere drenaje pleural con tubo (eventualmente con fibrinolíticos o videotoracoscopía) además de antibiótico endovenoso. El neumococo es el agente más frecuente en niños.

2.01.4.011 Cultivos y antibiograma

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Cultivo identifica el agente y el antibiograma su susceptibilidad (sensible, intermedio, resistente; CIM); permite ajustar el antibiótico empírico.
- Urocultivo: positivo con ≥100.000 UFC/ml en segundo chorro, ≥10.000 (o ≥50.000) en sondeo y cualquier recuento en punción suprapúbica; bolsa recolectora solo sirve si es negativa. Polimicrobiano sugiere contaminación.
- Hemocultivos: tomar 2 muestras antes del antibiótico (1-3 ml en lactantes); S. coagulasa negativo en una sola muestra suele ser contaminante.
- Cultivo faríngeo para S. pyogenes (estándar), coprocultivo en disentería, cultivo de LCR y líquido articular; Gram orienta mientras llega el cultivo.
- Ajustar a espectro más estrecho según antibiograma (desescalar); no tratar colonización (ej. bacteriuria asintomática en niño sin síntomas).
- Patrones de resistencia: E. coli resistente a ampicilina y cotrimoxazol frecuente; SAMR adquirido en la comunidad (clindamicina, cotrimoxazol); BLEE requiere carbapenémico o según antibiograma.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un lactante de 8 meses con fiebre de 39 °C sin foco tiene orina completa con leucocituria y nitritos positivos. El urocultivo, tomado por cateterismo vesical, informa Escherichia coli 50.000 UFC/mL, sensible a cefalosporinas de primera generación y resistente a ampicilina. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**
>
> **A)** Contaminación, porque es menor a 100.000 UFC/mL
> **B)** Es necesario un hemocultivo para confirmar
> **C)** Bacteriuria asintomática que no requiere tratamiento
> **D)** Debe repetirse con bolsa recolectora
> **E)** Infección urinaria confirmada
>
> Respuesta E. El punto de corte del urocultivo depende de la técnica: por punción suprapúbica cualquier recuento; por cateterismo vesical 10.000 UFC/mL o más (algunos usan 50.000); por segundo chorro 100.000 o más. Con fiebre, sedimento inflamatorio y 50.000 UFC/mL por cateterismo, la ITU está confirmada. El antibiograma permite ajustar el tratamiento, en este caso a cefalosporina.

2.01.4.012 Electrocardiograma

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: ped-23

QUÉ HAY QUE SABER

- ECG pediátrico cambia con la edad: en RN predomina el ventrículo derecho (eje a la derecha +60 a +180°, onda R alta en V1, T positiva en V1 en la primera semana y luego negativa hasta la adolescencia).
- FC normal: RN 100-180 lpm, lactante 100-160, preescolar 80-120, escolar 70-110; arritmia sinusal respiratoria es normal.
- Taquicardia supraventricular: FC >220 en lactante o >180 en niño, QRS estrecho, RR fijo, sin P visible; taquicardia sinusal tiene P y variabilidad, FC <220.
- Indicaciones: síncope, palpitaciones, dolor torácico con ejercicio, soplo patológico, cardiopatía, trastornos electrolíticos, intoxicaciones, antes de metilfenidato si hay riesgo cardíaco.
- Hallazgos de riesgo: QT largo (QTc >460 ms), preexcitación (PR corto, onda delta: WPW), Brugada, bloqueo AV, hipertrofia ventricular.
- Electrolitos: hiperkalemia con T picudas y QRS ancho; hipokalemia con onda U; hipocalcemia con QT largo. Alterado: derivar a cardiología infantil.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un adolescente de 14 años consulta por episodios de palpitaciones de inicio y término brusco. Entre crisis, el electrocardiograma muestra intervalo PR corto, onda delta (empastamiento inicial del QRS) y QRS levemente ensanchado. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Bloqueo auriculoventricular de primer grado
B) Síndrome de Wolff-Parkinson-White
C) Síndrome de QT largo
D) Hipertrofia ventricular izquierda
E) Bloqueo completo de rama derecha

Respuesta B. PR corto con onda delta y QRS ancho es la preexcitación ventricular por una vía accesoria (síndrome de Wolff-Parkinson-White) que, junto a taquicardias paroxísticas, constituye una causa importante de taquicardia supraventricular en niños. Debe derivarse a cardiología para estratificación y eventual ablación, por riesgo de muerte súbita si se asocia a fibrilación auricular.

2.01.4.013 Electrolitos plasmáticos

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 2.3 Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Valores normales: Na 135-145 mEq/L, K 3,5-5,5 mEq/L (más alto en RN), Cl 98-106 mEq/L, HCO3 22-26 mEq/L.
- Indicaciones: deshidratación moderada-grave o con fluidoterapia EV, vómitos persistentes, convulsiones, compromiso de conciencia, enfermedad renal, CAD, uso de diuréticos.
- Hiponatremia: SIADH (meningitis, neumonía, postoperatorio), pérdidas digestivas con aporte hipotónico, intoxicación hídrica; síntomas neurológicos si <125 o caída rápida.
- Hipernatremia: deshidratación con pérdida de agua libre, preparación concentrada de fórmula, diabetes insípida; corrección lenta (≤10-12 mEq/L/día).
- Hipokalemia: diarrea, vómitos (alcalosis), diuréticos, insulina; hiperkalemia: falla renal, hemólisis de la muestra (pseudohiperkalemia), hiperplasia suprarrenal congénita (con hiponatremia).
- Anión gap = Na - (Cl + HCO3): elevado en CAD, acidosis láctica, intoxicaciones; normal en diarrea y acidosis tubular. Corregir siempre en contexto clínico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un lactante de 6 meses con diarrea de 4 días llega irritable, con piel pastosa y signos de deshidratación moderada. Los electrolitos plasmáticos muestran Na+ 162 mEq/L, K+ 3,8 mEq/L y Cl- 128 mEq/L. **¿Cuál es el principio más importante del tratamiento?**

A) Corregir el sodio en 4 a 6 horas con suero glucosado al 5%
B) Administrar bicarbonato de sodio
C) Administrar furosemida
D) Restringir completamente el aporte de agua
E) Descenso lento del sodio, no más de 10 a 12 mEq/L por día, por riesgo de edema cerebral

Respuesta E. En la deshidratación hipernatrémica, las neuronas generan osmoles idiógenos para protegerse. Si el sodio baja rápidamente, entra agua a las células y se produce edema cerebral y convulsiones. Por ello la corrección debe ser lenta: descenso máximo de 10 a 12 mEq/L en 24 horas, reponiendo el déficit en 48 a 72 horas, con controles frecuentes de electrolitos.

2.01.4.014 Gases en sangre arterial

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 18.5 Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Valores normales arteriales: pH 7,35-7,45, PaCO2 35-45 mmHg, HCO3 22-26 mEq/L, PaO2 80-100 mmHg (con aire ambiente), BE ±2.
- Interpretación ordenada: pH (acidemia/alcalemia), trastorno primario (PaCO2 respiratorio, HCO3 metabólico), compensación esperada y anión gap.
- Acidosis respiratoria: hipoventilación (agotamiento en asma o bronquiolitis, depresión del SNC, neuromuscular); PaCO2 normal o alta en crisis asmática grave es signo de agotamiento.
- Acidosis metabólica: diarrea (AG normal), shock, CAD, IRA (AG alto); alcalosis metabólica: vómitos, estenosis pilórica; alcalosis respiratoria: hiperventilación, ansiedad, inicio de crisis asmática.
- Insuficiencia respiratoria: PaO2 <60 mmHg (tipo I) o PaCO2 >50 mmHg con acidosis (tipo II).
- Gases venosos o capilares sirven para pH y PaCO2 (no PaO2); la saturometría monitoriza la oxigenación de forma no invasiva.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un lactante de 10 meses con síndrome bronquial obstructivo lleva 3 horas en tratamiento con salbutamol y oxígeno. Está cada vez más somnoliento, con menor esfuerzo respiratorio y murmullo pulmonar disminuido. Los gases arteriales muestran pH 7,22, PaCO2 62 mmHg, HCO3- 24 mEq/L y PaO2 58 mmHg. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A) Acidosis respiratoria aguda con hipoxemia: falla respiratoria global
B) Alcalosis respiratoria compensada
C) Acidosis metabólica compensada
D) Gases normales para la edad
E) Alcalosis metabólica

Respuesta A. pH bajo con PaCO2 elevada y bicarbonato normal es acidosis respiratoria aguda (sin compensación renal). Junto con hipoxemia, somnolencia y menor esfuerzo, indica insuficiencia respiratoria global por agotamiento. En una obstrucción bronquial, una PaCO2 normal o alta es signo de gravedad. Requiere unidad de paciente crítico y probable soporte ventilatorio.

2.01.4.015 Hemograma

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: ped-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Valores varían con la edad: RN con Hb alta (14-22 g/dL) y leucocitosis; nadir fisiológico de Hb a los 2-3 meses (~9-11 g/dL); linfocitos predominan entre 1 mes y 4-5 años (fórmula invertida).
- Anemia: Hb <11 g/dL (6 m-5 años), <11,5 (5-11 años), <12 (12-14 años); VCM orienta: microcítica (ferropenia, talasemia), normocítica (hemólisis, pérdida aguda, ERC), macrocítica (déficit de B12/folato, hipotiroidismo, medicamentos).

- Reticulocitos altos: hemólisis o sangrado (regenerativa); bajos: falla medular o déficit de sustratos.
- Leucocitosis con neutrofilia y desviación a izquierda: infección bacteriana; linfocitosis con atípicos: VEB; linfocitosis marcada: coqueluche; eosinofilia: alergia, parásitos.
- Neutropenia: leve 1.000-1.500, moderada 500-1.000, grave <500/mm³; trombocitopenia <150.000 (PTI si aislada).
- Banderas rojas: bicitopenia o pancitopenia, blastos en frotis (leucemia), esquistocitos (SHU, microangiopatía): derivar urgente.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un lactante de 14 meses, sano, tiene un hemograma solicitado en su control: hemoglobina 11,8 g/dL, leucocitos 10.500/mm3 con 30% de neutrófilos y 62% de linfocitos, y plaquetas 320.000/mm3. El frotis no muestra células anormales. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A) Sugiere leucemia linfática; derivar a hematología
B) Hemograma normal para la edad
C) Neutropenia grave que requiere estudio
D) Infección viral que requiere tratamiento
E) Anemia que requiere suplementar hierro

Respuesta B. En lactantes y preescolares predominan normalmente los linfocitos en la fórmula leucocitaria; esta inversión fisiológica se mantiene aproximadamente hasta los 4 a 6 años. Con 30% de neutrófilos de 10.500 leucocitos, el recuento absoluto (3.150/mm3) es normal. La hemoglobina es normal a esta edad (mayor a 11 g/dL), igual que las plaquetas.

2.01.4.016 Orina completa

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Orina completa: examen físico (color, densidad), químico (tira reactiva) y sedimento microscópico.
- ITU: leucocituria (>5-10 leucocitos/campo), nitritos positivos (alta especificidad, baja sensibilidad en lactantes que orinan seguido), bacteriuria; siempre confirmar con urocultivo bien tomado.
- Hematuria: ≥5 GR/campo; GR dismórficos y cilindros hemáticos sugieren origen glomerular (GNAPE, nefropatía IgA).
- Proteinuria: tira ≥1+ (30 mg/dL); cuantificar con índice proteinuria/creatininuria en muestra aislada (normal <0,2; nefrótico >2). Proteinuria ortostática benigna en adolescentes.
- Glucosuria: diabetes o tubulopatía; cetonuria: ayuno, CAD; densidad baja persistente: diabetes insípida, ERC.
- Muestra: segundo chorro con aseo genital; sondeo o punción suprapúbica en lactantes para urocultivo; procesar dentro de 1 h o refrigerar.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 7 meses, sin antecedentes, con fiebre de hasta 39 °C de 2 días de evolución, decaimiento e inapetencia, sin síntomas respiratorios ni digestivos. Examen físico reactivo, salvo por la fiebre. Se instala bolsa recolectora perineal: el sedimento muestra leucocitos y bacterias abundantes. **¿Cuál es la conducta más adecuada antes de iniciar el tratamiento antibiótico?**

A) Iniciar cefadroxilo oral con el resultado de la bolsa recolectora
B) Realizar sondeo vesical para tomar un urocultivo confirmatorio
C) Esperar 48 horas sin tratamiento a que la bolsa confirme el diagnóstico
D) Solicitar cintigrama DMSA de urgencia
E) Dar el alta, porque la bolsa recolectora siempre contamina

Respuesta B. La bolsa recolectora tiene una tasa de falsos positivos demasiado alta para confirmar o tratar. Con un sedimento alterado, la norma exige confirmar con sondeo vesical o punción suprapúbica antes de iniciar antibióticos.

2.01.4.017 Parasitológico de deposiciones

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 6.1 Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Parasitológico seriado de deposiciones (PSD): 3 muestras en días alternos en fijador (PAF); detecta quistes, huevos y trofozoítos de protozoos y helmintos.
- Indicaciones: diarrea prolongada o crónica, dolor abdominal recurrente, malabsorción, eosinofilia, anemia ferropriva sin causa, prurito anal.
- Hallazgos más frecuentes: Blastocystis hominis (patogenicidad discutida, tratar si sintomático), Giardia lamblia (metronidazol, tinidazol), Entamoeba histolytica, Cryptosporidium (inmunodeprimidos).
- Comensales no patógenos (Entamoeba coli, Endolimax nana) no requieren tratamiento, pero indican contaminación fecal-oral.
- Oxiuros no se detectan bien en PSD: usar test de Graham (cinta adhesiva perianal en la mañana antes del aseo, 3 días).
- Resultado negativo no descarta Giardia (excreción intermitente): considerar antígeno fecal; tratar a convivientes en oxiuros.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 4 años que asiste a jardín infantil presenta deposiciones blandas, malolientes y flotantes, distensión abdominal y meteorismo desde hace 4 semanas, con baja de peso leve. Hay casos similares en su sala. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico más probable?**

A) Coprocultivo
B) Test de Graham
C) Parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras)
D) Rotavirus en deposiciones
E) Colonoscopía

Respuesta C. Diarrea crónica malabsortiva (esteatorreica, maloliente) con meteorismo en un niño de jardín, con casos en su sala, sugiere giardiasis, la parasitosis intestinal más frecuente en Chile. Se diagnostica con parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras en días alternos, por la excreción intermitente de quistes) o antígeno en deposiciones. Se trata con metronidazol, tinidazol o nitazoxanida.

2.01.4.018 Perfil bioquímico

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 7.19 Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo

QUÉ HAY QUE SABER

- Perfil bioquímico incluye glicemia, BUN, creatinina, ácido úrico, calcio, fósforo, proteínas totales, albúmina, colesterol, bilirrubina, transaminasas, fosfatasas alcalinas, LDH.
- Particularidades pediátricas: fosfatasas alcalinas fisiológicamente altas en etapas de crecimiento (lactante, estirón puberal); fósforo más alto en niños; creatinina menor según masa muscular.
- Calcio bajo: hipoparatiroidismo, déficit de vitamina D (raquitismo: fosfatasas muy altas, fósforo bajo), hipoalbuminemia (corregir); calcio alto: inmovilización, hiperparatiroidismo, neoplasias.
- Albúmina baja: síndrome nefrótico, desnutrición, enteropatía perdedora de proteínas, falla hepática.
- LDH y ácido úrico elevados: hemólisis, leucemia/linfoma, lisis tumoral.
- Interpretar en contexto clínico con valores de referencia por edad; alteraciones inesperadas: repetir y estudiar causa.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un lactante de 14 meses, de piel oscura, con lactancia materna exclusiva prolongada sin suplementación de vitamina D, presenta piernas arqueadas, ensanchamiento de muñecas y rosario costal. **¿Qué alteración del perfil bioquímico es la más esperable?**

A) Fosfatasa alcalina baja y fósforo alto
B) Todas las pruebas normales
C) Calcio muy elevado y PTH baja
D) Fosfatasa alcalina elevada, fósforo bajo y calcio normal o bajo
E) Fosfatasa alcalina normal y fósforo alto

Respuesta D. El raquitismo carencial por déficit de vitamina D produce menor absorción de calcio, hiperparatiroidismo secundario con fosfaturia y, por ello, hipofosfemia con calcio normal o bajo. La fosfatasa alcalina se eleva marcadamente por el aumento de actividad osteoblástica, y es el marcador más útil. La 25-OH vitamina D está baja.

2.01.4.019 Perfil lipídico

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Perfil lipídico: colesterol total, HDL, triglicéridos y LDL calculado (Friedewald si TG <400); idealmente en ayuno de 9-12 h.
- Valores aceptables en niños: CT <170 mg/dL, LDL <110, no-HDL <120, TG <75 (0-9 años) y <90 (10-19 años), HDL >45.
- Limítrofe: CT 170-199, LDL 110-129; alto: CT ≥200, LDL ≥130, TG ≥100 (<10 años) o ≥130 (10-19 años); HDL bajo <40.
- Indicaciones: tamizaje universal a los 9-11 años y 17-21 años; selectivo desde los 2 años con historia familiar de hipercolesterolemia o ECV precoz, obesidad, DM, HTA, ERC, síndrome nefrótico.
- LDL ≥190 mg/dL o ≥160 con historia familiar: sospechar hipercolesterolemia familiar (estudiar a la familia).
- Confirmar con 2 muestras separadas 2-12 semanas; descartar causas secundarias (hipotiroidismo, obesidad, nefrótico, fármacos) antes de iniciar manejo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En el control de salud de un niño de 5 años, sano y con IMC normal, la madre refiere que el padre del niño tuvo un infarto agudo al miocardio a los 45 años y tiene colesterol total de 320 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) No solicitar exámenes hasta los 18 años
B) Solicitar solo glicemia
C) Iniciar estatina empírica
D) Solicitar perfil lipídico en ayunas
E) Solicitar perfil lipídico solo si desarrolla obesidad

Respuesta D. Se recomienda tamizaje selectivo con perfil lipídico desde los 2 años en niños con antecedente familiar de enfermedad cardiovascular precoz (hombres menores de 55 años, mujeres menores de 65) o dislipidemia familiar, además de un tamizaje universal entre los 9 y 11 años. Así se pesquisa la hipercolesterolemia familiar, que requiere manejo precoz. Las estatinas no se usan sin diagnóstico.

2.01.4.020 Proteína C reactiva cuantitativa

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 18.9 Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- PCR: reactante de fase aguda sintetizado en el hígado; sube a las 6-8 h del estímulo, peak a las 48 h; vida media corta (19 h) lo que permite seguir la respuesta al tratamiento.
- Valores: normal <1 mg/dL (<10 mg/L); PCR >8-10 mg/dL sugiere infección bacteriana (neumonía bacteriana, pielonefritis, bacteriemia), sin ser diagnóstica.
- Útil en lactantes febriles sin foco para estratificar riesgo de infección bacteriana grave (junto con hemograma y procalcitonina) y en sospecha de artritis séptica u osteomielitis.

- Limitaciones: puede ser normal en infección muy precoz (<12 h) y elevarse en virus como adenovirus, influenza, enfermedad de Kawasaki, trauma, cirugía y enfermedades inflamatorias.
- PCR seriada: útil en sepsis neonatal (dos PCR normales a las 24-48 h ayudan a suspender antibióticos) y para monitorizar osteomielitis.
- No reemplaza la evaluación clínica: no tratar un número sin contexto.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un lactante de 4 meses presenta fiebre de 39 °C de 3 horas de evolución, sin foco al examen. Está en buenas condiciones. Se solicita hemograma, orina completa y proteína C reactiva, que resulta 0,6 mg/dL. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de la PCR?**
>
> **A)** Descarta infección bacteriana grave
> **B)** Permite dar el alta sin control
> **C)** Confirma una infección viral
> **D)** Indica que no se requiere orina completa
> **E)** Puede estar aún normal por el poco tiempo de evolución de la fiebre
>
> Respuesta E. La proteína C reactiva se eleva entre 6 y 12 horas tras el inicio del proceso inflamatorio y alcanza su máximo a las 36 a 48 horas. Con fiebre de menos de 6 a 12 horas puede ser normal aun en una infección bacteriana grave. Debe interpretarse con la clínica y la evolución; la procalcitonina sube más precozmente.

2.01.4.021 Pruebas de coagulación

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 8.11 Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno

QUÉ HAY QUE SABER

- Pruebas básicas: recuento de plaquetas, tiempo de protrombina (TP/INR, vía extrínseca: VII), TTPA (vía intrínseca: VIII, IX, XI, XII) y fibrinógeno.
- TTPA prolongado aislado: hemofilia A (VIII) o B (IX), von Willebrand (a veces), heparina, anticoagulante lúpico; mezclar con plasma normal: corrige en déficit de factores, no corrige con inhibidores.
- TP prolongado: déficit de vitamina K (enfermedad hemorrágica del RN si no recibió vitamina K, malabsorción, colestasia), daño hepático, anticoagulantes orales; corrige con vitamina K si es por déficit.
- TP y TTPA prolongados con plaquetas y fibrinógeno bajos y dímero D alto: coagulación intravascular diseminada (sepsis, meningococcemia).
- Plaquetas bajas con TP y TTPA normales: PTI, leucemia, SHU (esquistocitos); sangrado mucocutáneo con estudio normal: von Willebrand (estudio de factor y antígeno) o disfunción plaquetaria.
- Indicaciones: sangrado anormal, antes de cirugía con historia sugerente, sospecha de CID, hepatopatía; derivar a hematología si estudio alterado.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un niño de 3 años con equimosis fáciles tiene recuento de plaquetas normal, TP normal y TTPA prolongado. Se realiza una prueba de mezcla con plasma normal y el TTPA se corrige completamente. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**
>
> **A)** Presencia de un inhibidor (anticoagulante lúpico o anticuerpo contra un factor)
> **B)** Déficit de un factor de la vía intrínseca (ej. VIII, IX o XI)
> **C)** Déficit de factor VII
> **D)** Trombocitopenia inmune
> **E)** Coagulación intravascular diseminada
>
> Respuesta B. El TTPA evalúa la vía intrínseca (XII, XI, IX, VIII) y común; el TP la vía extrínseca (VII) y común. Si el TTPA prolongado se corrige al mezclar con plasma normal, falta un factor (el plasma normal lo aporta): en un niño con sangrado sugiere hemofilia A o B, y se dosifican factores VIII y IX.

2.01.4.022 Pruebas de función renal

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Creatinina sérica refleja la función renal pero varía con masa muscular y edad (más baja en niños); en RN refleja inicialmente la creatinina materna.
- Estimar VFG con fórmula de Schwartz modificada: VFG = 0,413 × talla (cm) / creatinina (mg/dL); normal >90 ml/min/1,73 m² desde los 2 años (menor en lactantes).
- BUN aumenta en deshidratación, hemorragia digestiva, catabolismo; relación BUN/creatinina >20 sugiere causa prerrenal.
- Lesión renal aguda: aumento de creatinina ≥1,5 veces basal o ≥0,3 mg/dL en 48 h, o diuresis <0,5 ml/kg/h; FENa <1% prerrenal y >2% renal (NTA).
- Complementar con orina completa, índice proteinuria/creatininuria, electrolitos y gases (acidosis), ecografía renal; cistatina C útil cuando la masa muscular es baja.
- VFG <60 por >3 meses o alteraciones persistentes: ERC, derivar a nefrología pediátrica; ajustar dosis de fármacos según VFG.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 8 años, con talla de 125 cm, tiene creatinina plasmática de 0,9 mg/dL. Se quiere estimar su velocidad de filtración glomerular. **¿Qué método es el más adecuado para estimarla en pediatría?**

A) Fórmula de Schwartz (talla y creatinina)
B) Fórmula de Cockcroft-Gault
C) Ecuación CKD-EPI
D) Solo el nitrógeno ureico
E) La creatinina sola, comparada con valores del adulto

Respuesta A. En niños, la filtración glomerular se estima con la fórmula de Schwartz modificada: VFG = 0,413 × talla (cm) / creatinina (mg/dL). En este caso, 0,413 × 125 / 0,9 = 57 mL/min/1,73 m2, es decir, disminuida. Las fórmulas del adulto (CKD-EPI, Cockcroft-Gault) no son válidas en niños, y la creatinina normal varía con la edad y la masa muscular.

2.01.4.023 Pruebas hepáticas

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 18.17 Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Daño hepatocelular: transaminasas (ALT más específica de hígado; AST también en músculo y glóbulos rojos); >10 veces lo normal en hepatitis viral aguda, isquemia, tóxicos (paracetamol).
- Colestasia: bilirrubina directa >1 mg/dL (o >20% si bilirrubina total >5), GGT y fosfatasas alcalinas elevadas; en lactante con acolia sospechar atresia de vías biliares (urgencia).
- Función hepática real: TP/INR (no corrige con vitamina K en falla hepática), albúmina, glicemia y amonio.
- Hiperbilirrubinemia indirecta: ictericia neonatal fisiológica, hemólisis (reticulocitos, LDH, Coombs), Gilbert (adolescente con ictericia leve en ayuno o enfermedad, sin hemólisis).
- Fosfatasas alcalinas aisladas elevadas en crecimiento son fisiológicas; CK elevada con transaminasas altas sugiere miopatía (distrofia de Duchenne).
- Transaminasas elevadas en niño obeso: hígado graso; persistentes sin causa: estudiar celiaquía, Wilson, autoinmune, virus; derivar a gastroenterología si falla hepática o colestasia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un lactante de 5 semanas, de término, presenta ictericia desde la segunda semana de vida, deposiciones de color blanco masilla (acolia) y orinas oscuras. Está con buen incremento ponderal. Al examen tiene hepatomegalia firme. Exámenes: bilirrubina total 8 mg/dL con directa 6 mg/dL y GGT elevada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Fototerapia
B) Suspender la lactancia materna por 48 horas
C) Derivación urgente para estudio de atresia de vías biliares
D) Control en 1 mes
E) Exanguinotransfusión

Respuesta C. Una bilirrubina directa elevada (mayor a 1 mg/dL o 20% del total) es colestasia y nunca es fisiológica; con acolia, coluria y GGT alta sugiere atresia de vías biliares. Requiere derivación urgente, porque la portoenteroestomía de Kasai rinde mejor antes de los 45 a 60 días de vida.

2.01.4.024 Pruebas tiroideas

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito

QUÉ HAY QUE SABER

- TSH es el mejor examen de tamizaje de función tiroidea; complementar con T4 libre.
- TSH alta + T4 libre baja: hipotiroidismo primario (congénito o Hashimoto); TSH alta + T4 libre normal: hipotiroidismo subclínico (repetir; tratar si TSH >10).
- TSH baja + T4 libre alta: hipertiroidismo (enfermedad de Graves; anticuerpos anti receptor de TSH); TSH baja/normal + T4 libre baja: hipotiroidismo central (hipofisario).
- Tamizaje neonatal con TSH en sangre de talón (40 h-7 días); TSH elevada: confirmar con TSH y T4 libre en sangre venosa y tratar de inmediato con levotiroxina.
- Valores de TSH en RN son fisiológicamente altos en las primeras 24-48 h (pico post parto); no interpretar antes.
- Anticuerpos antiperoxidasa (antiTPO) y antitiroglobulina apoyan tiroiditis autoinmune; indicaciones: talla baja, bocio, obesidad con baja velocidad de crecimiento, síndrome de Down, DM1.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

El programa de tamizaje neonatal informa que un recién nacido de 7 días tiene TSH elevada en la muestra de sangre en papel filtro. Está asintomático. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir el tamizaje en papel filtro a los 2 meses
B) Solicitar cintigrafía tiroidea antes de cualquier tratamiento
C) Esperar la aparición de síntomas para tratar
D) Citar de inmediato para confirmar con TSH y T4 libre en sangre venosa e iniciar levotiroxina sin esperar síntomas
E) Iniciar propiltiouracilo

Respuesta D. El hipotiroidismo congénito suele ser asintomático al nacer y es una causa prevenible de discapacidad intelectual. Ante un tamizaje alterado se confirma de inmediato con TSH y T4 libre séricas y, si se confirma, se inicia levotiroxina idealmente antes de los 15 días de vida. Los estudios etiológicos (ecografía, cintigrafía) no deben retrasar el tratamiento.

2.01.4.025 Serología y técnicas de aislamiento viral y bacteriano

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 18.5 Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico microbiológico: detección directa del agente (cultivo, antígenos, PCR) o respuesta inmune (serología IgM/IgG).
- Virus respiratorios: inmunofluorescencia o PCR de hisopado/aspirado nasofaríngeo (VRS, influenza, adenovirus, parainfluenza, metapneumovirus, SARS-CoV-2); útil en hospitalizados para cohortear y en influenza para indicar oseltamivir.
- Coqueluche: PCR para Bordetella pertussis en hisopado nasofaríngeo (mayor rendimiento en las primeras 3 semanas).

- Serología: IgM indica infección aguda (VHA, VEB VCA-IgM, Mycoplasma, toxoplasma); IgG indica infección pasada o inmunidad; seroconversión o alza de 4 veces el título confirma. Anticuerpos maternos persisten hasta 18 meses en lactantes (VIH: usar PCR).
- Test rápido de antígeno para S. pyogenes en faringe (alta especificidad) y rotavirus en deposiciones.
- Interpretar en contexto clínico: PCR positiva puede reflejar portación o excreción prolongada (adenovirus, rinovirus).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un lactante de 3 meses, en época invernal, presenta coriza, tos y luego dificultad respiratoria con sibilancias y crepitaciones difusas. Se hospitaliza y se desea identificar el agente viral para cohortear a los pacientes. **¿Cuál es el examen más adecuado?**
>
> **A)** Serología IgM para virus respiratorios
> **B)** Inmunofluorescencia o PCR viral en aspirado o hisopado nasofaríngeo
> **C)** Hemocultivo
> **D)** Cultivo de expectoración
> **E)** Recuento de eosinófilos
>
> Respuesta B. El diagnóstico etiológico de las infecciones respiratorias virales agudas se realiza con detección de antígenos (inmunofluorescencia) o PCR en muestra nasofaríngea, rápida y sensible. En la bronquiolitis el agente más frecuente es el virus respiratorio sincicial. La serología es tardía y poco útil en infecciones agudas; el hemocultivo y el cultivo de expectoración son para bacterias.

2.01.4.026 Test del sudor

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 4.5 Hemoptisis y Bronquiectasias

QUÉ HAY QUE SABER

- Test del sudor: estimulación con pilocarpina (iontoforesis) y medición de cloro en sudor; examen diagnóstico de fibrosis quística.
- Interpretación: cloro ≥60 mmol/L positivo (en 2 muestras confirma FQ); 30-59 mmol/L intermedio (repetir y estudio genético); <30 mmol/L normal.
- Indicaciones: infecciones respiratorias recurrentes o SBO persistente, neumonías a repetición, bronquiectasias, desnutrición con esteatorrea, íleo meconial, prolapso rectal, pólipos nasales, deshidratación con alcalosis hipoclorémica, hermano con FQ, tamizaje neonatal positivo (tripsina inmunorreactiva).
- Requisitos: niño >2 semanas y >2 kg, cantidad suficiente de sudor (≥75 mg o 15 μl); falsos positivos con desnutrición, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal; falsos negativos con edema.
- Confirmación con estudio genético de mutaciones CFTR (ΔF508 la más frecuente).
- Resultado positivo: derivar a centro de FQ (GES).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un niño de 2 años presenta neumonías y bronquitis obstructivas a repetición, tos productiva crónica, deposiciones abundantes, grasosas y malolientes, y mal incremento ponderal pese a buen apetito. Su madre nota que su piel es muy salada al besarlo. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**
>
> **A)** Cuantificación de inmunoglobulinas
> **B)** Espirometría
> **C)** TAC de tórax
> **D)** Anticuerpos antitransglutaminasa
> **E)** Test del sudor (cloro en sudor)
>
> Respuesta E. Infecciones respiratorias recurrentes con tos productiva, esteatorrea por insuficiencia pancreática, falla de crecimiento y piel salada sugieren fibrosis quística. El examen de elección es el test del sudor por iontoforesis con pilocarpina: cloro en sudor de 60 mmol/L o más en dos muestras confirma; entre 30 y 59 es limítrofe y requiere estudio genético del gen CFTR.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 12 códigos

2.01.5.001 Antropometría en la edad pediátrica

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Peso: balanza calibrada; lactante desnudo en pesa de bandeja, niño mayor con ropa interior de pie en balanza.
- Longitud en <2 años acostado en podómetro (infantómetro) con 2 personas, cabeza en plano de Frankfurt y piernas extendidas; talla de pie con estadiómetro desde los 2 años (talla de pie es ~0,7 cm menor).
- Perímetro craneano con cinta inextensible sobre glabela y protuberancia occipital (máximo diámetro), en cada control hasta los 2-3 años.
- Perímetro de cintura sobre el borde superior de la cresta ilíaca al final de la espiración, desde los 5-6 años para evaluar obesidad abdominal (≥p90).
- Registrar en curvas OMS según sexo y edad (corregida en prematuros hasta los 2 años) y calcular indicadores: P/E, T/E, P/T, IMC/E.
- Errores frecuentes: equipo no calibrado, ropa o pañal puesto, mala posición; interpretar la tendencia en controles sucesivos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 20 meses acude a su control de salud. La interna lo mide de pie en el estadiómetro, porque el niño ya camina, y registra su estatura en la curva de Talla para la Edad de la OMS. **¿Cuál es la corrección más adecuada a esta técnica?**

A) Ninguna: desde que camina se mide de pie
B) Medirlo acostado recién desde los 3 años
C) Medirlo de pie, pero restar 2 cm al valor obtenido
D) Medir solo el perímetro cefálico, que reemplaza a la talla en esta edad
E) Medirlo acostado con infantómetro, porque hasta los 2 años se registra la longitud

Respuesta E. Hasta los 2 años se mide al niño acostado con infantómetro (longitud); desde los 2 años cumplidos, de pie con estadiómetro (estatura). Que el niño camine no cambia la técnica, y las curvas OMS están construidas así.

2.01.5.002 Atención inmediata del recién nacido

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 18.15 Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Preparación: anamnesis perinatal (edad gestacional, líquido amniótico, factores de riesgo de infección), equipo de reanimación listo, cuna radiante encendida.
- Evaluación inicial: ¿término?, ¿respira o llora?, ¿buen tono? Si todo es sí: contacto piel a piel con la madre, secado, cubrir y clampeo tardío del cordón (≥30-60 s).
- Apgar al minuto y a los 5 minutos (FC, esfuerzo respiratorio, tono, irritabilidad refleja, color); no se usa para decidir reanimación.
- Procedimientos: vitamina K 1 mg IM (0,5 mg en <1.500 g), profilaxis ocular (eritromicina o cloranfenicol), identificación, antropometría, examen físico (malformaciones, permeabilidad anal y esofágica si hay polihidroamnios).
- Lactancia materna en la primera hora; BCG y hepatitis B antes del alta; tamizaje de TSH y PKU, auditivo y cardiopatías (saturometría) según protocolo.
- No se recomienda aspiración rutinaria de secreciones en RN vigoroso.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 50

Recién nacido de término por parto vaginal, con líquido amniótico claro. Al nacer llora inmediatamente, con frecuencia cardíaca de 145 latidos por minuto, buen tono muscular y piel rosada. **¿Cuál es la primera maniobra que realizas?**

A) Aspiración rutinaria de vías aéreas
B) Contacto piel a piel con la madre
C) Vitamina K intramuscular
D) Profilaxis ocular con eritromicina
E) Oxígeno suplementario

Respuesta B. Con las tres preguntas iniciales en sí (término, buen tono, llanto vigoroso), no se aspira de rutina ni se separa al recién nacido: la primera prioridad es el apego piel a piel precoz.

2.01.5.003 Cateterismo vesical

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: obtención de orina estéril para urocultivo en niño sin control de esfínteres, retención urinaria aguda, medición de diuresis en paciente crítico, uretrocistografía.
- Técnica estéril: lavado genital, guantes estériles, campo estéril, lubricación; en niñas separar labios y visualizar meato; en niños, retraer suavemente el prepucio sin forzar.
- Calibre: 5-6 Fr en lactantes pequeños, 8 Fr en niños, aumentar según edad.
- Descartar los primeros mililitros y recolectar en frasco estéril; urocultivo positivo con ≥10.000 UFC/ml (algunas guías ≥50.000).
- Contraindicaciones: trauma uretral (sangre en meato, hematoma perineal), infección uretral activa; en fimosis estrecha preferir punción suprapúbica.
- Complicaciones: trauma uretral, falsa vía, infección; en retención urinaria, vaciar y evaluar causa.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un lactante de 9 meses, sin control de esfínteres, presenta fiebre de 39 °C sin foco. Se decide estudiar una posible infección urinaria. **¿Cuál es el método más adecuado para obtener la muestra de urocultivo?**

A) Cateterismo vesical con técnica estéril
B) Bolsa recolectora adhesiva
C) Recolección del pañal
D) Segundo chorro espontáneo
E) Orina de 24 horas

Respuesta A. En niños sin control de esfínteres, el urocultivo debe tomarse por cateterismo vesical estéril (o punción suprapúbica), porque la bolsa recolectora tiene una alta tasa de contaminación: solo es útil si resulta negativa. El segundo chorro se usa en niños con control miccional. La técnica requiere aseo genital, sonda fina y desechar las primeras gotas.

2.01.5.004 Maniobra de Heimlich

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 18.8 Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: obstrucción completa de vía aérea por cuerpo extraño en niño consciente >1 año (no puede toser, hablar ni llorar, cianosis); si tose efectivamente, estimular la tos y no intervenir.
- Técnica (>1 año): colocarse detrás del niño, puño sobre la línea media del abdomen entre ombligo y xifoides, y compresiones abdominales rápidas hacia adentro y arriba hasta expulsar el objeto o pérdida de conciencia.
- Lactante <1 año: no compresiones abdominales (riesgo de lesión hepática); alternar 5 golpes interescapulares en decúbito prono con cabeza más baja y 5 compresiones torácicas en supino.
- Si pierde la conciencia: iniciar RCP comenzando con compresiones; al abrir vía aérea mirar la boca y retirar el objeto solo si es visible (no barrido digital a ciegas).
- En obesos o embarazadas: compresiones torácicas en lugar de abdominales.

- Después de la maniobra derivar a evaluación médica (posibles lesiones internas o cuerpo extraño residual: broncoscopía).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 73

Un niño de 7 años, mientras estaba comiendo, presenta agitación súbita, asociada a imposibilidad de respirar. No puede toser, hablar ni llorar. **¿Cuál es la maniobra más adecuada en este momento?**

A) Realizar respiración boca a boca
B) Meterle los dedos en la boca y retirar el cuerpo extraño
C) Dar golpes en la región interescapular
D) Abrazarlo por detrás y realizar compresiones subxifoideas
E) Realizar compresiones en el pecho, en decúbito supino

Respuesta D. Obstrucción completa de la vía aérea por cuerpo extraño en un niño consciente mayor de 1 año: maniobra de Heimlich, con compresiones abdominales subxifoideas desde atrás. Los golpes interescapulares con compresiones torácicas son para el menor de 1 año, y el barrido a ciegas está contraindicado.

2.01.5.005 Osteoclisis

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 18.11 Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

QUÉ HAY QUE SABER

- Osteoclisis (acceso intraóseo): vía de emergencia cuando no se obtiene acceso venoso en 60-90 segundos en paro cardiorrespiratorio, shock o estatus convulsivo.
- Sitio de elección en niños: tibia proximal, cara anteromedial 1-3 cm bajo la tuberosidad tibial; alternativas tibia distal (sobre maléolo medial), fémur distal, húmero proximal en mayores.
- Técnica: asepsia, aguja intraósea manual o dispositivo de taladro (EZ-IO), insertar perpendicular o en ángulo alejándose del cartílago de crecimiento hasta perder resistencia; confirmar con aspiración de médula y paso libre de suero sin extravasación.
- Permite administrar todos los fármacos, fluidos y hemoderivados con efecto similar a la vía venosa; usar bolos con presión.
- Contraindicaciones: fractura en el hueso elegido, intento previo en el mismo hueso, infección local, osteogénesis imperfecta.
- Complicaciones: extravasación y síndrome compartimental, osteomielitis; retirar en <24 h una vez obtenido acceso venoso.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 108

Un lactante de 4 meses presenta una diarrea grave y abundante, asociada a deterioro del estado general y sopor. Sus exámenes muestran elevación de la creatinina, hiponatremia e hipokalemia. Ha sido imposible encontrar una vía venosa periférica para administrar fluidos. **¿Cuál es el medio de hidratación más adecuado?**

A) Catéter femoral
B) Catéter subclavio
C) Denudación de safena
D) Vía intraósea
E) Sonda nasogástrica

Respuesta D. Un lactante con deshidratación grave y compromiso de conciencia (plan C) requiere reposición endovenosa inmediata. Si no se logra una vía periférica rápidamente (ej. 90 segundos o 3 intentos), la vía de elección en pediatría es la intraósea (osteoclisis), habitualmente en la tibia proximal, por la que se pueden pasar fluidos y fármacos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 136 · texto original del banco, sin revisar

Un lactante de 1 años de vida ingresa al servicio de urgencia en malas condiciones generales, soporoso, con extremidades pálidas y frías en la zona distal. Se indica hidratación endovenosa, pero, a pesar de intentarlo, es imposible acceder a un vía venosa. ¿Cuál es la vía de elección para admninistrar fluidos en este paciente?

A) Catéter venoso central
B) Línea arterial
C) Sonda nasogástrica
D) Denudación venosa
E) Osteoclisis

Respuesta E. En los niños, al fallar la vía venosa, se prefiere la osteoclisis. En los adultos, la denudacion venosa.

2.01.5.006 Oxigenoterapia

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 18.5 Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: hipoxemia (saturación <90-93% según condición) en bronquiolitis, neumonía, crisis asmática, insuficiencia respiratoria, shock, paro; meta saturación ≥93% (90-95% en prematuros para evitar retinopatía).
- Sistemas de bajo flujo: naricera (cánula nasal) 0,5-2 L/min en lactantes, hasta 4 L/min en niños (FiO2 24-40%); mascarilla simple 5-10 L/min (FiO2 35-50%).
- Alto requerimiento: mascarilla con reservorio 10-15 L/min (FiO2 60-90%); cánula nasal de alto flujo humidificada (1-2 L/kg/min) en bronquiolitis moderada-grave.
- Humidificar con flujos altos; monitorizar saturometría y signos de dificultad respiratoria.
- Hipoxemia que no corrige o hipercapnia: escalar a VNI o ventilación mecánica.
- Oxígeno domiciliario (POD) en displasia broncopulmonar u otras enfermedades crónicas según protocolo; precauciones: no fumar ni fuego cerca.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 4 meses con bronquiolitis de 3 días de evolución. Al examen: FR 62 rpm, tiraje subcostal e intercostal, sibilancias espiratorias y saturación de 89% con aire ambiental. Está alerta y se alimenta con dificultad. **Respecto del oxígeno, ¿cuál es la indicación más adecuada?**

A) No indicar oxígeno hasta que la saturación baje de 85%
B) Nebulizar salbutamol con aire comprimido en vez de oxígeno
C) Oxígeno al 100% con mascarilla con reservorio para lograr saturación de 100%
D) Intubación y ventilación mecánica inmediatas
E) Oxígeno por naricera de bajo flujo, ajustado para mantener saturación de 93% o más

Respuesta E. Una saturación bajo 93% en un lactante con bronquiolitis es criterio de hospitalización y de oxigenoterapia. Se usa naricera de bajo flujo, titulada para saturar 93% o más. No se busca saturar 100% y el niño está alerta, sin criterio de ventilación mecánica.

2.01.5.007 Proctoclisis

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 6.2 Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Proctoclisis: administración de líquidos por vía rectal (enema evacuante) para desimpactación fecal en constipación con fecaloma.
- Indicaciones: impactación fecal (masa fecal palpable en abdomen o tacto rectal) cuando no se usa desimpactación oral con PEG en dosis altas; preparación para procedimientos.
- Soluciones: suero fisiológico tibio 5-10 ml/kg o enemas comerciales; evitar enemas de fosfato en <2 años y en insuficiencia renal (hiperfosfemia, hipocalcemia); no usar agua corriente (intoxicación hídrica).
- Técnica: decúbito lateral izquierdo con rodillas flectadas, sonda rectal lubricada, introducir lentamente, retener algunos minutos.

- Contraindicaciones: sospecha de abdomen agudo, obstrucción intestinal, ECN, neutropenia, trauma rectal, cirugía reciente.
- Tras desimpactar, iniciar mantención con laxante osmótico (PEG o lactulosa) y hábito defecatorio.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un niño de 5 años con constipación crónica presenta dolor abdominal y escurrimiento fecal. Al examen se palpa masa fecal en hipogastrio y el tacto rectal confirma impactación fecal. Se planifica desimpactación con proctoclisis (enema). **¿En cuál de las siguientes situaciones está contraindicada la proctoclisis?**
>
> **A)** Constipación funcional con fecaloma
> **B)** Escurrimiento fecal (encopresis por rebalse)
> **C)** Neutropenia grave por quimioterapia
> **D)** Antecedente de fisura anal cicatrizada
> **E)** Dieta pobre en fibra
>
> Respuesta C. La desimpactación fecal puede hacerse con polietilenglicol oral en dosis altas o por vía rectal (proctoclisis o enemas). La manipulación rectal está contraindicada en pacientes neutropénicos o inmunosuprimidos (riesgo de bacteriemia), con sospecha de abdomen agudo u obstrucción, enterocolitis o cirugía colorrectal reciente. El escurrimiento por rebalse es justamente una indicación de desimpactar.

2.01.5.008 Punción lumbar

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 18.14 Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: sospecha de meningitis o encefalitis (fiebre con meningismo, lactante febril <28 días o con mal aspecto), convulsión febril con signos meníngeos o <12 meses con vacunas incompletas o antibiótico previo, hemorragia subaracnoidea con TC negativa.
- Contraindicaciones: hipertensión endocraneana o focalidad (TC previa), inestabilidad hemodinámica o respiratoria, coagulopatía o plaquetas <50.000, infección en el sitio de punción; no retrasar antibióticos por la PL.
- Técnica: posición sentada o decúbito lateral con flexión máxima, sin comprometer la ventilación en lactantes; espacio L3-L4 o L4-L5 (la médula termina en L2-L3 en lactantes); asepsia y aguja con mandril.
- Muestras: citoquímico (células, glucosa con glicemia simultánea, proteínas), Gram, cultivo, PCR; presión de apertura si es posible.
- LCR bacteriano: >1.000 células PMN, glucosa baja, proteínas altas; viral: pleocitosis mononuclear con glucosa normal.
- Complicaciones: cefalea post punción, punción traumática, infección, herniación si hay hipertensión endocraneana no detectada.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Lactante de 11 meses, con vacunas al día, con otitis media aguda en tratamiento con amoxicilina desde hace 3 días. Hoy, con fiebre de 39 °C, presenta una crisis tónico-clónica generalizada de 2 minutos que cede sola. A los 30 minutos está algo irritable, sin rigidez de nuca ni focalidad, con fontanela normotensa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Alta con antipiréticos y educación, porque es una convulsión febril simple
> **B)** Realizar punción lumbar, porque venía recibiendo antibióticos
> **C)** Solicitar electroencefalograma urgente
> **D)** Iniciar fenobarbital de mantención
> **E)** Realizar TAC de cerebro y dar el alta si es normal
>
> Respuesta B. En un lactante con convulsión febril, el tratamiento antibiótico previo puede enmascarar una meningitis decapitada: es indicación de punción lumbar, igual que los signos meníngeos, la letargia persistente o las vacunas incompletas. El EEG y la neuroimagen no están indicados de rutina.

2.01.5.009 Punción pleural

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 3.2 Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: derrame pleural paraneumónico significativo (>1 cm en decúbito lateral) para diagnóstico, derrame que compromete la respiración, sospecha de empiema.
- Técnica: asepsia, anestesia local, paciente sentado; punción en línea axilar media o posterior en 5º-7º espacio intercostal (o guiada por ecografía), por el borde superior de la costilla inferior (evitar paquete vasculonervioso).
- Muestras: pH, glucosa, LDH, proteínas, recuento celular, Gram y cultivo; contrastar con valores séricos (criterios de Light).
- Derrame complicado o empiema (pus, pH <7,2, glucosa <40 mg/dL, LDH >1.000, Gram/cultivo positivo): tubo de drenaje pleural ± fibrinolíticos o videotoracoscopía.
- Contraindicaciones relativas: coagulopatía, plaquetas bajas, infección cutánea en el sitio.
- Complicaciones: neumotórax (Rx de control), hemotórax, lesión hepática o esplénica, edema pulmonar por reexpansión si se evacúa gran volumen rápidamente.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Se realizará una punción pleural diagnóstica en un niño de 7 años con derrame pleural paraneumónico moderado, sentado e inclinado hacia adelante, con ecografía que marca el sitio de punción. **¿Cuál es la técnica correcta para introducir la aguja?**
>
> **A)** Por el borde superior de la costilla inferior
> **B)** Por el borde inferior de la costilla superior
> **C)** Por el centro del espacio intercostal, sin referencia costal
> **D)** En la línea medioclavicular, segundo espacio intercostal
> **E)** Por debajo de la décima costilla posterior
>
> Respuesta A. El paquete vasculonervioso intercostal (vena, arteria y nervio) discurre por el borde inferior de cada costilla. Por eso la aguja se introduce rasando el borde superior de la costilla inferior, en la línea axilar media o posterior, idealmente guiada por ecografía. El segundo espacio en la línea medioclavicular se usa para descomprimir un neumotórax a tensión, no para derrames.

2.01.5.010 Punción suprapúbica

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Punción suprapúbica: método de referencia para obtener orina estéril en lactantes sin control de esfínteres; cualquier recuento bacteriano en el urocultivo es significativo.
- Indicaciones: lactantes <1-2 años cuando el sondeo es imposible o poco confiable (fimosis estrecha, sinequia vulvar, malformaciones), necesidad de muestra no contaminada.
- Requisitos: vejiga llena (no haber orinado en 1 h; idealmente confirmar con ecografía), asepsia, punción 1-2 cm sobre la sínfisis púbica en la línea media, perpendicular o con leve inclinación cefálica.
- Contraindicaciones: vejiga vacía, distensión abdominal, malformaciones o cirugía abdominal baja, coagulopatía, infección cutánea local.
- Complicaciones (raras): hematuria microscópica transitoria, perforación intestinal, infección.
- Según el perfil, su realización se deriva a especialista; el médico general debe conocer indicaciones e interpretar el urocultivo obtenido.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un lactante de 2 meses con fiebre sin foco requiere urocultivo. No fue posible realizar cateterismo vesical por fimosis estrecha, por lo que se obtiene la muestra mediante punción suprapúbica, que informa Escherichia coli 2.000 UFC/mL. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A) Contaminación, porque el recuento es bajo
B) Bacteriuria asintomática
C) Requiere repetir con bolsa recolectora
D) Infección urinaria confirmada, ya que por punción suprapúbica cualquier recuento es significativo
E) Se necesitan más de 100.000 UFC/mL para confirmar

Respuesta D. La punción suprapúbica obtiene orina directamente de la vejiga, normalmente estéril, por lo que cualquier recuento de bacterias gramnegativas es significativo. Se indica en lactantes cuando no es posible el cateterismo (fimosis estrecha, sinequias), preferentemente guiada por ecografía con vejiga llena. Los puntos de corte de mayor recuento son para cateterismo y segundo chorro.

2.01.5.011 Reanimación neonatal

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 18.15 Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Pasos iniciales (primeros 30 s): mantener temperatura (cuna radiante, secar, gorro; bolsa plástica en <32 semanas), posicionar vía aérea, aspirar solo si hay obstrucción, estimular.
- Si apnea, respiración boqueante o FC <100 lpm: ventilación a presión positiva (VPP) en el primer minuto (minuto de oro) con bolsa-mascarilla a 40-60 respiraciones/min; es la intervención más importante.
- Iniciar con aire ambiente (FiO2 21%) en ≥35 semanas y 21-30% en prematuros; ajustar según saturación preductal (mano derecha) objetivo por minuto de vida; monitor de saturación y ECG.
- Si VPP no es efectiva: corregir (MR SOPA: mascarilla, reposicionar, succionar, abrir boca, presión, vía aérea alternativa).
- FC <60 lpm tras 30 s de VPP efectiva: intubar y compresiones torácicas (técnica de 2 pulgares, tercio inferior del esternón) relación 3:1 (90 compresiones + 30 ventilaciones/min) con FiO2 100%.
- FC <60 pese a compresiones: adrenalina 0,01-0,03 mg/kg EV (vena umbilical) o 0,05-0,1 mg/kg endotraqueal; considerar expansión con SF 10 ml/kg si hipovolemia.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 59

Recién nacido de término que nace deprimido, con apnea y una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. Se estimula, se administra oxígeno y se inician ventilaciones a presión positiva. Al reevaluar a los 30 segundos, la frecuencia cardíaca se mantiene en el mismo valor. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar adrenalina por vía endovenosa
B) Realizar intubación orotraqueal
C) Continuar con ventilación a presión positiva y reevaluar en 30 segundos
D) Aumentar la presión de ventilación y reevaluar en 30 segundos
E) Iniciar compresiones torácicas

Respuesta E. Tras 30 segundos de VPP efectiva, la frecuencia cardíaca sigue bajo 60: corresponde agregar masaje cardíaco coordinado con la ventilación.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 57

Recién nacido por cesárea de urgencia, por un registro fetal con signos de hipoxia. Al examen tiene cianosis generalizada e hipotonía, sin esfuerzo respiratorio; se seca y se pone bajo calor radiante, en posición de olfateo, con aporte de oxígeno. A los 50 segundos persiste en apnea y el pulso carotídeo es de 30 latidos por minuto. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?**

A) Conectar a ventilación mecánica
B) Administrar bicarbonato endovenoso
C) Administrar adrenalina por vía orotraqueal
D) Dar ventilación a presión positiva con mascarilla facial
E) Realizar masaje cardíaco

Respuesta D. Tras los pasos iniciales, un recién nacido en apnea con bradicardia grave requiere primero ventilación a presión positiva; el masaje cardíaco solo se agrega si la frecuencia sigue bajo 60 pese a la VPP efectiva.

Pregunta de práctica

Parto vaginal de una primigesta de 39 semanas. El recién nacido nace con llanto débil y tono flácido. Se traslada a cuna de calor radiante: se seca, se posiciona la cabeza en olfateo y se estimula. Al minuto de vida: continúa en apnea, no llora, y la auscultación muestra una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto. **¿Cuál es la conducta inmediata?**

A) Iniciar compresiones torácicas en relación 3:1
B) Iniciar ventilación a presión positiva con aire ambiental
C) Administrar adrenalina por vena umbilical
D) Dar oxígeno libre en flujo continuo al 100%
E) Calcular el Apgar y esperar al minuto 5 para intervenir

Respuesta B. Al minuto de vida, apnea y frecuencia cardíaca bajo 100 obligan a iniciar ventilación a presión positiva de inmediato. En un recién nacido de término se inicia con aire ambiental. El masaje y la adrenalina no tienen indicación todavía.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 151 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 26 años, cursando un embarazo de 41 semanas, inicia trabajo de parto. Al examen tienen 4 contracciones cada 10 minutos, dilatación cervical de 6 cm El registro fetal muestra desaceleraciones variables. Al romperse las membranas sale meconio espeso. El nacimiento se produce algunos minutos después, obteniéndose un recién nacido hiporreactivo e hipotónico. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Poner bajo calor radiante, administrar oxígeno, secar y reevaluar en 30 segundos
B) Realizar intubación orotraqueal y aspirar la vía aérea
C) Realizar ventilación a presión positiva
D) Realizar compresiones torácicas
E) Aspirar el contenido gástrico

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar intubación orotraqueal y aspirar la vía aérea (opción B). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

2.01.5.012 Reanimación cardiopulmonar pediátrica

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: ped-24

QUÉ HAY QUE SABER

- Cadena de supervivencia pediátrica: prevención, RCP precoz de calidad, activación del sistema de emergencia, soporte vital avanzado y cuidados post paro.
- Secuencia C-A-B: verificar respuesta, pedir ayuda y DEA, evaluar respiración y pulso (≤10 s); sin pulso o FC <60 con mala perfusión: iniciar compresiones.
- Compresiones: 100-120/min, profundidad 1/3 del tórax (4 cm lactante con 2 dedos o 2 pulgares; 5 cm niño con 1-2 manos), reexpansión completa, mínimas interrupciones. Relación 30:2 un reanimador, 15:2 dos reanimadores; con vía aérea avanzada 1 ventilación c/2-3 s.
- Si el reanimador está solo y no presenció el colapso: 2 minutos de RCP antes de ir a buscar ayuda (paro por asfixia); colapso súbito presenciado: activar emergencia y buscar DEA primero.
- DEA con parches pediátricos en <8 años (o adultos si no hay); FV/TV sin pulso: desfibrilar 2 J/kg, luego 4 J/kg; adrenalina 0,01 mg/kg EV/IO c/3-5 min; amiodarona 5 mg/kg en ritmos desfibrilables refractarios.

- Buscar causas reversibles (H y T) y tras recuperar circulación evitar hipoxemia, hiperoxia, hipotensión e hipertermia; trasladar a UCI pediátrica.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Usted y un colega encuentran a un lactante de 6 meses que no responde, no respira y no tiene pulso braquial. Inician la reanimación cardiopulmonar. **¿Cuál es la relación compresiones-ventilaciones y la técnica de compresión recomendada para dos reanimadores?**
> **A)** 30:2 con el talón de una mano sobre el esternón
> **B)** 15:2 con técnica de dos pulgares y manos rodeando el tórax, comprimiendo un tercio del diámetro anteroposterior
> **C)** 5:1 con dos dedos
> **D)** 3:1 como en el recién nacido
> **E)** Solo compresiones, sin ventilaciones
>
> Respuesta B. En RCP pediátrica, con un reanimador la relación es 30:2; con dos reanimadores, 15:2. En lactantes se prefiere la técnica de dos pulgares con manos rodeando el tórax (con dos reanimadores), comprimiendo al menos un tercio del diámetro anteroposterior (unos 4 cm), a 100 a 120 por minuto. La relación 3:1 es para la reanimación neonatal en sala de partos.